UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

DÉBORA CUNHA ROMANOV

NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO:
Desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

São Paulo
2024

DÉBORA CUNHA ROMANOV

NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO:
Desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADORA: Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro

São Paulo
2024

R759n Romanov, Débora Cunha.
Neurodiversidade no ambiente de trabalho: desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). / [recurso eletrônico] / Débora Cunha Romanov.
3 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientadora: Profa. Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro.
Referências bibliográficas: f. 218-234.

1. Neurodiversidade. 2. Autismo. 3. TEA. 4. Empregabilidade. 5. Desafios. 6. Barreiras. 7. Acessibilidade. 8. Ambiente de trabalho. I. Hanashiro, Darcy Mitiko Mori, *orientadora*. II. Título.

CDD 658

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Débora Cunha Romanov

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO: Desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

DÉBORA CUNHA ROMANOV

NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO:
Desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovada em 05 de agosto de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br DARCY MITIKO MORI HANASHIRO
Data: 05/08/2024 17:34:49-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br DIOGENES DE SOUZA BIDO
Data: 06/08/2024 10:21:05-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br SIMONE COSTA NUNES
Data: 14/08/2024 12:48:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª Drª Simone Costa Nunes

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)

Ao meu irmão Mateus, meu melhor amigo, por
nos ensinar, com seu jeito único de ser, como
podemos ser “mais humanos”

AGRADECIMENTOS

À Profª Drª Darcy M. M. Hanashiro, minha orientadora e profissional com currículo admirável e experiência notável, por ter me ensinado a pensar e escrever cientificamente. Nunca me esquecerei dos seus ensinamentos. Sem as suas orientações semanais, essa pesquisa não teria sido possível. Agradeço também por me apoiar sempre, em especial, nos momentos mais difíceis nesta jornada.

Ao meu marido, Sergey Romanov, pela paciência, compreensão e apoio ao longo de todos os dias dessa intensa trajetória. Graças ao seu amor incondicional, foi possível passar tantas e tantas horas e tantos e tantos dias em aulas, leituras, estudos e escrita. A você, meu eterno agradecimento.

À minha mãe, Eliana Cunha, meu exemplo de vida e pessoa admirável por inúmeros motivos, por todas as conversas, discussões e momentos compartilhados para que essa pesquisa fosse concluída. Além de todo o seu amor, incentivo e parceria, sua experiência e renome na área da deficiência visual foram essenciais para a melhor compreensão da temática proposta. Não conseguiria sem você.

A todas as pessoas autistas que conheci ao longo desses meses de pesquisa intensa, por terem confiado em mim e compartilhado suas experiências mais profundas. Agradeço também aos profissionais de todas as organizações, entidades e instituições sem fins lucrativos, em especial, a Specialisterne e a AFAPA, que dedicaram parte do seu tempo para as entrevistas. Vocês todos foram fundamentais para esse projeto.

Aos colegas de Mestrado, Denise, Emerson, Letícia e Rafael, pelos momentos compartilhados durante esses dois anos e meio de estudos. Construímos uma bela amizade.

Ao Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), e à Profª Drª Simone Costa Nunes, por aceitarem participar da banca e por suas inestimáveis contribuições, e a todos os demais professores com os quais convivi durante o curso. Agradeço pelos ensinamentos.

Ao Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida e demais professores do Mack Pesquisa, pela convivência e pela oportunidade de participar de pesquisas conduzidas por vocês; e à Comissão de Bolsas da UPM, pela concessão dos recursos que viabilizaram meus estudos.

E a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa pesquisa. Muito obrigada!

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
(Michael Jackson)

RESUMO

Cada vez mais pessoas na fase adulta têm sido diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com implicações diretas para a sua empregabilidade, entendida como a capacidade de se obter e manter um emprego formal ou de encontrar um novo emprego, quando necessário. Foram constatados poucos estudos empíricos a respeito do assunto e a ausência de uma visão estruturada e integrada dos desafios enfrentados por profissionais com TEA no mercado de trabalho. Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa foi entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais com TEA (Grupo 1), dos profissionais de recursos humanos (RH) e gestão de pessoas (Grupo 2) e dos profissionais de entidades e instituições sem fins lucrativos que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho (Grupo 3). Por meio de uma pesquisa qualitativa com abordagem interpretativa, foi realizada análise documental e foram conduzidas entrevistas em profundidade, com roteiros semiestruturados especificamente desenhados para dezenove profissionais do Grupo 1, seis profissionais do Grupo 2 e quatro profissionais do Grupo 3. Por meio da análise temática, foi construída a visão integrada dos desafios enfrentados por profissionais com TEA com relação à sua própria empregabilidade, com base em: (i) onze temas relacionados ao Grupo 1, que envolvem barreiras macro associadas ao diagnóstico de TEA, à transição para a vida adulta e aos mitos associados ao TEA, e barreiras específicas enfrentadas em organizações; (ii) seis temas relacionados ao Grupo 2, a respeito de barreiras macro para os programas de neurodiversidade, e barreiras específicas para a contratação e inclusão de pessoas com TEA no trabalho; e (iii) cinco temas relacionados aos profissionais do Grupo 3, que tratam de barreiras macro em organizações para programas de neurodiversidade, e barreiras específicas para a contratação e inclusão de pessoas com TEA no trabalho. Foram também definidos temas a respeito das iniciativas tomadas pelos profissionais com TEA para a sua própria empregabilidade, da estruturação de programas de neurodiversidade por organizações, e da estruturação de programas de capacitação de profissionais com TEA por entidades que atuam para tal finalidade. A análise temática foi conduzida com base no modelo social da deficiência, na neurodiversidade e nas diretrizes previstas na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Palavras-chave: Neurodiversidade. Autismo. TEA. Empregabilidade. Desafios. Barreiras. Acessibilidade. Ambiente de trabalho.

ABSTRACT

More people have been diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) in adulthood, with direct implications on their employability, defined as someone's ability to obtain and maintain formal employment or to find a new job when needed. Few empirical studies were found on the subject and there is absence of a structured and integrated view of the challenges faced by professionals with ASD in the job market. Therefore, the general objective of this research was to understand the challenges for the employability of people with ASD, based on an integrated view of the professionals with ASD themselves (Group 1), human resources (HR) and people management professionals (Group 2) and professionals from non-profit entities and institutions who work to train professionals with ASD for the job market (Group 3). By means of qualitative research with an interpretative approach, document analysis was carried out and in-depth interviews were conducted, with semi-structured scripts specifically designed for nineteen professionals of Group 1; six professionals of Group 2; and four professionals of Group 3. Through thematic analysis, an integrated view of the challenges faced by professionals with ASD in relation to their own employability was constructed, based on: (i) eleven themes related to professionals of Group 1, which involve macro barriers associated with the diagnosis of ASD, the transition to adulthood and the myths associated with ASD, and specific barriers faced in organizations; (ii) six themes related to professionals of Group 2, regarding macro barriers to neurodiversity programs, and specific barriers to hiring and including people with ASD at work; and (iii) five themes related to professionals of Group 3, which address macro barriers in organizations for neurodiversity programs, and specific barriers to hiring and including people with ASD at work. Themes were also defined regarding the initiatives taken by professionals with ASD for their own employability; the structuring of neurodiversity programs by organizations; and the structuring of training programs for professionals with ASD by entities that work for this purpose. The thematic analysis was conducted based on the social model of disability, neurodiversity and the guidelines provided for in the Brazilian Inclusion Law (BIL).

Keywords: Neurodiversity. Autism. ASD. Employability. Challenges. Barriers. Accessibility. Workplace.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estrutura dos modelos da deficiência e seus principais aspectos. 37
Figura 2. Determinantes de empregabilidade (*Determinants of employability*) para profissionais com TEA. 52
Figura 3. Mapa do referencial teórico proposto. 58
Figura 4. Seleção dos participantes do Grupo 1. 62
Figura 5. Seleção dos participantes do Grupo 2. 65
Figura 6. Seleção dos participantes do Grupo 3. 68
Figura 7. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 4 do Grupo 1. 86
Figura 8. Visão geral da análise temática para os Temas 5 a 11 do Grupo 1. 119
Figura 9. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 4 do Grupo 2. 137
Figura 10. Visão geral da análise temática para os Temas 5 e 6 do Grupo 2. 146
Figura 11. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 3 do Grupo 3. 161
Figura 12. Visão geral da análise temática para os Temas 4 e 5 do Grupo 3. 182
Figura 13. Visão integrada das barreiras macro identificadas por meio dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3. 200
Figura 14. Visão integrada das barreiras específicas identificadas por meio dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3. 202

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Principais características da CID e do DSM no Brasil a respeito do TEA. 28
Quadro 2. Níveis de suporte do TEA, segundo o DSM-5-TR. 28
Quadro 3. Principais leis, normas e definições legais aplicáveis às pessoas com TEA no Brasil. 31
Quadro 4. Principais conceitos da neurodiversidade (de acordo com o modelo social da deficiência). 40
Quadro 5. Principais termos relacionados à neurotipicidade (a partir da neurodiversidade). 42
Quadro 6. Desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA (visão integrada). 56
Quadro 7. Panorama dos participantes do Grupo 1. 63
Quadro 8. Apresentação dos participantes do Grupo 2. 66
Quadro 9. Apresentação dos participantes do Grupo 3. 69
Quadro 10. Visão geral com os dados das entrevistas dos participantes do Grupo 2. 73
Quadro 11. Visão geral com os dados das entrevistas dos participantes do Grupo 3. 74
Quadro 12. Passo-a-passo para a realização da análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006). 76
Quadro 13. Perfil etário dos participantes com TEA com relação ao diagnóstico. 79
Quadro 14. Coocorrências ou diagnósticos diferenciais recebidos pelas pessoas com TEA. 81
Quadro 15. Nível de escolaridade por gênero dos participantes do Grupo 1. 82
Quadro 16. Nível de escolaridade por gênero dos participantes do Grupo 1. 82
Quadro 17. Perfil das organizações e da forma de trabalho do Grupo 1. 84
Quadro 18. Perfil das organizações onde trabalham participantes do Grupo 2. 84
Quadro 19. Visão geral dos subtemas do Tema 1 do Grupo 1. 95
Quadro 20. Visão geral dos Temas 2 e 3 do Grupo 1. 101
Quadro 21. Visão geral dos subtemas do Tema 4 do Grupo 1. 118
Quadro 22. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 1. 125
Quadro 23. Visão geral dos Temas 6 a 11 do Grupo 1. 135
Quadro 24. Visão geral dos Temas 1 a 4 do Grupo 2. 145
Quadro 25. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 2. 153
Quadro 26. Visão geral dos subtemas do Tema 6 do Grupo 2. 160
Quadro 27. Visão geral dos subtemas do Tema 1 do Grupo 3. 173
Quadro 28. Visão geral dos Temas 2 e 3 do Grupo 3. 181

Quadro 29. Visão geral dos subtemas do Tema 4 do Grupo 3. 188
Quadro 30. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 3. 199
Quadro 31. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao desenho do trabalho (job design). 203
Quadro 32. Visão integrada das barreiras específicas associadas à contratação. 204
Quadro 33. Visão integrada das barreiras específicas associadas à integração (onboarding). 206
Quadro 34. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao treinamento e desenvolvimento. 207
Quadro 35. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao desempenho. 208
Quadro 36. Visão integrada das barreiras específicas associadas às relações sociais e bem-estar. 209

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AFAPA	Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Alegre
CDC	*Centers for Disease Control and Prevention*
CDPD	Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa – Humanos
CID	Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
CID-9	9ª edição da CID
CID-10	10ª edição da CID
CID-11	11ª edição da CID
CIDID	Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens: um manual de classificação das consequências das doenças
CIF	Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
DSM	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais
DSM-III	3ª edição do DSM
DSM-V	5ª edição do DSM
DSM-5-TR	versão atualizada da 5ª edição do DSM-V
FADERS	Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul
FASFIL	fundações privadas e associações sem fins lucrativos
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LBI	Lei Brasileira de Inclusão
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização não governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
RH	Recursos Humanos
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TDAH	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TEA	Transtorno do Espectro Autista
TOC	Transtorno Obsessivo-Compulsivo
UPM	Universidade Presbiteriana Mackenzie

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17
2 REFERENCIAL TEÓRICO 22
2.1 Autismo ou TEA (Transtorno do Espectro Autista)? Autistas ou pessoas com TEA? 22
2.1.1 Discussões a respeito do TEA nos últimos anos 24
2.1.2 Definições na saúde: CID e DSM 26
2.1.3 Diferentes níveis do TEA 28
2.1.4 Definição de TEA de acordo com a lei brasileira 29
2.2 Neurodiversidade e pessoas com TEA 32
2.2.1 Modelos teóricos da deficiência e a origem da neurodiversidade 33
2.2.2 Compreendendo a neurodiversidade 38
2.3 Neurodiversidade no trabalho e a empregabilidade de profissionais com TEA 42
2.3.1. Neurodiversidade no trabalho 46
2.3.2. Empregabilidade de profissionais com TEA 49
2.3.3. Desafios à empregabilidade de profissionais com TEA 52
3 PERCURSO METODOLÓGICO 58
3.1 Abordagem da pesquisa 59
3.2 Estratégia de pesquisa 60
3.3 Levantamento de dados 60
3.3.1 Seleção do Grupo 1 - Participantes com TEA 61
3.3.2 Seleção do Grupo 2 - Participantes de RH e de saúde e segurança do trabalho 63
3.3.3 Seleção do Grupo 3 - Participantes das organizações e entidades sem fins lucrativos de capacitação e/ou inclusão de profissionais com TEA no mercado de trabalho 66
3.3.4 Entrevistas com participantes do Grupo 1 71
3.3.5 Entrevistas com participantes do Grupo 2 72
3.3.6 Entrevistas com participantes do Grupo 3 73
3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 74
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 77
4.1 Perfil dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 79
4.1.1 Relatos do Grupo 1 85
4.1.2 Relatos do Grupo 2 136
4.1.3 Relatos do Grupo 3 161

4.2. Visão integrada dos relatos dos Grupos 1, 2 e 3 200
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 211
REFERÊNCIAS 218
APÊNDICE I 235
APÊNDICE II 239
APÊNDICE III 243
APÊNDICE IV 247
APÊNDICE V 248
APÊNDICE VI 249
APÊNDICE VII 250
APÊNDICE VIII 251
APÊNDICE IX 252
APÊNDICE X 253

1 INTRODUÇÃO

O autismo – também referido como Transtorno do Espectro Autista ou TEA – pode ser definido, em uma abordagem clínica, como um distúrbio do neurodesenvolvimento, que apresenta como características, dentre outras, desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, além de repertório restrito de interesses e atividades (BRASIL, 2022).

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente uma em cada 100 crianças apresenta algum nível de TEA no mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2022), o que pode se traduzir em diferentes níveis de suporte necessários. Recentes dados publicados em 2023 pelo *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) norte-americano, por sua vez, revelam que uma em cada 36 crianças de até 8 anos de idade foi diagnosticada com TEA nos Estados Unidos da América, representando um acréscimo com relação aos números do CDC de 2018, que indicavam a prevalência de uma em cada 44 crianças (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2023). Constata-se, portanto, um aumento constante de pessoas diagnosticadas com TEA no mundo, principalmente em razão da ampliação das definições do espectro e a melhoria das ferramentas de diagnóstico (FEINSTEIN, 2011; MAS, 2018; AYDOS, 2019; HUGHES, 2021).

No Brasil, o indivíduo com TEA somente passou a ser legalmente reconhecido como uma pessoa com deficiência a partir da Lei Federal nº 12.764/12, também conhecida como Lei Berenice Piana (BRASIL, 2012), sendo considerado sujeito dos direitos assegurados às pessoas com deficiência em geral. No entanto, somente com a promulgação da Lei nº 13.861/19, as especificidades inerentes ao TEA passaram a ser oficialmente incluídas nos censos demográficos (BRASIL, 2019), previstos para ocorrerem de dez em dez anos, a cada início de década.

Desta forma, os dados de pessoas com deficiência divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até o momento, não consideram especificamente as pessoas com TEA (i) dentre as 46 milhões de pessoas com deficiência no país, no Censo Demográfico de 2010, e (ii) nos indicadores recomendados para avaliação de inserção de pessoas no mundo do trabalho (taxas de participação, de formalização e de desocupação de pessoas com deficiência), na última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 (BRASIL, 2022). De fato, as informações oficiais a respeito de pessoas com TEA no país começaram a ser levantadas pela

primeira vez no Censo Demográfico de 2020, inclusive no que diz respeito à sua participação no mercado de trabalho, o que contribuiria para novas políticas públicas sobre o tema (VERAS; CASTRO, 2021). Entretanto, em razão da pandemia de COVID-19 e de questões orçamentárias, o Censo Demográfico iniciou-se somente em 2022, com a estimativa de divulgação dos resultados parciais e em diferentes mídias até 2025 (BRASIL, 2023).

Diante deste cenário, esclarece-se que, no Brasil, ainda se trabalha com estimativas quanto ao número de pessoas com TEA, que indicam que cerca de 6 milhões de indivíduos no país tenham sido diagnosticados com TEA até o momento (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2023).

Há diversas implicações sociais e econômicas decorrentes do crescente número de diagnósticos de TEA, além de custos emocionais por esses indivíduos não serem capazes de participar de forma igualitária das condições de trabalho oferecidas pelos empregadores (KRZEMINSKA; HAWSE, 2020). Acredita-se que as organizações venham percebendo um aumento na procura de emprego por pessoas com TEA (PARR; HUNTER, 2014), devendo, portanto, adequarem-se a essa realidade. Como consequência, aspectos relacionados às pessoas com TEA tornam-se relevantes não apenas para as áreas médica e/ou educacional, mas também para o ambiente corporativo (ARAÚJO; DOURADO, 2022).

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a pandemia da COVID-19, que expôs e aumentou as desigualdades em todo o mundo, piorou as dificuldades já enfrentadas pelos indivíduos com TEA, em razão de práticas de contratação discriminatórias - há muito reconhecidas - e ambientes de trabalho que apresentam, em geral, grandes obstáculos para pessoas com TEA (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2022). Esse cenário contribui para os altos índices de desemprego (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021; CORREIA et al, 2024) e subemprego ou emprego precário, com baixos salários, poucos benefícios e/ou contratos de curto prazo (LINDSAY et al., 2019), de uma grande maioria de adultos com TEA, que apresentam as mais altas taxas de desemprego dentre as pessoas com deficiência (KRZEMINSKA; HAWSE, 2020).

Algumas organizações lançaram recentemente programas de neurodiversidade, com propostas para a contratação e retenção de profissionais com diagnóstico de TEA e outras condições relacionadas, geralmente chamadas de pessoas neurodivergentes (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021). Em uma abordagem social da deficiência, a classificação como neurodivergente decorre da neurodiversidade, entendida como uma variação natural de diferenças nas funções do cérebro humano (DOYLE; MCDOWALL, 2022). Apesar disso,

muitas organizações sequer consideram a neurodiversidade em suas políticas e programas relacionados a pessoas (SZULC et al., 2021) e não há evidências empíricas consistentes e válidas a respeito da neurodiversidade no trabalho (DOYLE; MCDOWALL, 2022).

Ainda, constata-se que a literatura relacionada à deficiência é esparsa nos estudos de desenvolvimento de recursos humanos (*human resource development*) e que não tem tratado dos indivíduos com TEA, um grupo com características específicas principalmente nos campos de interação social e comunicação (JOHNSON; ENNIS-COLE; BONHAMGREGORY, 2020). Pesquisadores nacionais (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; AYDOS, 2019; LEOPOLDINO; SILVA FILHO; NISSEL, 2020; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021) e internacionais (BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014; DOYLE, 2019) relatam escassez de pesquisas com foco na vida profissional de adultos com TEA e sua inclusão no mercado de trabalho.

A este respeito, verifica-se que pesquisas internacionais dedicadas ao estudo de pessoas com TEA e/ou neurodivergentes no mercado de trabalho têm revelado um foco mais restrito, geralmente em questões específicas (KHAN et al. 2022), tais como habilidades específicas destes profissionais (LINDSAY et al., 2019; KRZEMINSKA; HAWSE, 2020; JOHNSON; ENNIS-COLE; BONHAMGREGORY, 2020; SZULC et al., 2021), inclusive no contexto da utilização de tecnologias para o favorecimento da inclusão e redução de desigualdades no ambiente de trabalho (WALKOWIAK, 2021), as percepções dos demais profissionais com relação à deficiência e/ou revelação do diagnóstico de TEA no ambiente de trabalho ou durante entrevistas de emprego (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021; FLOWER; DICKENS; HEDLEY, 2021; PATTON, 2022), a implementação de programas específicos para recrutamento e seleção de pessoas com TEA em organizações (CARRERO; KRZEMINSKA; HÄRTEL, 2019), boas práticas para a inclusão dos profissionais neurodivergentes no trabalho (BRÎNZEA, 2019), ajustes físicos no local de trabalho para acomodar profissionais neurodivergentes (WEBER et al., 2022) e potenciais vantagens e desvantagens de ser uma profissional com TEA e mulher no ambiente de trabalho (NORTH, 2021).

Em âmbito nacional, além de pesquisas voltadas para as habilidades das pessoas com TEA no trabalho (LEOPOLDINO; SILVA FILHO; NISSEL, 2020; VERAS; CASTRO, 2021), outras propostas relacionam-se a práticas de gestão para estes profissionais (BASTO; CEPELLOS, 2023), ao conhecimento ou aplicabilidade pelas organizações das disposições previstas no Art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, denominada “Lei de Cotas”

(ARAÚJO; DOURADO, 2022; GARBIN et al., 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023), à mensuração e comparação da capacidade produtiva profissional de pessoas com TEA em comparação aos demais profissionais (MELICIO; VENDRAMETTO; COSTA NETO, 2021); às ações e processos que visam à inclusão de pessoas com TEA no contexto de trabalho (LEOPOLDINO; SILVA FILHO; NISSEL, 2020; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021); e às percepções dos profissionais autistas quanto à sua própria trajetória (RODRIGUES, 2023).

Dentre as escassas pesquisas que tiveram como objetivo, de alguma forma, analisar os fatores, as dificuldades, as barreiras, os desafios e/ou obstáculos relacionados, de uma forma geral, ao mercado de trabalho para pessoas com TEA ou neurodivergentes, verificam-se estudos teóricos (SCOTT at al., 2018; LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; KHAN et al., 2022), outros que analisam especificamente aspectos da transição entre os estudos acadêmicos e o ingresso no mercado de trabalho (BERKELL, 1987; MEYERS; BAGNALL, 2015; HONSBERGER et al. 2018; VINCENT, 2020; PESONEN et al., 2022; ANDERSON; STEPHENSON; CARTER, 2022; MORIÑA; BIAGIOTTI, 2022; CORDELL, 2023), a percepção do público em geral quanto a profissionais com TEA em entrevistas de emprego (FLOWER; DICKENS; HEDLEY, 2021), aspectos relacionados ao próprio empregador, como o nível de conhecimento a respeito do TEA (MCMAHON; HENRY; LINTHICUM, 2021); barreiras relacionadas ao desenvolvimento do trabalho remoto por profissionais neurodivergentes (SZULC, 2022); e aspectos facilitadores e dificultores para a inclusão do profissional com TEA de acordo com suas próprias percepções (RODRIGUES, 2023).

Em poucas publicações internacionais identificadas nas bases Google Acadêmico, *Scopus*, EBSCO e *Web of Science* e relacionadas à empregabilidade (*employability*) de pessoas com TEA, destacam-se os estudos empíricos feitos por McMahon, Henry e Linthicum (2021), que, com base em um *framework* teórico da empregabilidade (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013), pesquisaram os fatores que poderiam impactar as percepções de empregabilidade de candidatos com TEA a vagas de emprego; e por Pesonen et al. (2022), que analisam a empregabilidade de estudantes com TEA a partir de cinco áreas de capital de graduação (*graduate capital*).

Por sua vez, a busca pelos termos “empregabilidade”, “TEA”, “autismo”, “neurodiversidade”, “neurodivergentes” e “trabalho”, em português, na base de dados do Google Acadêmico e no SPELL, sem limitação de áreas e/ou tipos de trabalhos publicados, também revelou a escassez de estudos nacionais relacionados especificamente a tais palavras.

Constata-se, em geral, que a empregabilidade é abordada de forma ampla, sem uma definição precisa do conceito, em conjunto com a análise de aspectos de inserção e/ou inclusão no mercado de trabalho de profissionais com TEA (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; LEOPOLDINO; SILVA FILHO; NISSEL, 2020; MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021; VERAS; CASTRO, 2021; GARBIN et al., 2022) e/ou em estudos teóricos (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; VERAS; CASTRO, 2021; MONTEIRO et al., 2022; ARAÚJO; DOURADO, 2022).

Diante desses achados nas literaturas internacional e nacional, pretende-se, portanto, conduzir uma pesquisa considerando-se as seguintes lacunas identificadas: (i) a predominância de trabalhos teóricos a respeito do tema; (ii) a ausência de uma visão estruturada e integrada da temática, vez que os estudos identificados são esparsos e ora analisam sob a perspectiva dos profissionais com TEA, ora sob a perspectiva dos profissionais de recursos humanos (RH), separadamente; (iii) os fatores, as dificuldades, as barreiras, os desafios e/ou obstáculos para a inclusão e/ou inserção no ambiente de trabalho dos profissionais com TEA no Brasil são apresentados de maneira segregada, esparsa ou apenas mencionados na introdução de artigos e/ou no referencial teórico, sem que haja uma discussão aprofundada a respeito da empregabilidade de pessoas com TEA; e (iv) a análise da deficiência a partir de conceitos relacionados ao modelo médico da deficiência, como indicado por grande parte dos estudos.

À luz do que foi exposto, pretende-se responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais com TEA (Grupo 1), dos profissionais de RH e de gestão de pessoas (Grupo 2) e dos profissionais de entidades e instituições sem fins lucrativos que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho (Grupo 3)?

Define-se o objetivo geral desta pesquisa como entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos profissionais do Grupo 1, dos profissionais do Grupo 2 e dos profissionais do Grupo 3. Os objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: (i) para o Grupo 1: (i.a) entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais do Grupo 1; e (i.b) identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais do Grupo 1 a respeito de sua empregabilidade; (ii) para o Grupo 2: (ii.a) analisar como são estruturados os programas de neurodiversidade voltados para profissionais com TEA em organizações, na visão dos profissionais do Grupo 2; e (ii.b) entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais do Grupo 2; e (iii) para o Grupo 3: (iii.a) analisar como são estruturados os

programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho, na visão dos profissionais do Grupo 3; e (iii.b) entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais do Grupo 3.

Para tanto, essa pesquisa é estruturada de forma a apresentar, inicialmente, as discussões a respeito do TEA ao longo da história, suas recentes classificações para fins de diagnóstico e as principais definições legais no Brasil, buscando a definição de termos que serão utilizados para a pesquisa. Após alguns apontamentos a respeito da neurodiversidade e do movimento social da deficiência, passa-se a discutir questões inerentes aos desafios à empregabilidade dos profissionais TEA em organizações brasileiras.

Ao final, por meio do percurso metodológico adotado para a condução da pesquisa proposta, foi apresentada a visão integrada dos desafios enfrentados por profissionais com TEA com relação à sua própria empregabilidade, a partir do modelo social da deficiência, da neurodiversidade e das disposições constantes da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AUTISMO OU TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)? AUTISTAS OU PESSOAS COM TEA?

Nos últimos 50 anos, em termos clínicos, o autismo passou de um distúrbio de início na infância, raro e estritamente definido, para o TEA, uma condição vitalícia bem divulgada, defendida e pesquisada, reconhecida como bastante comum e muito heterogênea (LORD et al., 2018).

A descrição das principais características clínicas do autismo como sendo déficits de comunicação social e comportamentos sensório-motores repetitivos e incomuns não mudou substancialmente desde sua delineação original. No entanto, o autismo agora é visto como um espectro (LORD et al., 2018), sendo denominado atualmente como TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Dentro do espectro, as habilidades e as necessidades de apoio para pessoas com TEA podem variar. Enquanto algumas pessoas necessitam de cuidados e apoio para toda a vida, outras podem viver de forma independente, realizar as atividades da vida diária e se inserir no ambiente de trabalho (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2022).

Apesar da possibilidade de detectar as características desde a primeira infância, percebe-se que o TEA tem sido diagnosticado muitos anos depois, até mesmo na idade adulta com diagnósticos tardios (NALIN et al., 2022; ROCHA et al., 2023), sendo determinado com base em critérios de comportamento (KRZEMINSKA; HAWSE, 2020) e mediante a aplicação de diversos instrumentos de triagem, avaliação e diagnóstico por profissionais da área da saúde. Ainda, são utilizadas as definições de autismo e TEA constantes da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), publicada pela OMS, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DSM), elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) (MAS, 2018).

Como explicam Ronzani et al. (2021), cada pessoa com TEA é única e terá necessidades de apoio específicas à sua situação em particular. Adicionalmente, em termos clínicos, uma pessoa com TEA pode apresentar diferentes graus de desenvolvimento cognitivo, oscilando desde a deficiência intelectual grave até a superdotação. Ronzani et al. (2021) esclarecem que ainda não foi definida pela literatura médica uma causa única para o TEA. Destaca-se também que outras condições psiquiátricas, denominadas “coocorrências”, ou de saúde, entendidas como “comorbidades”, poderão ocorrer de forma concomitante ao TEA (KAPLAN et al., 2006; PEHLIVANIDIS et al., 2020).

Apesar de afetar pessoas independentemente do seu gênero, em geral, meninas e mulheres são diagnosticadas mais tardiamente (SOARES et al., 2023; ORRÚ, 2024), em comparação a meninos e homens (GREEN et al., 2019). Acredita-se que tal fato decorre do crescente reconhecimento de diferenças das manifestações de TEA entre os gêneros, e de diagnóstico, tratamento e resultados (GREEN et al., 2019), a existência de estereótipos preestabelecidos socialmente com relação a mulheres (SOARES et al., 2023) e a utilização de camuflagem, mascaramento e outras estratégias de compensação por mulheres de forma geral (PRICE, 2024). Especificamente no ambiente de trabalho, da mesma forma, há evidências na literatura de que mulheres com TEA tenderiam a camuflar suas reais condições para promover sua aceitação e inclusão, pelo simples fato de serem mulheres e pessoas com TEA (NORTH, 2021).

Portanto, para fins desta pesquisa, entende-se como relevantes as discussões a respeito da classificação médica e diagnóstico do TEA durante as últimas décadas por alguns motivos, sendo eles: (i) a definição de conceitos que serão utilizados ao longo do presente trabalho; (ii) a justificativa para não utilização de certos termos que, apesar de ainda constarem das classificações nosológicas, não estão em linha com os entendimentos mais recentes sobre o

assunto, de acordo com o modelo social da deficiência e a neurodiversidade; (iii) a compreensão do sentimento geral expresso por diversos profissionais da saúde e estudiosos de que a denominada "epidemia" de TEA (PARR; HUNTER, 2014) é devida principalmente à ampliação das definições do espectro e à melhoria das ferramentas de diagnóstico (FEINSTEIN, 2011; MAS, 2018; AYDOS, 2019; HUGHES, 2021); e (iv) como tais discussões poderão potencialmente ter relação com aspectos da empregabilidade de profissionais com TEA, vez que muitos dos estudos analisados para fins desta pesquisa não identificam de forma clara quais critérios de classificação de TEA ou modelos teóricos da deficiência foram considerados para as investigações conduzidas pelos respectivos autores.

2.1.1 Discussões a respeito do TEA nos últimos anos

Em virtude da evolução das pesquisas e de diferentes pesquisadores que se dedicaram ao seu estudo ao longo da história, o TEA foi conhecido por diferentes denominações médicas, como transtorno ou distúrbio autístico, autismo da infância, autismo infantil, psicopatia autística e autismo infantil precoce (TAMANAHA; PERISSINOTO; CHIARI, 2008; VERAS; CASTRO, 2021), entre outros.

Apesar de haver alguma controvérsia a respeito de quem teria de fato utilizado a palavra "autismo" pela primeira vez na história e até mesmo alegações de um suposto plágio (FEINSTEIN, 2011), sua criação tem sido atribuída a Leo Kanner, psiquiatra infantil na Universidade Johns Hopkins, em 1943, que utilizou como base um termo grego (*autos*), cujo significado é "próprio", com a finalidade de descrever um conjunto de comportamentos específicos que observou em seu trabalho pioneiro com onze crianças (OZONOFF; DAWSON; MCPARTLAND, 2020).

Mesmo sendo capazes de realizar comunicação verbal, Kanner observou que os participantes do seu estudo raramente utilizavam a fala e apresentavam dificuldades de aprendizagem e comportamentos não esperados (OZONOFF; DAWSON; MCPARTLAND, 2020). Com base nesses achados, por muitos anos, o autismo passou a ser um diagnóstico indicado apenas para crianças que se comportavam como aquelas que foram inicialmente observadas por Leo Kanner, sendo denominado, portanto, de autismo infantil ou Distúrbio Autístico do Contato Afetivo.

Na Europa, outro nome relevante para o avanço nas pesquisas sobre o autismo é o de Hans Asperger. Há indícios na literatura de que o médico austríaco teria sido, de fato, o primeiro a estudar a temática, a tratar pacientes com os sinais descritos e a utilizar a palavra "autismo"

em discursos e apresentações, na Áustria, em meados da década de 1930, antes mesmo da publicação de Leo Kanner (FEINSTEIN, 2011). De todo modo, foi em uma publicação em um jornal austríaco, em 1944, que Hans Asperger descreveu o distúrbio caracterizado por "transtorno severo na interação social, uso pedante da fala, desajeitamento motor e incidência apenas no sexo masculino", denominando-o à época de Psicopatia Autística (TAMANAHA; PERISSINOTO; CHIARI, 2008; FEINSTEIN, 2011).

O tema do autismo continuou sendo debatido por diversos profissionais da saúde nos próximos anos, em diferentes países. Destaca-se que, entre as décadas de 1940 a 1960, houve a predominância de concepções da psicanálise a respeito do autismo. A partir de então, os estudiosos passaram a analisar outras explicações de naturezas orgânica e biológica do indivíduo (ORTEGA, 2009). Essa mudança reflete o "deslocamento das concepções psicanalíticas sobre o autismo para o predomínio de uma concepção biológica e cerebral do transtorno" (AYDOS, 2019, p. 100).

A partir de 1978, Lorna Wing e Judith Gould iniciaram estudos envolvendo um grupo de crianças inglesas e notaram que os indivíduos da amostra tinham prejuízos em sua capacidade de reciprocidade, interação social e comprometimento da comunicação e da imaginação, resultando esta última em um padrão restrito e repetitivo de atividades. As pesquisadoras denominaram esse conjunto de características como *Triad of Impairments*, em uma tradução livre para o português - Tríade das Incapacidades, conforme sugerido por Mas (2018). Perceberam, ainda, que muitas outras crianças apresentavam sinais da Tríade das Incapacidades, mas não necessariamente se encaixavam nas descrições restritivas de autismo propostas por Kanner (FEINSTEIN, 2011).

Lorna Wing e Judith Gould também constataram que não havia limites claros entre o que denominaram de autismo típico, autismo atípico e o que classificaram como Tríade das Incapacidades. Ainda, algumas pessoas apresentavam retardo mental profundo, enquanto outras estavam situadas nos parâmetros regulares de medida de inteligência, dentre as quais algumas se enquadravam na descrição proposta por Asperger (FEINSTEIN, 2011). Iniciaram-se, assim, as proposições iniciais para a existência de um "espectro" ou, como sugerido inicialmente por Lorna Wing, um "*continuum*" do autismo.

Em 1981, Lorna Wing criou o termo "Síndrome de Asperger", com base no trabalho de Hans Asperger. Neste momento, apesar da classificação desta síndrome ainda não constar oficialmente dos manuais oficiais para classificação nosológica, houve um consenso de que as características essenciais do autismo eram o prejuízo na vida social, o atraso ou desvio de

linguagem (comunicação) e o comportamento repetitivo, estereotipado ou ritualístico. No entanto, a diferença, de acordo com a proposição de Lorna Wing e Judith Gould, era a de que esses aspectos poderiam ocorrer de forma variada, com a necessidade de diferentes graus de apoio e com manifestações distintas (FEINSTEIN, 2011).

Há críticas, contudo, como as apresentadas por Steve Silberman, de que as definições propostas por Kanner e Asperger representaram estigma e motivo de embaraço aos indivíduos com TEA, direcionando as pesquisas nos anos que sucederam seus respectivos trabalhos para o "caminho errado" (FARRELL-BANKS, 2018).

De todo modo, a literatura indica que as discussões relacionadas ao TEA não estão encerradas e tendem a continuar pelos próximos anos na comunidade científica (FEINSTEIN, 2011), com o surgimento de novas teorias, como as propostas por Simon Baron-Cohen (FARRELL-BANKS, 2018) e do movimento da neurodiversidade.

2.1.2 Definições na saúde: CID e DSM

Apesar de críticas, como uma artificialidade na descrição proposta para a classificação (FEINSTEIN, 2011), em uma visão clínica, os critérios utilizados como base para o diagnóstico e as próprias definições do autismo (ora mais restritivas, ora mais amplas) sofreram alterações ao longo do tempo, sendo previstos em diferentes manuais de categorização nosológica (FERNANDES; TOMAZELLIB; GIRIANELLIC, 2020).

A partir da década de 1980, os manuais mais conhecidos passaram a ser a CID, publicada pela OMS, e o DSM, elaborado pela APA (MAS, 2018). Conforme explicam Fernandes, Tomazellib e Girianellic (2020), apesar de diferenças com relação a nomenclaturas, características e códigos utilizados para fins de diagnóstico, a CID e o DSM apresentam semelhanças quanto a pressupostos conceituais vigentes na época das respectivas publicações.

Com relação especificamente ao autismo, em 1979, a OMS o reconheceu oficialmente, pela primeira vez, com a publicação da 9ª edição da CID (CID-9). O documento fez referências a “autismo infantil” (como proposto por Kanner) e excluía explicitamente a esquizofrenia infantil. A CID-9 também incluiu a condição descrita por Hans Asperger - embora seu nome não conste ainda expressamente como uma classificação para fins de diagnóstico (FEINSTEIN, 2011).

Em 1980, a terceira edição do DSM (DSM-III) introduziu, também pela primeira vez, o termo “distúrbio invasivo do desenvolvimento” para uma categoria geral, que incluía autismo

e condições relacionadas, tendo como subgrupo o “autismo infantil”, definido por cinco fatores (FEINSTEIN, 2011).

Em 1991, foi realizada a tradução oficial do trabalho de Hans Asperger, de modo que, no ano seguinte, a Síndrome de Asperger foi oficialmente adotada pela OMS, na 10ª edição da CID (CID-10). Na sequência, em 1994, o assunto foi tratado pela APA, na 4ª edição do DSM (DSM-IV) (FEINSTEIN, 2011).

A classificação TEA somente é encontrada no DSM-V, publicado em 2013 (e não na CID-10), que entende o autismo dentro de um espectro (FERNANDES; TOMAZELLIB; GIRIANELLIC, 2020), variando de acordo com o nível de apoio necessário para cada indivíduo. A Síndrome de Asperger, apesar de constar como uma classificação própria na CID10, deixou de existir no DSM-V, sendo consolidada no conceito de TEA (LORD et al., 2018).

De acordo com o DSM-V, em sua 5ª edição atualizada (DSM-5-TR), o diagnóstico de TEA poderá estar acompanhado de outras condições, tanto genéticas (como a Síndrome do X frágil) quanto psiquiátricas (como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade – ou TDAH) (LORD et al., 2018).

Ressalta-se que o TEA também constou da 11ª edição da CID (CID-11) (VERAS; CASTRO, 2021), já aprovada pela OMS e vigente a partir de 01 de janeiro 2022 (RIO GRANDE DO SUL, 2022), compreendendo o autismo dentro de um espectro (FERNANDES; TOMAZELLIB; GIRIANELLIC, 2020). No Brasil, foi estabelecido, entretanto, um período de transição da CID-10 para a CID-11, o que deverá compreender entre dois e três anos a partir de sua entrada em vigor em 2022, de modo que as autoridades brasileiras acreditam que estará em uso nos sistemas de informação da vigilância nacionais a partir de 1º de janeiro de 2025 (BRASIL, 2022). Desta forma, não foi considerada esta versão da classificação para fins desta pesquisa.

No país, portanto, os profissionais de saúde ainda adotam a CID, que pode ser usada para estatísticas de morbidade e de mortalidade, sistemas de reembolso e de decisões automáticas de suporte em medicina; e o DSM, utilizado para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais e com objetivos que visam ao auxílio das decisões sobre as melhores aplicações dos recursos financeiros com base em dados estatísticos (MAS, 2018).

Ainda, como destacado por Di Nubila e Buchalla (2008), no país, grande parte da legislação relacionada à concessão de benefícios a pessoas com deficiência, dentre as quais as pessoas com TEA, exige a apresentação de laudo médico com a indicação dos códigos da CID.

Considerando as classificações nosológicas descritas neste item, propõe-se o Quadro 1, com o resumo das principais características da CID e do DSM no Brasil a respeito do TEA:

Quadro 1. Principais características da CID e do DSM no Brasil a respeito do TEA.

CID (elaborado pela OMS)	**DSM** (elaborado pela APA)
Mais utilizado para estatísticas de morbidade e de mortalidade, sistemas de reembolso e de decisões automáticas de suporte em medicina (MAS, 2018).	Mais utilizado para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais e com objetivos que visam ao auxílio das decisões sobre as melhores aplicações dos recursos financeiros com base em dados estatísticos (MAS, 2018).
Grande parte da legislação relacionada à concessão de benefícios a pessoas com deficiência (dentre as quais pessoas com TEA), exige a apresentação de laudo médico com a indicação dos códigos CID (DI NUBILA; BUCHALLA, 2008).	Apresenta critérios para diagnóstico por meio de especificadores que podem levar a uma descrição mais detalhada dos indivíduos analisados e indicar o nível de gravidade dos sintomas (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2023).
A CID-10 inclui o autismo dentre os transtornos globais do desenvolvimento (F84), com as subclassificações autismo infantil (F84.0), autismo atípico (F84.1), Síndrome de Rett (F84.2), Outro transtorno desintegrativo da infância (F84.3), Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados (F84.4), Síndrome de Asperger (F84.5), Outros transtornos globais do desenvolvimento (F84.8) e Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (F84.9) (BRASIL, 2008).	O DSM-5-TR atualmente indica o Transtorno do Espectro Autista dentre os transtornos do neurodesenvolvimento (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2023). Segundo o DSM-5-TR, as características essenciais do TEA são: (i) prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social (denominado "Critério A") e (ii) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (denominado "Critério B"). De acordo com o manual, esses aspectos devem estar presentes desde o início da infância e limitar ou prejudicar o funcionamento diário do indivíduo (denominados "Critérios C e D") (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2023).

Fonte: Elaborado pela autora.

2.1.3 Diferentes níveis do TEA

O DSM-5-TR propõe a classificação clínica do TEA em diferentes níveis, de acordo com o nível de suporte necessário para cada caso. Para esclarecimentos, com base em Fernandes, Tomazellib e Girianellic (2020), descreve-se no Quadro 2 os níveis do TEA previstos no DSM-5-TR:

Quadro 2. Níveis de suporte do TEA, segundo o DSM-5-TR.

Nível I	Na ausência de apoio ao indivíduo com TEA, há prejuízo social notável, dificuldades para iniciar interações, por vezes parecem apresentar um interesse reduzido por estas, há tentativas malsucedidas no contato social, além da dificuldade de organização, planejamento e certa inflexibilidade de comportamentos.
Nível II (continua)	O indivíduo com TEA exige apoio substancial, havendo prejuízos sociais aparentes, limitações para iniciar e manter interações, inflexibilidade de

(continuação)	comportamento e dificuldade para lidar com mudanças.
Nível III	O indivíduo com TEA exige muito apoio substancial, havendo déficits graves nas habilidades de comunicação social, inflexibilidade de comportamento e extrema dificuldade com mudanças.

Fonte: Elaborado pela autora.

Ronzani et al. (2021) esclarecem que o TEA e o déficit intelectual, apesar de poderem coexistir em um mesmo indivíduo, são condições distintas. Podem apresentar, contudo, alguns aspectos em comum, como o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldades na linguagem e aspectos genéticos. Esse cenário pode interferir na identificação e diferenciação entre o TEA propriamente dito (em especial, nos níveis II e III) e a deficiência intelectual.

Ressalta-se, ainda, que, para indivíduos com o nível I de suporte, como indicado no Quadro 2, passou-se a utilizar a denominação de TEA/Autismo de Alto Desempenho e/ou TEA/Autismo de Alta Funcionalidade, que, embora definido de diferentes formas na literatura, representa a ideia de que o indivíduo apresenta "inteligência normal e um domínio da linguagem relativamente bom", apesar de comportamentos incomuns (OZONOFF, DAWSON, MCPARTLAND, 2020).

Destaca-se, contudo, o aumento nas críticas da recente literatura especializada quanto à aplicação dos termos TEA/Autismo de Alto Desempenho e/ou TEA/Autismo de Alta Funcionalidade, por serem considerados, individualmente, descritores clínicos imprecisos, ao se basearem somente em pontuações do quociente de inteligência, não levando em conta, portanto, outras habilidades funcionais consideradas quando do diagnóstico do TEA (particularmente para aqueles sem deficiência intelectual) (ALVARES et al., 2020). O argumento tem sido apoiado por grande parte da comunidade de pessoas com TEA, de modo que não será aplicado na presente pesquisa.

2.1.4 Definição de TEA de acordo com a lei brasileira

Neste tópico, não se pretende apresentar de forma exaustiva toda a legislação nacional e as obrigações assumidas pelo país em âmbito internacional, por meio de tratados, convenções e cartas, relacionadas ao TEA e/ou às pessoas com deficiência, mas tão somente selecionar aspectos que poderão ser relevantes para fins de definição de conceitos para a presente pesquisa.

Em virtude de movimentos sociais em defesa dos direitos de pessoas com TEA (MONTEIRO et al., 2022), foi promulgada no país a Lei Federal nº 12.764/12, também

conhecida como Lei Berenice Piana, que determina que o indivíduo com TEA deve ser reconhecido como uma pessoa com deficiência e, portanto, titular de garantias e proteções previstas às pessoas com deficiência em geral, como aquelas estabelecidas na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) (VERAS; CASTRO, 2021; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022), ratificada por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

O TEA, de acordo com as orientações para fins de cumprimento da Lei de Cotas (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2018), é considerado como uma deficiência mental ou psicossocial.

Já o conceito legal de "pessoa com deficiência" no Brasil está previsto no Art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, ou LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), que reflete a disposição da CDPD e o modelo biopsicossocial da deficiência (FOGAÇA; KLAZURA, 2021), como será discutido adiante neste trabalho:

> Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A LBI apresenta as diretrizes básicas para a promoção da inclusão, esclarece quanto à natureza de cada deficiência e prevê a garantia de acesso à formação, trabalho e renda de pessoas com deficiência, dentre as quais se encontram os indivíduos com TEA (ARAÚJO; DOURADO, 2022; MONTEIRO et al., 2022).

A definição legal de "pessoa com TEA" está, por sua vez, prevista no Art. 1º, §1º da Lei Federal nº 12.764/12 (BRASIL, 2012):

> Art. 1º, §1º. Para os efeitos desta Lei, e considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:
>
> I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
>
> II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Adicionalmente, conforme proposto pelo Art. 2º da referida lei, foi criada uma Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que "abrange diagnóstico e intervenção terapêutica precoce, ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), educação inclusiva, proteção social e inserção profissional em igualdade de condições" (MONTEIRO et al., 2022, p. 9).

Diante da legislação apresentada neste item, apresenta-se o Quadro 3 com um resumo das principais leis, normas e definições legais aplicáveis às pessoas com TEA no Brasil:

Quadro 3. Principais leis, normas e definições legais aplicáveis às pessoas com TEA no Brasil.

Principais leis	Principais definições legais
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008	Ratifica a CDPD, tornando suas disposições aplicáveis no Brasil.
Lei Federal nº 12.764/12 (Lei Berenice Piana)	Define a pessoa com TEA como sendo uma pessoa com deficiência. Caracteriza o TEA como uma deficiência relacionada à comunicação e à interação social.
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão, ou LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência)	Reflete a disposição da CDPD e o modelo biopsicossocial da deficiência (FOGAÇA; KLAZURA, 2021). Determina as diretrizes básicas para a promoção da inclusão e prevê a garantia de acesso à formação, trabalho e renda de pessoas com deficiência, dentre as quais se encontram os indivíduos com TEA. Define o conceito de pessoa com deficiência para fins legais.
"Orientações para fins de cumprimento da Lei de Cotas" do Ministério do Trabalho e Emprego	TEA como deficiência mental ou psicossocial.

Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar das definições legais, destaca-se a existência de uma recente discussão na literatura, em especial em países de origem anglo-saxã, a respeito da utilização da linguagem mais apropriada e respeitosa para referências a pessoas com deficiência, em especial no que diz respeito ao TEA (TABOAS; DOEPKE; ZIMMERMAN, 2023; BUIJSMAN; BEGEER; SCHEEREN, 2023; BURY et al., 2023; KEATING et al., 2023). São elas: (i) a *identity-first language*, que coloca a identidade da pessoa em primeiro lugar e, portanto, abraça a deficiência como sendo parte da própria pessoa (em português, o "autista"); e (ii) a *person-first language*, que dá ênfase ao indivíduo ao invés do transtorno ou da deficiência e promove, portanto, o uso de termos, em português, como "pessoa com TEA".

Taboas, Doepke e Zimmerman (2023) explicam, ainda, que, segundo estudos realizados no Reino Unido e na Austrália, diferentes grupos de pessoas envolvidas com o TEA aceitam ambas as terminologias como corretas, dependendo do contexto. Especificamente na

pesquisa conduzida por Taboas, Doepke e Zimmerman (2023), os dados revelaram que: (i) os profissionais que trabalham com assuntos relacionados ao TEA preferem a utilização do termo “pessoa com TEA”; enquanto (ii) os adultos com TEA preferiam o termo “autista”.

Desta forma, considerando a classificação clínica mais recente proposta nos manuais (CID e DSM), as definições na legislação brasileira e os achados de Taboas, Doepke e Zimmerman (2023), o presente trabalho utilizará os termos “TEA”, “transtorno do espectro autista”, “pessoa com deficiência”, “pessoa com TEA”, “profissional com TEA” ou “indivíduo com TEA”, mantendo referências a “autismo”, “autista” ou “Asperger” somente quando houver citações específicas de autores e pesquisadores que assim o fizeram, quando forem utilizados pelos participantes deste estudo ou quando o contexto assim exigir, como nos estudos que trataram de indivíduos com a Síndrome de Asperger (enquanto a classificação ainda estava em discussão e/ou vigente na literatura).

Adicionalmente, nota-se que, de um lado, a definição de critérios nosológicos para o TEA e o seu reconhecimento como uma deficiência, para todos os fins legais, resultou na garantia de direitos e de acesso a políticas específicas aos indivíduos com TEA, inclusive relacionados ao ambiente de trabalho. Por outro lado, no entanto, alguns autores passaram a refletir acerca de outras consequências para o indivíduo com TEA, em um contexto mais amplo de discussões a respeito do diagnóstico do TEA e da neurodiversidade.

A este respeito, pode-se entender que a abordagem meramente clínica e a formalização do TEA legalmente como uma deficiência também poderão levar à incorporação de alguns estigmas associados ao TEA e ao senso comum a respeito de deficiências em geral, como os da incapacidade e da dependência (AYDOS, 2019).

Questões relacionadas a outras concepções da deficiência e da própria neurodiversidade poderão ter relação com a empregabilidade de pessoas com TEA e, portanto, serão discutidas nesta pesquisa.

2.2 NEURODIVERSIDADE E PESSOAS COM TEA

O TEA tem sido tradicionalmente classificado, em termos clínicos, como um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades na comunicação social e repertório restritivo de comportamentos e atividades.

Nos últimos anos, houve também a definição, na legislação nacional, da pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência, em linha com abordagens contemporâneas da

deficiência, que serão apresentadas neste trabalho, e a LBI, apoiada no modelo biopsicossocial (FOGAÇA; KLAZURA, 2021), que deverá servir de base para as políticas públicas nacionais nos próximos anos.

Contudo, apesar desses avanços, os direitos assegurados às pessoas com deficiência no país ainda são baseados majoritariamente em um laudo médico (BRASIL, 2023) e no código da CID indicado, demonstrando até o momento uma aparente prevalência do modelo médico para essa finalidade, como verificado por Doyle e McDowall em outras nações (2022). No Estado de São Paulo, por exemplo, a recente Lei Estadual nº 17.669, de 06 de abril de 2023, determinou que o laudo médico pericial que ateste o TEA passará a ter prazo de validade indeterminado e poderá ser emitido por profissional da rede de saúde pública ou privada (SÃO PAULO, 2023).

Em âmbito nacional, segundo o Decreto Federal nº 11.487, de 10 de abril de 2023, um novo grupo de trabalho para fins de avaliação biopsicossocial unificada da deficiência foi instituído no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (BRASIL, 2023). A proposta é a migração para uma avaliação multiprofissional e interdisciplinar a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), um modelo da OMS (BRASIL, 2023) representativo do modelo biopsicossocial.

Além disso, recentemente tem crescido o movimento social para que o TEA seja efetivamente reconhecido como parte da neurodiversidade (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021), ao invés de um distúrbio, tornando a neurodiversidade um conceito central nos debates a respeito dos direitos e interesses de pessoas com TEA (HUGHES, 2021).

No país, relatam-se ainda poucos estudos a respeito da neurodiversidade, sendo que, da amostra identificada e analisada por Sadzinski Junior, Wayszceyk e Wuo (2020), constatam-se: (i) a predominância da utilização do modelo social da deficiência e da visão biológica do autismo; (ii) a interpretação da neurodiversidade como consequência da diversidade humana; (iii) o destaque para aspectos positivos das particularidades do TEA para o indivíduo; e (iv) a ausência de aspectos relacionados ao processo histórico e atual do movimento da neurodiversidade em território nacional.

2.2.1 Modelos teóricos da deficiência e a origem da neurodiversidade

A origem das discussões a respeito da neurodiversidade está relacionada aos denominados “estudos da deficiência”, iniciados ao final da década de 1970 em países de língua

inglesa, coincidindo com outros movimentos em andamento à época, como o antipsiquiátrico, a organização do feminismo e as ações relacionadas à raça (ORTEGA, 2009).

A criação do termo "neurodiversidade" é usualmente creditada a Judith Singer, socióloga, filha e mãe de mulheres com TEA, que, em 1999, descreveu uma política de "diversidade neurológica" ou "neurodiversidade".

Para Rosqvist, Stenning e Chown (2020), tal política surge como parte da justiça social, que reconhece desigualdades de poder entre as pessoas situadas de forma diferente em termos neurológicos, em comparação às estratificações sociais existentes na sociedade. Logo, as pessoas neurologicamente diferentes representariam um acréscimo às categorias de classe, gênero e raça (HUGHES, 2021).

De acordo com a literatura, há diversos modelos propostos para a análise da deficiência ao longo dos anos. Contudo, para fins desta pesquisa, destaca-se que as deficiências são analisadas, predominantemente, em linha com três principais modelos teóricos: (i) o modelo médico (ou biomédico), que ainda prevalece e é compreendido em, ao menos, dois níveis – (i.a) ideológico, que enxerga a deficiência como um "modelo de tragédia pessoal" (CHAPMAN, 2020); e (i.b) teórico, que vê a incapacidade como uma patologia, um distúrbio, uma doença ou uma lesão que requer, portanto, tratamento e reabilitação (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021); (ii) o modelo social, que percebe e interpreta a deficiência como uma construção social, criada, principalmente, pelo ambiente no qual a pessoa vive (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021); e (iii) o modelo biopsicossocial, de acordo com o qual questões como funcionalidade e incapacidade dependeriam da interação de diferentes fatores, de naturezas biológica, psicológica e social, que determinam a atividade e a participação de cada indivíduo (MARTINS; BORGES, 2012).

A seguir, serão apresentadas as principais características dos três modelos teóricos da deficiência selecionados.

Em linhas gerais, o modelo médico interpreta a deficiência como algo orgânico e uma resposta do corpo humano a alguma doença e/ou lesão, que pode levar a determinadas incapacidades, como as físicas (FRANÇA, 2013). Partindo-se desse pressuposto, portanto, a deficiência deveria ser sanada e/ou corrigida por meio de intervenções clínicas sobre o corpo humano, com a finalidade de aprimorar o seu funcionamento e, se aplicável, reduzir as desvantagens experimentadas no ambiente social (FRANÇA, 2013).

De acordo com Martins e Borges (2012), a ênfase do modelo médico é dada, portanto, à deficiência como uma característica do indivíduo, que deve ser submetido à reabilitação para

sua plena recuperação. As políticas públicas, nesta perspectiva, têm como finalidade os cuidados à saúde enquanto cura e ausência da doença. A terminologia utilizada, já em desuso, reforçava aspectos negativos da deficiência, tais como “defeituoso”, “aleijado”, “portador de deficiência”, “portador de necessidades especiais”, “excepcional”, “especial”, “imperfeito”, “inválido”, “anormal”, entre outras apontadas por Martins e Borges (2012).

França (2013) explica, ainda, que a proposta do modelo médico da deficiência foi formalizada por meio da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens: um manual de classificação das consequências das doenças (CIDID), instrumento complementar à CID.

A CIDID, criada em 1976, tinha o objetivo de apresentar uma classificação das condições consideradas crônicas de saúde, apresentando, como revela França (2013), as seguintes definições específicas, traduzidas para o português como sugerido por Sassaki (2005): (i) *impairment*, como “impedimento, limitação, perda ou anormalidade”; (ii) *disability*, como a deficiência propriamente dita; e (iii) *handicap*, como uma incapacidade, que não deve ser confundido com o conceito de deficiência, pois denota um estado negativo de funcionamento da pessoa (SASSAKI, 2005). Atualmente, o documento não é mais utilizado, tendo sido substituído pela CIF, promovida pela OMS (FRANÇA, 2013).

No que diz respeito ao modelo social da deficiência, segundo Ortega (2009), suas bases encontram-se no texto seminal *Fundamental Principles of Disability*, publicado, em 1975, pela *Union of the Physical Impaired Against Segregation*, com destaque para a divisão entre os conceitos de *impairment* e *disability*, com as respectivas traduções para o português mencionadas no parágrafo anterior.

O modelo social propõe interpretar a deficiência não como uma “tragédia pessoal”, como explicado por Chapman (2020), mas como fruto da cultura e da sociedade na qual o indivíduo está inserido, que considera determinadas características como problemáticas ou desvantajosas (ORTEGA, 2009).

No modelo social da deficiência, portanto, busca-se a abordagem de fatores ambientais que levam à desigualdade, exclusão e segregação das pessoas com deficiência (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021), contrapondo-se ao modelo médico hegemônico, que enfatiza o diagnóstico e interpreta o indivíduo com deficiência como alguém dependente (ORTEGA, 2009).

Apesar de uma preferência declarada por Chapman (2020) acerca deste modelo social com relação ao modelo médico ao se tratar da deficiência em geral, o autor aponta algumas

questões no que diz respeito à aplicação do modelo social à neurodiversidade e, em especial, o paradigma da neurodiversidade, que será tratado em tópico específico a seguir.

Para Chapman (2020), essas questões estariam prioritariamente relacionadas ao próprio conceito de *impairment* (perda ou impedimento), que poderia ser conflitante com a noção de que a neurodiversidade seria a regra. Nesta perspectiva, para ser considerado *impaired* (impedido) de alguma forma, o indivíduo deveria ser considerado incapacitado com relação a algo que não seria, de fato, *unimpaired* (não impedido).

Em termos práticos, assim, para Chapman (2020), o modelo social não rejeitaria totalmente a premissa de que haveria uma "norma padrão" para a espécie humana, mas apresentaria uma proposição diferente, no sentido de que as regras sociais seriam mais relevantes para a *disability* (deficiência) do que o *impairment* (impedimento) do indivíduo propriamente dito.

Martins e Borges (2012), por sua vez, avaliam os modelos médico e social como antagônicos, no que diz respeito à abordagem da deficiência. Também no contexto da neurodiversidade, Chapman (2020) explica que os debates entre os dois modelos (médico e social) têm ocorrido em uma esfera mais ideológica, de modo que há aqueles que defendem a neurodiversidade e consideram as representações "trágicas" da deficiência cognitiva como desumanas; e há críticos da perspectiva da neurodiversidade, que sugerem que esta pode levar à ignorância das duras realidades vividas por pessoas com alguma deficiência cognitiva.

Para Chapman (2020), ainda, o modelo médico, em geral, não seria adequado para enquadrar a deficiência cognitiva de forma precisa, por ser incapaz de fornecer um relato objetivo de função e disfunção, levando, na visão do autor, à identificação indevida de patologias. Já o modelo social, para Chapman (2020), também seria insatisfatório, ao se prender a duas posições, na sua visão, insustentáveis: negação de dificuldades reais enfrentadas pelo indivíduo na sociedade; e/ou a adesão, ainda que implícita, a uma norma padrão que seria insustentável para a espécie humana (a de que a diversidade seria a regra).

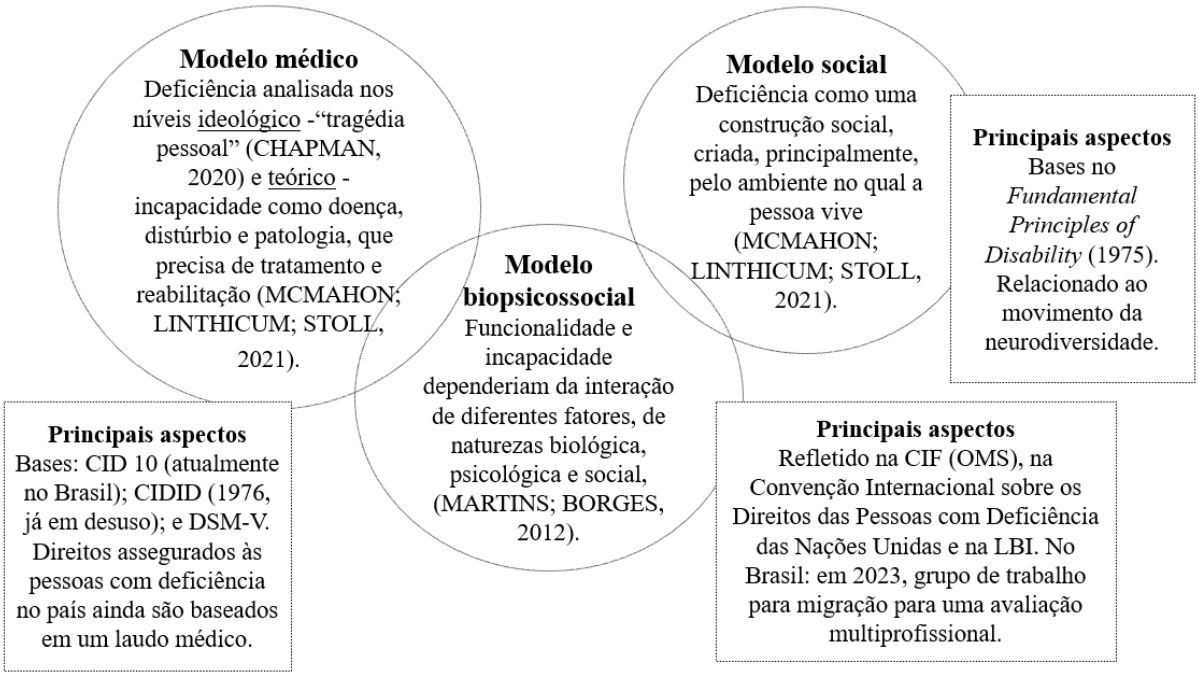
Essa dicotomia entre os modelos médico e social e as limitações de ambos levaram à proposição de um terceiro modelo, denominado biopsicossocial, que analisa a deficiência sob três visões distintas da saúde: biológica, individual e social; e em três diferentes dimensões: física, psicológica e social (MARTINS; BORGES, 2012). Logo, uma alteração poderia se manifestar em um ou mais níveis analisados (físico, psicológico e/ou social), mas sem necessariamente comprometer os demais (MARTINS; BORGES, 2012). Uma das principais alterações é o enfoque em componentes da saúde do indivíduo, e não na doença.

O modelo biopsicossocial é refletido na CIF, tendo uma aplicação universal, não voltada apenas para deficiências, além de tratar das funcionalidades de forma neutra, ou seja, não necessariamente de forma positiva ou negativa. Segundo Fogaça e Klazura (2021), a CIF se tornou um vocabulário de natureza biopsicossocial, que apresenta a descrição dos impedimentos corporais e das barreiras sociais e à participação, alertando que se tornou necessário o reconhecimento da desigualdade gerada pela deficiência.

Fogaça e Klazura (2021) ainda explicam que o modelo biopsicossocial representa uma visão contemporânea da deficiência, refletida tanto na CDPD quanto na LBI, que adotam oficialmente a terminologia "pessoa com deficiência" – que será utilizada para fins desta pesquisa.

A partir das definições propostas para cada modelo, sugere-se a Figura 1 com a estrutura dos modelos da deficiência e seus principais aspectos:

Figura 1. Estrutura dos modelos da deficiência e seus principais aspectos.



Fonte: Adaptado pela autora de Brasil (2019).

Apesar da relevância dos três modelos descritos nesta pesquisa para a temática da deficiência e do TEA, para fins do que se pretende com este estudo, será adotada a proposição trazida pelo modelo social da deficiência, por estar diretamente associada à neurodiversidade, ao movimento da neurodiversidade e ao paradigma da neurodiversidade.

Doyle e McDougall (2022) reforçam, inclusive, a necessidade de pesquisas relacionadas à neurodiversidade que incorporem as perspectivas macroeconômica e sociojurídica e que sejam capazes de identificar áreas, no ciclo de contratação de um empregado neurodivergente, nas quais uma mudança de política levaria, por fim, a uma presença maior desses profissionais no mercado de trabalho.

2.2.2 Compreendendo a neurodiversidade

Rosqvist, Stenning e Chown (2020) apontam que não há na literatura descrições exaustivas a respeito da neurodiversidade. Como será demonstrado neste tópico, as definições relacionadas à temática da neurodiversidade, portanto, dependerão das abordagens e dos modelos teóricos escolhidos pelos pesquisadores em cada estudo.

De acordo com a abordagem proposta pelo modelo médico da deficiência, a definição clínica que seria melhor aplicável ao conceito de neurodiversidade seria a de um "transtorno mental" (CHAPMAN, 2020), previsto no DSM-V como uma:

> [...] síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, regulação emocional ou comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental.

Também como destacado por Chapman (2020), o conceito transcrito acima leva em conta uma condição que deva ser considerada tanto como uma disfunção quanto um prejuízo ao indivíduo, para ser definido como clinicamente relevante. Não será, portanto, a concepção adotada para fins desta pesquisa.

Por outro lado, autores da linha do modelo social da deficiência defendem o conceito da neurodiversidade alinhado com o simples fato de que é esperada uma variação neurológica entre os humanos (CHAPMAN, 2020), assim como a biodiversidade relaciona-se ao fato de que há variação biológica em um ecossistema (HUGHES, 2021). Sob a ótica do modelo social, a neurodiversidade também é geralmente descrita como uma reação ao modelo médico da deficiência (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020).

A neurodiversidade, assim, estaria relacionada à compreensão do que torna cada pessoa diferente, em termos cognitivos, emocionais e em virtude dos demais traços de percepção de cada indivíduo, por meio da promoção de uma perspectiva baseada nos pontos fortes de cada pessoa (WALKOWIAK, 2021). É utilizado, geralmente, como referência às variações percebidas no funcionamento cognitivo, afetivo e sensorial que se diferem da maioria

da população ou do neurotipo predominante (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020). Tais variações são denominadas neurodivergências (CHAPMAN; BOTHA, 2023).

Ressalta-se, contudo, que, apesar de o termo neurodiversidade ter sido cunhado pela primeira vez para descrever pessoas com TEA, atualmente, tem sido expandido para incluir outras condições (BRÎNZEA, 2019; WEBER et al., 2022), como o TDAH, dispraxia ou a dislexia (SZULC et al., 2021; DOYLE; MCDOWALL, 2022; KHAN et al., 2022), entre outros.

Outro conceito relevante para a compreensão do tema é o do movimento da neurodiversidade, que tem sido interpretado como um fruto mais recente do modelo social de deficiência. Esse movimento é defendido, valorizado e celebrado por muitos indivíduos com TEA, devendo ser considerado como semelhante a qualquer outra diversidade (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021). Relaciona-se, assim, à vertente do modelo social da deficiência. No Brasil, contudo, ressalta-se que o movimento da neurodiversidade ainda é pouco conhecido, inclusive entre especialistas da área (AYDOS, 2019).

O movimento da neurodiversidade propõe, em linhas gerais, remodelar a interpretação social acerca de questões neurocognitivas, reconhecendo-as como diferenças individuais e sociais, ao invés de apenas condições médicas (KHAN et al., 2022). No contexto deste movimento, os traços associados ao TEA devem ser entendidos apenas como uma forma diferente de pensar (FARRELL-BANKS, 2018), além e/ou ao invés de um distúrbio do neurodesenvolvimento (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021).

Radulski (2022), por sua vez, sugere que o movimento da neurodiversidade poderá levar a mais pesquisas envolvendo a compreensão das motivações sociais que levam à camuflagem, ao mascaramento e à adoção de outras estratégias de compensação por pessoas com TEA. Radulski sugere, ainda, o termo "*visible neurominority group*" como referência às pessoas com TEA, em razão do fato de pessoas com TEA necessitarem dessas estratégias para evitar que características comumente associadas ao TEA sejam percebidas em público.

Alguns autores também consideram a existência do denominado paradigma da neurodiversidade (*neurodiversity paradigm*) (HUGHES, 2020; CHAPMAN, 2020). Para eles, o paradigma da neurodiversidade refere-se às mudanças necessárias que devem ser implementadas nas teorias e ideologias aplicáveis, para que possibilitem o reenquadramento de indivíduos que, geralmente, acabam excluídos das normas neurocognitivas padrão, sendo considerados como minorias, em virtude de questões patológicas e médicas individuais (CHAPMAN, 2020). Neste sentido, o paradigma da neurodiversidade é apresentado como o

fundamento filosófico (*philosophical foundation*) para o movimento da neurodiversidade (HUGHES, 2021).

De acordo com o paradigma da neurodiversidade, segundo Chapman (2021), a diversidade neurocognitiva seria a norma, ao invés de um resultado das definições médicas que acabam por restringir o que seria esperado como normalidade. Entende-se por diversidade neurocognitiva a manifestação normal e saudável da biodiversidade (CHAPMAN, 2021), mas em termos cognitivos. Propõe-se, portanto, a abranger diferenças intangíveis, relacionadas ao funcionamento da mente de diferentes pessoas (WALKOWIAK, 2021). Contudo, Doyle e McDougall (2022) ressaltam que ainda faltam evidências para que seja definido o impacto do paradigma da neurodiversidade na prática.

Com base nos conceitos expostos neste tópico, sugere-se o Quadro 4, com a apresentação dos principais conceitos a respeito da neurodiversidade, em linha com o modelo social da deficiência:

Quadro 4. Principais conceitos da neurodiversidade (de acordo com o modelo social da deficiência).

Neurodiversidade	Espera-se uma variação neurológica entre os humanos (CHAPMAN, 2020), como visto na biodiversidade de um ecossistema (HUGHES, 2021). Refere-se às variações percebidas no funcionamento cognitivo, afetivo e sensorial que se diferem da maioria da população ou do neurotipo predominante (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020). Para fins deste estudo, será considerada, no entanto, para as pessoas com TEA.
Neurodivergências	São consideradas como as variações neurocognitivas percebidas em diferentes pessoas que, em uma perspectiva clínica, poderão incluir TDAH, dislexia e outras formas distintas de desenvolvimento cognitivo (CHAPMAN; BOTHA, 2023).
Movimento da neurodiversidade	Relaciona-se ao modelo social de deficiência. Busca modificar a interpretação social acerca de questões neurocognitivas, reconhecendo-as como diferenças individuais e sociais, ao invés de apenas condições médicas (KHAN et al., 2022). No contexto deste movimento, os traços associados ao TEA devem ser entendidos apenas como uma forma diferente de pensar (FARRELL-BANKS, 2018), além e/ou ao invés de um distúrbio do neurodesenvolvimento (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021).
Paradigma da neurodiversidade (*neurodiversity paradigm*)	Refere-se às mudanças necessárias em teorias e ideologias aplicáveis para que indivíduos que, geralmente, acabam excluídos das normas neurocognitivas padrão, sejam reenquadrados como parte da manifestação normal e saudável da biodiversidade (CHAPMAN, 2020).

Fonte: Elaborado pela autora.

Para uma melhor compreensão da neurodiversidade, sugere-se também a discussão a respeito do que seria, então, a neurotipicidade e os principais termos correlatos.

O termo neurotipicidade é conceitualmente dependente e relacionado ao conceito da neurodiversidade. Rosqvist, Stenning e Chown (2020) explicam que, assim como não há definições exaustivas acerca da neurodiversidade, não se pode afirmar que há conceitos definitivos a respeito da neurotipicidade (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020), que dependerá da abordagem e/ou modelo considerado para análise da questão.

Para o modelo social da deficiência e mais especificamente no contexto da neurodiversidade, de acordo com a proposta apresentada anteriormente, padrões não regulares de neurodesenvolvimento não deveriam ser interpretados como ausência de saúde e/ou doença, que necessitam de correções e/ou intervenções. Seriam apenas condições neurodivergentes, que representariam uma ampla variedade de diferenças observadas na humanidade (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020).

Sob a perspectiva do modelo médico da deficiência, no entanto, pode-se interpretar a neurotipicidade como sendo as condições observadas em um indivíduo que é clínica e psicologicamente saudável, desenvolvendo-se em um padrão regular quando comparado com outras pessoas com características atípicas (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020).

Logo, diferenças físicas ou cognitivas são vistas como deficiências, ou seja, déficits que um indivíduo apresenta ou não apresenta e que necessitam ser corrigidos, prioritariamente em pessoas neurodivergentes (JURGENS, 2020).

A partir dessa interpretação, permite-se a classificação entre pessoas neurotípicas e neurodivergentes, que seria utilizada para identificar diferentes capacidades – e não incapacidades (KRZEMINSKA; HAWSE, 2020).

Alerta-se que, apesar de também ser encontrado na literatura, ainda que de forma menos recorrente, o termo “neurodiverso”, optou-se, para fins desta pesquisa, pela utilização do termo mais recorrentemente aplicado na área – “neurodivergente”, como proposto por Kassiane Asasumasu (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020), inclusive por haver o entendimento de que a palavra “neurodiverso” não faria sentido em termos gramaticais no idioma inglês (NE’EMAN; PELLICANO, 2022).

Assim, na perspectiva do modelo social da deficiência, indivíduos neurologicamente distintos seriam denominados “neurodivergentes”, enquanto aqueles dentro dos parâmetros

estatísticos, com base em testes cognitivos relevantes ou avaliações de comportamento (DOYLE; MCDOWALL, 2022), seriam geralmente referidos como “neurotípicos”.

Ainda, de acordo com a visão social da deficiência, rejeita-se a ideia de que diferenças cognitivas das pessoas neurodivergentes, em comparação com as neurotípicas, seriam falhas ou defeitos a serem corrigidos ou objeto de intervenções (JURGENS, 2020).

Com base nos conceitos expostos no presente tópico, apresenta-se no Quadro 5 os principais termos relacionados à neurotipicidade, a partir da própria neurodiversidade:

Quadro 5. Principais termos relacionados à neurotipicidade (a partir da neurodiversidade).

Neurotipicidade	Representaria o padrão regular de desenvolvimento humano, quando comparado com outras pessoas com características atípicas (ROSQVIST; STENNING; CHOWN, 2020). Na perspectiva do modelo social da deficiência, no entanto, padrões não regulares de neurodesenvolvimento não deveriam ser interpretados como ausência de saúde e/ou doença, que necessitam de correções e/ou intervenções.
Pessoas neurotípicas	Indivíduos dentro dos parâmetros estatísticos, com base em testes cognitivos relevantes ou avaliações de comportamento (DOYLE; MCDOWALL, 2022).
Pessoas neurodivergentes	Indivíduos neurologicamente distintos. Termo mais recorrente aplicado na área.
Pessoas neurodiversas	Utilizado como sinônimo de pessoas neurodivergentes por alguns autores. Não será, no entanto, considerado para fins desta pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora.

2.3 NEURODIVERSIDADE NO TRABALHO E A EMPREGABILIDADE DE PROFISSIONAIS COM TEA

Ainda que não seja foco deste estudo, não se ignora que os direitos e as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência (dentre as quais incluem-se aquelas com TEA) no Brasil têm previsão legal, como a Lei de Cotas, tendo sido objeto, inclusive, da análise de estudos empíricos nacionais prévios (GARBIN et al., 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023).

Destacam-se também iniciativas recentes, como a Lei Estadual nº 17.645, de 07 de março de 2023, já em vigor, que cria, no Estado de São Paulo, “a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência” (SÃO PAULO, 2023). Um dos objetivos da referida política, descritos em seu Art. 1º, §3º, é a contribuição para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, promovendo o acesso a um trabalho digno nos

termos da lei, para nele se manter e progredir (SÃO PAULO, 2023). Trata-se de iniciativa do governo local e que poderá ser analisada em pesquisas posteriores.

O trabalho com apoio é definido como *Supported Employment*, em países de língua inglesa, e como *Empleo con Apoyo*, em espanhol (COSTA; SINHORETTO, 2017). No Brasil, o trabalho com apoio está previsto no parágrafo único do Art. 37 da LBI, que o define como uma das formas de colocação competitiva de pessoas com deficiência no trabalho, apresentando as diretrizes que deverão ser seguidas nestes casos:

> Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.
>
> Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes (grifos nossos):
>
> I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;
> II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
> III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
> IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
> V - realização de avaliações periódicas;
> VI - articulação intersetorial das políticas públicas;
> VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.

O emprego apoiado, por sua vez, pode ser considerado como uma das modalidades do trabalho com apoio (COSTA; SINHORETTO, 2017). O Projeto de Lei 1532/2023, em votação no Senado Federal, trata do "emprego apoiado" às pessoas com deficiência e pretende alterar algumas disposições da LBI a este respeito, inclusive com a previsão de uma "Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho e no Emprego" (BRASIL, 2023).

O emprego apoiado surgiu ao final da década de 1970, nos Estados Unidos da América, com a finalidade de viabilizar a inclusão no trabalho de pessoas com deficiência intelectual, após críticas às oficinas protegidas de trabalho (BETTI, 2017). Essas oficinas foram idealizadas para preparar pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho, mas em um ambiente separado do ambiente de trabalho propriamente dito.

O emprego apoiado é definido por Betti (2017, p. 4) como “uma metodologia que visa à inclusão no mercado competitivo de trabalho” de pessoas que estejam “em situação de incapacidade mais significativa”, devendo ser respeitados seus interesses e escolhas, suas capacidades e as necessidades de apoio. Para Costa e Sinhoretto (2017, p. 10), o emprego apoiado é uma metodologia que “consiste em preparar pessoas com deficiência interessadas num posto de trabalho mediante a assistência pessoal de profissionais especializados”.

É uma visão baseada no modelo social da deficiência (BETTI, 2017), alinhada, portanto, com o proposto para essa pesquisa. Ainda, esclarece-se que, para este estudo, serão consideradas especificamente as pessoas com TEA, que poderão ou não ter deficiência intelectual concomitante.

Betti (2017) também explica que, inicialmente, foram desenvolvidas duas modalidades para o emprego apoiado: (i) individual – para os profissionais que necessitavam de menos apoio; e (ii) grupais – usualmente utilizadas para as pessoas que precisavam de mais apoio e com as seguintes divisões (ii.a) enclave – com a inserção de um grupo em uma organização que dividia as atividades que deveriam ser realizadas, sob a coordenação de um supervisor; e (ii.b) móvel – formada por um grupo de pessoas supervisionado por um profissional e que poderiam realizar diferentes atividades na comunidade. Atualmente, como revela Betti (2017), essas modalidades grupais não são mais consideradas como emprego apoiado, permanecendo apenas o trabalho realizado individualmente com o profissional.

Ainda, para Betti (2017), a metodologia do emprego apoiado é dividida em três etapas:

(i) Etapa 1 - Descoberta do perfil vocacional: uma etapa desenvolvida com relação à pessoa com TEA, que envolve avaliações do profissional, por meio de entrevistas, observações e acompanhamento, para a identificação de seus interesses e escolhas, suas capacidades e necessidades de apoio;

(ii) Etapa 2 - Desenvolvimento do emprego: uma etapa relacionada às organizações, com a finalidade de verificar funções que tenham compatibilidade com o perfil vocacional do profissional mapeado. São levadas em conta a cultura da organização, a disponibilidade para apoios para o profissional e quais seriam os requisitos para a implementação dos referidos apoios. Há a possibilidade tanto de se utilizar posições na organização que já existem quanto de se criar vagas para recepcionar os profissionais avaliados. Após a contratação, é feita uma análise detalhada das atividades que serão

realizadas pelo profissional, com o intuito de se elaborar um Plano Individual de Treinamento e Inclusão Social; e

(iii) Etapa 3 – Acompanhamento pós-colocação: é feito o acompanhamento dos treinamentos disponibilizados e da inclusão do profissional na organização, como uma forma de apurar se os apoios desenvolvidos são adequados para atendimento da pessoa contratada. A partir do momento em que se percebe que a organização e o profissional estão adaptados, o acompanhamento passa a ser contínuo, feito à distância, com o intuito de monitorar as condições da inclusão realizada, podendo ser feitas intervenções ao longo do tempo, se necessário.

Além das obrigações legais propriamente ditas, motivados pelo desejo de ser socialmente responsáveis e obter uma vantagem competitiva, beneficiando-se das competências e habilidades associadas à neurodiversidade (KHAN et al., 2022), constata-se um número crescente de empregadores que têm desenvolvido modelos de gestão e práticas de contratação mais inclusivas em geral (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021).

Há diferenças, no entanto, nas ações que têm como objetivo a promoção do ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, de acordo com o país ou região analisados, representando, em geral, intervenções com foco no indivíduo com deficiência e/ou no empregador, por meio de incentivos e orientações de melhores práticas de mercado (DOYLE; MCDOWALL, 2022). Neste cenário, muitas vezes, pequenas e médias organizações acabam ainda não fazendo parte de tais iniciativas (MURFITT et al., 2018).

Nota-se também que a maioria desses programas continua a ter como base conceitos advindos do modelo médico da deficiência, como ainda ocorre no Brasil (BRASIL, 2023). De acordo com tais conceitos, o ambiente de trabalho é considerado como um fator fixo, fazendo com que o próprio indivíduo com deficiência deva se adaptar às condições impostas pelas organizações (DOYLE; MCDOWALL, 2022).

Sugere-se, por meio deste trabalho, a análise da mudança dessa perspectiva médica para a social, como advogam Doyle e McDowall (2022). Especificamente no que diz respeito à neurodiversidade no ambiente de trabalho, Doyle e McDowall (2022) ressaltam um contexto de sobreposição e potencial conflito entre conceitos de diferentes naturezas, como sociais, legais e de desenvolvimento de conceitos acerca do tema.

Khan et al. (2022) complementam ao revelar que as ideias relacionadas à neurodiversidade são desenhadas com base em um contexto médico, psicológico e educacional,

com limitada pesquisa empírica relacionada à neurodiversidade nos estudos organizacionais e de gestão, reforçando a relevância da presente pesquisa.

2.3.1. Neurodiversidade no trabalho

Como mencionado na introdução do presente estudo, foram identificados alguns estudos teóricos na literatura que abordam a temática da neurodiversidade no ambiente de trabalho.

Segundo Dreaver et al. (2019), ainda há uma compreensão limitada de como apoiar da melhor forma profissionais com TEA no ambiente de trabalho. Spoor, Bury e Hedley (2021) acreditam que as atitudes dos empregados em geral com relação a programas voltados para o emprego de pessoas com TEA podem impactar o seu sucesso. Johnson et al. (2020), por sua vez, acreditam que as dificuldades relacionadas aos profissionais neurodivergentes no ambiente de trabalho não se relacionam necessária e diretamente aos profissionais com TEA em si, mas a oportunidades limitadas de engajamento e crescimento nas organizações.

Ao investigar as perspectivas dos empregadores quanto à contratação de profissionais com TEA, Albright, Kuloka e Scarpa (2020) indicam que adultos com TEA têm revelado frustação com relação à abordagem proposta em alguns programas de reabilitação vocacional em linha com o modelo médico da deficiência. Nestes casos, os autores explicam que referidos programas acabam por trabalhar em mudanças no próprio indivíduo, para que se acomode às necessidades do ambiente laboral, ao invés de promover a aceitação e a acomodação dos locais de trabalho propriamente ditos, de forma a permitir que o indivíduo com TEA se desenvolva.

Para que essa aceitação e acomodação ocorram em organizações, Albright, Kuloka e Scarpa (2020) sugerem o aprimoramento da compreensão a respeito do TEA, por meio de treinamentos nos locais de trabalho para essa finalidade.

Ainda a respeito da integração de profissionais com TEA em organizações, Spoor, Bury e Hedley (2021) realizaram um estudo empírico com a finalidade de observar as atitudes de profissionais neurotípicos com relação a um programa de emprego para profissionais TEA (*autism employment programme*) em uma organização australiana. Por meio da análise temática de dados obtidos de trinta e dois empregados neurotípicos da referida organização, os autores identificaram três principais temas: (i) os benefícios do programa, que sugeriram que os profissionais com TEA são vistos de forma positiva pelos demais colegas neurotípicos, levando, em geral, a uma maior compreensão sobre o TEA; (ii) os desafios do programa, com percepções

de que haveria um tratamento especial para os profissionais com TEA e a existência de atitudes negativas com relação às pessoas com TEA; e (iii) as preocupações a respeito da integração da força de trabalho como um todo, com a identificação de oportunidades reduzidas para a integração social e no emprego ao se considerar o ambiente de trabalho de forma mais ampla.

Adicionalmente, Veras e Castro (2021) identificaram a existência de poucos programas de formação profissional brasileiros, tendo como resultados currículos e programas mal elaborados, e poucas políticas públicas voltadas à inclusão do profissional com TEA no mercado de trabalho.

Ainda, dentre os trabalhos identificados para esta pesquisa, destaca-se a revisão da literatura relacionada à neurodiversidade nas organizações, especificamente para identificação de lacunas, proposta por Doyle e McDougall (2022), que concluem que a investigação acadêmica a respeito da neurodiversidade no ambiente de trabalho ainda é insuficiente. Alerta-se que, em sua revisão, os pesquisadores não restringiram o conceito de neurodiversidade apenas ao TEA, mas consideraram também outras condições, como TDAH e dislexia.

Com base nos resultados identificados, Doyle e McDougall (2022) propuseram a divisão de três níveis de análise para fins de aprimoramento das discussões relacionadas à neurodiversidade no ambiente de trabalho, sendo: (i) um nível micro, equivalente ao empregado neurodivergente, e que tem conexão a questões como o desempenho individual no trabalho e a percepção de que devem ser capazes de seguir normas sociais semelhantes aos colegas de trabalho neurotípicos para a manutenção do emprego. Este nível também pode ser influenciado por aspectos como gênero, etnia, raça, orientação sexual, idade e status econômico; (ii) um nível intermediário, que se relaciona ao contexto imediato em que o empregado neurodivergente está inserido, envolvendo aspectos como o desenho proposto para a vaga, a estação de trabalho e o ambiente físico e as normas de comunicações entre membros da equipe e destes com a organização. Entendem que este nível é influenciado também pelo contexto sócio-histórico em que tais normas foram criadas; e (iii) um nível macro, que avalia aspectos da neurodiversidade por meio do uso de políticas aplicáveis ao contexto de trabalho e incentivos para que os empregadores abordem a questão na contratação e gestão de seus talentos.

Szulc et al. (2021) defendem, por sua vez, que o desenvolvimento pelas organizações de oportunidades voltadas a questões específicas, como comunicação interpessoal e o espaço físico do trabalho, nas quais as pessoas neurodivergentes enfrentam as maiores dificuldades, poderia fornecer suporte efetivo para uma comunicação interpessoal, auxiliando em situações de estresse ou envolvendo maior sensibilidade nos sentidos. A partir desta interpretação, Szulc

et al. (2021) propõem um modelo conceitual (*conceptual model*) para a integração do profissional neurodivergente em organizações, com foco no desempenho organizacional, nas habilidades, motivações e oportunidades relacionadas à força de trabalho neurodivergente e no nível de satisfação desses empregados.

No que diz respeito às habilidades, considerando as características individuais dos profissionais neurodivergentes, Szulc et al. (2021) propõem a revisão nas seguintes áreas do ciclo de vida do empregado em uma organização: (i) processo de recrutamento e seleção, de modo a refletir uma definição mais ampla de habilidades esperadas da força de trabalho; e (ii) treinamento e seleção, para auxiliar no processamento pelos profissionais neurodivergentes de informações, da comunicação ou na adaptação a mudanças, por meio de treinamento interpessoal, suporte individualizado ou colegas de trabalho que dariam apoio para as tarefas diárias e gestão do volume de trabalho.

No quesito motivação, que se relaciona à intenção do indivíduo em utilizar suas habilidades de forma mais produtiva, Szulc et al. (2021) interpretam que as estratégias geralmente utilizadas para motivar empregados neurotípicos podem não ser adequadas para os neurodivergentes. Portanto, recomendam focar nas seguintes condições: (i) melhoria da comunicação entre os profissionais neurodivergentes e seus respectivos empregadores, com a utilização, por exemplo, de meios eletrônicos e digitais, que podem auxiliar nas dificuldades oriundas da interação social; e (ii) desenho do trabalho (*job design*) previsto, pois há evidências de que profissionais neurodivergentes poderiam ter mais dificuldades com demandas muito flexíveis.

No que diz respeito às oportunidades, segundo Szulc et al. (2021), estas poderiam estar relacionadas a intervenções de natureza tecnológica ou não. Em geral, os autores reforçam a percepção de que empregados neurodivergentes poderiam se beneficiar de oportunidades relacionadas a: (i) desenvolvimento tecnológico da organização; (ii) mudanças no ambiente físico do trabalho, em virtude da maior sensibilidade que as pessoas neurodivergentes em geral demonstram com relação a temperatura, umidade, odores e barulhos; e (iii) relações institucionais da organização onde trabalham com outras organizações e até mesmo autoridades governamentais com conhecimento em pessoas neurodivergentes.

Walkowiak (2021) reforça a proposição de que as tecnologias poderiam contribuir com, ao menos, quatro áreas da organização, para fins do aprimoramento da neurodiversidade: (i) recrutamento, para busca de candidatos em diferentes canais de comunicação, melhorias na adequação de vagas a candidatos e remoção de certos estereótipos durante entrevistas; (ii)

treinamento e conscientização, com a digitalização de materiais de treinamento, permitindo sessões assíncronas e por meio do uso do computador, e divulgação de temas relacionados à neurodiversidade por meio de redes sociais; (iii) sistema de suporte aos profissionais, como a mentoria voltada para o trabalho; e (iv) ambiente físico, como a utilização de fones de ouvido e outros recursos.

Doyle e McDougall (2022), por sua vez, utilizam-se da divisão proposta em seu estudo e aplicam os princípios do *Universal Design* (desenho universal[1]), relacionados à justiça, flexibilidade e simplicidade, os quais explicam terem como objetivo o aumento da acessibilidade de construções e tecnologias. Por se tratar de uma proposta teórica inovadora, recomendam a revisão, crítica e aprofundamento dessas sugestões pelas áreas de psicologia industrial/organizacional e RH e na pesquisa em administração como um todo.

2.3.2. Empregabilidade de profissionais com TEA

De modo geral, a palavra empregabilidade deriva do verbo "empregar", que pode ter diferentes significados, envolvendo o ato de "dar emprego" de alguma forma, mas que, atualmente, ganhou um conceito mais amplo no mundo corporativo: "a condição de ser contratável" (MINARELLI, 2010).

Para fins desta pesquisa, portanto, o conceito de empregabilidade será a capacidade de um profissional com TEA de obter e manter um emprego formal, ou de encontrar um novo emprego, se necessário (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013).

Além disso, a empregabilidade também será interpretada como o reconhecimento pelos empregadores da probabilidade de candidatos a empregos fazerem contribuições positivas para suas respectivas organizações (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013, p. 11).

De acordo com essa perspectiva, Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) entendem que os empregadores levariam em conta suas próprias percepções acerca do quanto as habilidades dos candidatos a vagas de emprego poderiam contribuir, de forma positiva, para suas respectivas organizações, considerando os seguintes critérios: (i) habilidades interpessoais, com a capacidade de o profissional de se relacionar com os demais colegas, o que seria

[1] De acordo com o Art. 3º, II, da LBI, desenho universal é considerado como a "concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva".

considerado como uma recompensa para a organização (*rewarding*); (ii) capacidade do profissional de aprender e realizar o trabalho (*able*); e (iii) as ambições, orientações e ética profissional do empregado, tornando-o produtivo (*willing*), que serão mais bem descritas no *framework* teórico que será discutido neste tópico.

Ainda que a empregabilidade tenha sido objeto de estudos desde 1950, Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) indicam que ainda há uma lacuna entre a pesquisa acadêmica a respeito do tema e as práticas de contratação propriamente ditas. Segundo os autores, isso decorre do fato de que, de um lado, há evidências empíricas a favor da importância de determinados atributos de caráter psicológico para o desempenho no emprego por um profissional, tais como habilidades cognitivas e personalidade, mas, de outro, empregadores revelam a tendência a apresentar maior interesse nas habilidades sociais (*social skills*) dos empregados - do que em sua habilidade cognitiva.

Como consequência dessa aparente discrepância, poderiam ser detectadas duas mudanças da natureza dos trabalhos no mundo atual, quais sejam: (i) trabalhos cada vez menos formais, estruturados e sujeitos a rotinas; e (ii) exigência cada vez maior da realização de tarefas de forma colaborativa, com profissionais com diferentes históricos e origens (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013). De acordo com os achados apresentados no item 2.3.3 a seguir, tais aspectos parecem apresentar desafios consideráveis para os profissionais com TEA.

Diante desta constatação, Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) propõem, em seu estudo teórico: (i) uma revisão da literatura, na área de psicologia, a respeito das diferenças individuais relacionadas a sucesso na carreira; (ii) uma revisão daquilo que os empregadores de fato desejam quando de novas contratações de profissionais; e (iii) ao final, um *framework* teórico para unificar ambas as perspectivas.

Com relação à revisão da literatura indicada, os autores constataram que, dentre os principais modelos aplicáveis aos estudos a respeito de sucesso na carreira, os psicólogos tendem a focar no modelo de capital humano. No contexto do referido modelo, a educação formal seria apontada como o seu mais importante componente, sendo que o nível de instrução de um indivíduo seria utilizado como um primeiro filtro em processos seletivos para vagas de emprego.

No entanto, como destacam Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013), há evidências científicas de que a relação entre sucesso acadêmico e sucesso na carreira seriam, na realidade, modestas. Apesar de muitos psicólogos tradicionalmente argumentarem que o

nível de instrução representaria uma função das habilidades cognitivas de um indivíduo, outros estudos reforçam a importância de outras características pessoais de candidatos como preditores de desempenho, inclusive acadêmico.

Para os autores, consequentemente, uma vez tendo comprovado que o candidato tem as mínimas condições em termos de qualificações acadêmicas, outros fatores passariam a ser mais importantes para determinar os níveis de sucesso em uma organização, como discutido a seguir.

No que diz respeito aos aspectos desejados por empregadores quando da realização de novas contratações, a característica de empregados ou de candidatos a vagas de emprego que parece ser considerada mais importante para fins de empregabilidade seriam as habilidades interpessoais ou as competências sociais do indivíduo (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013). Isso explicaria, por exemplo, o motivo de algumas pessoas com altos coeficientes de inteligência não serem consideradas como passíveis de contratação por organizações (HOGAN; CHAMORRO-PREMUZIC; KAISER, 2013), ou, como se pretende demonstrar com esta pesquisa, a situação dos profissionais com TEA.

O *framework teórico* trazido por Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) permite a diferenciação entre o perfil do candidato à vaga de emprego e a percepção do empregador a respeito deste mesmo perfil, para fins da desejada empregabilidade (MCMAHON; HENRY; LINTHICUM, 2021). No entanto, para McMahon, Henry e Linthicum (2021) faltariam ao modelo teórico outros fatores que poderiam influenciar as percepções dos empregadores a respeito de candidatos a vagas de emprego além do perfil do profissional, em especial no que diz respeito aos profissionais com TEA.

Para as autoras, tais fatores poderiam afetar de forma crítica a empregabilidade de profissionais com TEA e envolveriam: (i) a decisão do candidato à vaga de emprego de revelar seu diagnóstico clínico durante a entrevista; (ii) a presença de características do TEA no candidato à vaga durante a entrevista; (iii) o conhecimento prévio do empregador a respeito do TEA; e (iv) a tendência do empregador a se comportar de forma socialmente desejável.

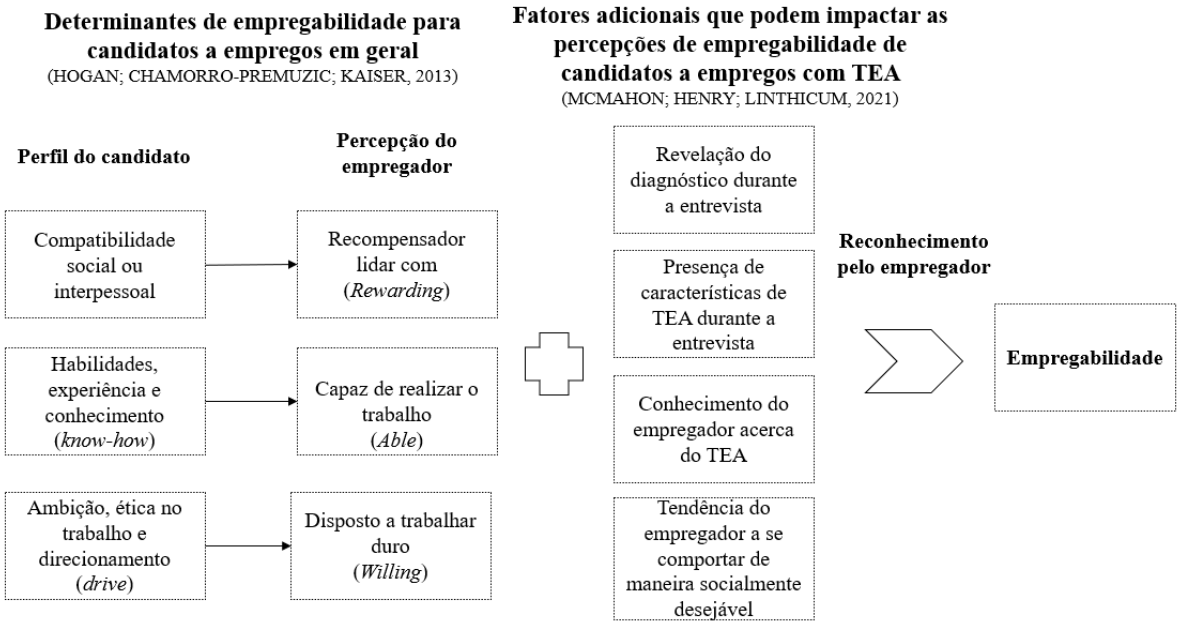
De acordo com os resultados da pesquisa empírica quantitativa conduzida por McMahon, Henry e Linthicum (2021) com trezentos e doze participantes neurotípicos, os fatores relacionados ao empregador, mais especificamente o conhecimento prévio a respeito do TEA e a tendência de se comportar de forma socialmente desejável, influenciam de forma significativa suas percepções a respeito dos candidatos às vagas de emprego. Portanto, as autoras entendem que a percepção de empregabilidade de candidatos com TEA é influenciada

fortemente pelas características do próprio empregador, em comparação às características descritas no perfil do candidato.

A partir de sua pesquisa, McMahon, Henry e Linthicum (2021) sugerem que modelos conceituais relacionados à empregabilidade de pessoas com TEA considerem tanto o candidato à vaga de emprego quanto os fatores do empregador que poderão impactar em suas percepções da empregabilidade do profissional com TEA em análise – o que reforça a importância da análise integrada da temática, como sugerido nos objetivos deste estudo.

Com base no *framework* teórico com as condições determinantes de empregabilidade (*determinants of employability*) proposto por Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) e nos fatores adicionais que podem impactar as percepções de empregabilidade de candidatos a emprego com TEA, apontados por McMahon, Henry e Linthicum (2021), sugere-se a Figura 2 acerca da empregabilidade de pessoas com TEA:

Figura 2. Determinantes de empregabilidade (Determinants of employability) para profissionais com TEA.



Fonte: Traduzido e adaptado pela Autora de Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013) e McMahon, Henry e Linthicum (2021).

2.3.3. Desafios à empregabilidade de profissionais com TEA

O TEA tende a impactar as oportunidades de educação e de empregabilidade das pessoas que são diagnosticadas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2022). Ainda, muitas organizações, mesmo que não de forma intencional, acabam por excluir ou não

considerar os talentos de pessoas neurodivergentes (SCOTT et al., 2019), quando não consideram a neurodiversidade no ambiente de trabalho.

Khan et al. (2022) explicam que o número significantemente maior de desemprego de pessoas neurodivergentes pode também ser atribuído à falta de conhecimento de como criar e gerir um ambiente de trabalho com profissionais neurodivergentes, buscando resultados positivos para a organização.

Szulc et al. (2021) revelam que os profissionais neurodivergentes costumam enfrentar obstáculos que os impedem de usar suas habilidades de forma mais eficiente, sendo considerados como verdadeiras barreiras ao emprego (KHAN et al., 2022).

No Brasil, as poucas evidências relacionadas às dificuldades enfrentadas por profissionais com TEA no mercado de trabalho mencionam situações similares às que foram descritas globalmente, apesar de apresentarem características próprias à situação local (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; VERAS; CASTRO, 2021; RODRIGUES, 2023).

Em uma análise ampla, apesar de sua capacidade e vontade de trabalhar, profissionais com TEA continuam a enfrentar desvantagens significativas no mercado de trabalho em três níveis: (i) individual, em razão de restrições relacionadas ao próprio autismo, como limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017); (ii) organizacional, como a ausência de compreensão e apoio nas configurações dos empregos encontrados (BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014); e (iii) governamental, em virtude de outras questões estruturais do Brasil, como a falta de políticas públicas orientadas especificamente para este público (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017), a ausência de eficácia das cotas para pessoas com deficiência e de incentivos para as organizações brasileiras (BASTO; CEPELLOS, 2023).

Garbin et al. (2022) constataram que indivíduos com TEA identificam, em geral, três dificuldades principais quanto ao mercado de trabalho: (i) obtenção do emprego; (ii) permanência no emprego; e (iii) obtenção de uma colocação compatível com a formação do profissional.

Rodrigues (2023), por sua vez, indica o que seriam considerados dificultadores da trajetória profissional da pessoa com TEA, com destaque para processos seletivos e falta de experiência, falta de diagnóstico antes ou durante a trajetória profissional, falta de entendimento de colegas e liderança, despreparo da liderança e falta de feedback, desempenho de funções e atividades inadequadas, falta de adaptações no ambiente de trabalho, falta ou mudança de rotina e crises envolvendo saúde mental e afastamentos.

Para fins de melhor compreensão a respeito dos desafios relacionados aos profissionais com TEA no mercado de trabalho, propõe-se a divisão dos principais achados da literatura internacional e nacional por meio de uma adaptação das seis áreas principais de RH, como sugeridas por Doyle e McDougall (2022), quais sejam: (i) desenho do trabalho (*job design*); (ii) contratação; (iii) integração (*onboarding*); (iv) treinamento e desenvolvimento; (v) desempenho; e (vi) relações sociais e bem-estar no ambiente de trabalho.

A respeito do desenho do trabalho (*job design*), Melo, Garrocho e Guerra (2021) relatam que o próprio processo de identificar uma vaga de emprego pode ser confuso e gerar de ansiedade para muitos indivíduos com TEA que, por diversas vezes, desconhecem se possuem as qualificações necessárias para o cargo.

Há também relatos de oferta de vagas com baixa qualidade (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017) e a falta de preparo vocacional (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; BASTO; CEPELLOS, 2023) como empecilhos para a contratação de profissionais com TEA. Em pesquisa empírica realizada com seis profissionais com TEA, Hurlbutt e Chalmers (2004) apontaram que, em geral, os participantes do estudo revelaram não ter conseguido obter empregos nas áreas nas quais receberam treinamento e terem perdido oportunidades de emprego por diversas vezes. Relataram, ainda, ter muita dificuldade em encontrar e manter empregos compatíveis com seu nível de habilidades técnicas. Processos de contratação, por exemplo, tendem a definir talentos de forma mais restritiva e excessivamente baseados no desempenho do candidato em entrevistas (SZULC, 2021).

No que tange à contratação propriamente dita, Conceição, Escalante e Silva (2021) relatam que muitos profissionais com TEA sentem grandes dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Descrevem a atuação da Specialisterne, organização não governamental (ONG) que tem como finalidade a promoção da formação, habilitação e inclusão de indivíduos com TEA em organizações.

Por meio de uma revisão da literatura, Khan et al. (2022) identificam os desafios apontados pela literatura internacional como comuns aos indivíduos neurodivergentes para o processo de obtenção de trabalho. Relatam aspectos associados à revelação de sua própria neurodiversidade durante o processo de candidatura; e à falta de apoio e acomodações para estes profissionais quando da candidatura a uma vaga de emprego.

As dificuldades relacionadas aos empregadores e aos profissionais de RH, por sua vez, iniciam-se quando do recrutamento de profissionais neurodivergentes para vagas de emprego. Nesta fase do processo, Khan et al. (2022) incluem como barreiras a falta de conhecimento

pelos profissionais de RH a respeito da neurodiversidade, o que acaba levando à estereotipagem e a atitudes negativas com relação às pessoas neurodivergentes. Em geral, quando tais condições são observadas em organizações, Khan et al. (2022) explicam que o recrutamento de indivíduos neurodivergentes, se concluído, acaba sendo realizado apenas para fins de cumprimento de obrigações legais.

Além disso, outra questão apontada como um dos entraves para as pessoas com TEA no ambiente de trabalho é o preconceito de empregadores (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023).

Szulc et al. (2021) referem-se às barreiras enfrentadas pelos profissionais neurodivergentes no processo de integração (*onboarding*) em organizações, especificamente no que diz respeito à superação de potenciais problemas atrelados à interação social. Os autores explicam que tal fato parece decorrer da aplicação de práticas de RH previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias.

Para fins de avaliação de desempenho, estudos envolvendo as relações de trabalho de profissionais com TEA também indicam situações que poderiam representar desafios para profissionais neurodivergentes, como as que envolvem resolução de problemas e mudanças de rotinas, pois supervisores e colegas de trabalho, em geral, têm a expectativa de que adultos trabalhem de forma independente no emprego (LINDSAY et al., 2019). Johnson et al. (2020) justificam a limitação de opções no emprego em razão das falhas de comunicação relatadas na literatura e a falta de habilidades sociais que são vitais para o ambiente de trabalho.

Na pesquisa conduzida por Hurlbutt e Chalmers (2004) com seis profissionais com TEA, alguns participantes revelam frustração com aspectos sociais do trabalho e mais dificuldades em interações sociais – e não necessariamente com as tarefas propriamente ditas.

Ainda, por terem uma compreensão muito literal da linguagem, alguns aspectos indicados como relevantes para a empregabilidade por profissionais de RH, como comunicação e interação social, podem ser particularmente desafiadoras para pessoas com TEA no ambiente de trabalho (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021). É mais frequente, por exemplo, observar que esses profissionais falem formalmente ou usem volume, tom ou modulações de voz incomuns, sendo muitas vezes interpretados por outros colegas de trabalho neurotípicos como rudes ou estranhos (LINDSAY et al., 2019).

Além de relações sociais típicas do ambiente de trabalho, a literatura também relata dificuldades associadas ao ambiente físico do trabalho, inclusive quanto ao trabalho remoto

(SZULC, 2022). A este respeito, se, por um lado, o distanciamento de luzes brilhantes e o barulho típico do escritório podem representar um alívio para profissionais com TEA, por outro, tais situações podem ser associadas à mudança na sua rotina e, portanto, resultar em uma experiência estressante (SZULC, 2022).

Do ponto de vista dos empregadores, há relatos na literatura que indicam, dentre os motivos que levam organizações a não empregar pessoas com TEA, a existência de dúvidas pelos recrutadores e gestores quanto à capacidade desses profissionais de: (i) comportar-se de determinadas maneiras (que seriam esperadas no mundo corporativo); (ii) apresentar sensibilidade e demonstrar emoções faciais; (iii) serem capazes de se relacionar em grupos; e (iv) compreender conceitos abstratos (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021).

Em suma, o Quadro 6 sintetiza uma visão integrada dos principais desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, de acordo com a adaptação proposta para as seis áreas principais de RH mencionadas neste tópico e sugeridas por Doyle e McDougall (2022) e com relação aos achados na literatura teórica e empírica no que diz respeito aos próprios profissionais neurodivergentes e com TEA (PT), às entidades de capacitação de profissionais neurodivergentes para o mercado de trabalho (EC) e às organizações empregadoras (OE):

Quadro 6. Desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA (visão integrada).

Áreas principais de RH (adaptado de Doyle e McDougall, 2022)	**Com relação a OE, EC e PT[2]**	**Desafios à empregabilidade de profissionais com TEA**
Desenho do trabalho (*job design)*	OE	Ausência de compreensão e apoio nas configurações dos empregos encontrados (BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014). Oferta de vagas com baixa qualidade (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017). Falta de preparo vocacional dos profissionais com TEA (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; BASTO; CEPELLOS, 2023).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Obtenção de uma colocação compatível com a formação do profissional (HURLBUTT; CHALMERS, 2004; GARBIN et al., 2022). Dificuldade na manutenção de empregos compatíveis com o respectivo nível de habilidades técnicas (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Confusão e ansiedade no processo de identificar uma vaga de emprego, por desconhecerem se possuem as qualificações necessárias para o cargo (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021).
Contratação	OE	Falta de conhecimento pelos profissionais de RH a respeito da neurodiversidade, estereotipagem e atitudes negativas com relação às pessoas neurodivergentes (KHAN et al.,

(continua)

[2] PT = próprios profissionais neurodivergentes e com TEA
EC = entidades de capacitação de profissionais neurodivergentes para o mercado de trabalho
OE = organizações empregadoras

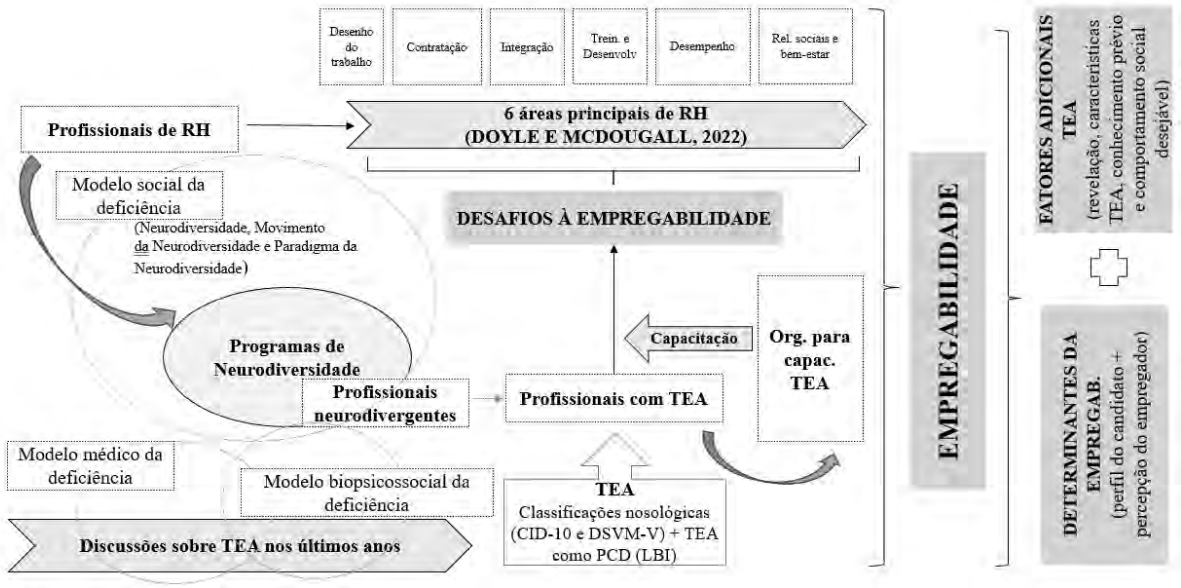
(continuação)		2022). Preconceito de empregadores (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023). Processos de contratação com definição de talentos de forma mais restritiva e excessivamente baseados no desempenho do candidato em entrevistas (SZULC, 2021).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Revelação da própria neurodiversidade durante o processo de candidatura (KHAN et al., 2022). Sensação de falta de apoio e acomodações quando da candidatura a uma vaga de emprego (KHAN et al., 2022). Obtenção do emprego (GARBIN et al., 2022). Percepção de grandes dificuldades para ingressar no mercado de trabalho (CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021).
Integração (*onboarding*)	OE	Superação de potenciais problemas atrelados à interação social (SZULC, 2021). Aplicação de práticas de RH previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias (SZULC, 2021). Dúvidas a respeito da integração dos profissionais com TEA no ambiente de trabalho como um todo, em razão de programa de emprego voltado especificamente para profissionais TEA (SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Permanência no emprego (GARBIN et al., 2022). Restrições relacionadas ao próprio autismo, como limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017).
Treinamento e desenvolvimento	OE	Existência de poucos programas de formação profissional voltados para profissionais com TEA (VERAS; CASTRO, 2021). Compreensão limitada de como apoiar da melhor forma profissionais com TEA no ambiente de trabalho (DREAVER et al., 2019). Necessidade de aprimoramento a respeito da compreensão a respeito do TEA, por meio de treinamentos nos locais de trabalho para essa finalidade (ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Frustação de adultos com TEA com relação à abordagem proposta em alguns programas de reabilitação vocacional em linha com o modelo médico da deficiência (ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020).
Desempenho	OE	Expectativa de supervisores e colegas de trabalho, em geral, de que adultos trabalhem de forma independente no emprego (LINDSAY et al., 2019). Aplicação de práticas de RH previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias (SZULC, 2021). Oportunidades limitadas de engajamento e crescimento para profissionais neurodivergentes nas organizações (JOHNSON et al., 2020).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Permanência no emprego (GARBIN et al., 2022). Restrições relacionadas ao próprio autismo, como limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017).
Relações sociais e bem-estar (continua)	OE	Existência de dúvidas quanto à capacidade dos profissionais com TEA de: (i) comportar-se de determinadas maneiras (que seriam esperadas no mundo corporativo); (ii) apresentar

(continuação)		sensibilidade e demonstrar emoções faciais; (iii) serem capazes de se relacionar em grupos; e (iv) compreender conceitos abstratos (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021). Percepção dos colegas neurotípicos de que haveria um tratamento especial às pessoas com TEA no ambiente de trabalho, em organização com programa de emprego voltado para pessoas com TEA (SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021).
	EC	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).
	PT	Frustração com aspectos sociais do trabalho e mais dificuldades em interações sociais (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Dificuldades associadas ao ambiente físico do trabalho, inclusive quanto ao trabalho remoto (SZULC, 2022). Estresse na mudança de rotina (SZULC, 2022).

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir do referencial teórico proposto, sugere-se na Figura 3, portanto, um mapa inicial com os principais conceitos e termos identificados na literatura:

Figura 3. Mapa do referencial teórico proposto.



Fonte: Elaborado pela autora.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Humanos (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), sob o CAAE nº 73802023.2.0000.0084, respeitando todos os critérios da ética em pesquisa com seres humanos previstos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde n°. 510/2016.

Foram garantidos o sigilo, a privacidade e a confidencialidade de todas as informações obtidas dos participantes, por meio da assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada participante, conforme modelos aprovados pelo CEP para os grupos de participantes descritos no item 3.3. (Apêndices I a III). Os dados coletados somente serão utilizados para fins da pesquisa realizada e os resultados poderão ser publicados apenas para fins acadêmicos.

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

A escolha pela abordagem qualitativa neste estudo foi feita prioritariamente em virtude dos objetivos geral e específicos definidos para a pesquisa, da proposta de análise da questão de pesquisa sob a ótica do modelo social da deficiência e da neurodiversidade e das características gerais da pesquisa qualitativa apresentadas por Creswell e Creswell (2021) e por Merriam (2009).

Considerando que a característica central da abordagem qualitativa é o fato de que as pessoas constroem a realidade em suas interações com seus mundos sociais (MERRIAM, 2009), o foco da análise foi mantido na percepção dos significados que os próprios participantes do estudo deram às questões que foram apresentadas em cada roteiro de entrevista, em especial, como tais participantes interpretam os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA.

Ressalta-se, ainda, a relevância da figura da pesquisadora em uma pesquisa de natureza qualitativa (CRESWELL; CRESWELL, 2021). Diante da multidisciplinaridade da temática proposta para o presente estudo, entende-se que as experiências pessoais passadas da pesquisadora foram importante recurso para a pesquisa de campo. Com formação acadêmica em Direito, com atuação na área empresarial e em *compliance*, e em ciências da saúde (Educação Física), para fins da realização da presente pesquisa, a pesquisadora também efetuou o aprofundamento em estudos, oferecidos por instituições de ensino superior renomadas, envolvendo especificamente: (i) o TEA, por meio da participação em cursos especializados e uma pós-graduação específica sobre o TEA; (ii) a diversidade e inclusão em organizações, com pós-graduação específica sobre a temática; e (iii) os direitos das pessoas com deficiência, por meio de curso especificamente desenvolvido para discutir essa questão.

Além disso, para fins de compreensão de como as experiências passadas poderão moldar as interpretações da pesquisadora (CRESWELL; CRESWELL, 2021), revela-se a existência de um membro do núcleo familiar próximo, atualmente com 34 anos de idade,

diagnosticado com TEA, nível III de apoio, aproximadamente aos dois anos de idade, o que levou ao convívio da pesquisadora com uma pessoa com TEA nas atividades diárias pelo mesmo período de 34 anos.

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

A pesquisa qualitativa é, por sua natureza, interpretativa (MERRIAM, 2009; CRESWELL; CRESWELL, 2021). Tendo em vista a multidisciplinaridade da pesquisa que será conduzida e a possibilidade de sua aplicação em diversos campos de estudos e à prática das áreas de administração e negócios (MERRIAM, 2009), foi, portanto, conduzida uma pesquisa qualitativa interpretativa básica.

A partir da questão de pesquisa formulada e dos objetivos geral e específicos definidos, o interesse da pesquisadora na condução da pesquisa teve relação com a forma com a qual os próprios participantes interpretam e dão significados para aquilo que consideram desafios para a empregabilidade das pessoas com TEA.

3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS

Como participantes da pesquisa para fins de levantamento de dados, foram caracterizados três grupos de profissionais, descritos abaixo:

(i) Grupo 1: 19 profissionais com TEA, todos com nível I de suporte, maiores de 18 anos, que (i) atualmente estão trabalhando em organizações, independentemente do gênero, da idade, da formação, da área em que atuam ou do tipo de vínculo de trabalho; ou que (ii) ainda que não estejam atualmente trabalhando, já trabalharam em organizações, independentemente do gênero, da idade, da formação, da área em que atuam ou do tipo de vínculo de trabalho;

(ii) Grupo 2: 6 profissionais de RH e de saúde e segurança do trabalho, maiores de 18 anos, que estão atualmente trabalhando em organizações que contratam profissionais com TEA, em razão de políticas de neurodiversidade implementadas ou não; e

(iii) Grupo 3: 4 profissionais, maiores de 18 anos, que trabalham em instituições e entidades sem fins lucrativos voltadas para a capacitação e/ou inclusão de

> profissionais com TEA no mercado de trabalho, independentemente da indústria e/ou área de atuação dos referidos profissionais.

Com o intuito de manter o equilíbrio na coleta de dados (FALQUETO; HOFFMAN; FARIAS, 2019), destaca-se que foram estabelecidos dois objetivos específicos em conexão com cada roteiro constante dos Apêndices IV a VI, totalizando, portanto, os seis objetivos específicos descritos na introdução da presente dissertação.

Adicionalmente, por meio da análise documental de informações, documentos, reportagens e relatórios disponibilizados para acesso público por meio da *internet*, foram objeto da análise temática outras organizações e entidades e instituições sem fins lucrativos que desenvolvem programas de neurodiversidade e que afirmam contratar pessoas com TEA. Essas organizações e entidades e instituições sem fins lucrativos não representam necessariamente o local onde os participantes dos Grupos 2 e 3 atuam.

São apresentadas a seguir as ações realizadas durante a pesquisa para a seleção dos referidos profissionais:

3.3.1 Seleção do Grupo 1 - Participantes com TEA

Para a seleção dos profissionais com TEA que compuseram o Grupo 1, após a aprovação pela banca de qualificação, foram retomados os contatos com as dez pessoas com TEA de conhecimento da pesquisadora que já haviam manifestado o interesse em participar das entrevistas quando da elaboração do projeto. No entanto, apenas quatro dos dez profissionais com TEA acabaram confirmando a sua disponibilidade para continuar na pesquisa, assim que fosse obtida a aprovação pelo CEP.

Diante disso, uma nova busca por profissionais com TEA que se enquadrassem nos critérios de inclusão para o estudo foi iniciada em agosto de 2023, mediante envio de mensagens em canais disponibilizados por redes sociais (LinkedIn e Instagram) para pessoas com TEA que indicavam trabalhar ou terem trabalhado em algum momento de suas vidas.

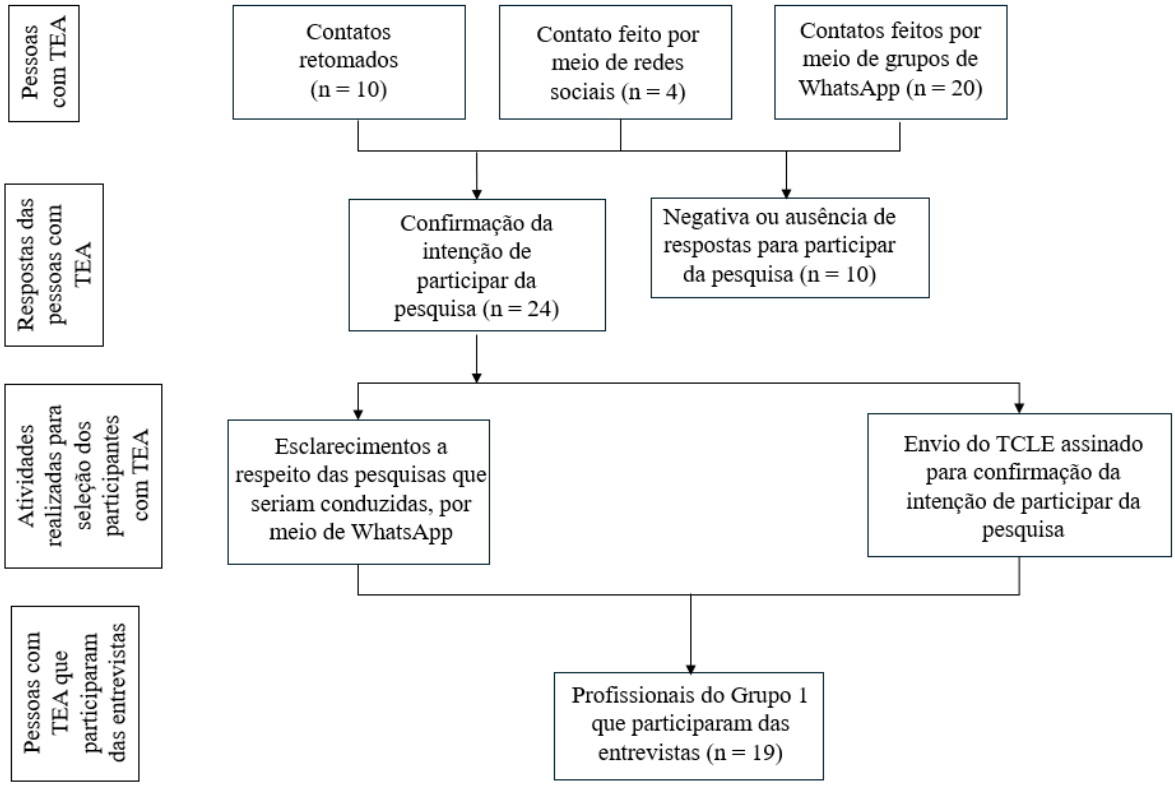
Após a aprovação pelo CEP em fevereiro de 2024, o processo de divulgação da pesquisa foi ampliado e intensificado, principalmente com o envio de mensagens por meio de redes sociais (como o LinkedIn) e aplicativos (como o WhatsApp) para grupos que se identificavam como sendo compostos por pessoas com TEA e com outras neurodivergências e que discutiam temáticas relacionadas à inclusão no trabalho. Neste contexto, a divulgação a

respeito da pesquisa passou a ocorrer de forma mais orgânica nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, sendo impulsionada pelas próprias pessoas com TEA e com outras neurodivergências.

Como resultado, 24 pessoas com TEA entraram em contato com a pesquisadora, por meio do WhatsApp, entre os meses de fevereiro e abril de 2024, com a intenção de participar das pesquisas, sendo que 19 de fato participaram das entrevistas.

A Figura 4 indica as etapas para a seleção dos participantes do Grupo 1:

Figura 4. Seleção dos participantes do Grupo 1.



Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando que muitos dos participantes com TEA ainda não revelaram que são pessoas com TEA para seus empregadores e os compromissos de sigilo e confidencialidade, assumidos com o CEP para a condução da pesquisa de forma ética e de acordo com as normas aplicáveis, o Quadro 7 apresenta um panorama dos participantes com TEA que compuseram o Grupo 1 de participantes do estudo:

Quadro 7. Panorama dos participantes do Grupo 1.

Gênero dos Participantes do Grupo 1	Nº de Participantes por Gênero	Idade dos Participantes do Grupo 1	Nº de Participantes por faixa etária	Raças dos Participantes do Grupo 1	Nº de Participantes por raça	Local de residência dos Participantes do Grupo 1	Nº de Participantes do Grupo 1 por localidade
Feminino	8	**20 a 29 anos**	7	**Preta**	1	**Região Nordeste**	2
Masculino	10	**30 a 39 anos**	9	**Parda**	4	**Região Sudeste**	13
Outros	1	**40 a 49 anos**	3	**Branca**	14	**Região Sul**	4
Total	19	**Total**	19	**Total**	19	**Total**	19

Fonte: Elaborado pela autora

Para fins da pesquisa, a condição de pessoa com TEA com nível I de suporte foi apurada por meio da autodeclaração dos participantes do Grupo 1. Alguns participantes, no entanto, optaram por enviar o laudo com o diagnóstico, o currículo indicando a CID do TEA ou o perfil no LinkedIn, identificando-se como pessoa com TEA ou pessoa como deficiência.

3.3.2 Seleção do Grupo 2 - Participantes de RH e de saúde e segurança do trabalho

Para a seleção dos profissionais do Grupo 2, após a aprovação pela banca de qualificação, inicialmente, foram retomados os contatos com os profissionais de RH das 3 organizações que já haviam manifestado o interesse em participar das entrevistas quando da elaboração do projeto. Duas profissionais de RH acabaram confirmando a sua disponibilidade para continuar na pesquisa, assim que fosse obtida a aprovação pelo CEP. A partir deste cenário, foram realizadas as seguintes ações com essas profissionais:

(i) contato telefônico, em 04 de outubro de 2023, com uma profissional de RH de uma organização que implementou programa de neurodiversidade e que contrata regularmente profissionais com TEA, oportunidade em que foram testados alguns aspectos do roteiro para entrevistas com participantes do Grupo 2, após comentários feitos pela banca de qualificação. Não foi realizada a gravação da conversa; e

(ii) uma reunião, por meio de videochamada no aplicativo Teams da Microsoft, com 28min48seg de duração, realizada em 20 de dezembro de 2023, para realização do pré-teste com o roteiro para entrevistas com participantes do Grupo 2, após comentários feitos pela banca de qualificação. Para essa finalidade, foi entrevistada uma profissional de RH de uma organização que

> implementou programa de neurodiversidade e que contrata regularmente profissionais com TEA e que autorizou expressamente a gravação da videoconferência.

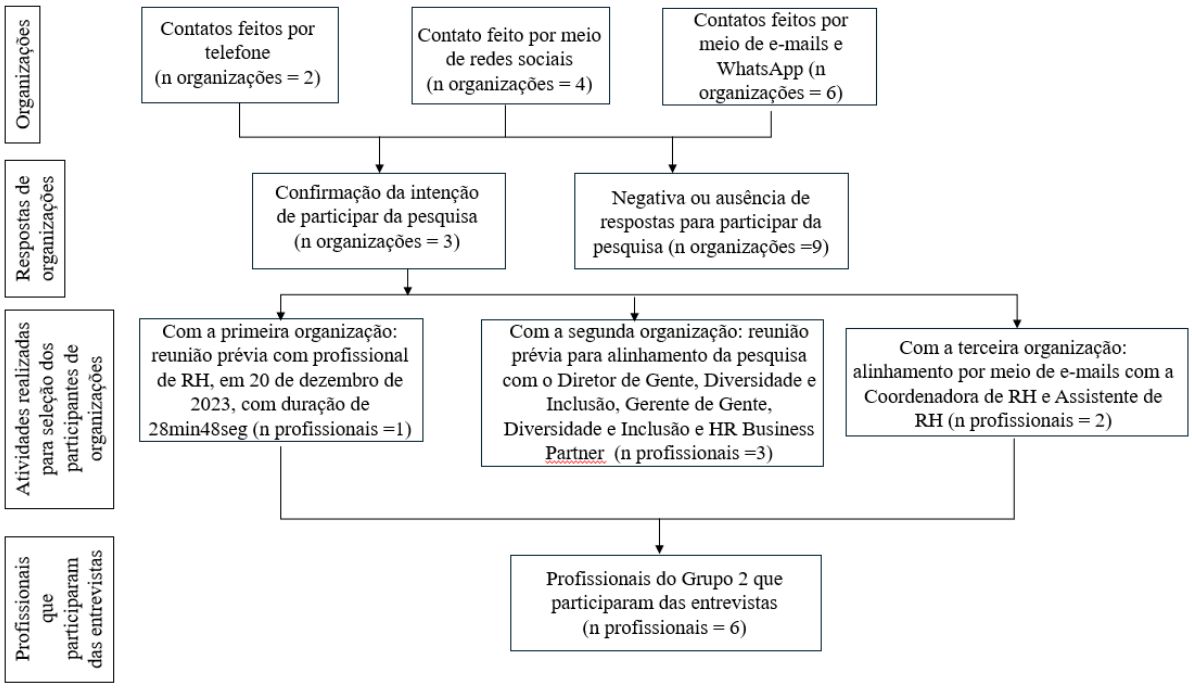
Apesar do retorno inicialmente favorável das duas participantes, apenas uma delas acabou de fato participando das entrevistas, tendo firmado o TCLE correspondente ao Grupo 2 (Apêndice II).

Paralelamente aos contatos realizados, foi também conduzida uma busca na internet, por meio do navegador Google Chrome, por outros profissionais de RH e gestão de pessoas de organizações que se enquadrassem nos critérios de inclusão para o Grupo 2, a partir de agosto de 2024. Neste contexto, foram: (i) mapeadas organizações que afirmam ter programas de neurodiversidade ou contratar pessoas neurodivergentes; (ii) enviados e-mails e mensagens em canais disponibilizados pelos sites (como o WhatsApp institucional) das referidas organizações; e (iii) realizado o contato via redes sociais das mencionadas organizações (LinkedIn), questionando a respeito do interesse em participar da pesquisa. Ainda, foram realizados contatos com pessoas de conhecimento da pesquisadora para obtenção de possíveis indicações de profissionais que se enquadrassem nos critérios do Grupo 2.

Como resultado, 4 organizações retornaram os contatos e manifestaram, em um primeiro momento, o interesse em participar da pesquisa. Contudo, após os contatos iniciais feitos por telefone e por mensagens de WhatsApp, apenas profissionais de 3 organizações acabaram por realizar as entrevistas.

A Figura 5 proposta reflete as etapas para a seleção dos participantes:

Figura 5. Seleção dos participantes do Grupo 2.



Fonte: Elaborada pela autora.

Ao final, 6 participantes do Grupo 2 de 3 diferentes organizações participaram das entrevistas, sendo que: (i) a Participante RH 1 trabalha em uma das organizações mapeadas; (ii) a Participante RH 2 e Participante RH 3 trabalham em uma segunda organização; e (iii) a Participante RH 4, a Participante RH 5 e o Participante RH 6 trabalham em uma terceira organização.

Considerando que nenhuma organização autorizou expressamente a menção ao seu nome ou mesmo uma possível identificação por meio da descrição de suas atividades e área de atuação, para preservar a confidencialidade dos participantes e o sigilo das informações, assumido como premissa para a condução da pesquisa, os participantes foram apresentados de modo a não revelar quem são essas pessoas e quais são essas organizações, como descrito no Quadro 8:

Quadro 8. Apresentação dos participantes do Grupo 2.

Nº atribuído ao participante	Perfil da organização ou entidade onde trabalha	Local do escritório	Gênero	Cargos declarados pelos participantes
Participante RH 1	Organização de grande porte (acima de 500 empregados)	São Paulo/SP	Feminino	HR Business Partner
Participante RH 2	Organização de médio porte (acima de 200 empregados)	São Paulo/SP	Feminino	Coordenadora de RH
Participante RH 3	Organização de médio porte (acima de 200 empregados)	São Paulo/SP	Feminino	Analista de RH
Participante RH 4	Organização de grande porte (acima de 500 empregados)	São Paulo/SP	Feminino	Coordenadora de Enfermagem do Trabalho
Participante RH 5	Organização de grande porte (acima de 500 empregados)	São Paulo/SP	Feminino	Gerente de Saúde
Participante RH 6	Organização de grande porte (acima de 500 empregados)	São Paulo/SP	Masculino	Gerente de Gestão de Pessoas

Fonte: Elaborado pela autora

3.3.3 Seleção do Grupo 3 - Participantes das organizações e entidades sem fins lucrativos de capacitação e/ou inclusão de profissionais com TEA no mercado de trabalho

Para a seleção dos profissionais do Grupo 3, após a aprovação do projeto de pesquisa pela banca de qualificação, foram previamente selecionadas, por meio de buscas na internet, utilizando o navegador Google Chrome, vinte organizações e entidades sem entidades sem fins lucrativos que indicavam expressamente em seus websites e/ou redes sociais pelo menos uma das seguintes informações: (i) atendimento a pessoas com TEA acima de 18 anos; e/ou (ii) prestação de serviços, promoção de atividades e/ou desenvolvimento de projetos relacionados à capacitação para o mercado de trabalho e/ou inclusão profissional de pessoas com TEA e/ou atuação em projetos de neurodiversidade em organizações, independentemente do município de sua sede ou escritório para atuação.

A partir dos meios de comunicação com o público disponibilizados por cada organização ou entidade, foram enviados e-mails e/ou mensagens nas redes sociais e/ou realizados contatos no número de WhatsApp institucional, questionando a respeito do interesse das vinte organizações e entidades sem fins lucrativos selecionadas de participar da pesquisa que seria conduzida nos termos do projeto de pesquisa, que, à época dos contatos, seria submetida para a aprovação pelo CEP.

Inicialmente, nove organizações e entidades retornaram os contatos, demonstrando a intenção de participar dos estudos. A partir deste cenário, foram realizadas as seguintes ações:

(iii) duas reuniões prévias, por meio de videochamadas no aplicativo Teams da Microsoft, com cerca de 30min de duração cada, em 31 de março de 2023 e 28 de agosto de 2023, com a Coordenadora da área de Formação da Specialisterne, formada em Psicologia e com cerca de 5 anos de atuação na mencionada instituição. A Specialisterne é uma "organização social, nascida na Dinamarca em 2004 e com presença em 23 países, que se dedica à inclusão profissional de pessoas com autismo e outros diagnósticos na neurodiversidade" (SPECIALISTERNE, 2024). Foi também preparado um resumo do projeto de pesquisa aprovado pelo CEP para avaliação pela diretoria da Specialisterne;

(iv) duas reuniões, por meio de videochamadas no aplicativo Teams da Microsoft, com 25 e 38min de duração, respectivamente, realizadas em 22 de agosto de 2023 e 29 de agosto de 2023, para realização do pré-teste com o roteiro para entrevistas com participantes do Grupo 3, após comentários feitos pela banca de qualificação, para fins de submissão do projeto para a análise pelo CEP, o que ocorreu em 31 de agosto de 2023. Para essa finalidade, foram entrevistados dois profissionais de organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, localizadas no município de São Paulo, no estado de São Paulo, que trabalham com serviços de capacitação e inclusão de profissionais com TEA;

(v) entendimentos por meio de mensagens e e-mails com fundadores de duas startups que atuam com projetos envolvendo a neurodiversidade no trabalho e a inclusão de profissionais neurodivergentes;

(vi) entendimentos por meio de mensagens e e-mails com duas profissionais de consultorias que trabalham com programas de diversidade e inclusão voltados para pessoas com deficiência e profissionais com TEA;

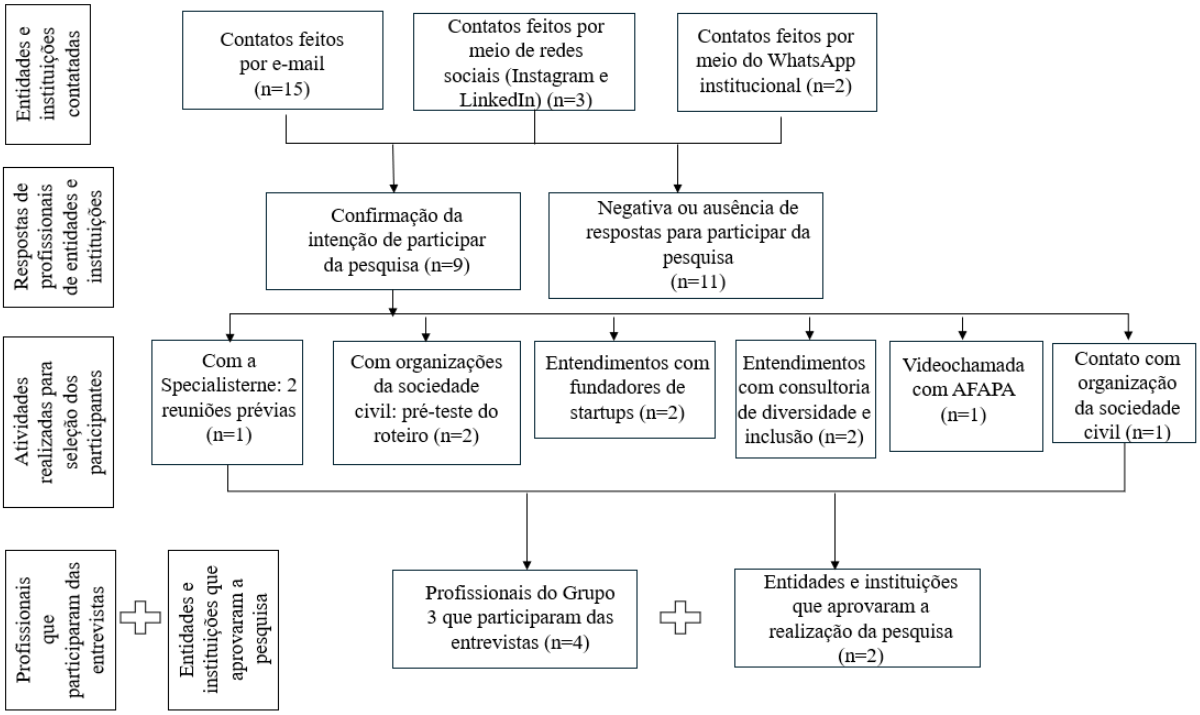
(vii) videochamada pelo WhatsApp, em 17 de agosto de 2023, com a Coordenadora de Projetos da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Alegre - AFAPA, para discutir a respeito da pesquisa e projetos em andamento na referida instituição. A AFAPA "se constituiu como uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, no dia 11 de novembro de 2019 pela iniciativa de familiares e amigos das pessoas com autismo" (AFAPA, 2024); e

(viii) contato telefônico, em 22 de agosto de 2023, com a Coordenadora de Relação com Empresas de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, localizada em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que trabalha com serviços de capacitação e inclusão de profissionais com TEA.

Apesar do retorno inicialmente favorável dos nove participantes, ao todo, profissionais de apenas 4 organizações e entidades sem fins lucrativos que capacitam profissionais com TEA ou desenvolvem ações para sua inclusão no mercado de trabalho acabaram de fato participando das entrevistas, sendo que 2 entidades sem fins lucrativos (Specialisterne e AFAPA) autorizaram expressamente a divulgação de seus nomes na presente pesquisa, conforme Termos de Anuência firmados para tal finalidade (Apêndices VII e VIII).

A Figura 6 proposta reflete as etapas para a seleção dos participantes:

Figura 6. Seleção dos participantes do Grupo 3.



Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando que apenas a Specialisterne e a AFAPA autorizaram expressamente a menção ao nome das suas respectivas entidades, para preservar a confidencialidade dos demais participantes e o sigilo das atividades desenvolvidas pelas demais organizações e entidades sem fins lucrativos do Grupo 3, os participantes foram apresentados de modo a não revelar quem são essas pessoas e quais são essas instituições, como descrito no Quadro 9:

Quadro 9. Apresentação dos participantes do Grupo 3.

Nº atribuído ao participante	Perfil da organização ou entidade onde trabalha	Local do escritório	Gênero	Cargos declarados pelos participantes
Participante Org. 1	Organização privada que tem como objetivo prestar serviços a profissionais e organizações a respeito da neurodiversidade no trabalho	São Paulo/SP	Feminino	Fundadora
Participante Org. 2	Specialisterne	São Paulo/SP	Feminino	Coordenadora de Treinamento
Participante Org. 3	Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que, entre os serviços prestados à sociedade, oferece apoio à inclusão no ambiente de trabalho de profissionais com TEA	São Paulo/SP	Masculino	Supervisor de Serviços de Inclusão
Participante Org. 4	AFAPA que, entre os projetos desenvolvidos, há o denominado "Preparação para o Trabalho" de profissionais com TEA	Porto Alegre/RS	Feminino	Coordenadora de Projetos

Fonte: Elaborado pela autora

Com relação às formas para a coleta dos dados da pesquisa, foram realizadas: (i) a análise de documentos (análise documental), como relatórios, projetos e outras informações disponíveis para acesso ao público, tanto das organizações e instituições e entidades sem fins lucrativos que capacitam profissionais com TEA para o trabalho onde os participantes dos Grupos 2 e 3 atuam como de outras mapeadas com a utilização da internet, com o navegador Google Chrome; e (ii) a realização de entrevistas com os participantes dos Grupos 1, 2 e 3. Como explicado por Kvale (2006), a entrevista, em pesquisas qualitativas, tem se tornado, nas últimas décadas, um método adequado para a investigação das percepções dos participantes e que, geralmente, tem sido considerada como uma forma democrática de emancipação da pesquisa nas áreas sociais.

Após a aprovação pelo CEP da UPM em 02 de fevereiro de 2024, foram conduzidas entrevistas em profundidade (GODOI; MATTOS, 2010) com os participantes dos Grupos 1, 2 e 3, por meio da utilização de roteiro semiestruturado desenvolvido especificamente para cada grupo, com questões mais centrais a respeito da temática da pesquisa e com conexão com os

objetivos específicos propostos para a pesquisa, na forma constante dos Apêndices IV a VI, respectivamente.

Especificamente quanto ao roteiro de pesquisa para o Grupo 1 proposto no Apêndice IV, ressalta-se que o modelo inicialmente proposto no projeto de pesquisa foi significativamente alterado, seguindo os apontamentos feitos pela banca de qualificação. Além disso, durante o mês de agosto de 2023 e com o intuito de submeter à análise do CEP, o roteiro para participantes do Grupo 1 também foi submetido para análise e revisão por: (i) um profissional com TEA de conhecimento pessoal da pesquisadora, que também participou posteriormente das entrevistas; e (ii) uma profissional da área da saúde, com Mestrado e Doutorado na área de Psicologia da Educação e que atua com pessoas com deficiência e com TEA há aproximadamente trinta anos.

Optou-se pela entrevista em profundidade pela intenção da pesquisa de apreender aspectos do trabalho realizado pelos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 e como tais participantes atribuem valores e significados para suas próprias experiências (GODOI; MATTOS, 2010). A realização de entrevistas apoiadas em roteiros tem como objetivo ordenar e formular perguntas que atendam aos objetivos específicos definidos na pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, permita certa flexibilidade quando da condução das entrevistas, especialmente com relação aos profissionais com TEA.

Previamente à realização da entrevista, os participantes dos Grupos 1, 2 e 3 foram convidados a assinar o TCLE elaborado especificamente para o referido grupo, de acordo com os Apêndices I a III, respectivamente. Cada TCLE foi previamente assinado pela pesquisadora antes do envio para o referido participante. Todos os participantes aceitaram as condições descritas no TCLE e o assinaram, autorizando expressamente a gravação da imagem e/ou do som nas entrevistas.

As entrevistas foram feitas pelo aplicativo *Teams* da Microsoft, com a gravação de vídeo e transcrição automática das falas dos participantes e da pesquisadora, exceto uma das entrevistas com uma participante do Grupo 3, que foi realizada por meio de videochamada do WhatsApp e gravada mediante a utilização de aplicativo para gravação no celular baixado do *Play Store* do *Android*, denominado “Gravador de Voz” e transcrita por meio da plataforma *Transkriptor*.

Apesar da transcrição automática fornecida pelo aplicativo *Teams* e a realizada pela plataforma *Transkriptor*, três revisões criteriosas foram realizadas pela pesquisadora de cada uma das entrevistas gravadas, ao: (i) ler a primeira versão da transcrição obtida; (ii) assistir o

vídeo gravado, pausar quando necessário e corrigir as transcrições incorretas; e (iii) reler cada documento após finalizado para ajustes finais. Como consequência, cada revisão levou, em média, 5 horas para conclusão, representando um total de aproximadamente 15 horas de atividades de transcrição incorridas pela pesquisadora para cada entrevista realizada, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da duração da entrevista. Após esse trabalho, uma nova revisão foi feita pela orientadora do projeto, com a finalidade de identificar eventuais lacunas ou erros não detectados na primeira etapa. Como proposto por Braun e Clarke (2006), essas transcrições são parte do *corpus* da análise temática que foi conduzida.

De forma geral, os participantes demonstraram grande interesse pelo tema investigado e comentaram a respeito da relevância da pesquisa para a sociedade, para as organizações e para as pessoas com TEA. Manifestaram também a intenção de obter resultados da pesquisa e discutir após a finalização do processo. As especificidades das entrevistas realizadas com cada grupo foram descritas a seguir.

3.3.4 Entrevistas com participantes do Grupo 1

Os participantes do Grupo 1 foram novamente contatados pela pesquisadora por meio de e-mails ou envio de mensagens de WhatsApp, no Instagram ou no LinkedIn para a realização das entrevistas.

Apesar de o roteiro de entrevistas proposto no Apêndice IV ter sido seguido integralmente em todas as entrevistas realizadas com participantes do Grupo 1, destaca-se que, em razão das diferentes experiências vivenciadas pelos referidos participantes e a existência de características específicas em cada pessoa com TEA ("*no two autistic adults are the same*") (CARRERO; KRZEMINSKA; HÄRTEL, 2019), alguns participantes acabaram optando por discutir outros aspectos de sua vida, o que inclui, por exemplo, desafios encarados durante os anos de estudos no ensino superior, questões envolvendo pessoas de suas famílias e amigos fora do ambiente de trabalho e condições para acesso a profissionais de saúde para fins de avaliações relacionadas ao diagnóstico do TEA. Outros participantes, por demonstrarem ter uma compreensão mais literal da linguagem (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021) e pensamento analítico, acabaram demandando mais condução nas entrevistas do que o inicialmente proposto em um roteiro semiestruturado, sem afetar, no entanto, os relatos prestados espontaneamente pelos participantes do Grupo 1.

Outro aspecto das entrevistas realizadas com o Grupo 1 que merece destaque é o fato de vários participantes terem mencionado ao final das entrevistas que se sentiram acolhidos durante seus relatos, reconhecendo a compreensão da pesquisadora quanto às experiências compartilhadas e um processo de escuta ativa. A este respeito, sugere-se que essa percepção dos participantes do Grupo 1 poderia decorrer das características e experiência pessoal da própria pesquisadora com o TEA e outras neurodivergências; de todo modo, o perfil do pesquisador na condução de pesquisas com pessoas com TEA é um fator que poderá ser analisado futuramente em outros estudos.

As entrevistas com os participantes do Grupo 1 tiveram a duração entre 15min33seg e 1h28min17seg, individualmente, representando um total de aproximadamente 20 horas em entrevistas. Considerando o número de participantes do Grupo 1 (n=19) e para preservar o sigilo e a confidencialidade de cada participante que é pessoa com TEA, optou-se por não apresentar um quadro com o detalhamento das entrevistas, realizadas entre os meses de fevereiro e abril de 2024.

3.3.5 Entrevistas com participantes do Grupo 2

Os participantes do Grupo 2 foram novamente contatados pela pesquisadora por meio de e-mails. A Participante RH 1, que havia participado do pré-teste, em 20 de dezembro de 2023, autorizou expressamente a utilização da gravação previamente realizada.

Não foram necessários ajustes ao roteiro proposto no Apêndice V durante as entrevistas com os participantes do Grupo 2, que tiveram a duração entre 28min48seg e 1h09min, individualmente, representando um total de aproximadamente 2h15min em entrevistas.

A visão geral dos trabalhos relacionados ao levantamento de dados por meio das entrevistas está representada no Quadro 10:

Quadro 10. Visão geral com os dados das entrevistas dos participantes do Grupo 2.

Nº atribuído ao participante	Forma de realização da entrevista	Tempo de duração da entrevista (em horas, minutos e segundos)	Data de realização da entrevista	Forma de transcrição	Tempo incorrido em transcrição e leituras prévias (em horas aproximadas)
Participante RH 1	Teams, com gravação de som e imagem	28min48seg	20 de dezembro de 2023 (pré-teste)	Automática pelo Teams	3h
Participante RH 2 Participante RH 3	Teams, com gravação de som e imagem	31min41seg	06 de março de 2024	Automática pelo Teams	3h
Participante RH 4 Participante RH 5 Participante RH 6	Teams com gravação de som e imagem	1h09min	10 de maio de 2024	Automática pelo Teams	6h
Total	N.A.	2h15min (aprox.)	N.A.		12h

Fonte: Elaborado pela autora.

3.3.6 Entrevistas com participantes do Grupo 3

Os participantes do Grupo 3 foram novamente contatados pela pesquisadora por meio de e-mails. O Participante Org. 3, que havia participado do pré-teste, em 29 de agosto de 2023, autorizou expressamente a utilização da gravação previamente realizada. A outra participante de entidade sem fins lucrativos que realizou o segundo pré-teste em 22 de agosto de 2023 preferiu não seguir com a pesquisa. A Participante Org. 4 que conversou via videochamada também autorizou expressamente a utilização da gravação para análise dos dados obtidos.

Não foram necessários ajustes ao roteiro proposto no Apêndice VI durante as entrevistas com os participantes do Grupo 3, que tiveram a duração entre 23min e 1h06min, individualmente, representando um total de aproximadamente 3h em entrevistas.

A visão geral dos trabalhos relacionados ao levantamento de dados por meio das entrevistas está representada no Quadro 11:

Quadro 11. Visão geral com os dados das entrevistas dos participantes do Grupo 3.

Nº atribuído ao participante	Forma de realização da entrevista	Tempo de duração da entrevista (em horas, minutos e segundos)	Data de realização da entrevista	Forma de transcrição	Tempo incorrido em transcrição e leituras prévias (em horas aproximadas)
Participante Org. 1	Teams, com gravação de som e imagem	23min19seg	12 de março de 2024	Automática pelo Teams	3h
Participante Org. 2	Teams, com gravação de som e imagem	1h06min45seg	18 de abril de 2024	Automática pelo Teams	7h
Participante Org. 3	Teams com gravação de som e imagem	37min48seg	29 de agosto de 2023 (pré-teste)	Automática pelo Teams	4h
Participante Org. 4	Videochamada de WhatsApp, com gravação de som	49min49seg	17 de agosto de 2023 (pré-teste)	Plataforma Transkriptor	6h
Total	N.A.	3h (aprox.)	N.A.		20h

Fonte: Elaborado pela autora.

No que diz respeito à saturação teórica da pesquisa, foram levadas em consideração as recomendações de Falqueto, Hoffman e Farias (2018) quanto à combinação de fatores em estudos qualitativos. Para essa finalidade, a coleta de dados e a análise foram feitas de maneira concomitante, observando-se quais elementos surgiram a partir dos relatos e quais foram replicados. Apesar de não serem seguidos critérios meramente quantitativos para seu atingimento, de acordo com os estudos citados por Falqueto, Hoffman e Farias (2018), a tendência é que o ponto de saturação seja observado nos temas de maneira geral, até a 12ª entrevista, podendo ocorrer variações, no entanto, dependendo dos temas analisados.

Considerando: (i) o foco nos desafios à empregabilidade de pessoas com TEA, ou seja, em participantes do Grupo 1; e (ii) o fato de que cada pessoa com TEA apresenta características próprias e particularidades, em razão da combinação de diferentes aspectos pessoais, além da eventual coocorrência com outras neurodivergências e até mesmo altas habilidades e superdotação, entende-se que foi obtida a saturação por volta da 17ª entrevista com profissionais do Grupo 1, tendo sido feita a 19ª entrevista para confirmação, como descrito no Apêndice IX.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

As entrevistas foram analisadas de acordo com a análise temática proposta por Braun e Clarke (2006), em linha com a epistemologia construcionista proposta pelas autoras. A

definição de prevalência foi feita de diferentes formas, no nível do item, ou de acordo com o número de diferentes participantes que articularam o tema no conjunto de trechos extraídos das entrevistas como um todo; ou a cada ocorrência individual do tema no conjunto de trechos extraídos das entrevistas como um todo (BRAUN; CLARKE, 2006).

A identificação dos temas foi realizada de forma indutiva ou "*bottom up*", sendo possível entender, portanto, que estão fortemente ligados aos relatos coletados. O nível de identificação de tais temas foi, como regra, o semântico, com base nos significados explícitos ou de superfície dos relatos coletados. Para os participantes do Grupo 1, no entanto, em alguns momentos também foi realizada uma identificação latente, dependendo das características de sua comunicação em alguns momentos da entrevista.

Para a familiarização com o *corpus* composto pelas transcrições, as entrevistas foram objeto de duas novas leituras, com a finalidade de propor, inicialmente, uma pré-categorização elaborada manualmente pela pesquisadora, por meio do desenho de um mapa mental para cada objetivo específico proposto, utilizando-se o programa *PowerPoint*, da *Microsoft*. Essa proposta preliminar de categorização foi feita com base: (i) nos potenciais subtemas e temas identificados nas entrevistas; (ii) em categorizações sugeridas pela literatura aplicável, caso tivesse relação com algum potencial subtema ou tema; (iii) na visão integrada dos principais desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, de acordo com a adaptação proposta para as seis áreas principais de RH sugeridas por Doyle e McDougall (2022) e com relação aos achados na literatura no que diz respeito aos próprios profissionais neurodivergentes e com TEA, às entidades de capacitação de profissionais neurodivergentes para o mercado de trabalho e às organizações empregadora, descritas no Quadro 6.

Após esse trabalho inicial, as categorizações foram inseridas no MAXQDA *Analytics* Pro 24.3.0, com o objetivo de estruturar as análises que seriam feitas com a utilização do software e viabilizar a criação dos primeiros códigos de forma mais ordenada. Após revisão e discussão com a professora orientadora do projeto em sessões de orientação, os primeiros códigos, subtemas e temas foram definidos para a análise temática e apresentados no Seminário de Pesquisa da UPM, realizado em 02 de abril de 2024.

Após o evento, outras 4 revisões foram conduzidas, em média, de cada transcrição, com a finalidade de rever: (i) os extratos codificados no MAXQDA *Analytics* Pro 24.3.0; e (ii) o conjunto de dados como um todo. Consequentemente, a cada revisão novos temas foram identificados, tendo outros temas sido agrupados ou separados. Alguns temas e subtemas foram

eliminados, com a finalidade de se evitar a repetição, sobreposição ou colidência com outros temas e subtemas já definidos.

Após a identificação da essência de cada tema, realizou-se uma análise detalhada de como cada tema e subtema se encaixava nos objetivos específicos definidos para a pesquisa. Nesse processo, novos temas e subtemas acabaram emergindo dos trechos analisados e alguns temas e subtemas foram agrupados ou eliminados, em um processo constante de revisão e aprimoramento.

Ao final da análise, foram obtidos relatórios extraídos do MAXQDA *Analytics* Pro 24.3.0, com o retrato final da análise realizada.

Apesar de não haver regras específicas para a condução de uma análise temática, de forma geral, foram seguidos, portanto, os seis passos propostos por Braun e Clarke (2006), que são detalhados no Quadro 12:

Quadro 12. Passo-a-passo para a realização da análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006).

Fase 1. Familiarização com os dados	Além dos trabalhos para a transcrição do material, a transcrição de cada entrevista foi lida por mais duas vezes, com o objetivo de se obter a imersão nos relatos com profundidade e amplitude de conteúdo. Foram feitas notas e anotadas ideias.
Fase 2. Criação dos primeiros códigos	Foram identificados trechos das entrevistas com conteúdo relevante para fins da pesquisa.
Fase 3. Busca por temas	Foram realizadas: (i) a alocação de diferentes códigos em potenciais temas; (ii) análise de como os códigos combinavam entre si para criação de subtemas; e (iii) definição de temas.
Fase 4. Revisão dos temas	Foram feitas cerca de quatro revisões envolvendo: (i) a revisão dos extratos codificados; e (ii) a revisão do conjunto dos relatos como um todo. Consequentemente, a cada revisão novos temas foram identificados; outros foram agrupados ou separados; e alguns foram eliminados, evitando-se a repetição ou colidência com outros temas.
Fase 5. Definição e nomeação de temas	Após a identificação da essência de cada tema, foi feita uma análise detalhada de como se encaixavam nos objetivos definidos para a pesquisa. Novamente, foi dada especial atenção para evitar uma eventual sobreposição de temas. Nova identificação de subtemas para alguns temas surgiu no processo.
Fase 6. Produção do relatório	Foi feita a análise final e elaboração do relatório, em uma versão concisa, coerente, lógica e não-repetitiva, a partir dos trechos obtidos e analisados.

Fonte: Elaborado pela autora.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos dados extraídos a partir dos documentos e dos trechos dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 foi realizada a partir do modelo social da deficiência, diretamente relacionado à neurodiversidade, ao movimento da neurodiversidade e ao paradigma da neurodiversidade, apresentados no item 2.2.2. desta pesquisa. A visão, portanto, é a de que a deficiência é resultado de uma construção social, criada, principalmente, pelo ambiente no qual o indivíduo vive (MCMAHON; LINTHICUM; STOLL, 2021) – e não uma questão associada à pessoa com deficiência propriamente dita.

Além disso, a análise também foi guiada pelo entendimento de Prizant (2023), que, em sua obra "Humano à sua Maneira", afirma que o TEA "não é uma doença. É um jeito diferente de ser humano. Crianças e adultos autistas não são doentes; progridem como todos nós ao longo de determinados estágios de desenvolvimento" (PRIZANT, 2023, p. 22).

Por tais motivos, os termos e a linguagem utilizados para a análise estarão, sempre que possível, alinhados à proposta trazida pelo modelo social da deficiência e pela neurodiversidade. Entretanto, quando necessário para compreensão do tema tratado, alguns conceitos alinhados ao modelo médico ou ao modelo biopsicossocial da deficiência serão aplicados, com a devida indicação. Este é caso do termo "diagnóstico", por exemplo, que revela uma condição médica da pessoa, que é verificada obrigatoriamente por um médico, de acordo com os critérios previstos nos manuais indicados no item 2.1.2. deste estudo.

Neste contexto, os desafios à empregabilidade identificados não serão considerados com relação à pessoa com TEA, mas estarão sempre relacionados a barreiras constatadas no ambiente onde a pessoa com deficiência está inserida, sendo consideradas como "barreira", nos termos do Art. 3º, inciso IV, da LBI:

> [...] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros [...]

Quanto à existência de barreiras, Garcia e Sala (2017) explicam que a CDPD propôs importante alteração no conceito de pessoa com deficiência, ao determinar que a deficiência é o resultado da interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras. De acordo com o mesmo Art. 3º da LBI, as barreiras poderão serão ser urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. A deficiência, portanto, não seria

mais um atributo ou característica da pessoa com deficiência, mas uma consequência das referidas barreiras que são impeditivos para que a pessoa com deficiência participe efetivamente da sociedade.

Para superar tais barreiras, a CDPD prevê a criação de apoios, permitindo autonomia às pessoas com deficiência. Como consequência, tais apoios devem ser desenvolvidos onde haja barreiras que impedem o pleno desenvolvimento e participação das pessoas com deficiência na sociedade, nas organizações e nas suas vidas pessoais. Por tal motivo, a análise foi pautada em dois outros conceitos apresentados no Art. 3º da LBI, nos incisos I e II, respectivamente, quais sejam:

> I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
>
> II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.

De acordo com o indicado no item 2.1.4. da pesquisa, serão utilizados os termos "TEA", "transtorno do espectro autista", "pessoa com deficiência", "pessoa com TEA", "profissional com TEA" ou "indivíduo com TEA" para fins da análise temática, mantendo-se, contudo, referências a "autismo", "autista" ou "Asperger" quando algum participante tiver mencionado tais expressões durante as entrevistas.

Ainda, com relação à linguagem utilizada para identificar as pessoas com TEA nesta pesquisa, apesar da proposta de aplicação da forma *person-first language* (pessoa com TEA) prevista no item 2.1.4., será respeitada e considerada a forma *identity-first language* (autista), caso o participante assim o tenha feito durante o seu relato.

Considerando os compromissos de sigilo e confidencialidade assumidos perante o CEP e individualmente com cada participante como premissa para a participação na pesquisa, a identidade de todas as pessoas entrevistadas e as características das organizações, instituições e entidades sem fins lucrativos onde os participantes dos Grupos 2 e 3 trabalham foram rigidamente preservadas, com exceção da Specialisterne e da AFAPA que expressamente autorizaram a menção a seus nomes empresariais. Por tal motivo: (i) o perfil dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 foi construído com a finalidade de apresentar um panorama do grupo analisado, sem relacionar informações e dados que pudessem levar à identificação de cada um

ou das organizações, instituições e entidades sem fins lucrativos onde atuam, ainda que de forma indireta; e (ii) os trechos das entrevistas realizadas que foram transcritos são mais curtos e objetivos, preservando o contexto da conversa e a história de cada participante.

Tendo em vista o objetivo geral e os objetivos específicos propostos, a análise dos dados foi realizada com a proposta de se construir uma visão geral e integrada dos desafios à empregabilidade de pessoas com TEA, sendo que aspectos específicos de cada tema identificado poderão ser explorados em próximos estudos.

Dos 6 objetivos específicos propostos, 2 foram propostos para cada um dos 3 grupos de participantes. Consequentemente, a análise e distribuição dos temas será feita em consideração tanto aos 3 grupos (Grupos 1, 2 e 3) quanto aos respectivos objetivos específicos propostos para cada grupo, atingindo-se, ao final, o objetivo geral após todas as referidas análises.

Com base no exposto, a análise foi conduzida da seguinte forma: (i) apresentação do perfil dos participantes de cada grupo, em uma visão panorâmica; (ii) definição de temas e subtemas para cada grupo de participantes, de acordo com os objetivos específicos relacionados a tais grupos; e (iii) apresentação de uma visão integrada da temática proposta, a partir dos 3 grupos definidos.

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS 1, 2 E 3

A partir da apresentação dos participantes do Grupo 1 proposta no Quadro 7, constata-se que a média de idade dos participantes com TEA é de aproximadamente 32,5 anos de idade. Com exceção de um profissional com TEA que foi diagnosticado na infância, três participantes receberam o diagnóstico antes dos 20 anos de idade e os demais (n = 15) após essa idade, representando aproximadamente 79% do total de pessoas com TEA que foram entrevistadas, conforme Quadro 13:

Quadro 13. Perfil etário dos participantes com TEA com relação ao diagnóstico.

Idade em que o participante do Grupo 1 relata ter recebido o diagnóstico de TEA (em anos)	**Nº de participantes do Grupo 1**	**Percentual (%) aproximado**
0 a 9	1	5,3%
10 a 19	3	15,8%
20 a 29	8	42,1%
30 a 39 (continua)	5	26,3%

(continuação)		
40 a 49	2	10,5%
Total	19	

Fonte: Elaborado pela autora.

Adicionalmente, de acordo com os relatos obtidos, 12 participantes do Grupo 1 indicaram ter recebido o diagnóstico de TEA nos últimos 5 anos, o que representa aproximadamente 63% do total de pessoas com TEA entrevistadas.

Essas evidências indicam que os resultados obtidos a partir das entrevistas com os participantes do Grupo 1 estão em linha com a percepção do aumento de diagnósticos recentes de TEA e na idade adulta apontada na literatura (NALIN et al., 2022; ROCHA et al., 2023) e constatada nas entrevistas com a Participante Org. 2:

> [...] a maioria recebe um diagnóstico tardio. Então, a maioria na fase adulta mesmo. Nem adolescência assim. Fase adulta mesmo. Muitas pessoas que chegam até nós falando "ah, eu recebi esse ano... eu recebi no ano passado". Então, com certeza, é tardiamente e a maioria que chega para a gente já tem o diagnóstico.

Outro aspecto identificado nos relatos dos participantes do Grupo 1 foi a incidência de coocorrências de outras condições comumente associadas ao TEA; ou diferentes diagnósticos ao longo da vida até a definição do quadro de TEA. A respeito do termo "coocorrências", sugere-se sua utilização por ser apontado como a forma mais apropriada para caracterizar condições psiquiátricas que podem ocorrer de forma concomitante (KAPLAN et al., 2006; PEHLIVANIDIS et al., 2020). Além disso, parece ser a terminologia mais adequada ao modelo social da deficiência, como sugere o *Department of Disability Inclusion and Special Needs* da *University of Birmingham* (2024). Sob a ótica do modelo médico da deficiência, essas condições seriam denominadas "comorbidades" (KAPLAN et al., 2006).

Dentre as coocorrências ou diagnósticos durante a vida citados, destacam-se a bipolaridade, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a ansiedade, a depressão, o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), a dislexia e a Síndrome de Tourette. Algumas coocorrências e diagnósticos foram mencionadas como existindo de forma simultânea em um mesmo participante. O Quadro 14 apresenta os resultados apurados:

Quadro 14. Coocorrências ou diagnósticos diferenciais recebidos pelas pessoas com TEA.

Coocorrências (ou "comorbidades") ao TEA e/ou diagnósticos diferenciais ao do TEA	**Nº de relatos**
Bipolaridade	3
TDAH	8
Ansiedade	4
Depressão	7
TOC	1
Dislexia	1
Síndrome de Tourette	1

Fonte: Elaborada pela autora.

Adicionalmente, 5 participantes do Grupo 1 mencionaram ter recebido o diagnóstico de Altas Habilidades ou Superdotação, o que pode ocorrer com alguns indivídiduos com TEA, conforme explicado por Vilarinho-Rezende, Fleith e Alencar (2016).

Os resultados apurados estão alinhados a estudos conduzidos previamente que indicam: (i) a prevalência de coocorrências, como TDAH, em pessoas com TEA (ANTSHEL; RUSSO, 2019; PEHLIVANIDIS et al., 2020); (ii) o recebimento de diferentes diagnósticos ao longo da vida, antes da definição como pessoa com TEA, principalmente a partir da revisão dos critérios diagnósticos previstos no DSM-V-TR (FRIGAUX; et al, 2021); e (iii) a constatação de superdotação ou altas habilidades em algumas pessoas, que poderá até mesmo alterar algumas características geralmente observadas em pessoas com TEA (BURGER-VELTMEIJER; MINNAERT; VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH, 2011).

No que diz respeito ao nível de escolaridade dos participantes do Grupo 1, aproximadamente: (i) 21% dos participantes concluíram um ou mais cursos técnicos; (ii) 21% estão cursando a primeira graduação; (iii) 42% concluíram a primeira graduação; (iv) 5% estão cursando a segunda graduação; e (v) 11% concluíram a segunda graduação. O nível de escolaridade também foi analisado por gênero dos participantes, de acordo com o Quadro 15:

Quadro 15. Nível de escolaridade por gênero dos participantes do Grupo 1.

Nível de escolaridade	Total	Percentual	Feminino	Percentual	Masculino	Percentual	Outros	Percentual
Cursando 1ª graduação	4	21%	2	25%	2	20%	0	0%
Graduação concluída	8	42%	4	50%	3	30%	1	100%
2ª Graduação concluída	2	11%	1	12,5%	1	10%	0	0%
Cursando 2ª graduação	1	5%	1	12,5%	0	0%	0	0%
Técnico concluído	4	21%	0	0%	4	40%	0	0%
Total	19	100%	8	100%	10	100%	1	100%

Fonte: Elaborada pela autora.

Os resultados poderão contribuir para futuras pesquisas a respeito do nível de escolaridade de adultos com TEA no país, que tenham recebido o diagnóstico nos últimos anos.

Segundo pesquisa conduzida em 2024 pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (FADERS), a respeito das características da população com Transtorno do Espectro Autista no Estado do Rio Grande do Sul, "a grande maioria das pessoas com autismo está frequentando algum nível de escolarização" (CORREIA et al, 2024, p. 40).

Quanto às áreas dos estudos realizados pelos participantes do Grupo 1, observam-se que são de diferentes campos das ciências, contrariando a percepção de que os profissionais com TEA atuariam majoritariamente nas áreas da tecnologia e matemática (SKIBELL, 2017). Ainda, levando-se em consideração que, como indicado no Quadro 15, vários participantes concluíram mais de uma graduação ou curso técnico ou estão cursando uma segunda graduação, mais de um participante pode estar associado às áreas apontadas no Quadro 16:

Quadro 16. Nível de escolaridade por gênero dos participantes do Grupo 1.

Áreas dos estudos realizados pelos profissionais com TEA	Nº de Participantes que estudam ou estudaram as áreas
Tecnologia	3
Jurídico	2
Ciências Sociais	2
Pedagogia	3
Contabilidade	1
Administração	1
Meio Ambiente (continua)	4

(continuação)	
Educação Física	1
Letras	1
Engenharia	2
Psicologia	2
Design	1
Turismo	1

Fonte: Elaborado pela autora.

Se, por um lado, os participantes do Grupo 1 informaram as diferentes áreas de estudos realizados na educação formal, por outro, 42% dos profissionais com TEA confirmaram que trabalham atualmente ou que já trabalharam em áreas diferentes daquelas de sua formação. Tais achados parecem consistentes com os apontados no estudo conduzido por Hurlbutt e Chalmers (2004), que verificaram que, em geral, os profissionais com TEA que participaram de suas pesquisas: (i) não teriam conseguido obter empregos nas áreas nas quais receberam treinamento; (ii) teriam perdido oportunidades de emprego por diversas vezes; e (iii) teriam muita dificuldade em encontrar e manter empregos compatíveis com seu nível de habilidades técnicas. Não foram consideradas as respostas indicando a situação de desemprego para apurar esse percentual. Esse fato pode ser um fator que tem impulsionado alguns profissionais com TEA da pesquisa a procurar por outros cursos e formações, como o visto no Quadro 16.

Os profissionais com TEA informaram o tipo de organização ou a forma de trabalho que realizam atualmente ou que realizaram. Como cada profissional chegou a atuar em diferentes locais e com mais de uma forma de vínculo de trabalho, para definir em qual categoria o profissional com TEA se enquadraria para fins da presente pesquisa, foram considerados os tipos de organização e as formas de trabalho que foram realizadas por um número maior de anos, consecutivos ou não, pelo profissional com TEA. Como resultado, aproximadamente: (i) 31,6% atuam ou já atuaram em empresas de grande porte, assim consideradas aquelas com mais de 500 empregados (AGÊNCIA IBGE, 2023); (ii) 15,8% atuam em startups[3]; (iii) 5,3% atuam ou já atuaram em fundações privadas e associações sem fins lucrativos[4]; (iv) 21% trabalham ou

[3] As startups podem ser definidas como “um modelo de negócio inovador, voltado para um nicho que ainda não foi “descoberto” no mercado” (PUC CARREIRAS, 2023).

[4] As fundações privadas e associações sem fins lucrativos (FASFIL) são “entidades sem fins lucrativos e que se enquadrem, simultaneamente, nos cinco seguintes critérios”: (i) são privadas; (ii) sem fins lucrativos; (iii) são legalmente constituídas; (iv) autoadministradas; e (v) voluntárias (IBGE, 2012, p. 13).

trabalharam em órgãos públicos[5]; e (v) 10,5% optaram por seguir como autônomos[6]. Por sua vez, 15,8% indicaram que estavam desempregados[7] no momento da realização das entrevistas. O Quadro 17 indica o mapeamento realizado:

Quadro 17. Perfil das organizações e da forma de trabalho do Grupo 1.

Tipo de organização ou forma de trabalho	Nº de participantes do Grupo 1	Percentual
Empresas de grande porte	6	31,6%
Startups	3	15,8%
Fundações privadas e associações sem fins lucrativos (FASFIL)	1	5,3%
Órgãos públicos	4	21%
Autônomos	2	10,5%
Desempregados	3	15,8%
Total	19	100%

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir das categorias sugeridas no Quadro 17 para os locais de trabalho e formas de trabalho majoritariamente adotados pelos participantes com TEA, as organizações onde os participantes do Grupo 2 trabalham atualmente foram divididas, no Quadro 18, de acordo com a classificação proposta pelo IBGE, que considera o número de empregados contratados por cada organização para fins de definição de empresas de grande ou médio porte:

Quadro 18. Perfil das organizações onde trabalham participantes do Grupo 2.

Tipo de organização ou forma de trabalho	Nº de organizações por tipo	Percentual (aproximado)
Empresas de grande porte	2	66,67%
Empresas de médio porte	1	33,33%
Total	3	100%

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota-se que os maiores percentuais indicados nos Quadros 15 e 16, relacionados aos locais onde participantes do Grupo 1 trabalham ou trabalharam por mais tempo e onde os

[5] Segundo o IBGE (2024), os órgãos públicos são "criados e extintos por ato do Poder Público", "são integrantes da Administração Pública", "não têm personalidade jurídica própria", "destinam-se à prestação de serviços públicos" e "não têm finalidade lucrativa".

[6] Autônomos "compreendem os proprietários, individuais ou em conjunto com outros, de empresas não constituídas em sociedade, tendo ou não empregados remunerados" (IBGE, 2014, p. 4).

[7] Desempregados são as pessoas "com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir emprego" (IBGE, 2024).

profissionais do Grupo 2 atualmente atuam, respectivamente, são de “empresas de grande porte”.

Por meio da análise documental, envolvendo sites, notícias publicadas pela mídia digital e relatórios publicados por outras organizações que não são necessariamente as indicadas no Quadro 18, constata-se que a contratação de pessoas com TEA é geralmente realizada de forma recorrente por empresas de grande porte e, em sua maioria, multinacionais, que já desenvolveram ou estão em fase de desenvolvimento de programas de neurodiversidade, tais como Danone, AstraZeneca e Takeda (SIMÕES, 2023), Johnson & Johnson e SAP (GOTO, 2022), IBM (SARAIVA, 2021), entre outras.

Essas evidências parecem corroborar o entendimento de que o perfil das organizações que apresentam programas de neurodiversidade e contratam profissionais com TEA de forma recorrente estão, em geral, associadas a organizações de grande porte e, em especial, multinacionais (KRZEMINSKA et al., 2019; OTT; RUSSO; MOELLER, 2022). Entretanto, programas de neurodiversidade e a contratação de pessoas com TEA não são ações restritas e exclusivas de organizações de grande porte. Além da necessidade de cumprimento da Lei de Cotas, é provável que essas organizações apresentem, no momento, condições financeiras mais favoráveis e que recebam diretrizes e apoio de suas respectivas matrizes no exterior para a criação e a divulgação de programas dessa natureza no Brasil.

Questões associadas à implementação dos programas de neurodiversidade e a contratação de consultorias e outras entidades para apoiar as organizações nessa missão serão tratadas nos demais temas propostos na presente análise.

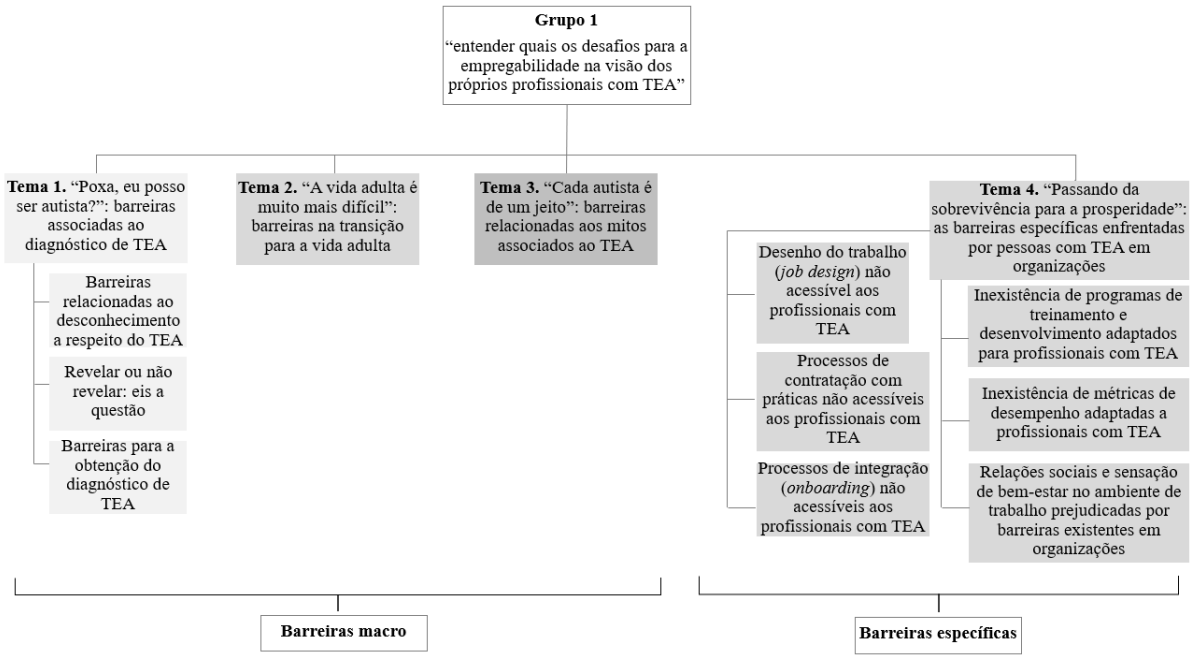
4.1.1 Relatos do Grupo 1

Um dos dois objetivos específicos definidos para a pesquisa e que está relacionado aos participantes do Grupo 1 é “entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais com TEA”.

Os seguintes temas foram estabelecidos para o referido objetivo: (i) Tema 1 – “Poxa, eu posso ser autista?”: barreiras associadas ao diagnóstico de TEA; (ii) Tema 2 – “A vida adulta é muito mais difícil”: barreiras na transição para a vida adulta; (iii) Tema 3. “Cada autista é de um jeito”: barreiras relacionadas aos mitos associados ao TEA; e (iv) Tema 4 – “Passando da sobrevivência para a prosperidade”: as barreiras específicas enfrentadas por pessoas com TEA em organizações.

A Figura 7 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 7. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 4 do Grupo 1.



Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar dos Temas 1, 2 e 3 estarem relacionados direta ou indiretamente com questões associadas ao TEA, não se afirma ou sequer se sugere que ser uma pessoa com TEA ou que as características comumente associadas ao TEA sejam algo negativo ou uma barreira por si só. Diferentemente de estudos previamente mapeados que utilizam, ainda que não de forma expressa, conceitos oriundos do modelo médico da deficiência (LEOPOLDO; COSTA COELHO, 2017; MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021) para identificar desafios de profissionais com TEA no trabalho, a presente pesquisa baseia-se no modelo social da deficiência.

Consequentemente, a análise dos Temas 1, 2 e 3 é feita de forma a: (i) identificar barreiras macro enfrentadas pelos participantes do Grupo 1 em razão do ambiente em que estavam inseridos e das demais pessoas com as quais conviveram, gerando as experiências relatadas nas entrevistas e ora traduzidas em temas nesta análise; e (ii) discutir em que medida tais aspectos poderiam interferir em sua empregabilidade.

Tema 1. Poxa, eu posso ser autista?": barreiras associadas ao diagnóstico de TEA

Para o Tema 1 do Grupo 1, foram definidos os seguintes subtemas: (i) Barreiras relacionadas ao desconhecimento a respeito do TEA; (ii) Revelar ou não revelar no trabalho: eis a questão; e (iii) Barreiras para a obtenção do diagnóstico de TEA.

Barreiras relacionadas ao desconhecimento a respeito do TEA

Considerando que 15 participantes do Grupo 1 receberam o diagnóstico de TEA após os 20 anos de idade (representando aproximadamente 79% do total de pessoas com TEA que foram entrevistadas) e que 12 participantes do Grupo 1 indicaram ter recebido o diagnóstico de TEA nos últimos 5 anos (representando aproximadamente 63% do total de pessoas com TEA entrevistadas), parte dos relatos feitos por esses participantes esteve relacionada às reações e percepções que tiveram e como se sentiram durante a jornada para o diagnóstico de TEA.

Em um primeiro momento, um dos aspectos que se pretende destacar é a alegação de ausência de conhecimento a respeito do que seria o TEA e como seria viver como uma pessoa com TEA, como se percebe a partir da fala do Participante TEA 1 e do Participante TEA 9:

> [...] eu não sabia o que falar porque eu nem conhecia o TEA direito (Participante TEA 1).

> "E como assim? Poxa, eu posso ser autista? Como assim? Esse conjunto de características pode se... traduzir em autismo?" [...] Na época, provavelmente nem sabia os termos direitinho, tive que estudar depois (Participante TEA 9).

A Participante TEA 15 também compartilha da percepção de desconhecimento e desinformação a respeito do TEA em adultos, como o Participante TEA 1, o que a levou a buscar informações por conta própria, como forma de obter alguns esclarecimentos iniciais a respeito do assunto:

> É, eu fiquei um pouco confusa. Por não entender, por desinformação. Aí depois eu pesquisei e começaram a aparecer muitos vídeos para mim sobre autismo e mulheres adultas. E eu comecei a ver esses vídeos de mulheres autistas falando que... sobre o processo de diagnóstico, né? E aí eu... entendi que, realmente, bate muito com as minhas características. Questão sensorial, a questão das habilidades sociais... é porque eu ficava muito confusa [...].

Na perspectiva do modelo social para a análise proposta, registram-se os sentimentos descritos pela Participante TEA 16, pela Participante TEA 7 e pela Participante TEA 11 com

relação às avaliações de seus respectivos modos de agir, ser e de se comunicar feitas por pessoas com as quais conviveram durante suas vidas, provavelmente motivadas pelo mesmo desconhecimento descrito por outros participantes:

> Então, antes eu... Eu não sabia o que era. Imaginava o que era, mas eu senti o que eu sentia, só que eu era "a esquisita" para as pessoas, "a estranha", "a antissocial", "a rancorosa". A pessoa que não tem trava na língua, que fala o que pensa (Participante TEA 16).

> [...] porque era assim que eu me via literalmente, antes de eu saber realmente o que é autismo, essas coisas que meus pais falaram que eu podia ser, que eu não me via como uma ser humana, eu me via como uma criatura, um extraterrestre, um monstro. Sei lá, eu não conseguia mais me ver como ser humana [...]. Bem antes do meu namoro, na escola, eu sempre fui tida como uma estranha, esquisita e não, tipo, "ela é diferente", era "ela é esquisita, ela é estranha", era o mais que eu escutava, não é tipo "ela é diferente da gente" (Participante TEA 7).

> Não mudou muita coisa, não, porque eu sempre fui tratada como uma pessoa que tem deficiência. A questão é que eu era só mais um nome dos tantos nomes que me davam pejorativos - boca de lata, feia, demônia. Várias coisas. Aquilo era só um qualificador, só (Participante TEA 11).

O diagnóstico pode também levar a determinadas concepções prévias das próprias pessoas com TEA a respeito do TEA, resultantes do desconhecimento, como descrevem o Participante TEA 8 e a Participante TEA 11:

> Então, eu tinha uma visão um pouco mais caricata do... mesmo lendo muito *paper* e coisa assim, uma visão muito caricata do que era a experiência autista. [...] Eu tenho ainda aquela imagem bem construída pela sociedade, eu imagino, e que ainda tenho que desconstruir na minha cabeça e coisa assim, de que, por exemplo... é como se um autista, né? (Participante TEA 8).

> Eu mudei a minha visão em relação ao autismo pela leitura do quadrinho da editora Nemo – "A Diferença Invisível", porque eu vi que eu não estava sozinha, porque o autismo só de nome não representa nada. [...] Então, foi um livro... um livro que me fez entender o que é o autismo e ter o hiper foco em autismo (Participante TEA 11).

Diante de situações de desconhecimento ou de imagens preconcebidas a respeito do TEA, outra possível consequência de um diagnóstico recente e na idade adulta para uma pessoa com TEA é a necessidade de avaliar suas possibilidades em termos profissionais e a necessidade de definir quais seriam os apoios para a garantia de acessibilidade no trabalho, como explica a Participante TEA 8:

> É eu... Eu ainda estou digerindo assim, sabe? É a situação. Inclusive, até estou conversando com a minha neuropsicóloga. E perguntando para ela algumas questões relativas, por exemplo, adaptações e suporte, sabe, e a possibilidade de me candidatar agora a concursos públicos como PCD, sabe?

Os achados do presente tema parecem corroborar o entendimento de Casagrande, Galante e Silva (2024), em estudo de caso, com abordagem qualitativa e realização de entrevista semiestruturada com 24 perguntas, de uma profissional com 21 anos de idade e diagnóstico tardio de TEA. Por meio da análise de conteúdo, os autores sugeriram algumas categorias, dentre as quais se destaca para a presente discussão o "processo de diagnóstico e reações", indicando a percepção de sentimentos negativos e desconhecimento da participante com relação ao diagnóstico. A presente pesquisa, entretanto, difere-se do estudo conduzido por Casagrande, Galante e Silva (2024) à medida em que: (i) foi utilizado método distinto para a análise; (ii) foram entrevistados 19 participantes com TEA; e (iii) cada tema foi analisado em profundidade, buscando-se a visão integrada dos Grupos 1, 2 e 3.

Revelar ou não revelar no trabalho: eis a questão

Como explicado por Kidwell, Clancy e Fisher (2023), há custos para pessoas com TEA associados tanto à escolha em si de revelar ou não sua identidade no ambiente de trabalho quanto ao mascaramento (*masking*), quando optarem por não se declarar como indivíduos com TEA. A análise a respeito das ações de mascaramento por pessoas com TEA foram feitas no Tema 11 do Grupo 1, como uma das estratégias adotadas muitas vezes para manutenção de sua empregabilidade.

Ainda, para Kidwell, Clancy e Fisher (2023), a revelação do diagnóstico de TEA é, geralmente, feita pela pessoa com TEA voluntariamente ou de forma proativa, de modo que o profissional com TEA poderá avaliar se e quando deseja comentar a respeito da sua neurodivergência, incluindo para fins de participação em processos seletivos direcionados a pessoas com deficiência para fins de cumprimento da Lei de Cotas, como discutido no Tema 8 do Grupo 1.

Se, por um lado, a revelação do diagnóstico de TEA permitiria a discussão com empregadores e organizações a respeito de apoios necessários e acessibilidade, por outro, há o receio por parte dos profissionais com TEA de que haja discriminação, estigma, preconceito ou outras atitudes negativas e desconfiança por parte de colegas neurotípicos e de gestores (ROMUALDEZ; WALKER; REMINGTON, 2021), como comentam o Participante TEA 9, o Participante TEA 19 e a Participante TEA 11:

> A parte do autismo, eu nunca revelei. Eu acho que no meu trabalho anterior eu revelei. É... mas eu sempre deixei um pouco "pra lá". É... por medo preconceito. Basicamente (Participante TEA 9).

> Olha, eu não queria me expor, assim, para todo mundo que eu era autista, que eu sou...Se eu... Eu só falo se eu sinto necessidade de comentar com alguém. [...] Não, não é para todo mundo que eu falei esse tipo de coisa (Participante TEA 19).

> Dependendo da área, por exemplo, se for educação ou se forem determinadas áreas, porque as pessoas não vão confiar em você, porque você...[...] Dependendo da área, é preferível não falar. Só quando estiver lá dentro, porque eu...Então, dependendo do caso, é melhor ocultar. E outra coisa é não levar para o pessoal negativa (Participante TEA 11).

De um lado, há evidências, observadas nos relatos da Participante TEA 7, de que a revelação do diagnóstico durante a fase de entrevistas, em processos de recrutamento e seleção, não tenha sido recepcionada de forma positiva pelo recrutador:

> Não, eu coloco, sim. Coloco. E teve uma vez que eu não coloquei e eu acabei mandando um currículo errado, sem a informação do autismo. Aí, eu tive uma entrevista que eu participei. Surgiu essa oportunidade. Fiz a entrevista e falei que eu sou autista, mas, quando eu falei, a cara do recrutador mudou, assim, do nada. Negativa, desdém. Aí é, tipo, ele continuou com a entrevista só com essa, com... só com essa cara. Aí depois encerrou normal: "Ó, vou, é, vou ver aqui com meu superior, vou levar alguns dias e eu te retorno". Falou assim. Passou um, não... dias. Como sempre, fala que retornam, mas... só que não. Poucos retornam e aí dá aquele desânimo.

De outro lado, não informar a respeito do diagnóstico durante o processo de entrevistas poderia levar a uma avaliação do profissional com TEA pelo recrutador de acordo com os padrões neurotípicos, sem consideração das potencialidades e eventuais necessidades de apoio da pessoa com TEA, como descreve a Participante TEA 15 em uma das experiências que teve ao optar por não informar que é uma profissional com TEA:

> [...] eu não informei que eu era autista. No feedback, falava que eu fui desclassificada porque eu interrompi uma das colegas 2 vezes. Aí eu não lembrava. Eu não percebi, porque eu, às vezes, eu interrompo sem querer, entendeu? E eu também... Aí, o que ela sugeriu, que ela ficou falando, deu um monte de sugestão de livro de como desenvolver empatia.

Esse cenário acaba por gerar incertezas para o profissional com TEA acerca da sua decisão quanto à revelação de seu diagnóstico, principalmente quanto à obtenção e manutenção de um emprego, podendo ser considerado um tema sensível para discussões, como compartilha o Participante TEA 1:

> Até meados de março de 2023, fui muito recluso em relação ao TEA. Era algo muito delicado para mim. Eu tinha problemas em me aceitar. E vendo outros

> autistas, convivendo melhor no meio autista, eu passei a me aceitar melhor. Tanto que hoje eu falo abertamente para qualquer pessoa que eu prevejo que eu vou ter mais que uma relação casual, eu já deixo claro que eu tenho TEA. [...] E, enfim, teve esse período entre eu conseguir esse emprego até eu começar a me aceitar melhor. Então, era bem... era um pouquinho chato, digamos assim, que eu mantinha bem escondido e tinha vergonha das minhas, das minhas particularidades.

Ao comparar os prós e contras entre revelar ou não sua condição neuroatípica no trabalho, é de se esperar que um profissional com TEA avalie os potenciais benefícios que teria ao se declarar como pessoa com TEA. Caso entenda que não necessite de muitos apoios para superar as barreiras existentes em organizações, a tendência é de que um profissional com TEA opte por não se apresentar como um indivíduo com TEA, até mesmo para permitir que outros profissionais que necessitem de mais suporte possam obtê-lo, como justifica o Participante TEA 9:

> Olha, eu vou falar que eu não tenho opinião definitiva sobre o assunto, porque, de uma certa forma, eu sendo o nível um de suporte e superdotado, além do medo de preconceito, eu também não me declaro porque eu também não quero que a empresa cumpra a cota comigo, sabe? Tipo, é um dos motivos, assim, que... até em empresas em que eu pensei me declarar, eu refreie isso [...]. É, acho que... sei lá, se eu tivesse me revelado, não sei também se as pessoas me dariam instruções mais diretas ou não, ou se iam entender que, geralmente quando eu estou querendo mudar alguma coisa ali, eu estou certo, até porque eu, se eu... se eu não estou muito certo, também não falo. E também eu não gosto de me expor à toa.

Outra situação que pode ocorrer quando uma pessoa com TEA resolve apresentar seu diagnóstico no ambiente de trabalho é a interpretação de que o profissional seria menos capaz do que outros profissionais neurotípicos, confundindo-se a necessidade de apoios com o capacitismo[8], como descrevem a Participante TEA 16 e a Participante TEA 11:

> Eu falei "Não estou entendendo de novo qual que é a postura". E elas não sabiam que eu tinha o diagnóstico, sabe? Mas também eu evito ficar falando, porque, ao invés de você ter acolhimento, porque não quero que ninguém passe a mão na minha cabeça, sabe? Ninguém me transforme numa coitadinha porque eu não me vejo assim. Apesar que foi muito difícil, mas eu não vou falar. O cara tá pisando no meu pescoço e eu vou falar assim "Ó, pode vir pisar de novo, né?" Entendeu? (Participante TEA 16).

[8] Capacitismo pode ser definido como o ato que "ocorre por meio de determinadas formas de tratamento, comunicação e práticas, além de barreiras físicas, arquitetônicas e atitudinais que impedem o pleno exercício da cidadania" pelas pessoas com deficiência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024). De acordo com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (2024), o capacitismo é também considerado como "uma das mais recorrentes formas de preconceito contra pessoas com deficiência", sendo "caracterizado, principalmente, quando se pressupõe que alguém é incapaz apenas pelo fato de possuir alguma deficiência".

> [...] é igual a um caso que aconteceu da pessoa passar num concurso público, mas, por causa do laudo, as pessoas falam “mas você não aguenta pessoas” (Participante TEA 11).

A percepção do Participante TEA 14 é de que, ao não revelar o diagnóstico, alguns profissionais com TEA conseguiriam ter sucesso nas respectivas carreiras e atingir cargos de liderança:

> Enquanto assim, tem pessoas que eu conheço também que tem um diagnóstico também, mas que não expõe. E tá lá assim, no topo das empresas e tal, já tem muitos exemplos de profissionais de alto desempenho nessas empresas, em vários setores.

Um ponto que poderia se caracterizar como um potencial novo achado, caso evidências adicionais sejam obtidas em pesquisas futuras, está relacionado à percepção da Participante TEA 15 e do Participante TEA 14 de que, ao se declararem publicamente como pessoa com TEA e revelar até mesmo em suas redes sociais, ofertas de estágio e de trabalho tenham sido reduzidas drasticamente:

> [...] quando eu coloquei no LinkedIn que eu sou autista no meu perfil, antes eu recebia muita proposta de emprego, porque o meu currículo, ele... Ele é robusto. Eu recebia muita proposta de estágio antes e eu sempre cancelava, porque eu já estava em outros que eu queria mais. Quando eu coloquei que eu sou autista, desde então, eu não recebi mais nenhuma. É, eu percebi isso, viu? Eu percebi. Eu não sei, assim, eu não tenho como comprovar.

> [...] Depois de um tempo eu passei a colocar no meu currículo a observação de que era PCD. E aí, passou também a ser uma dificuldade, porque antes eu tinha essas obras, esses trabalhos. Praticamente, eu mandava currículo [...] e, assim, depois que eu tive as primeiras experiências, pronto, eu não ficava mais parado, até que eu não tinha nenhuma preocupação. [...] Enfim, nunca tinha sido problema. Depois que eu passei a colocar isso no meu currículo, passou a ficar mais raro.

Relato similar foi feito pela Participante Org. 2, no Tema 5 do Grupo 3, quando informa já ter ouvido confissão similar de outros profissionais com TEA que assessora. Caso seja possível corroborar empiricamente tais situações, poderão reforçar o preconceito de empregadores quanto à contratação de pessoas com TEA, como exposto por alguns autores nacionais em estudos prévios (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023.

Independentemente desse reflexo percebido pela Participante TEA 15 quanto ao seu currículo, em sua avaliação, é preferível a revelação de sua neurodivergência em virtude dos apoios e adaptações necessárias para acessibilidade em organizações onde pretende trabalhar,

visando à melhoria de sua qualidade de vida, ainda que isso venha a impactar em sua remuneração:

> Mas eu não vou tirar, porque eu prefiro trabalhar em uma empresa ganhando menos, mas que eu vou... Eu vou ter as medidas de adaptação. Se alguém começar a falar que eu sou grossa, vai ter como resolver. Se eu tiver com alguma coisa, alguma sobrecarga sensorial, eles vão resolver também [...].

Barreiras para a obtenção do diagnóstico de TEA

Como explicado por Rocha et al. (2023) em uma revisão narrativa de literatura, não é algo fora do comum que pessoas com TEA recebam vários diagnósticos equivocados ou com atraso quando da busca por respostas junto a profissionais de saúde. A presente pesquisa diferencia-se do estudo teórico mencionado por se caracterizar como uma pesquisa empírica, conduzida com diversos participantes no Grupo 1 e que levará a uma visão integrada dos desafios à empregabilidade de pessoas com TEA.

De todo modo, corroborando o entendimento de Rocha et al. (2023), a Participante TEA 15 informa conhecer outros estudantes com TEA que passaram pela experiência de diagnósticos errados, além de ela mesmo ter passado pela situação; o Participante TEA 9 explica ter sido tratado para crises de ansiedade, ao invés de considerado seu TEA e seu TDAH; e o Participante TEA 1 relata ter recebido diagnósticos que foram descartados ao longo dos anos, como bipolaridade e TDAH, antes do TEA:

> É, muita gente fala isso, que recebeu o diagnóstico errado [...] Os sintomas... os médicos que não são especialistas e os psiquiatras, eles, psicólogos, eles tendem a confundir os padrões que, às vezes, a gente fica tipo muito para baixo (Participante TEA 15).

> E por muito tempo eu tratei autismo e TDAH como ansiedade, muito tempo (Participante TEA 9).

> Os problemas na infância, adolescência, tanto na socialização é... eu passei por vários diagnósticos que foram descartados ao longo do tempo, desde bipolaridade, TDAH até finalizar com meu autismo (Participante TEA 1).

Pessoas do gênero feminino poderão sofrer ainda mais atraso na obtenção do diagnóstico de TEA, por diferentes motivos, dentre os quais citam-se: (i) a existência de estereótipos preestabelecidos socialmente, como indicam Soares et al. (2023), em estudo teórico de revisão de escopo a respeito das implicações do diagnóstico tardio do TEA em mulheres; e (ii) aspectos associados ao mascaramento e à camuflagem do TEA em mulheres (NORTH, 2021; ORRÚ, 2024; PRICE, 2024), como discutido no Tema 11 deste Grupo 1.

Considerando os diferenciais indicados para a presente pesquisa, descreve-se a experiência da Participante TEA 18, com anos de terapia para endereçamento de diferentes questões pessoais, até o diagnóstico de TEA na fase adulta:

> Eu faço terapia já há muitos anos, eu estava sentindo dificuldade em algumas questões relativas rigidez, principalmente, sabe. Rigidez comportamental, assim, e aí ela me sugeriu. Ela falou assim "por que que você não faz avaliação e tal" [...] Aí eu fiz. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era.

Apesar de ser uma situação observada tanto na literatura quanto nos resultados obtidos nos relatos do Grupo 1, atrasos no diagnóstico de TEA não são exclusivamente observados em mulheres. De acordo com as experiências compartilhadas pelo Participante TEA 8 e pelo Participante TEA 2, pessoas do gênero masculino acabam enfrentando o mesmo problema, o que parece reforçar o entendimento de Nalin et al. (2022), em estudo teórico conduzido por meio de revisão integrativa a respeito dos impactos do diagnóstico tardio do TEA em adultos, de forma geral:

> É, mas o que me levou de fato a chegar nesse diagnóstico agora é que eu estava investigando outra coisa. Eu tenho muitos problemas pessoais, emocionais e de estresse, não sei o quê, de capacidade de fazer as coisas cotidianas e etc. E aí eu tinha procurado consultas psiquiátricas, etc, para observar isso (Participante TEA 8).
>
> Minha mãe sabia que tinha algo de errado, mas não tinha o apoio médico. Minha mãe sempre procurou coisa e falavam "não, uma coisa normal. Tipo assim, passa com a idade" ou qualquer coisa assim (Participante TEA 2).

Nota-se que, como não receberam formalmente o diagnóstico, pessoas com TEA acabam buscando apoio junto a profissionais da saúde em uma tentativa de endereçar questões pessoais que, muitas vezes, surgem em virtude de barreiras enfrentadas.

Outra barreira aparentemente não identificada nos estudos prévios para a presente pesquisa e que poderá, portanto, ser mais bem explorada futuramente diz respeito aos custos envolvidos no processo de diagnóstico de TEA que, como comentado pelo Participante TEA 9, podem representar uma quantia relevante:

> É caríssimo. A pessoa não consegue emprego, porque ela tem lá aquelas características indesejáveis no emprego. Aí ela não consegue nunca pagar aquele, aquele, aquela avaliação que é cara. E aí ela nunca vai conseguir, nem sequer ter acesso a uma consultoria, nem para vaga de entrada.

Tais valores poderiam estar associados a diferentes fatores, tais como (i) a necessidade de diferentes avaliações da pessoa que busca o diagnóstico de TEA que serão conduzidas por equipes multidisciplinares, envolvendo diversos profissionais de saúde; (ii) os atrasos e

equívocos no diagnóstico de TEA, como mencionados neste tema, que podem levar ao início e reinício de avaliações; e (iii) a ausência de políticas públicas especificamente voltadas para as pessoas com TEA e que favoreceriam o diagnóstico mais célere. Há também aspectos associados à cobertura de avaliações e procedimentos por planos de saúde, para aqueles que utilizam a rede particular de saúde, que poderiam impactar da mesma forma nos custos.

De todo modo, equívocos ou atrasos em geral na obtenção do diagnóstico de TEA parecem gerar consequências como as indicadas pelo Participante TEA 9 – aumentar as barreiras para ingresso no mercado de trabalho e a empregabilidade de profissionais com TEA. Isso porque, sem o laudo, os indivíduos com TEA não poderão concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência para atendimento da Lei de Cotas, potencializando a percepção dos participantes do Grupo descrita no Tema 8 do Grupo 1 de que organizações parecem dar preferência a outros tipos de deficiência para contratação em vagas afirmativas.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 1 do Grupo 1 foram organizados no Quadro 19:

Quadro 19. Visão geral dos subtemas do Tema 1 do Grupo 1.

Subtemas do Tema 1 do Grupo 1	**Descrição das barreiras macro identificadas nos subtemas do Tema 1 do Grupo 1**
Barreiras relacionadas ao desconhecimento a respeito do TEA	Ausência de conhecimento a respeito do TEA pela pessoa com TEA ao receber o diagnóstico tardio e de como seria viver como uma pessoa com TEA. Falta de informações corretas e precisas a respeito do TEA para pessoas com TEA que receberam diagnóstico tardio. Concepções prévias equivocadas das próprias pessoas com TEA ao receber o diagnóstico tardio. Manifestações negativas de pessoas com as quais conviveram durante a vida em razão de diferentes formas de ser, de se manifestar e de se comunicar que algumas pessoas com TEA podem apresentar. Necessidade de definição de apoios específicos a cada pessoa com TEA para garantir acessibilidade no trabalho.
Revelar ou não revelar no trabalho: eis a questão	Receio de profissionais com TEA de que haja discriminação, estigma, preconceito ou outras atitudes negativas e desconfiança de colegas neurotípicos e gestores ao revelar o diagnóstico de TEA. Percepção de que a revelação do diagnóstico de TEA por profissionais com TEA durante entrevistas não seria bem recepcionada por recrutadores. Percepção de que a ausência de revelação do diagnóstico de TEA durante o processo de recrutamento e seleção poderia levar a uma avaliação do profissional com TEA de acordo com padrões neurotípicos. Sensação de um cenário de incertezas pelo profissional com TEA a respeito de revelar ou não o diagnóstico de TEA no trabalho. Percepção de que não haveria muitos benefícios na revelação do diagnóstico de TEA no trabalho por profissionais com TEA que necessitam menos apoios para acessibilidade. Percepção de que a revelação de diagnóstico de TEA no trabalho levaria a potencial capacitismo. Percepção de que não revelar o diagnóstico de TEA no trabalho poderia ajudar a ter sucesso na carreira e atingir cargos de liderança. Percepção de que a revelação de diagnóstico de TEA publicamente poderia levar à redução de ofertas de vagas de emprego e estágio.
Barreiras para a obtenção do diagnóstico de TEA	Obtenção de diagnósticos equivocados por pessoas com TEA, levando a atrasos no diagnóstico de TEA. Percepção de que pessoas do gênero feminino poderiam sofrer ainda mais com o atraso na obtenção do diagnóstico. Altos custos envolvidos no processo de obtenção do diagnóstico de TEA. Percepção de que os atrasos na obtenção do diagnóstico de TEA poderiam aumentar as barreiras

(continua)

(continuação)	para ingresso no mercado de trabalho e impactar negativamente a empregabilidade de profissionais com TEA. Impossibilidade de concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência para atendimento da Lei de Cotas pelo atraso na obtenção do laudo específico.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 2. "A vida adulta é muito mais difícil": barreiras na transição para a vida adulta

Segundo Chun et al. (2022), a transição para a vida adulta pode ser um processo complexo, por envolver diferentes domínios da vida de uma pessoa, como educação, trabalho, vida de modo independente, comunidade, saúde e relações sociais. Esse cenário pode ser particularmente desafiador para profissionais com TEA, por terem, muitas vezes, que lidar com questões com as quais não estavam acostumados, como comentam o Participante TEA 1 e a Participante TEA 18:

> A vida adulta é muito mais difícil, ter que conciliar tanta coisa ao mesmo tempo. A minha mente não lida muito bem. [...] Só de pensar em ir para a faculdade, eu começava a ter um *shutdown* e acaba que esse semestre é o primeiro que eu estou tentando mudar, que eu peguei 2 matérias quando eu costumava pegar 5 e eu já estou conversando com o colegiado, com o NEI, núcleo de estabilidade de inclusão, que dá suporte aos PCD na universidade, de uma forma de montar uma estratégia para que eu possa ter um percurso acadêmico saudável (Participante TEA 1).

> Ah, foi difícil, foi difícil, porque, nossa, eu lembro que eu fazia muita coisa. É fazer estágio, fazia monografia, estudava para a OAB, um monte de coisa junta e eu tinha muita dificuldade mesmo de planejar e executar (Participante TEA 18).

Como explica Monteiro (2014), a inserção profissional de uma pessoa é tradicionalmente associada ao estabelecimento da identidade adulta do indivíduo. No entanto, segundo o IBGE (2022), o desemprego e a informalidade são maiores entre as pessoas com deficiência, dentre as quais são consideradas as pessoas com TEA. Os relatos parecem indicar dificuldades para a obtenção dos primeiros empregos, como explicado pela Participante TEA 7, ou para recolocação no mercado após optar inicialmente por constituir uma família, de acordo com o Participante TEA 17:

> Também teve uma época desse período de 2016-2017. Teve um dia que minha mãe me fez acordar cedo. Ela ainda foi comigo. Ela fez questão de acordar cedo, me fez acordar cedo para andar no centro de Santo Amaro. Parar em agência de entrevista, para ficar distribuindo currículo. [...] Teve uma vez eu mandei para uma agência nessa região de Santo Amaro. Eu vi ela pegando meu currículo e eu peguei ela no flagra, tipo, eu estava descendo uma hora, estava ouvindo... Quando eu olhei, eu consegui ver meu nome, eu falei: "Ela rasgou o meu currículo?" (Participante TEA 7).

> Depois de 6 anos e meio em casa, a gente fica desacreditado das potencialidades, né? Então, eu fiquei com muito medo [...]. E aí, assim... poucas entrevistas, assim, de muitas vagas na área de assistente administrativo, gestão de projetos que eu trabalhava ou vagas PCD. Só 3 entrevistas eu consegui em 2019 (Participante TEA 17).

Quanto aos estudos na transição para a fase adulta, o Participante TEA 1 e a Participante TEA 15 compartilham algumas barreiras associadas à forma como são estruturados os cursos superiores no Brasil e como isso pode dificultar a obtenção do diploma por pessoas com TEA:

> A faculdade é um desafio, porque ela não entra 100% no meu foco. [...] Eu sou extremamente prático, eu sou extremamente relacionado com o mercado, com o que eu vejo no dia a dia com o que eu poderia melhorar para a vida das pessoas, enquanto o meio acadêmico é um pouco diferente. Isso fez com que a faculdade se tornasse uma grande coisa para lidar (Participante TEA 1).

> Na faculdade, mudam os horários todos. Aí, é extremamente difícil ter uma rotina na faculdade, se a gente tem mudança de horários, não tem previsibilidade, porque tem que trabalhar de acordo com os horários da faculdade. Você tem que fazer seus horários da faculdade e depois pensar em quais horários vão sobrar para você poder trabalhar. E é horrível. [...] outras pessoas que também estão tendo muita dificuldade para se formar e as pessoas que trocam de curso o tempo inteiro. Então, eu acho que esse modelo de faculdade não funciona muito. Primeiro, presencial, totalmente presencial e muito longo e que... eu acho que a gente podia fazer que nem algumas faculdades dos Estados Unidos, que dá para a gente escolher as matérias. [...] Seria bom para a gente pegar matérias isoladas, poder escolher (Participante TEA 15).

A conciliação entre o trabalho e os estudos é também uma barreira relevante para as pessoas com TEA, como descreve o Participante TEA 1, que teve que solicitar o trancamento de vários semestres do curso, por sentir que não conseguiria concluir, ou acabou reprovando por faltas:

> Eu tranquei 2 de 4 semestres e um que eu não tranquei. O primeiro semestre foi tranquilo, que eu consegui passar em tudo. Apesar das dificuldades, o segundo semestre eu tranquei completamente. O terceiro eu tranquei metade das matérias. Uma delas eu reprovei, uma das que eu não ia. Eu reprovei por faltas. Outras 2 eu passei e o quarto semestre, que foi o último, eu tranquei novamente, então, está sendo uma trajetória complicada.

Tema 3. "Cada autista é de um jeito": barreiras relacionadas aos mitos associados ao TEA

Como apresentado no item 2.1.2. desta pesquisa, o diagnóstico de TEA é feito com base em manuais de categorização nosológica, como a CID e o DSM, que estabelecem critérios

para a definição de TEA do ponto de vista clínico. Entretanto, isto não significa que toda e qualquer pessoa com TEA será exatamente igual e necessitará dos mesmos apoios para garantir acessibilidade, principalmente em uma situação de emprego. Como destacam Alvarez-López et al. (2014), os mitos sobre o TEA podem ser constituídos a partir do "*conocimiento empírico de la sociedad*", de modo que não representam necessariamente informações falsas, mas o senso comum a respeito de algum assunto.

Por se caracterizar como um espectro, a combinação de diferentes características de uma pessoa com TEA, além da potencial coocorrência com outras neurodivergências e até mesmo altas habilidades e superdotação, faz com que cada indivíduo seja único e precise ser compreendido em sua individualidade. Caso tais diferenças sejam desconsideradas, por exemplo, por uma organização, corre-se o risco da criação de barreiras adicionais para a empregabilidade da pessoa com TEA. O Participante TEA 2, a Participante TEA 18 e o Participante TEA 1 comentam um pouco a respeito desse cenário, em suas respectivas avaliações:

> [...] a contratação tinha que ser uma coisa mais individualizada nesse sentido, porque, querendo ou não, falando no autismo – não no caso da pessoa com deficiência como um todo, mesmo podendo valer – é um espectro. Tem várias características que, muitas vezes, aparecem em uma, outras vezes não aparece em outro (Participante TEA 2).
>
> [...] Então, o que que a empresa deve fazer que eu acho é saber que cada autista é único, então, quando a pessoa chega no ambiente, perguntar quais são as suas dificuldades, entendeu? Porque, por exemplo, eu não tenho problemas sensoriais, mas eu tenho outros tipos de questão (Participante TEA 18).
>
> Ouvir e compreender como todo autista é particular. A única pessoa que vai saber adaptar aquele ambiente para o autista é o próprio autista. Porém, como o autismo é bem particular, sempre vai ter coisas diferentes (Participante TEA 1).

Caso se parta do pressuposto de que todos os profissionais com TEA teriam problemas atrelados à interação social (SZULC, 2021) e que preferem o trabalho remoto (SZULC, 2022), um empregador poderia sugerir um modelo de trabalho totalmente remoto e sem muitas interações com uma equipe, como sendo ajustes aplicáveis a todos os profissionais com TEA. Mas, ao ouvir as preferências da Participante TEA 18, nota-se que trabalhar com times, até mesmo com grande número de pessoas, não seria necessariamente um problema a ser superado e que há uma tendência ao equilíbrio quanto ao regime de trabalho presencial e remoto:

> Então, eu, por exemplo, eu tenho uma sociabilidade maior. Eu, por exemplo, eu gosto de falar em público, eu me sinto bem ali. [...] Já trabalhei em time também, já trabalhei em equipes grandes, inclusive eu gostava até, sabe? Eu não achava ruim, achava bom isso. Às vezes, até me faz um pouco de falta.

> Porque é, por exemplo, no home office. Eu gosto de um home office. É prático e tal, mas eu não consigo fazer todos os dias da semana home office, porque eu preciso variar aquele ambiente. Li um pouco, sabe, então, eu fico no meio termo entre gostar muito de trabalhar em equipe, atender o público e, às vezes, ter um momento ali sozinha e tal.

O Participante TEA 1 esclarece que, apesar de se sentir cansado após interações sociais, sente falta do que denomina "calor humano" e do contato com as pessoas. Logo, não necessariamente precisar ter seus momentos para regulação representaria uma ausência de vontade de interagir com outras pessoas:

> Sim, porque eu gosto muito desse calor humano, dessas relações no escritório, mas eu fico muito cansado. Eu tenho meu próprio... eu tenho minha própria rotina, minha própria forma de organização, que não dá para aplicar no escritório. Dá para aplicar aqui em casa, então, acaba que trabalhar em casa é muito melhor, mas eu ainda sinto falta das pessoas.

A análise a respeito do regime de trabalho em si (presencial, remoto ou híbrido) foi aprofundada no Tema 5, quando da discussão a respeito de desenhos de trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA. Mas, para fins de exemplos de diferenças entre indivíduos com TEA proposta neste Tema 3 do Grupo 1, algumas pessoas com TEA que declararam ter recebido o diagnóstico de TDAH em conjunto ao TEA, como o Participante TEA 8 e o Participante TEA 2, avaliam que o regime exclusivamente remoto potencialmente aumentaria distrações que entendem que não teriam no formato presencial de trabalho:

> Exato e, por certos modos, e aí eu não sei se é pelo... acho que é mais pelo TDAH do que pelo autismo, eu imagino que... não todo dia, mas alguns dias indo presencialmente, vai até ser um benefício eu estar no escritório, porque reduz a quantidade de distrações que eu posso me sujeitar ou que vão me acontecer. [...] Eu estando tipo, fisicamente no escritório, eu me sinto tipo "eu estou aqui para trabalhar", eu vou só trabalhar e não tem lá muita coisa que vai me distrair, exceto mais coisas de trabalho, então, assim fica mais direcionado (Participante TEA 8).

> O meu cargo tem que bater ponto e tudo mais, mas também eu, pessoalmente, prefiro, porque em casa eu não consigo me concentrar (Participante TEA 2).

Outra característica apontada geralmente como sendo típica de pessoas com TEA são limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017). Novamente, com base nessa constatação, poderá haver dúvida de empregadores quanto à capacidade de profissionais com TEA de interações com outros profissionais neurotípicos, caso seja feita uma avaliação generalizada de todos os profissionais com TEA. O relato da Participante TEA 13, por sua vez, demonstra algo bem diferente quanto que se é esperado:

> Eu falo, sempre tive facilidade para falar e tal. É, e eu acho que eu não realmente não aparento muitas características que se espera em relação ao autismo, a não ser que você conviva muito. Por isso que eu acho que meu psicólogo, que me viu toda semana, percebeu mais fácil.

Tais constatações, contudo, não significam que nenhum profissional com TEA terá dificuldades de interação social ou comunicação, mas tão somente reforçam a necessidade de se conhecer cada profissional com TEA para fins de definição de suas necessidades de apoio. A Participante TEA 16, em seu relato, já indica que sempre teve como uma barreira a convivência social em ambientes não inclusivos:

> Não era só questão, por exemplo, na escola, de aprendizagem, mas era também um jeito... na maneira comportamental, porque eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de entender as pistas sociais e me senti inadequada às vezes. Por mais que eu sou boa para conversar e por eu ter feito terapia a vida inteira. E foi isso que realmente.... O que me salvou. [...] Por exemplo, na parte social, foi a que mais tinha dificuldade para me relacionar com as pessoas. Eu tinha, às vezes, livros de imagem corporal, por exemplo, de como que era o gesto de cada pessoa, desde uma paquera na adolescência, por exemplo, me demonstrar o que que era motivo de querer ter algum interesse comigo. E eu sempre tive aquela dificuldade, mais quieta. Não conseguia fazer o que minhas amigas faziam.

Há também a ideia de que profissionais com TEA estariam restritos a áreas relacionadas a tecnologia e matemática, como indica o Participante TEA 14:

> O pessoal também tem uma imagem de que é autista, então vai trabalhar com números, com tecnologias. Não necessariamente.

De acordo com o perfil das áreas de estudos dos participantes do Grupo 1 indicada no Quadro 16, contudo, observa-se que as pessoas com TEA podem ser de diferentes campos das ciências, contrariando a percepção de que os profissionais com TEA atuariam majoritariamente nas áreas da tecnologia e matemática (SKIBELL, 2017).

Os achados discutidos neste tema indicam a necessidade de se reavaliar conceitos e padrões estabelecidos na literatura que abordam pessoas com TEA como se fossem um grupo único, com características similares e, logo, com necessidades de apoios iguais. Ainda, há a percepção de que estudos prévios têm se baseado provavelmente em indivíduos com TEA que demandam níveis de suporte maiores, o que não parece ser a realidade de profissionais que têm recebido o diagnóstico já na fase adulta de suas vidas.

À medida em que se compreende melhor o espectro do TEA e que mais indivíduos recebam o diagnóstico tardiamente, recomenda-se que mais pesquisas e discussões sejam

conduzidas para endereçar a questão e desenhar o potencial novo panorama de empregabilidade de profissionais com TEA.

Os achados descritos nos Temas 2 e 3 do Grupo 1 foram organizados no Quadro 20:

Quadro 20. Visão geral dos Temas 2 e 3 do Grupo 1.

Temas 2 e 3 do Grupo 1	**Descrição das barreiras macro identificadas nos Temas 2 e 3 do Grupo 1**
"A vida adulta é muito mais difícil": barreiras na transição para a vida adulta	Conciliação de diferentes questões da vida pessoal e profissional, com as quais a pessoa com TEA não estava acostumada. Barreiras para a obtenção do primeiro emprego por profissionais com TEA. Barreiras para a recolocação profissional de profissionais com TEA. Barreiras associadas à forma como os cursos superiores no Brasil são estruturados (mudança constante de horários de aulas, tendência de que as aulas sejam mais teóricas do que práticas, aulas presenciais). Conciliação entre a vida acadêmica e a vida profissional de pessoas com TEA. Atrasos na conclusão de cursos superiores por profissionais com TEA. Mudança de cursos superiores por profissionais com TEA, levando a atrasos no início da vida profissional.
"Cada autista é de um jeito": barreiras relacionadas aos mitos associados ao TEA	Compreensão de que todas as pessoas com TEA seriam iguais e necessitariam dos mesmos apoios. Desconsideração da individualidade de cada profissional com TEA por organizações para identificação dos apoios necessários. Percepção de que todos os profissionais com TEA não gostam de interagir com outras pessoas e que preferem o isolamento. Percepção de que todos os profissionais com TEA preferem trabalhar em regime exclusivamente remoto. Percepção de que profissionais com TEA não seriam capazes de conversar e interagir com outros colegas neurotípicos. Percepção de que todos os profissionais com TEA deveriam trabalhar em áreas relacionadas a tecnologia e matemática.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 4. "Passando da sobrevivência para a prosperidade": as barreiras específicas enfrentadas por pessoas com TEA em organizações.

Para o Tema 4, utilizou-se como inspiração o evento organizado pela ONU em 02 de abril de 2024, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, intitulado "Passando da sobrevivência para a prosperidade: pessoas com autismo compartilham suas perspectivas" (ONU, 2024). A proposta do Tema 4 é, portanto, abordar barreiras específicas enfrentadas por pessoas com TEA em organizações, com base nas seis áreas principais de RH sugeridas por Doyle e McDougall (2022), discutidas no item 2.3.3. do presente estudo, que potencialmente estariam dificultando a empregabilidade de profissionais com TEA.

Com base nas referidas seis áreas de RH e a partir da aplicação dos conceitos de acessibilidade[9] e de desenho universal[10] previstos na LBI, foram propostos os seguintes subtemas para este Tema 4 do Grupo 1: (i) Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA; (ii) Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA; (iii) Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA; (iv) Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA; (v) Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA; e (vi) Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações.

Como discutido nessa pesquisa, a temática tratada neste Tema 4 do Grupo 1 refere-se a um objetivo específico que também foi associado aos participantes do Grupo 2 e 3. Será discutida, posteriormente, a visão integrada dos participantes dos três grupos (Grupos 1, 2 e 3) a respeito das barreiras específicas em organizações para a contratação e inclusão de profissionais com TEA no trabalho, que levem à identificação dos desafios para a empregabilidade das pessoas com TEA.

Desenho do trabalho (job design) não acessível aos profissionais com TEA

Um potencial novo achado obtido por meio do relato da Participante TEA 15 diz respeito à percepção de que conhecer mais sobre o ambiente e a rotina do trabalho poderia auxiliar na acessibilidade de profissionais com TEA a cargos em organizações:

> [...] não é importante pensar só no que você gosta de estudar, mas é mais importante ainda pensar em como é o ambiente de trabalho e a rotina de trabalho depois que você vai estudar. [...] pensando tanto nas emoções, nas sensações, do que a gente está.... Como que a gente ia reagir, como seria o convívio interpessoal. [...] Pensar na rotina de trabalho é mais importante do que pensar no que você gosta, porque, às vezes, você consegue até uma área mais interdisciplinar.

---

[9] Art. 3º da LBI, inciso I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

[10] Art. 3º da LBI, inciso II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.

Essa percepção é compartilhada pelo Participante RH 6 no Tema 5 do Grupo 3, quando notou redução na rotatividade de pessoas com TEA contratadas após inserir em seu processo de contratação uma etapa para a familiarização do profissional com TEA com o ambiente de trabalho e as principais rotinas que seriam desenvolvidas pelo recém-contratado.

Além da rotina, a duração da jornada de trabalho parece ser outro achado que também impacta a acessibilidade de pessoas com TEA a vagas de emprego, como explica o Participante TEA 17:

> E o engraçado é que a Specialisterne... o turno dela não é de 6 horas, é de 8 horas. [...] Porque eles entendem que a gente é uma vaga regular.

Adicionalmente, a solicitação de demandas após o horário regular de trabalho poderia levar a uma sensação de desconforto para pessoas com TEA, conforme experiência descrita pela Participante TEA 7 em local onde trabalhou, quando a gestora ligava para ela e pedia para retornar ao local de trabalho, mesmo já tendo informado a saída no ponto de controle de jornada:

> Ela me fazia voltar para o trabalho depois do expediente, já teve 2-3 vezes. Eu marcava ponto na hora de ir embora e eu saía.
> E aí, o que acontecia? Estava no ponto de ônibus. Eu estava pegando meu ônibus e recebia mensagem celular no celular: "Volta para a empresa agora" E eu falei: "Gente, mas já deu meu horário". [...] Ela não me dava escolha. E eu não tinha coragem de me impor e falar "não é meu horário, eu vou embora, não vão fazer eu voltar". Eu fiz isso umas 2-3 vezes e eu lá terminando e assim eu não recebia. Eu não recebia pelo horário extra, porque – claro! - porque eu marcava ponto na hora de ir embora.

A este respeito, esclarece-se que a jornada padrão de trabalho no Brasil é de oito horas diárias[11], não podendo ultrapassar quarenta e quatro horas semanais[12]. Considerando as especificidades de pessoas com TEA, que necessitam muitas vezes de apoio para a realização de suas tarefas laborais, e as eventuais coocorrências comumente associadas ao TEA, que podem levar à necessidade de atendimento clínico regularmente e consumo de medicação específica que poderá ter efeitos colaterais, muitos desses profissionais ainda não teriam condições de enfrentar horas tão extensas de trabalho em um único dia. A impossibilidade de rever a duração do tempo padrão que o empregado deve ficar à disposição do empregador em organizações também parece ser um motivo que afastaria os profissionais com TEA do mercado

[11] Art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite (BRASIL, 1943).

[12] Art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal do Brasil (CF) - XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (BRASIL, 1988).

de trabalho brasileiro, tendo em vista que cada pessoa com TEA é diferente e poderá necessitar de apoios específicos. Essa percepção é compartilhada pela Participante Org. 2 no Tema 5.

Como apontado por Hurlbutt e Chalmers (2004) e Garbin et al. (2022), a ausência de oferta de vagas de emprego compatíveis com a formação dos profissionais com TEA parece ser uma barreira para a contratação de pessoas com TEA. Tal fato é reforçado pelo trecho da fala do Participante TEA 14:

> Uma coisa que eu vejo que é comum, que eu relatei, é a questão das vagas, de sempre receber vagas operacionais, tudo. Eu nunca entrei num processo desse, mas eu conheço pessoas que entraram e pessoas que tiveram formação numa área, mas só com poder conseguir emprego teve que mudar radicalmente de área, ir para uma área operacional, e muitas vezes a pessoa tem um currículo muito bom, mas por entrar numa vaga PCD, a pessoa vai morrer naquele cargo. Assim, eu já ouvi esse relato de pessoas assim, sabe? Entrou como assistente administrativo e passar 20 anos a ser assistente administrativo. [...] eu já acompanho algumas páginas com vagas, mas mesmo essas páginas nunca encaixam em nenhuma vaga que eles divulgam. [...] Tem até uma empresa que eu vejo que divulga muitas vagas e eu vejo que eles postam vagas interessantes. de coordenador, supervisor, mas nunca é algo que eu me encaixaria fazendo. Coordenador de marketing. Em outras áreas do setor econômico, negócio, finanças. Eu não me encaixaria.

Para alguns profissionais com TEA, a existência de vagas para atuação em home office ou, ao menos, regime híbrido de trabalho seria um diferencial para ampliar a possibilidade de contratação de profissionais com TEA, como comenta a Participante TEA 15 e a experiência descrita pelo Participante TEA 9:

> E isso era uma das coisas que eu levo em consideração também para ir para essa área, porque nessa área tem muita possibilidade de home office que em quase nenhuma outra área tem (Participante TEA 15).

> Então, acho que é bem perceptível, olhando em retrospectiva, foi, por exemplo, quando a gente passou do presencial para o online. As minhas relações, elas se fortaleceram no online. Ao contrário de todo o resto do mundo “Cara, não. A relação presencial é melhor”. No online, eu consegui ficar muito mais aberto, assim. Por conta dali, da timidez excessiva do presencial. No online, as minhas relações tanto com a minha área quanto com outras áreas fortaleceram muito. Tomando retrospecto, eu posso falar (Participante TEA 9).

Parte das questões associadas ao regime de teletrabalho envolve a sobrecarga sentida por pessoas com TEA com o trajeto entre a residência e o trabalho, como informado pelo Participante TEA 1:

> É porque eu tive muita dificuldade de ônibus, com ônibus. Eu ainda tenho, mas eu peguei o costume. Então é ter que pegar ônibus. É estressante, extremamente estressante ter que gente demais no mesmo espaço. É extremamente tenso. Eu chego em casa muito deslocado, não pelo trabalho.

> Se eu viesse do trabalho direto para casa, se eu trabalhasse do lado de casa, eu não ia chegar a metade, com metade da esgotamento que eu chego em casa. A maior parte do estresse do trabalho vem daí, da volta.

Apesar de reconhecer os benefícios do regime remoto de trabalho, o Participante TEA 17 reconhece que o contato presencial em alguns dias na semana facilitaria a organização de demandas e tarefas com seus gestores:

> Isso, 2 dias por semana eu vou no presencial e 3 eu fico em casa. Eu prefiro. Eu prefiro. Apesar que, assim, quando a gente está presencialmente, as demandas e projetos que a gente tem é... se resolvem com muito mais facilidade quando está presencial, porque eu e minha chefe sentamos do lado e a gente está em intenso contato. Quando está online, eu preciso que ela esteja livre de alguma reunião.

A falta de previsibilidade e horários fixos em alguns tipos de trabalho, como em consultorias, pode ser apontada como uma barreira para alguns profissionais com TEA, de acordo com a experiência compartilhada pela Participante TEA 15:

> [...] e também lá tinha um grande problema de que não tinha horário fixo. Às vezes, eles precisavam que a gente ficasse há mais tempo e, assim... aí depois folgava, entendeu? Por causa do ritmo da demanda. [...] Essa falta de horários me deixava muito ansiosa, porque, às vezes, eu já tinha planejado na minha cabeça de fazer alguma coisa. Aí, chegava de última hora e não. E mudava. E eu ficava, assim, eu entrava em crise mesmo.

Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA

No que diz respeito aos processos de contratação, a percepção do Participante TEA 5, que se declara publicamente como pessoa com TEA e informou que tem procurado vagas destinadas a pessoas com deficiência, é de que, apesar de participar de entrevistas e indicar os apoios de que precisa, não tem sido contratado por organizações:

> Quando eu sou chamado, quando eu sou chamado para entrevista, eu faço entrevista, explico os suportes que eu preciso, que eu necessito, mas, infelizmente, não venho sendo chamado.

Quando questionado a respeito de quais apoios geralmente solicita em entrevistas de emprego, o Participante TEA 5 descreveu que necessita de um ambiente com menos ruídos e menos distrações, por conta do transtorno de ansiedade, uma das coocorrências comumente associadas ao TEA:

> Então, às vezes... é que eu tenho crise de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, que é uma comorbidade que eu tenho por conta do autismo, e eu também transpiro muito, por conta da ansiedade. Essa ansiedade causa

> transpiração e a gente fica nervoso. Então, eu preciso de um ambiente mais calmo, com menos ruídos, assim, para não dispersar e, infelizmente, acabo sendo dispensado da entrevista por conta de que muitos não entendem o nosso lado. O lado do autista.

A Participante TEA 16 compartilhou experiências similares com ausência de retorno de recrutadores após participar de entrevistas – o que, inclusive, a estimulou a procurar a atuação como profissional autônoma:

> Quando eu estava na situação de fazer a seleção para as pessoas que entram na empresa, era uma vivência. Quando eu espero a questão do resultado da seleção é outra vivência. E me deixa muito angustiada, quando eu faço processo seletivo e que os líderes não dão devolutiva e o feedback de quem passou ou não passou na entrevista ou no cargo, sabe, que vai exercer. Por exemplo, há 1 ano atrás eu fiz uma entrevista para trabalhar numa clínica. Até hoje estou aguardando o resultado. [...] Mas não tiveram o cuidado de falar "olha, não é para esse momento, a sua situação para o cargo, as suas competências, então, fica para uma próxima oportunidade". Então, nem isso foi feito para humanizar de uma maneira melhor com relação à contratação ou não.

Possivelmente, um dos motivos para a ausência de êxito dos candidatos com TEA seja o fato de que os processos de contratação parecem tentar definir talentos de forma mais restritiva e excessivamente baseados no desempenho do candidato em entrevistas, como explicado por Szulc (2021). Levando-se em consideração que a tendência é que: (i) as pessoas com TEA apresentem características próprias de comunicação e compreensão de situações sociais, como apresentado por Leopoldino e Costa Coelho (2017); e que (ii) como exposto no Tema 4 do Grupo 3, os profissionais de gestão de pessoas e RH de organizações ainda não teriam conhecimento a respeito do TEA e da neurodiversidade (KHAN et al., 2022), o desempenho de um profissional com TEA em uma entrevista padrão, apurado mediante o uso de métricas padrão, seja considerado inferior ao de outros candidatos neurotípicos, levando à sua desclassificação. A fala da Participante TEA 15 reforçaria essa possível interpretação, ao comentar a respeito da utilização de dinâmicas de grupo em processos de recrutamento e seleção para profissionais neurodivergentes:

> Na etapa de dinâmica de grupo, eu nunca passei em nenhuma dinâmica de grupo. Aí eu não conseguia nem passar para as próximas etapas. Porque, quando eles reprovam, eles já reprovam na dinâmica de grupo, eles não deixam passar para as próximas. Nem se você tiver competência técnica. Ou seja, se você não tiver, tipo, um bom desempenho na dinâmica de grupo, de acordo com o que eles esperam, você já é desclassificado só pelo perfil comportamental. Tem algumas empresas que ainda colocam testes de personalidade. E como que... eu fico pensando: às vezes, uma pessoa que tem algum transtorno mental, nem precisa ser autista, mas algum, qualquer transtorno mental, talvez não passe nesses testes de personalidade.

Tanto o conhecimento prévio a respeito do TEA quanto a tendência de uma organização de se comportar de forma socialmente desejável poderiam influenciar de forma significativa em suas percepções a respeito dos candidatos com TEA às vagas de emprego, como apontado por McMahon, Henry e Linthicum (2021). A contrário senso, quanto menor o conhecimento de profissionais de gestão de pessoas e RH ou menor a tendência de adoção de práticas inclusivas por organizações, menores seriam as chances de contratação de profissionais com TEA em práticas de recrutamento e seleção regulares.

Quanto à adaptação de processos seletivos, de acordo com o explicado pelo Participante TEA 9, participar de entrevistas online seria uma forma de facilitar a sua interação:

> Posso falar que as entrevistas online me ajudam imensamente. Me é muito mais fácil quebrar essa barreira no online. E, depois que ela é quebrada, tudo bem.

A Participante TEA 16 reforça a necessidade de adaptações específicas para cada profissional com TEA desde a sua contratação e de um trabalho próximo a ser desenvolvido pelo gestor envolvido no processo de contratação:

> Eu acho que nós temos que trabalhar essa questão mesmo dos gestores que forem fazer a seleção dos novos candidatos, colocar isso em pauta, porque, por exemplo, a maioria aprende de uma maneira diferente, mas todos aprendem. Eu acho que tem que ser muito personalizado essa questão do trabalho, das funções que o candidato for fazer e ser contratado dentro de uma empresa.

O Participante TEA 1, que atua na área de tecnologia, compartilha a sua vivência em processos seletivos da sua área de atuação, informando que não seriam comuns dinâmicas de grupo, mas somente a avaliação das competências técnicas do profissional com TEA para uma determinada função:

> Não é comum, eu nunca vi nenhuma, nunca ouvi falar de processos seletivos na minha área com dinâmica de grupo. No meu caso, foi o quê? Desenvolver uma aplicação, aplicação simples, do zero. Depois, dar manutenção e melhorar uma aplicação que eles já tinham - uma outra coisa bem simples, e depois foi entrevista técnica em tempo real. Programar em tempo real, enquanto meu superior assistia - e foi bem tranquilo, não teve nada.

A este respeito, sugere-se a investigação em estudos futuros em que medida o desenho do trabalho e dos processos de contratação da área da tecnologia favoreceria a empregabilidade de pessoas com TEA na tecnologia e, portanto, atrairia mais candidatos, não representando

necessariamente uma tendência de pessoas com TEA a trabalhar com tecnologia simplesmente em razão das características do TEA.

Processos de integração (onboarding) não acessíveis aos profissionais com TEA

Os processos de integração de profissionais com TEA à organização e às equipes devem também ser adaptados como forma de reduzir barreiras. Como identificado por Leopoldino e Costa Coelho (2017), pessoas com TEA poderão sentir algumas limitações na comunicação e o Profissional TEA 17 descreve como apoio para superar barreiras comunicacionais a possibilidade de se comunicar por escrito:

> Grande parte dos trabalhos, sou eu e minha chefe, mas há projetos que eu tenho que ter interações, não extensas, mas mínimas com os outros e para mim não tem problema. O que eu tenho dificuldade é, assim, ter que ligar para o escritório. Aí eu tenho muita dificuldade. Mas se eu puder escrever um e-mail, se eu puder mandar um Teams, aí, tá tudo certo. Assim não tem problema.

Para o Participante TEA 9, o maior desafio estaria em iniciar conversas, mas informa que não teria problemas em continuar uma conversa em um segundo momento:

> Por exemplo, o meu problema sempre foi começar conversas, mas nunca foi continuar conversas. Então, uma vez que pessoas vieram falar comigo sobre qualquer coisa, isso fluiu.

Uma das adaptações que poderiam ser implementadas em uma organização para oferecer apoio para aqueles que sentem restrições para iniciar conversas, como o Participante TEA 9, seria criar espaços para que os profissionais neurotípicos e neuroatípicos se conheçam e compartilhem interesses em comum, não restringindo o contato de uma pessoa com TEA apenas a outras pessoas com TEA:

> Eu acho também que, na primeira semana, seria muito bom ter uma coisa, assim, para a socialização, alguma medida assim. A gente gosta de conversar sobre nossos hiper focos, né? Então, seria interessante você perguntar se tem alguma pessoa ali que gosta de RPG. Se alguém gosta de RPG também na empresa, facilita a comunicação.

No que diz respeito a algumas dificuldades associadas ao ambiente físico do trabalho ou estresses na mudança de rotina, como mapeado por Szulc (2022), algumas adaptações poderão ser implementadas a pedido do profissional com TEA, como forma de viabilizar a sua integração ao trabalho. O relato do Participante TEA 1 dá exemplos de como apoios foram implementados de acordo com as suas necessidades:

> Então, eu fui pedindo pequenas adaptações, como flexibilidade de horário, uma rotina mais rígida e uma certa tolerância. Alguns problemas, como comunicação, certa tolerância, e se eu tiver que sair do escritório por alguma crise por estar sobrecarregado. E um lugar fixo para manter rotina, que foi uma coisa que eu pedi também no final e a empresa foi bem solícita - e até hoje, com qualquer problema, com qualquer detalhe.

Ao analisar o trecho da fala do Participante TEA 1, constata-se que a sua percepção é de que a organização onde trabalha tem atendido de forma satisfatória aos seus pedidos. De forma similar, o Participante TEA 17 explica que, por meio da relação com sua gestora direta, conseguiu desenvolver fluxos de trabalho e organização de tarefas que favorecem a sua atuação:

> Quando eu entrei no trabalho, a gente criou uma forma de aprendizado e uma forma de passar as tarefas, eu e ela para acostumar como seriam as demandas.

Apesar desses achados que sugerem existir apoio por parte de organizações para a integração do profissional com TEA no trabalho, o relato do Participante TEA 9 indica que ainda haveria uma ausência de compreensão de empregadores, como apontado por Baldwin, Costley e Warren (2014):

> Então, assim, eu acho que os profissionais autistas podem buscar estabelecer, sempre que o ambiente de trabalho permitir. Infelizmente, não são todos que permitem, mas estabelecer ali como que é a melhor forma de se comunicar e qual a melhor forma de trabalhar e buscar grupos de apoio.

Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA

Como avaliado por Johnson et al. (2020), constatam-se oportunidades limitadas de engajamento e crescimento para profissionais neurodivergentes em organizações, o que é suportado pelo relato do Participante TEA 4:

> Eu comecei como empacotador, só que aí eles fecharam o setor. Aí me passaram para reposição, mas, por conta dos imprevistos, na parte de carrinho, que o cara saiu. Eu tive que ser remanejado de setor para ocupar o espaço. Aí, quando eu estava na empresa de varejo, eu comecei, como é pequena, na parte de estoque, mas, como fechou por conta da pandemia, eu não tive tanto tanta experiência, não fiquei tanto tempo lá.

Provavelmente, um dos motivos para tanto seria uma compreensão ainda limitada de gestores a respeito de como apoiar da melhor forma profissionais com TEA no ambiente de trabalho (DREAVER et al., 2019). Para aprimorar o conhecimento a respeito da neurodiversidade e de profissionais com TEA no trabalho, algumas organizações têm

desenvolvido programas de neurodiversidade. Como parte dos referidos programas de neurodiversidade e dentre as ações conduzidas por organizações são oferecidos treinamentos adaptados para pessoas com TEA, realizadas palestras, organizados grupos de afinidade e outras estratégias para favorecer o desenvolvimento dos profissionais com TEA.

O que se nota, entretanto, é que profissionais com TEA que trabalham em organizações que contratam pessoas com TEA têm a percepção de que essas iniciativas nem sempre contam com a adesão da força de trabalho:

> Eu participei, eu participo, mas eu vejo que é um pouco esvaziado, não tem muita interação assim, sabe? "Ah, hoje tem a semana do PCD". Aí tem uma inserção desse grupo, mas durante esses 6 meses que eu estou como integrante, não teve muita interação. Ou eu estou por fora ou realmente não teve.

Além disso, de acordo com a experiência compartilhada pelo Participante TEA 9, não haveria muitos grupos dedicados especificamente à discussão da neurodiversidade, sendo a temática tratada em conjunto com outras pessoas com deficiência:

> Eu acho que a constituição de grupos de afinidade, então, é sempre muito bem-vindo, apesar de eu não ter conhecimento nenhuma empresa que tem um grupo só de autistas. Geralmente, a neurodiversidade, ela é discutida em grupo de PCDs.

Não ter espaços dentro da organização para a discussão de aspectos específicos da neurodiversidade e para endereçar os apoios mais adequados para pessoas com TEA pode levar à frustração de profissionais com TEA com iniciativas propostas por organizações para treinamento e desenvolvimento. É o que demonstra a Participante TEA 15, ao compartilhar sua experiência com treinamentos propostos pela organização onde trabalha para pessoas com deficiência em geral, sem respeitar as individualidades de cada pessoa e os suportes para cada tipo de deficiência:

> Olha, eu acho que o treinamento foi um pouco ruim. Foi ruim porque, assim, eles misturaram todo mundo. [...] Aí, tem pessoas muito diferentes. Então, assim, o pessoal estava em níveis também diferentes de aprendizagem. [...] Eu acho que não é porque é todo mundo PCD que tem que ir no mesmo ritmo, entendeu?

Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA

Conforme explicado por Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013), de maneira geral, empregadores tendem a apresentar maior interesse nas habilidades sociais (*social skills*)

dos empregados do que em suas habilidades cognitivas. O relato da Participante TEA 13 corrobora essa constatação:

> É, vai depender muito da empresa para que as adaptações sejam feitas. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que talvez eu pudesse mudar em todas as empresas. É assim "olha, você tem um trabalho, tipo uma atividade, a pessoa precisa saber fazer essa atividade". Ela não tem que ser obrigada a ser a pessoa que vai te bajular, vai ser, sei lá, super sociável com você. Que vai ser parte da "família da empresa", sei lá. Se a pessoa está fazendo o trabalho dela, é isso. "Estou entregando as coisas todas no prazo. As coisas ficam bem-feitas. Nunca recebi nenhuma crítica quanto ao meu trabalho. Agora ainda sou obrigada a ficar tendo essa resposta social". Não faz sentido.

Além disso, segundo Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013), há evidências científicas de que a relação entre sucesso acadêmico e sucesso na carreira seriam, na realidade, moderadas. Essa percepção de empregadores quanto às habilidades de profissionais parece afetar diretamente as métricas de desempenho aplicadas a profissionais com TEA sem qualquer adaptação, assim como a sua empregabilidade (MCMAHON; HENRY; LINTHICUM, 2021), como é possível confirmar com o relato da Participante TEA 15:

> Para a gente não ficar estagnado, tipo, no mesmo nível de carreira, sendo que, às vezes, a gente tem habilidades técnicas, por mais que não tenha todas as habilidades do mundo, tem habilidades para prosseguir. E é assim com todo mundo, né? Todo mundo tem um ponto forte e ponto fraco.

Entre os achados da presente pesquisa e possíveis contribuições para a proposta de adaptação de métricas de desempenho para profissionais com TEA, são sugeridas: (i) a definição de critérios objetivos e organizados de modo a passar uma previsibilidade para o profissional com TEA a respeito do que deve ser feito e o que é esperado que se faça; e (ii) a flexibilização de critérios relacionados a aspectos de socialização, conforme apresentado pela Participante TEA 15:

> Mas, no feedback, e, ainda, no *performance review*, eu acho que é importante se deixar metas e objetivos claros para a pessoa. Isso e ser mais flexível na questão social. [...] Porque, às vezes, a gente não vai seguir, mas a gente nem sabia que era para cumprir uma meta. Como que eu vou cumprir uma coisa que eu não sabia que eu precisava? Não vai ter sentido. Então, é importante ter essa previsibilidade. Talvez, assim "ó, para você atingir o cargo tal, você precisa fazer tipo um checklist". "Você precisa atingir isso, isso, isso e isso". Se você não atingir, você nunca vai passar.

Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações

Barreiras nas organizações podem impactar negativamente a sensação de bem-estar ou as relações sociais de pessoas com TEA com os demais profissionais neurotípicos e até mesmo seus gestores (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Phung et al. (2021) explicam que essas interações poderão levar a diferentes situações vivenciadas por pessoas com TEA, como o *meltdow*n, o *burnout* no TEA, a inércia (*inertia*) e o *shutdown*.

Para Phung et al. (2021), o *meltdown* poderia ser descrito como um fenômeno que poderá ser demonstrado de diferentes formas por pessoas com TEA quando se sentem sobrecarregadas, com falta de controle e estresse acumulado.

Por meio de um estudo conduzido com 32 adultos com TEA, Lewis e Stevens (2023) definiram seis temas que capturariam a experiência de se ter um *meltdown*: (i) sentir-se sobrecarregado por fatores informacionais, sensoriais, sociais ou emocionais; (ii) experimentar emoções extremas, como raiva, tristeza e medo; (iii) perder a lógica, o que envolve desafios com pensamento e memória; (iv) lutar por autocontrole, quando o participante da pesquisa relatou ter perdido contato com si mesmo; (v) conseguir liberar emoções, o que foi descrito pelos participantes da pesquisa como uma "explosão" de comportamentos externos ou autolesão; e (vi) minimizar prejuízos sociais, emocionais ou físicos, ao evitar gatilhos ou se auto isolar quando possível.

A este respeito, o relato do Participante TEA 17 descreve uma situação de imprevisto ocorrida no trabalho que levou a um episódio de *meltdown*, como descrito por Lewis e Stevens (2023):

> Eu tive que ficar só no notebook, eu tinha que fazer muitas conferências e isso me desregulou a tal ponto. Aí vieram imprevistos na hora, coisas urgentes e eu me desregulei totalmente.

Já a Participante TEA 4 relatou sentir uma vontade de chorar no trabalho por não compreender o que estava sentindo em determinadas ocasiões, o que também parece estar alinhado à análise feita por Lewis e Stevens (2023) quanto a um episódio de *meltdown*:

> Eu tinha um mal-estar e aí tinha um choro. Era tipo uma vergonha que eu ficava. Me sentia assim, porque eu não sabia o que eu estava sentindo e aí vinha o choro.

Como apontado por Raymaker et al. (2020), adultos com TEA com frequência compartilham experiências de *burnout* no TEA (*autistic burnout*) e os resultados negativos dessa situação. Phung et al. (2021) descrevem o *burnout* em pessoas com TEA como sendo a exaustão severa e crônica em função de aspectos comumente associados ao TEA, como o mascaramento, discutido no Tema 11 deste Grupo 1.

Com a finalidade de contribuir para o conceito de *burnout* em pessoas com TEA, Raymaker et al. (2020) realizaram uma pesquisa empírica com 19 indivíduos com TEA e, por meio da análise temática, descreveram as características primárias do *burnout* no TEA, como sendo exaustão crônica, perda de habilidades e tolerância reduzida a estímulos. Para os autores, o burnout no TEA aconteceria em razão de: (i) fatores da vida da pessoa com TEA, que acumulariam a carga sensorial vivenciada, e (ii) existência de barreiras que não permitiriam o alívio dessa carga, levando a pessoa com TEA a impactos negativos em sua saúde e qualidade de vida. A percepção dos participantes do estudo conduzido por Raymaker et al. (2020) é de que também haveria falta de empatia por parte das pessoas neurotípicas com relação ao *burnout* no TEA. Os aspectos do *burnout* no TEA (*autistic burnout*) o diferenciaria do *burnout* ocupacional ou da depressão clínica (RAYMAKER et al., 2020).

A Participante TEA 7 e o Participante TEA 8 alegam terem tido episódios de *burnout* em suas vidas profissionais, sem terem, contudo, o diagnóstico específico de *burnout* dado por um médico. Com base nas sensações descritas pelos participantes do estudo de Raymaker et al. (2020), a experiência descrita pela Participante TEA 7 e pelo Participante TEA 8 parecem refletir, na realidade, o que seria o *burnout* no TEA (*autistic burnout*), sendo que a falta de compreensão dos gestores e colegas de trabalho neurotípicos e da própria organização teriam contribuído para o quadro:

> E também teve uma vez que essa empresa aí que, realmente, eu quase entrei no período de *burnout*, que eu chegava na empresa, mesmo tendo dormido bem, esgotada, a ponto de querer chorar. Estava já estava com aquela sensação: "Eu não estou crescendo nessa empresa, eu estou muito estagnada até, principalmente, na vida". Inclusive, uma pessoa nova do RH percebeu isso em mim, contou para o chefe dela e falou: "Vamos romper o contrato, porque ela falou que, para mim, você está muito desanimada. E a gente não quer que te afete. Isso afeta o seu dia a dia, tanto pessoal quanto aqui. A gente vai romper seu contrato, vamos te demitir" (Participante TEA 7).
>
> [...] O *burnout*, assim, eu não cheguei ao ir médico para ele me diagnosticar assim como *burnout*, mas eu percebi os sintomas, porque eu procurei ler e entender o que é *burnout*. Aí, simplesmente apresentei sintomas, que são os sintomas de esgotamento físico e mental. Eu já estava tendo choro, choro muito excessivo, que eu me lembro como fosse hoje. Teve um período no trabalho que eu chegava na empresa, eu marcava meu ponto, ligava meu

> computador, mas depois eu ficava no banheiro chorando uns 5 minutos (Participante TEA 7).
>
> *Burnout*, especificamente, me é um pouco mais etéreo, porque nunca me foi explicado. Eu nunca olhei, pesquisei muito a fundo especificamente o que classifica ou não como *burnout*, mas eu sei de um caso em particular, de que uma época aí que eu tive um *burnout* muito violento, ou algo que eu imagino que seja *burnout*, que era uma época que estava trabalhando numa empresa que me cobrava demais para um cargo que eu estava muito abaixo do que eles estavam esperando. O nível de responsabilidade que estavam jogando para cima de mim e estava estudando presencialmente. [...] E aí, com isso, por exemplo, eu cheguei à conclusão, tipo, não dá para continuar nesse emprego aqui, eu vou trocar. E aí foi a primeira vez que eu troquei de emprego. Tive *burnout* por estar numa empresa que era menos compreensiva (Participante TEA 8).

Phung et al. (2021) também sugerem uma definição para o que denominam de inércia (*inertia*), considerada como o estado mental prolongado de uma pessoa com TEA de se sentir "presa", tendo como consequência a impossibilidade de fisicamente se engajar em atividades que a pessoa com TEA gostaria de fazer. Outra situação definida por Phung et al. (2021) seria o *shutdown*, que, na visão dos autores, seria semelhante ao *meltdown*, mas que refletiria experiências internas vivenciadas por uma pessoa com TEA. Neste caso, o indivíduo com TEA sentiria a necessidade de se retirar do ambiente onde se encontra e teria sentimentos negativos.

A Participante TEA 7 comenta ter passado por situações de *shutdown* no trabalho, mas que conseguiu ter o apoio da sua supervisora para conseguir lidar com as sensações que experimentou:

> Eu tinha o *shutdown*, que era a sobrecarga. Eu ficava muito cansada, às vezes, de muita exposição [...]. Quando a minha supervisora percebia, ela falava "você está bem?". Eu falei "tô, estou só um pouquinho tonta, essas coisas", e ela "vai lá pra sala, vai lá pro escritório, respira um pouco".

Já a Participante TEA 15 reconhece ter experimentado tanto o *meltdown* quanto o *shutdown*, descrevendo as sensações que teve e como isso afeta a sua vida profissional, por sentir que não consegue sequer se levantar para trabalhar:

> Os médicos que não são especialistas e os psiquiatras e os psicólogos tendem a confundir os padrões. Às vezes, a gente fica muito para baixo. Já tive situações em que eu fiquei tão para baixo que eu não conseguia levantar e falar assim. Ou, então, ficar muito agitada e, inclusive, no emprego. Eu já tive umas situações, assim, que eu tive que pegar atestado, de tão ansiosa e alterada que eu estava. Eu fico alterada, aí eu começo a chorar muito, a gritar ou então eu fico muito cansada a ponto de não conseguir nem me levantar da cama. Então, às vezes, acho que a médica confundia isso com mania e depressão. [...] Quando acontece isso, fica impossível trabalhar.

Há similaridades com o relato do Participante TEA 10, que compartilhou ter entrado em uma situação de inércia e *shutdown* após ter sido excluído de um treinamento promovido pela organização onde trabalhava, sem que seus gestores tivessem comunicado adequadamente a situação a ele e, após o ocorrido, não teriam entrado em contato para saber como ele estava e se sentia:

> Aí fui embora, não fui trabalhar no outro dia também e acho que já era sexta-feira. Aí fui na segunda. Fui nessa semana seguinte e eu não sei se foi na outra ou logo depois, mas foi no máximo assim, duas, três semanas. Chegou um dia em que eu não consegui levantar da cama, não consegui trabalhar, simplesmente não fui. Ninguém me ligou, ninguém quis saber de nada. Deu segunda, deu terça, ninguém ligou. Acho que foram ligar lá para quarta, quinta-feira. E aí pensei "é, tem algo errado aqui". [...] Foi quando eu marquei o psiquiatra.

Na relação com colegas e gestores neurotípicos, pode também haver a impressão de que a solicitação de apoios específicos para superação de barreiras no ambiente de trabalho poderia conferir um tratamento especial às pessoas com TEA no ambiente organizacional, como indicado em estudo conduzido por Spoor, Bury e Hedley (2021) em organização que implementou programa de empregado voltado para profissionais com TEA. O relato da Participante TEA 15 indica que essa situação, de fato, poderá ocorrer:

> E outra coisa era a questão do ar-condicionado. Teve uma época que o acondicionado ficou estragado, fazendo muito barulho e eu pedi para o meu chefe para ficar em casa, em *home office*, enquanto não arrumasse. E ele falou que não podia, porque, se ele me deixasse de *home office*, ele ia ter que deixar todo mundo.

Além disso, com relação a festas e confraternizações que ocorrem na organização, a percepção da Participante TEA 15 e do Participante TEA 17 é de que precisariam participar de toda forma, por ser uma espécie de regra social corporativa do mundo neurotípico e que a sua ausência estaria sujeita a comentários de colegas e gestores:

> As questões das festas de fim de ano era outra coisa que era muito difícil, porque, se você não fosse ficar, quem não ia, o pessoal ficava comentando depois (Participante TEA 15).

> [...] Porque, queira ou não, a gente é atípico, mas está no mundo neurotípico e essas coisas contam. Então, assim, eu prefiro fazer só essa aparição, conversar com algumas pessoas e ir embora, sabe? (Participante TEA 17).

O modo como os demais colegas neurotípicos podem reagir a diferentes formas de ser, de se manifestar e de se comunicar que alguns profissionais com TEA podem apresentar

constitui fator que afeta a sensação de bem-estar de pessoas com TEA em organizações. É o que se percebe das experiências relatadas pelo Participante TEA 5 e pela Participante TEA 15:

> Quando eu estava numa empresa atacadista, não me dava muito bem com algumas pessoas. Algumas pessoas já faziam chacota e era muito complicado também. [...] Eu sou uma pessoa muito discreta também, então, às vezes, eu acabo, por receio de não ser muito bem aceito, eu fico sendo uma pessoa mais discreta (Participante TEA 5).

> Eu acho que lá na empresa onde eu trabalhei as meninas me achavam arrogante por causa das respostas que eu dava também. Por exemplo, me convidava para sair. Aí, eu falava que não queria, só que aí depois alguém me chamava e falava que tinha ficado com raiva, que a pessoa tinha ficado com raiva. Eu só falava que não tinha querido ir e ficava me perguntando por que, entendeu? (Participante TEA 15).

Uma das formas de mitigar os efeitos de tais barreiras seria a ampliação do conhecimento a respeito da neurodiversidade, principalmente por meio de programas de neurodiversidade.

Como discutido no Tema 4 do Grupo 3, a implementação de programas de neurodiversidade parece ter relação tanto com a maturidade da área de gestão de pessoas e dos programas de compliance e de inclusão e diversidade de uma organização quanto com o orçamento dedicado para tanto. Constata-se, assim, uma tendência de que tais programas existam em mais entidades de maior porte do que em outras de menor tamanho.

Esse cenário pode fazer com que indivíduos com TEA prefiram tentar obter vagas de emprego em organizações de maior porte, por apresentarem programas de diversidade e inclusão ou mesmo de neurodiversidade, ainda que essa mudança possa representar um reinício de carreira e uma aceitação de redução na remuneração compatível com seu nível de experiência, como descreve a Participante TEA 15:

> Não é que eu vou ganhar menos, mas eu vou retroceder um pouco no nível que eu estava, porque eu tive que mudar de área, porque na área que eu estava antes, as empresas, elas são menores e empresa menor nenhuma tem um programa de inclusão e diversidade. Só empresa muito grande e tem departamentos só de inclusão e diversidade. [...] Eu estava pesquisando muito sobre isso e muito focada. Só que aí eu falei que eu acho que eu ia ter mais chances nessa área, entendeu? Só que eu não ia ter inclusão, porque as empresas são pequenas e eu ia ter tanto esse problema social. Estava me desgastando tanto.

Ainda, há indícios de que questões relacionadas à sensação de bem-estar e saúde mental no ambiente de trabalho seriam fundamentais para profissionais neurodivergentes para a escolha de um emprego, como compartilha a Participante TEA 15:

> A prioridade é seguir na minha área de maior interesse ou a prioridade é ter a maior qualidade de vida, o que inclui saúde mental? Principalmente nessa parte. E a questão também sensorial, talvez segurança sensorial, imagino que seja o nome. E a questão de relacionamento interpessoal. Então, eu acho que isso para mim vale muito mais do que salário e do que, tipo, me manter na carreira que eu já tinha construído, que eu já estava quase para ser assim... eu já estava fazendo o trabalho de pessoa sênior. Então, eu conseguia tocar o projeto inteiro sozinha, desde a parte do estagiário até a função sênior. Eu já conseguia fazer sozinha porque eu tinha aprendido muito.

Também indicando a importância de se manter relacionamentos saudáveis no trabalho, o Participante TEA 2 comenta que não necessariamente a quantidade de pessoas com as quais possui interação poderia ser considerada uma barreira, mas a qualidade desse relacionamento:

> É assim, uma turma muito maior – e eu não sei até que ponto até quantos que começariam a me incomodar na minha sala. Mas, na minha sala, são quatro ou cinco pessoas, então, não é um grupo grande, não é uma coisa que me dá problema, mas também comigo acho que a qualidade da pessoa, ter uma interação saudável com a pessoa, então, daí é mais tranquilo. Mas se são pessoas que eu vou ter dificuldade sempre, então, pode ter duas pessoas na sala que eu, às vezes, posso já ficar incomodado.

A sugestão apresentada pela Participante TEA 15 é de que os empregadores passem a disponibilizar salas sensoriais para permitir que as pessoas com TEA consigam obter apoios que precisam em situações de estresse ou de sobrecarga emocional ou sensorial:

> É ter um ambiente, uma sala para a gente, quando estiver passando por alguma crise emocional, sensorial, social, descansar, tipo, isolar quando tiver algum barulho lá fora, uma obra.

Outra sugestão que poderia ser implementada, de acordo com a Participante TEA 15, é com relação a festas e outras confraternizações corporativas, dando a opção de ambientes com menos estímulos para que as pessoas com TEA possam também desfrutar desses momentos, como preferirem:

> E nas festas também. E, tipo assim, eu também quero ir nas festas para comer coisas gostosas, entendeu? Só que seria bom, tipo, ter um ambiente e que não é todo mundo também que gosta de música alta mesmo. Mesmo quem é neurotípico, tem gente que não gosta. Tem um ambiente em que a música está mais baixa. E para quem quiser ficar lá, não só a gente. E a gente ficar lá e ficar, tipo, com alguns jogos, porque os jogos facilitam muito a interação.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 4 do Grupo 1 foram organizados no Quadro 21:

Quadro 21. Visão geral dos subtemas do Tema 4 do Grupo 1.

Subtemas do Tema 4 do Grupo 1	**Descrição das barreiras específicas identificadas nos subtemas do Tema 4 do Grupo 1**
Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA	Ausência de conhecimento prévio pelo profissional com TEA sobre as características do ambiente de trabalho e a rotina de trabalho. Falta de flexibilidade para o profissional com TEA na duração da jornada de trabalho padrão. Ausência de oferta de vagas de emprego compatíveis com a formação de profissionais com TEA. Poucas ofertas de vaga em home office ou regime híbrido para profissionais com TEA. Falta de definição de horários fixos e previsibilidade para profissionais com TEA em algumas áreas, como consultorias.
Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA	Ausência de retorno ao candidato com TEA ao aplicar para vagas de emprego em geral. Ausência de retorno ao candidato com TEA ao aplicar para vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência. Ausência de retorno ao candidato com TEA após informar em entrevistas a respeito dos apoios necessários. Utilização de dinâmicas de grupo como etapa eliminatória para profissionais com TEA em processos de contratação. Ausência de adaptação de processos seletivos para profissionais com TEA para a modalidade online. Ausência de adaptações específicas para profissionais com TEA de acordo com suas características e necessidades.
Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA	Ausência de disponibilização de meios de comunicação por escrito para profissionais com TEA, como aplicativos e softwares. Ausência de interação dos profissionais da organização neurotípicos com profissionais com TEA. Ausência de ambientes e momentos para socialização na organização acessíveis para profissionais com TEA.
Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA	Falta de treinamento para as funções que serão desempenhadas pelo profissional com TEA. Baixa adesão e participação de profissionais da organização em programas e iniciativas voltadas à neurodiversidade e pessoas com deficiência. Ausência de programas especificamente voltados para pessoas com TEA. Ausência de individualização de treinamentos para os diferentes tipos de deficiência.
Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Ênfase em habilidades sociais (*social skills*) para fins de avaliação do profissional com TEA. Ausência de parâmetros para avaliação de habilidades técnicas de profissionais com TEA. Ausência de critérios objetivos e plano de carreira para profissionais com TEA.
Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Situações no trabalho que levam a episódios de *meltdown* de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam ao burnout no TEA (*autistic burnout*) de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam a episódios de inércia (*inertia*) de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam a episódios de *shutdown* de profissionais com TEA. Sensação de falta de compreensão de gestores e demais colegas neurotípicos em situações de *meltdown*, *burnout* no TEA (*autistic burnout*), inércia (*inertia*) e *shutdown* de profissionais com TEA. Impressão de profissionais neurotípicos e gestores de que apoios necessários para superação de barreiras na organização são forma de tratamento especial a profissionais com TEA. Sensação de pressão social dos demais colegas neurotípicos para participação em festas e confraternizações corporativas. Manifestações negativas de colegas neurotípicos e gestores em razão de diferentes formas de ser, de se manifestar e de se comunicar que alguns profissionais com TEA podem apresentar. Percepção de que programas de neurodiversidade só existiriam em organizações de grande porte, restringindo opções de emprego e carreira para profissionais com TEA. Percepção de profissionais com TEA de que precisam reiniciar carreiras constantemente por falta de acessibilidade em organizações.

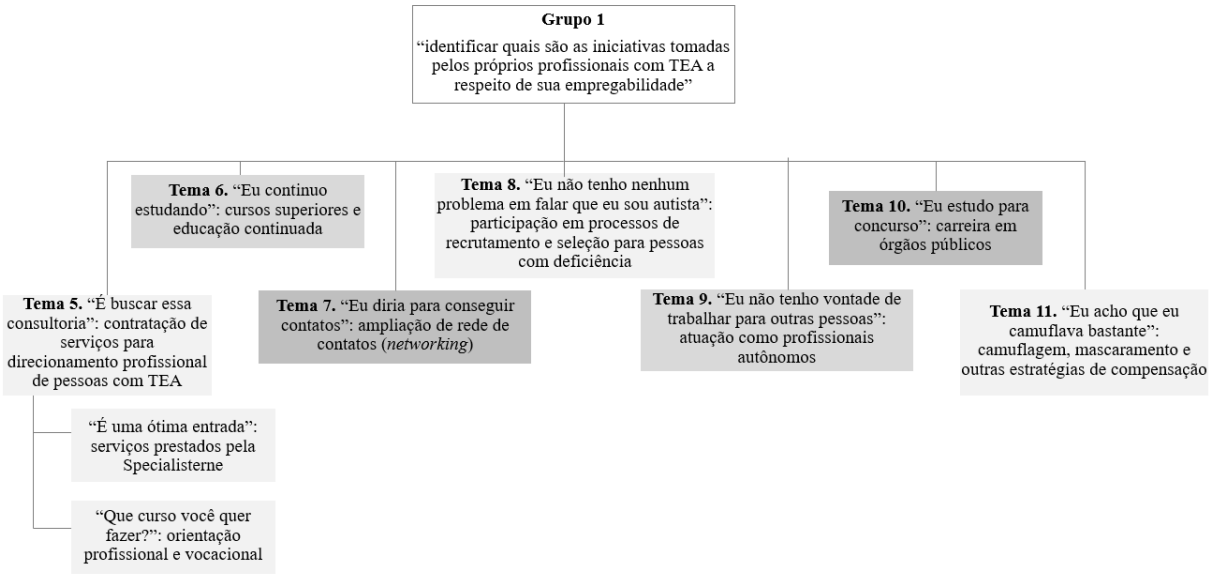
Fonte: Elaborado pela autora.

O segundo dos objetivos específicos definidos para a pesquisa e que está relacionado aos participantes do Grupo 1 é “identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade”.

Os seguintes temas foram estabelecidos em linha com o referido objetivo específico: (i) Tema 5 - “É buscar essa consultoria”: contratação de serviços para direcionamento profissional de pessoas com TEA; (ii) Tema 6 - “Eu continuo estudando”: cursos superiores e educação continuada; (iii) Tema 7 - “Eu diria para conseguir contatos”: ampliação de rede de contatos (*networking*); (iv) Tema 8 - “Eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou autista”: participação em processos de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência; (v) Tema 9 - “Eu não tenho vontade de trabalhar para outras pessoas”: atuação como profissionais autônomos; (vi) Tema 10 - “Eu estudo para concurso”: carreira em órgãos públicos; e (vii) Tema 11 – “Eu acho que eu camuflava bastante”: camuflagem, mascaramento e outras estratégias de compensação.

A Figura 8 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 8. Visão geral da análise temática para os Temas 5 a 11 do Grupo 1.



Fonte: Elaborado pela autora.

Não se pretende esgotar com o presente estudo todas as iniciativas adotadas por profissionais com TEA para a própria empregabilidade em organizações. Da mesma forma, não se sugere que questões associadas à sua contratação e permanência em organizações seriam

problemas do indivíduo com TEA em si nem que esses profissionais deveriam se adaptar ou modificar aspectos comumente associados ao TEA para, somente assim, sejam considerados como “empregáveis”.

O ponto de vista adotado continua sendo o modelo social da deficiência, de modo que são as organizações que devem reduzir barreiras para o acesso de profissionais com TEA ao mercado de trabalho. Neste contexto, as iniciativas tomadas por pessoas com TEA para a empregabilidade que foram mapeadas representam, na realidade, apoios específicos e estratégias que são adotados com o intuito de viabilizar a superação de barreiras em organizações, considerando que nem sempre poderão contar com recursos de acessibilidade na busca por empregos.

Tema 5. “É buscar essa consultoria”: contratação de serviços para direcionamento profissional de pessoas com TEA

Como subtemas definidos para o Tema 5 do Grupo 1, foram definidos: (i) “É uma ótima entrada”: serviços prestados pela Specialisterne; e (ii) “Que curso você quer fazer?”: orientação profissional e vocacional. Não foram considerados para a análise os serviços prestados por profissionais da saúde, como psicólogos e psiquiatras, por terem uma natureza mais abrangente de cuidados ao indivíduo com TEA, ainda que, em alguns dos casos, possam também dar apoio a questões relacionadas ao trabalho quando da realização do atendimento.

“É uma ótima entrada”: serviços prestados pela Specialisterne

Uma das formas adotadas pelos profissionais com TEA para aumentar suas chances de obtenção de emprego é a contratação de serviços especializados para a capacitação e colocação profissional, como os oferecidos pela Specialisterne. Tais serviços serão discutidos em mais detalhes nesta pesquisa, como nos Temas 1 e 3 do Grupo 3, considerando que foram obtidos relatos de uma profissional que atua na Specialisterne.

A Specialisterne já é relativamente conhecida no mercado de capacitação, recrutamento e seleção de profissionais com TEA, tendo sido mencionada em estudos nacionais prévios, como os conduzidos por Conceição, Escalante e Silva (2021) e Rodrigues (2023). Contudo, na presente pesquisa, por meio de uma visão integrada, a novidade é a discussão a

respeito da percepção dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 a respeito das atividades conduzidas pela Specialisterne.

A este respeito, o Participante TEA 17, único participante do Grupo 1 que informa ter buscado os serviços da Specialisterne que são oferecidos para profissionais autistas (que serão objeto de análise no Tema 2 do Grupo 3), relata que, após o diagnóstico e um período tentando obter recolocação no mercado de trabalho sem obter sucesso, optou por entrar em contato com a Specialisterne e iniciar os treinamentos que são ofertados gratuitamente, ainda que não houvesse a garantia de que seria contratado por um dos parceiros da entidade:

> Tanto que, por exemplo, aí... nesse intermeio, eu lembrei da Specialisterne. Fiz minha ficha, entrevista. [...] me chamaram em 2022, foi quando eu fiz a minha capacitação e já consegui emprego. Na verdade, não é uma opção você escolher que departamento você está, entendeu? Então, assim, você faz a capacitação e não é obrigatório a Specialisterne ter um trabalho. Eles veem o seu desempenho, veem o seu perfil e aí eles buscam alguns... alguns parceiros. [...]

No caso da Participante TEA 17, após o treinamento e os cursos oferecidos pela Specialisterne, ele acabou sendo, em um primeiro momento, indicado para prestação de serviços em um dos parceiros da Specialisterne, no modelo de terceirização, que será discutido no Tema 1 do Grupo 3:

> É assim: quando você entra num parceiro da Specialisterne, você é terceiro da empresa. Então, nesse momento que você é terceiro, você tem um acompanhamento de um tutor. Quando a empresa te contrata diretamente, aí, ela pode optar em continuar com esse tutor ou não.

Posteriormente, o Participante TEA 17 informa ter sido contratado na modalidade contratação direta, também discutida no Tema 1 do Grupo 3, passando a fazer parte do quadro de empregados da organização onde exercia suas atividades laborais quando da realização da entrevista. Segundo a percepção do Participante TEA 17, ele teria sido alocado em funções compatíveis com seu perfil, sendo acompanhado de fato pelos profissionais da Specialisterne. Além disso, comenta ter uma sensação de ter sido integrado ao ambiente de trabalho, estando ciente de que precisaria reiniciar o processo de adaptação, caso fosse remanejado de área ou de vaga dentro da organização:

> Eu estou em um departamento de assistente administrativo, cuidando de planilha, cuidando de dados, cuidando disso que eu gosto muito na verdade. [...] Eu fui acompanhado durante um ano, então, foi toda essa inserção, toda essa mediação que me deixou confortável para continuar sendo efetivado ali. Integrado mesmo. Lógico que vai ter os seus desafios. Eu consigo uma nova posição lá dentro com uma chefe diferente, com um chefe diferente. Aí,

> começa um novo trabalho, meu mesmo, de acostumar, me integrar e interagir com novas pessoas.

Essas afirmações parecem estar alinhadas com a visão da Participante Org. 2, quando explica a respeito dos serviços prestados a profissionais com TEA, apresentados no Tema 2 do Grupo 3. O que o Participante TEA 17 descreve como "toda uma sensibilização" que seria feita Specialisterne em uma organização para recepcionar um profissional com TEA faz parte das atividades práticas que são propostas dentre os serviços prestados pela Specialisterne em organizações e discutidas no Tema 3 do Grupo 3:

> Participante TEA 17: [...] Como tem toda uma sensibilização da Specialisterne para equipe, então, você já entra um pouco mais confortável, apesar que eu demorei, assim, para cumprimentar as pessoas quase 2 meses.

Como discutido no Tema 1 deste Grupo 1, são inúmeras as barreiras percebidas pelos profissionais com TEA, para que essas pessoas sejam e se mantenham empregáveis. Para o Participante TEA 17, a sensação é que as ações de sensibilização feitas por entidades como a Specialisterne acabariam por reduzir um pouco as barreiras sentidas em organizações, apesar de não as eliminar totalmente. Trata-se de um aspecto relevante para a presente discussão, pois dá sinais de que as práticas para sensibilização de equipes que recepcionarão profissionais com TEA não bastam para a sua verdadeira inclusão no ambiente de trabalho.

No que diz respeito às características das vagas trabalhadas por organizações em conjunto com entidades como a Specialisterne, o Participante TEA 17 e o Participante TEA 9 descrevem o seu entendimento de que seriam: (i) posições de entrada no mercado de trabalho, principalmente para aqueles que estão desempregados ou buscando outra profissão; ou (ii) mais adequadas para pessoas com TEA com maiores necessidades de apoios e adaptações para superar barreiras existentes em organizações:

> Por exemplo, eu acompanho muitas pessoas autistas no meu LinkedIn e que são da área de TI. Então, para essas pessoas não é um diferencial buscar a Specialisterne, porque a Specialisterne é uma porta de entrada ao mercado de trabalho. Mas, para quem está desempregado, buscando uma nova rota profissional, é buscar essa consultoria. É uma ótima entrada, uma ótima entrada profissional (Participante TEA 17).

> Assessorias de autismo, até onde eu sei, até onde eu conversei com as pessoas, elas estão muito voltadas para a vaga "*entry level*". Então, elas ainda têm... não estão trabalhando muito, até onde eu sei, em vagas um pouco mais sênior. Então, é comum para quem está buscando a entrada no mercado e é comum para quem tem níveis de suporte um pouco maiores. Mas quem tem o nível de porte menor ou já está mais sênior e procurou não entende esse trabalho das assessorias ainda como efetivo para si. Então, eu não sei se já tem alguma,

> desde as últimas vezes que conversei sobre isso, mas as que eu conversei eram muito vagas de entrada (Participante TEA 9).

Tais alegações parecem estar em linha com o informado pela Participante Org. 2 e pelo Participante Org. 3, quando explicam, no Tema 3 do Grupo 3, os tipos de posições que acabam trabalhando junto a organizações que contratam serviços prestados por entidades e instituições sem fins lucrativos para capacitação de profissionais com TEA. Das entrevistas realizadas e analisadas no Tema 6 do Grupo 2, a posição que foi aberta para a única pessoa com TEA contratada na organização onde a Participante RH 2 trabalha é uma vaga de estágio, ou seja, da mesma forma considerada uma posição de início de carreira.

Há evidências, portanto, obtidas na presente pesquisa de que seriam, de fato, apenas trabalhadas tais vagas por entidades e instituições que capacitam profissionais com TEA. Ainda que a Specialisterne informe ter sua origem na área de tecnologia e informação e propiciar treinamento para tanto, a percepção do Participante TEA 17 é que não seriam serviços adequados para profissionais que já atuam na área de tecnologia e informação, mas somente para aqueles que estão desempregados ou que gostariam de mudar de área de atuação.

Entender quais seriam os motivos para essa avaliação de diferentes participantes dos Grupos 1, 2 e 3 a respeito de um potencial cenário de contratação limitado a vagas de entrada ou administrativas é relevante, quando se fala em empregabilidade de pessoas com TEA.

"Que curso você quer fazer?": orientação vocacional e profissional

A orientação vocacional e profissional acaba sendo cada vez mais procurada por estudantes do ensino médio quando da análise e escolha de qual curso superior será selecionado e frequentado, para fins de definição de seus planos e projetos profissionais (FARIA, 2020).

No que diz respeito a pessoas com TEA, contudo, Leopoldino e Costa Coelho (2017) e Cepellos (2023) entendem que ainda falta preparo vocacional para pessoas com TEA, o que afeta as chances de contratação por organizações. Albright, Kuloka e Scarpa (2020) identificaram, por sua vez, frustração de profissionais com TEA com relação à abordagem proposta em alguns programas de reabilitação vocacional, pois há a tendência de se trabalhar de acordo com a perspectiva do modelo médico da deficiência.

Os achados do presente estudo, no entanto, revelam uma percepção diferente dos profissionais com TEA entrevistados a respeito das experiências que tiveram com processos de orientação vocacional e profissional. O Participante TEA 17, por exemplo, comenta ter estado

em dúvidas a respeito do que cursar e que um teste vocacional o teria indicado uma opção que achou interessante:

> Eu estava em dúvida do que fazer. Num teste vocacional, deu resultado de ciências biológicas. Fui fazer, achei interessante e sempre busquei...

Na visão da Participante TEA 15, o aspecto mais relevante apontado em uma orientação vocacional foi o fato de ter sido sugerido pensar também nas atribuições e no desenho de trabalho que uma determinada profissão poderá ter – e não apenas a identificação de suas preferências e afinidades com matérias de um determinado curso superior. A Participante TEA 15 apenas lamenta somente ter tido acesso a tais serviços ao ingressar na universidade:

> Depois que eu fiz a orientação vocacional e me falaram isso, a minha mentalidade mudou completamente, porque eu percebi que se eu tivesse pensado dessa maneira antes de fazer, antes de ter entrado em medicina e na engenharia, eu teria levado em conta as minhas questões sociais, porque medicina é tratar diretamente com pessoas.

Ao comentar a respeito dos desafios enfrentados atualmente na carreira jurídica, a Participante TEA 18 revela que o teste vocacional realizado enquanto ainda era estudante já apontava para potenciais barreiras que enfrentaria ao cursar Direito e atuar como advogada:

> Eu acho que de escolhas de carreira [...], eu fiz um teste vocacional e na época eu já queria Direito, mas eu fiz o teste, porque a escola aplicava, era de graça e tal. Eu falei "eu vou fazer" e aí deu lá que eu poderia até trabalhar com Direito, mas não deu direito, deu medicina, deu outras áreas lá, mas eles falaram comigo na época o seguinte falar "ó, você pode até fazer direito, mas se você for advogar, você não vai dar conta, por exemplo, de cobrar do seu cliente". Sabe por quê? Porque o meu perfil sempre foi assim, mais social e menos flexível.

A orientação vocacional e profissional pode também ser abordada em um contexto mais amplo de busca pelo autoconhecimento, como uma das maneiras citadas pelo Participante TEA 2 para auxiliar na superação de barreiras para a empregabilidade:

> E também para se autoconhecer para, por exemplo, reconhecer quando está errado. Coisas assim, que, às vezes, a gente não se conhece o bastante, vamos dizer assim, aquela questão, às vezes, mesmo até de ego, que a gente acha que está sempre certo e coisas nesse sentido. Um pouco de autoconhecimento, para ter noção da realidade que está acontecendo.

De modo geral, os achados sugerem que a busca por serviços de orientação vocacional e profissional parecem ter auxiliado os profissionais com TEA na escolha dos cursos superiores

e no direcionamento para profissões que, ao menos teoricamente, poderiam representar menos barreiras para acessibilidade de pessoas com TEA.

A aparente diferença entre o apontado nas entrevistas e o indicado na literatura de referência a respeito do preparo vocacional de pessoas com TEA pode ter ocorrido em virtude dos seguintes fatores: (i) foram entrevistados apenas profissionais com TEA com menor nível de suporte, de modo que outras pessoas com TEA com necessidade de mais apoio possam ter percepções distintas; (ii) todos os profissionais com TEA que relataram suas experiências com orientação profissional e vocacional receberam o diagnóstico de TEA tardiamente, de modo que outras pessoas com TEA que tenham recebido o diagnóstico em momentos diferentes da vida podem também ter experiências diferentes; e (iii) apesar da percepção aparentemente positiva a respeito da orientação vocacional recebida, o Participante TEA 17 e a Participante TEA 15 estão em processo de mudança de carreira e iniciando novos projetos nas respectivas organizações onde trabalham.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 5 do Grupo 1 foram organizados no Quadro 22:

Quadro 22. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 1.

Subtemas do Tema 5 do Grupo 1	**Descrição das iniciativas tomadas pelos profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade identificadas nos subtemas do Tema 5 do Grupo 1**
"É uma ótima entrada": serviços prestados pela Specialisterne	Serviço procurado por profissional que buscava recolocação no mercado sem obter sucesso. Participação de treinamentos ofertados gratuitamente pela Specialisterne. Ciência de que não há garantias para a contratação após o treinamento. Prestação de serviços como terceirizado da Specialisterne (modalidade terceirização). Contratação pelo parceiro da Specialisterne após a prestação de serviços (modalidade contratação direta). Alocação em atividades no parceiro compatíveis com o perfil do profissional com TEA. Percepção do profissional com TEA de que teria sido integrado ao ambiente de trabalho. Percepção do profissional com TEA de que foi realizada a sensibilização das equipes do parceiro pela Specialisterne. Percepção de que as oportunidades de vagas trabalhadas pela Specialisterne seriam posições de entrada no mercado de trabalho, principalmente para desempregados ou pessoas com TEA que buscam outra profissão. Percepção de que as oportunidades de vagas trabalhadas pela Specialisterne seriam mais adequadas para pessoas com TEA com maiores necessidades de apoios e adaptações.
"Que curso você quer fazer?": orientação profissional e vocacional	Percepção de que processos de orientação vocacional e profissional a pessoas com TEA poderiam indicar opções interessantes de carreira. Percepção de que processos de orientação vocacional e profissional a pessoas com TEA poderiam apoiar a pessoa com TEA na identificação de atribuições da função desejada na organização e nas características do desenho de trabalho de uma determinada profissão. Percepção de que os processos de orientação vocacional e profissional a pessoas com TEA poderiam ajudar na busca pelo autoconhecimento.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 6. "Eu continuo estudando": cursos superiores e educação continuada

Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2024), 75% dos egressos de cursos de ensino superior conseguem emprego formal em até um ano após a colação de grau. Assim, há evidências de que obter uma formação no ensino superior poderia aumentar as chances de empregabilidade de uma pessoa.

Talvez este seja um dos motivos pelos quais os planos com relação aos estudos estiveram presentes em todos os relatos dos participantes do Grupo 1, quando se tratou da temática "empregabilidade". Entretanto, assim como não existe uma pessoa com TEA que seja igual a outra (CARRERO; KRZEMINSKA; HÄRTEL, 2019), também as percepções e as metas de cada participante do Grupo 1 foram as mais variadas. Dentre os participantes do Grupo 1: (i) sete pessoas com TEA confirmaram ter realizado cursos de pós-graduação *lato sensu*; e (ii) quatro pessoas com TEA confirmaram ter realizado ou estar em processo de conclusão de cursos de pós-graduação *stricto sensu*. As barreiras relacionadas ao acesso a estudos e a conclusão de cursos foram tratadas no Tema 2 do Grupo 1.

Em geral, como indicado pelo Participante TEA 2, o entendimento é de que estudar e obter qualificações seriam uma forma de sair da zona de conforto e apostar no desenvolvimento próprio:

> Resumindo, não ficar na zona de conforto, porque... a zona de conforto é confortável. Aquela coisa que você fica preguiçoso e, querendo ou não, no ambiente de trabalho, você tem que estar sempre, o tempo inteiro, se desenvolvendo e crescendo.

Já o Participante TEA 8, que atua na área de tecnologia e sistemas de informação, acredita que não seria necessariamente obrigatório obter uma formação em educação superior para conseguir progredir na carreira e aprimorar seus conhecimentos. Apesar disso, considera obter um diploma assim que possível por reconhecer que é algo geralmente solicitado em organizações:

> A questão de carreira, eu não acho que eu realmente precise de um curso superior para seguir na minha área, ainda mais com experiência [...] Faria para concluir mesmo. E, por esse lado, eu estou considerando realmente essa possibilidade. Só para ter ensino superior, vamos assim dizer. Tipo assim, tem muitas coisas que pedem [...].

Por questões financeiras, entre outras questões pessoais, o Participante TEA 5 explica ter concluído diversos cursos de nível básico e profissionalizantes, focado em sua empregabilidade:

> Especialização, não. Eu fiz mais cursos de informática básica. Eu fiz curso de idiomas básico, né? Por conta de questões financeiras e tal, acabei fazendo só o nível básico, mas, também antes de começar a trabalhar, fiz um curso profissionalizante, no nível médio, o de departamento pessoal, secretariado.

Alguns participantes, por sua vez, informam que preferem estudar sozinhos, como autodidatas, ao invés de fazer diferentes cursos e aulas:

> Eu sou mais autodidata, embora a faculdade seja interessante, eu tenho um pequeno desejo de fazer pós e seguir com uma carreira acadêmica. [...] Eu faço poucos cursos, eu geralmente faço o seguinte: eu quero aprender isso. O que dá para fazer com isso? Eu quero aprender a tecnologia x - para que ela serve? O que que dá para fazer? Ela serve para XYZ, então, eu vou fazer uma coisa XYZ sem ter a mínima noção dessa tecnologia. O que que eu preciso para fazer para dar o primeiro passo? É isso. (Participante TEA 1)

> Eu sempre pego coisas para estudar sozinha, não pego muitos cursos. Agora estou tentando fazer mais isso. (Participante TEA 13)

Contudo, como indica o Participante TEA 2, conseguir estudar sozinho pode também ser um desafio para uma pessoa com TEA, dependendo de suas características pessoais:

> [...] e eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar por conta própria, tanto que a sala de aula mesmo que faz bastante diferença para mim.

Tema 7. "Eu diria para conseguir contatos": ampliação de rede de contatos (networking)

Estudos prévios nacionais e internacionais apontam reiteradamente as dificuldades de pessoas com TEA na comunicação e interação social, como Hurlbutt e Chalmers (2004), Leopoldino e Costa Coelho (2017), Johnson et al. (2020), Melo, Garrocho e Guerra (2021) e Szulc et al. (2021).

Entretanto, o que surge do relato dos Participantes TEA 1, TEA 10 e TEA 11 é o reconhecimento da importância da ampliação de rede de contatos (ou *networking*), como forma de facilitar a obtenção e manutenção de uma vaga de emprego por uma pessoa com TEA, o que, como regra, dependeria de uma boa comunicação e interações sociais recorrentes:

> No geral, eu diria para conseguir contatos. Que contatos são a coisa mais valiosa que eu consegui no trabalho até hoje. Com contatos, se consegue mais trabalho, você consegue mais dinheiro, você consegue mais oportunidades, você consegue aprender mais. Se você souber a pessoa certa para chamar no momento certo (Participantes TEA 1).

> [...] Ter uma rede não necessariamente de neurodivergentes, mas quanto mais gente se aproximando daquilo ali que você tem enquanto vivência, isso ajuda demais.

> Eu falo que é igual, se você não tiver, se você não tiver um portfólio, se você não tiver que alguém te indicou a empresa, se não tivesse a coisa de diversidade, eles não abrem espaço para você (Participante TEA 11).

Trata-se potencialmente de um novo achado envolvendo as dinâmicas sociais de profissionais com TEA e seus reflexos na obtenção de empregos e que poderá ser mais bem explorado em pesquisas futuras. Não se ignora, contudo, que a realização de *networking* poderá ser algo difícil, dependendo das condições econômico-sociais, e extenuante para alguns profissionais com TEA, dependendo de suas características, como descreve a Participante TEA 11:

> [...] eu estou numa cidade pequena, dependo do famoso "QI". Você já ouviu falar do famoso "QI", não é? "Quem indica". [...] Então, isso me cansa muito, porque, por exemplo, eu não sou filha de papaizinho [...]. Não sou filha de médico (Participante TEA 16).

Tema 8. "Eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou autista": participação em processos de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência

Participar ou não em processos de recrutamento e seleção direcionados para pessoas com deficiência pode envolver, em um primeiro momento, uma decisão de cada indivíduo de se revelar como sendo uma pessoa com TEA ou não. Como visto no Tema 1 do Grupo 1, nem todos os profissionais sentem-se confortáveis em assumir publicamente (ou ao menos no ambiente de trabalho) o diagnóstico de TEA, por diferentes motivos.

De todo modo, a partir do momento em que decidem pela autodeclaração como pessoa com TEA, nenhum dos participantes do Grupo 1 vê problemas na aplicação para processos seletivos direcionados para pessoas com deficiência, como explicado pelo Participante TEA 1 e pelo Participante TEA 9:

> No momento, não, desde que eu me destravei. Eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou autista. Uma vaga não faria diferença. Eu participei recentemente de um processo seletivo de uma vaga que seria de ação afirmativa (Participante TEA 1).

> Para mim, assim, *bottom line*, o que a gente tem na lei hoje é o melhor que você pode oferecer com o nível de pesquisa e reflexão que a gente tem hoje, que autista é enquadrado como PCD, independente do grau de suporte e tal, porque é o melhor que a gente pode delimitar com o que a gente tem (Participante TEA 9).

De fato, como descrito no item 2.1.4. desta pesquisa, desde 2012, com a Lei Berenice Piana, as pessoas com TEA passaram a ser reconhecidas como pessoas com deficiência e,

consequentemente, titulares das mesmas garantias e direitos assegurados para as pessoas com deficiência em geral, o que inclui a elegibilidade para as vagas definidas para atendimento da Lei de Cotas.

Apesar disso, há a percepção de que os profissionais com TEA não têm sido selecionados para as referidas vagas, em uma aparente decisão de organizações pela contratação de pessoas com outras deficiências em detrimento de indivíduos com TEA. É o que conta o Participante TEA 5, desempregado quando da realização da entrevista:

> Bom, o autismo para... segundo a lei, a lei LBI, é considerado uma deficiência, então, obrigatoriamente, os autistas são incluídos nas cotas PCD. Porém, eles não estão sendo aproveitados, porque muitas empresas ainda pensam que PCD é só cadeirante, PCD é deficiente visual... e não dão a atenção devida, a mesma atenção que dão para as outras deficiências para pessoas autistas. [...] e nós, autistas, nós somos... quando as empresas veem PCD, veem só como cadeirante, com deficiência visual. Eles não dão muita atenção para pessoas autistas, infelizmente.

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego a respeito de empregados com deficiência contratados e informados no eSocial[13] (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2024) parecem corroborar essa percepção, ao indicar que "grande parte das deficiências são física, visual e auditiva". O TEA, de acordo com as Orientações para fins de cumprimento da Lei de Cotas (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2018), é considerado uma deficiência mental ou psicossocial.

O Participante TEA 17 e a Participante TEA 11 também compartilharam dificuldades e impedimentos para serem contratados quando tentaram participar de processos seletivos para vagas destinadas a pessoas com deficiência:

> Quando era uma vaga PCD, eu participava. Se alguém... se alguém pedisse o diagnóstico, o laudo, aí eu enviava. Então, assim, foram várias tentativas, 5 possibilidades, 3 entrevistas e não, não passei, não passei (Participante TEA 17).

> Olha, eu entrei por questão também do Comitê de Diversidade da empresa, então, tipo, eu fui para uma vaga regular, mas eu acredito que o pessoal de Diversidade me contratou mais por isso, para me dar uma oportunidade, que eu falo que as empresas não dão. Eu falo: quando você chega com um portfólio, quando você tem experiência, quando você mostra o portfólio, as pessoas têm um emprego, mas ninguém quer dar uma oportunidade (Participante TEA 11).

[13] Por meio do eSocial, os empregadores devem "comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS" (BRASIL, 2019).

Adicionalmente, foi constatada falta de conhecimento específico de alguns profissionais com TEA a respeito das regras previstas na Lei de Cotas para contratação de pessoas com deficiência, indicando que não seria aplicável para atividades de fábrica, como indicam o Participante TEA 17 e o Participante TEA 10 – quando a Lei de Cotas coloca como requisitos apenas o número de empregados contratados, sem restrições quanto a atividades desenvolvidas:

> É, porque... como é uma fábrica, tem algumas dificuldades de inserção, porque, apesar de eu trabalhar no escritório, ela é uma fábrica. Então, é muito difícil você ter um PCD dentro de um parque fabril, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual ou auditivo, então, a gente não tem cota, mas tem inserção de pessoas com deficiência. Tem grupo de afinidade lá (Participante TEA 17).

Além da contratação como pessoa com deficiência para fins da Lei de Cotas, há a ideia de que as organizações não têm investido em acessibilidade e apoios para redução de barreiras para que as pessoas com TEA consigam permanecer empregadas. É o que se nota da fala do Participante TEA 2:

> Isso não é nem só para autista, para qualquer PCD mesmo, porque, entre aspas, é a mesma coisa que as cotas. Você coloca uma cota para pessoa. É, vamos dizer, cota de vestibulares ou coisa assim, você coloca para pessoa trabalhar. Mas o que garante que a pessoa vai conseguir ficar? É mais para... eu acho... que é mais para europeu ver do que qualquer coisa, porque simplesmente o que precisa é aquilo ser aplicado na prática. Não adianta só fazer e obrigar a pessoa a contratar e não entender que ela precisa de um funcionário que esteja funcionando, que esteja bem. Que seja uma pessoa produtiva dentro daquela empresa.

Tema 9. "Eu não tenho vontade de trabalhar para outras pessoas": atuação como profissionais autônomos

Com base nos trechos das entrevistas conduzidas com a Participante TEA 16 e o Participante TEA 10, constata-se que alguns profissionais com TEA acabaram decidindo atuar de forma autônoma, não mais desejando passar pelos desafios associados à obtenção de emprego em organizações:

> [...] eu só trabalho aqui agora, nesse, nesse momento, nesse espaço, que estou reformando, inclusive, ainda, porque faz 3 anos que eu estou aqui nessa casa, que eu escolhi, e eu não tenho vontade de trabalhar para outras pessoas. Não é aversão. Não sei dizer se é aversão, mas eu tenho muito desgaste. Sabe quando, com 47 anos, eu acho que eu prefiro pagar uma MEI e trabalhar para mim, sabe? Quem confia no meu trabalho vai vir até aqui no meu espaço (Participante TEA 16).

> Então, eu estou como autônomo aqui, batendo cabeça, estou treinando um bocado, estou fazendo coisas diferentes, mas é isso que eu tenho feito (Participante TEA 10). Hoje eu passo por dificuldades financeiras enormes, muito sérias mesmo [...]. Mas, de fato, sou mais feliz.

Trata-se de um potencial novo achado não mapeado nas buscas inicialmente feitas para fins da presente pesquisa e que pode sugerir caminhos para estudos futuros.

Tema 10. "Eu estudo para concurso": carreira em órgãos públicos

Em virtude das barreiras encontradas em organizações para a empregabilidade, alguns participantes do Grupo 1 informaram que decidiram prestar concursos para cargos em órgãos públicos ou assumiram cargos em comissão quando da realização das entrevistas.

Contudo, a carreira em órgãos públicos não deve ser considerada como adequada para toda e qualquer pessoa com TEA, pois, assim como as pessoas neurotípicas, é algo que sempre dependerá, inicialmente, das aspirações do profissional com TEA para o seu futuro e do seu perfil. É o que se afere da fala do Participante TEA 19:

> Tentei, assim, como... tentei ver concurso público, mas aí eu pensei assim... Não é o tipo de coisa que eu quero.

Além disso, como explicado pela Participante TEA 18 e pelo Participante TEA 2, o processo de se organizar para estudar, planejar e se preparar para os concursos dos quais participarão e assistir aulas (que podem ocorrer na modalidade a distância) pode representar barreiras relevantes para a construção de uma carreira em órgãos públicos:

> [...] eu estudo para concurso, e, assim, eu tive algum sucesso, mas tive muitos fracassos e a principal frustração minha era não conseguir estudar mais de 50% do edital para uma prova, sabe? [...] Eu vi que eu tenho um problema de planejamento e de execução, de colocar em prática e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como por exemplo, trabalhar e estudar (Participante TEA 18).
>
> [...] talvez eu possa fazer concurso ou coisas assim, mas daí eu percebi que eu não me daria muito bem em concursos públicos. Eu vi que, primeiro, que tinha concurso que eu não saberia estudar para eles, porque é muito concurso. Às vezes, é aula a distância, essas coisas para esses cursinhos. Então, eu não ia me adaptar porque... tem uns que são... Não vou dizer direcionados a certas pessoas, mas, por exemplo, ele sempre fala que tem cursinho e fala que certa bancada interpreta de um jeito e outra bancada interpreta de outro. São certas coisas que eu não vou me dar o trabalho de aprender isso, ainda num curso de... vamos assim... não numa aula presencial, poque eu tenho uma dificuldade muito grande com aulas a distância, por exemplo (Participante TEA 2).

Outros profissionais, como a Participante TEA 16, consideraram a carreira em órgãos públicos em algum momento da sua vida profissional e obtiveram êxito nessa empreitada:

> Certo, então, eu... Eu passei em 3 concursos, eu exonerei um e os outros 2 foram em outras 2 cidades.

Destaca-se que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 (BRASIL, 2018), as pessoas com deficiência, dentre as quais se enquadram as pessoas com TEA, têm direito a, no mínimo, 5% das vagas oferecidas para concurso público da administração pública federal direta e indireta. O parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990) prevê, a seu turno, a reserva de até 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais para pessoas com deficiência. Sugere-se, portanto, que o atraso na obtenção do diagnóstico, como discutido no Tema 1 do Grupo 1, poderá impactar o processo de ingresso de profissionais com TEA em carreiras públicas.

Tema 11 – "Eu acho que eu camuflava bastante": camuflagem, mascaramento e outras estratégias de compensação

Segundo Van der Putten et al. (2024), a camuflagem tem sido cada vez mais estudada por pesquisadores e tem sido considerada como um fator importante relacionado aos diagnósticos tardios de TEA e para a identificação de outras coocorrências, como o TDAH.

Como explicam Hull et al. (2017), a camuflagem pode ser compreendida como sendo o uso de estratégias de compensação por uma pessoa com TEA, de forma consciente ou inconsciente, para mascarar as características comumente associadas ao TEA, com a finalidade de enfrentar determinadas situações sociais. Já Price (2024), por sua vez, explica que, para a literatura da psicologia, o mascaramento seria composto tanto pela camuflagem (tentativa de esconder características comumente associadas ao TEA para permitir que a pessoa com TEA se "misture" aos demais neurotípicos) quanto pela compensação (uso de estratégias para "superar" desafios relacionados ao TEA). Em razão das diferenças de definição que poderão existir entre os conceitos de camuflagem, mascaramento e estratégias de compensação apresentada, para a presente análise, será utilizada a abordagem proposta por Hull et al. (2017).

Neste sentido, para avaliar as experiências com a camuflagem por pessoas com TEA, Hull et al. (2017) conduziram um estudo qualitativo com 92 participantes com TEA, apresentando questões com foco na natureza, nas motivações e nas consequências da camuflagem. Por meio da análise temática, os autores sugeriram um modelo com três etapas

para o processo de camuflagem, compreendendo: (i) as motivações para a camuflagem, que incluem a intenção de se enquadrar socialmente e aumentar conexões sociais com outros indivíduos; (ii) a compreensão de que a camuflagem seria composta pela combinação entre o mascaramento e outras estratégias de compensação; e (iii) as consequências a longo prazo da camuflagem, que incluem exaustão, enfrentamento de estereótipos e ameaças à autopercepção das pessoas com TEA.

Como descrito no Tema 4 do Grupo 1, Raymaker et al. (2020) sugerem que a camuflagem, o mascaramento e as estratégias de compensação podem também levar a uma situação de *burnout* no TEA (*autistic burnout*).

Os resultados obtidos por Hull et al. (2017) para a construção do modelo de três níveis proposto pelos autores parecem ser suportados pelos relatos do Participante TEA 17, da Participante TEA 13, da Participante TEA 16, do Participante TEA 8 e da Participante TEA 18, que utilizam a camuflagem, com o mascaramento e outras estratégias de compensação no ambiente de trabalho, como formas de conseguirem executar suas tarefas laborais e atender às expectativas de suas funções nos respectivos locais de trabalho:

> Vai ter um desgaste emocional muito grande, sabe? E, por exemplo, você ficar 8 horas num trabalho e mascarando. Você já vai ter que ter uma energia para lidar com as pessoas, com a pressão do trabalho e a pressão que você põe sobre si, eu acho que é muito pesado (Participante TEA 17).

> Então, é como se tivesse realmente que colocar um esforço muito grande para se comportar de uma forma que não é a mais natural. [...] Até desses comportamentos de rigidez e de organização, etc., ficar fingindo que eu não precisava fazer, inclusive outras coisas que eu só fui perceber depois: de ficar me balançando, a cadeira rodando, andando em círculo. Eu não podia. Não posso fazer isso na frente dos outros e isso me deixava esgotada (Participante TEA 13).

> Eu acho que eu camuflava bastante. Eu acho, não. Eu tenho certeza, porque eu não parava para... eu queria fazer a comunicação. Eu queria atender bem, eu era super educada. Sou até hoje. [...] Com algumas pessoas eu consigo trazer essa informalidade. Só que aí não sou eu também. Não sei explicar. Eu vou para a máscara social e aí eu não consigo bancar essa máscara o tempo todo (Participante TEA 16).

> Eu imagino que, em parte, por ter crescido sem nenhuma forma diagnóstica, coisa assim, o que aconteceu comigo em particular foi que eu, eventualmente, aprendi a me policiar violentamente na minha maneira como eu interajo com as pessoas. Então, por exemplo, para mim, eu interajo com as pessoas de maneira extremamente artificial, tipo, às vezes, para mim, eu consigo imaginar que eu estou sendo muito caricato, mas tende a ter uma reação menos negativa das pessoas do que as minhas interações antes de eu começar a ser assim. [...] Mas eu vejo que as pessoas estão reagindo de maneira diferente a mim versus aos outros. Eu sou um cara excêntrico e essa excentricidade que eu vejo que os outros estão percebendo, ela me incomoda e eu fico a sensação de arrependimento às vezes (Participante TEA 8).

> Você fala bem, você não é tímida. Mas só Deus sabe o custo que isso tem, né? (Participante TEA 18).

Outras situações em que é mais usual a utilização de mascaramento por profissionais com TEA são confraternizações com equipes e outros departamentos e festas corporativas, como explica o Profissional TEA 17:

> Tem outras pessoas envolvidas, outras pessoas de outros departamentos que vão. E festa de final de ano assim eu vou. Eu uso um *masking* mesmo.

Ainda a respeito da camuflagem, Lai et al. (2017) avaliaram dados de 30 pessoas do gênero feminino com TEA e 30 pessoas do gênero masculino com TEA e identificaram que há tendência de que mais mulheres utilizem a camuflagem do que homens, apesar de ser uma estratégia que pode ser regularmente utilizada por indivíduos de ambos os gêneros. Essa diferença poderia ter alguma relação com certos vieses que afetariam, inclusive, o processo de obtenção do diagnóstico de TEA por mulheres (HULL et al., 2017). Os trechos da fala da Participante TEA 13 parecem estar em linha com os resultados dos estudos de Lai et al. (2017):

> Parece que [...] os autistas homens, eles têm uma aceitação maior e até uma coisa que, às vezes, as outras pessoas enxergam mais o autismo neles. Então, eles "ah, eu posso ser desse jeito", tipo assim. E aí, nas mulheres, eu acho que, como naturalmente é exigido de mulheres que tenham mais habilidade de socializar [...], são consideradas pessoas frias ou pessoas que não têm sentimento ou não sei... grosseiras.

Os relatos da Participante TEA 11, da Participante TEA 15 e da Participante TEA 16 refletem os respectivos desafios enfrentados para tentarem entender as críticas e comentários que recebiam das pessoas com as quais se relacionaram e como se utilizaram da camuflagem, do mascaramento e de outras estratégias, como estudos, pesquisas e leitura de livros, para superar essas barreiras:

> Claro que eu já aprendi que existem algumas regrinhas "Tudo bem? Tudo bem. E como você está? Tudo ótimo e maravilhoso". Eu sempre tenho aquelas frases prontas, minhas frases curtinhas para responder essas questões. Por exemplo, no meu estado, Minas Gerais "todo mundo vai lá em casa". Não, ninguém quer que você vá lá em casa. É só forma de educação e eu vou aprender (Participante TEA 11).

> Quando eu fiz um curso de comunicação para tentar isso, o moço falou que eu falava de maneira muito robótica. Aí, eu fui e comecei a pesquisar mais. Eu achava que eu ia conseguir mudar isso, entendeu? E eu queria muito mudar, porque eu imaginava que era um problema que tinha comigo (Participante TEA 15).

> Eu ficava vendo muitos vídeos na internet, lendo livros, tipo, aquele livro "O corpo fala", que ensina a linguagem corporal, porque todo mundo sempre

> ficou falando que eu não sorria, que eu não gesticulava, que eu era muito rígida. E aí eu ficava cismada com isso e críticas de trabalho em grupo também (Participante TEA 15).
>
> [...] Porque, por exemplo, na parte social, foi a que mais tinha dificuldade, para me relacionar com as pessoas. Eu tinha, às vezes, livros de imagem corporal, por exemplo, de como que era o gesto de cada pessoa, desde uma paquera na adolescência, por exemplo, me demonstrar o que que era motivo de querer ter algum interesse comigo. E eu sempre tive aquela dificuldade, mais quieta, não conseguia fazer o que minhas amigas faziam (Participante TEA 16).

Apesar das estratégias que as pessoas com TEA acabam tendo que adotar para se adaptar, como a camuflagem, com alto custo para a sua vida pessoal e profissional e a sua saúde mental, como o abordado no Tema 11 do Grupo 1, considerando o modelo social da deficiência e os conceitos da LBI, reforça-se a necessidade de que as adaptações sejam oferecidas pelo ambiente onde se encontram, como organizações, e pelas pessoas com as quais convivem. Desta forma, o profissional com TEA poderá deixar de utilizar o mascaramento (ou ao menos reduzir o seu uso), aliviando a pressão que sente para a manutenção dessa estratégia, como explica o Participante TEA 17:

> Eu acho que, tanto para a vida profissional ou pessoal, é tentar diminuir o *masking*, sabe? Eu acho que esse é o principal. Eu tenho, algumas vezes, por causa de festa. Mas, durante os dias que eu trabalho, sou eu mesmo, porque, senão, eu acho que eu não vou ter autonomia, não vou ter liberdade e não vou aguentar. Eu vou ter crise, essa é a verdade. Eu vou ter crise, se não for eu mesmo.

Os achados descritos nos Temas 6 a 11 do Grupo 1 foram organizados no Quadro 23:

Quadro 23. Visão geral dos Temas 6 a 11 do Grupo 1.

Temas 6 a 11 do Grupo 1	**Descrição das iniciativas tomadas pelos profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade identificadas nos Temas 6 a 11 do Grupo 1**
"Eu continuo estudando": cursos superiores e educação continuada	Percepção de profissionais com TEA de que estudar e obter qualificações são formas de sair da zona de conforto e apostar no desenvolvimento próprio. Percepção de que o progresso na carreira na área de tecnologia e sistemas de informação não dependeria de educação superior. Escolha dos cursos que serão feitos poderá depender de condições financeiras da pessoa com TEA. Indicação de que algumas pessoas com TEA preferem estudar sozinhas (autodidatas). Indicação de que para outras pessoas com TEA estudar sozinhas seria um desafio.
"Eu diria para conseguir contatos": ampliação de rede de contatos (*networking*) (continua)	Reconhecimento de pessoas com TEA da importância da ampliação de rede de contatos (*networking*). Percepção de que o *networking* facilitaria a obtenção e manutenção de empregos por uma pessoa com TEA. Percepção de algumas pessoas com TEA de que criar um networking seria algo difícil, dependendo de condições socioeconômicas e das características da pessoa com TEA.

(continuação) "Eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou autista": participação em processos de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência	Evidências de que profissionais com TEA que assumem seu diagnóstico de TEA não teriam problemas em se candidatar a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Percepção de que organizações decidiriam pela contratação de pessoas com outras deficiências, em detrimento de pessoas com TEA. Existência de barreiras para a contratação de pessoas com TEA por organizações para vagas destinadas a pessoas com deficiência. Falta de conhecimento específico a respeito da Lei de Cotas por profissionais com TEA. Percepção de que organizações não têm investido em acessibilidade e apoios específicos para pessoas com TEA após a contratação em processos seletivos específicos para pessoas com deficiência.
"Eu não tenho vontade de trabalhar para outras pessoas": atuação como profissionais autônomos	Indicação de que alguns profissionais com TEA preferem trabalhar de forma autônoma para evitar barreiras associadas à obtenção de emprego em organizações.
"Eu estudo para concurso": carreira em órgãos públicos	Indicação de que nem todos os profissionais com TEA preferem seguir carreira em órgãos públicos. Evidências de que o processo de se organizar para estudar, planejar e se preparar para concursos públicos poderia ser uma barreira para alguns profissionais com TEA. Percepção de que a carreira em órgãos públicos seria uma opção para alguns profissionais com TEA.
"Eu acho que eu camuflava bastante": camuflagem, mascaramento e outras estratégias de compensação	Utilização da camuflagem, do mascaramento (*masking*) e de outras estratégias de compensação no ambiente de trabalho por profissionais com TEA. Camuflagem, mascaramento e outras estratégias de compensação no ambiente de trabalho como forma de a pessoa com TEA conseguir executar suas tarefas e atender às expectativas de gestores. Utilização do mascaramento por profissionais com TEA em situações sociais corporativas. Evidências de que há tendência de que mulheres com TEA sintam mais necessidade da camuflagem. Utilização da camuflagem, do mascaramento e de outras estratégias de compensação por profissionais com TEA para mitigar comentários negativos recebidos das pessoas com as quais convivem. Evidências de que a adoção da camuflagem, do mascaramento e de outras estratégias de compensação impactariam negativamente a vida pessoal e profissional da pessoa com TEA. Evidências de que a adoção da camuflagem, do mascaramento e de outras estratégias de compensação impactariam negativamente a saúde mental da pessoa com TEA, podendo contribuir para o *burnout* no TEA (*autistic burnout*).

Fonte: Elaborado pela autora.

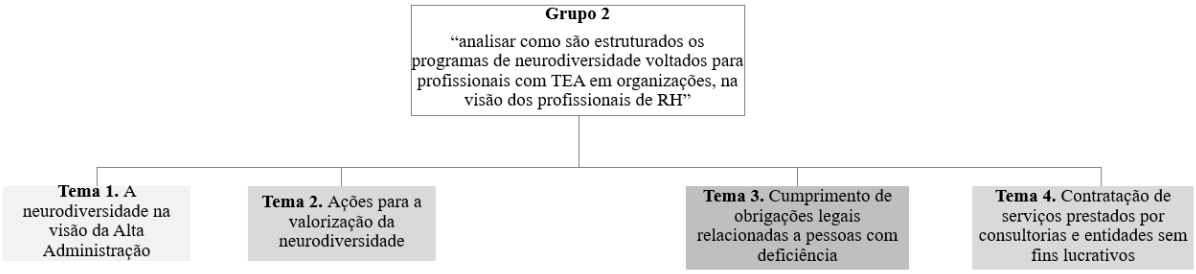
4.1.2 Relatos do Grupo 2

Um dos objetivos específicos definidos para a pesquisa e que está relacionado aos participantes do Grupo 2 é "analisar como são estruturados os programas de neurodiversidade voltados para profissionais com TEA em organizações, na visão dos profissionais de RH".

Os seguintes temas foram estabelecidos em linha com o referido objetivo específico: (i) Tema 1 – A neurodiversidade na visão da Alta Administração; (ii) Tema 2 – Ações para a valorização da neurodiversidade; (iii) Tema 3 - Cumprimento de obrigações legais relacionadas a pessoas com deficiência; e (iv) Tema 4 – Contratação de serviços prestados por consultorias e entidades sem fins lucrativos.

A Figura 9 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 9. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 4 do Grupo 2.



Fonte: Elaborado pela Autora

Tema 1. A neurodiversidade na visão da Alta Administração[14]

Para fins de discussão, sugere-se avaliar, inicialmente, como os programas de diversidade e inclusão, em especial, aqueles voltados a pessoas com deficiência, ou relacionadas à própria neurodiversidade são percebidos e incentivados pela Alta Administração. A este respeito, como relatado pelo Participante RH 6, esse posicionamento parece ser um fator crucial para a percepção da neurodiversidade nas práticas de RH e de gestão de pessoas da organização:

> Eu acho que o interesse genuíno da alta liderança é fundamental. Para mim, é sempre o principal ganho que a gente tem [...]. Já é senso comum na nossa companhia de que essa é uma companhia que gera oportunidade para todas as pessoas. [...] Então, esse é um primeiro ponto. [...] O que contribui muito é que, de verdade, inclusão hoje é um dos pilares estratégicos do ESG e o bônus dos executivos está ligado à estratégia ESG.

Quando não há clareza quanto ao posicionamento da Alta Administração a respeito dessa temática, no entanto, o que se constata é a ausência de visibilidade da área de RH ou gestão de pessoas de uma organização quanto à longevidade de programas de neurodiversidade, de acordo com o que se percebe do relato da Participante RH 3:

> Bom, eu não diria que eles abraçam, nem que eles apoiam e nem que eles não apoiam [...]. Eu acho que, com as nossas entregas, a gente teve um reconhecimento do nosso trabalho, então, eu entendo que eles acreditam no que a gente faz [...]. Eu não diria que não tem abertura, mas ainda não tem essa cultura, esse costume [...]. Não vai ser algo que a gente vai precisar lutar

[14] Segundo o Glossário de Gestão de Riscos em Governança Pública elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2024), a Alta Administração é composta pelos "gestores que integram o nível executivo mais elevado da organização com poderes para estabelecer as políticas, os objetivos e conduzir a implementação da estratégia para realizar os objetivos da organização".

> para que tenha visibilidade. Então, é algo que vai ser muito mais orgânico. Com o tempo a gente vai ter essa informação.

Esse posicionamento é, muitas das vezes, reflexo das diretrizes da matriz em multinacionais, associadas, em um primeiro momento, às práticas de compliance e de diversidade e inclusão de forma mais ampla. A este respeito, pesquisa divulgada em 2024 pelo Instituto Ethos (LOUREIRO, 2024), indica que as organizações consideradas mais inclusivas no país foram a Dow, a Bayer, a Accenture e a Sodexo, reforçando este entendimento.

Por meio da análise da fala da Participante RH 1, que trabalha em uma organização multinacional que apresenta um programa de neurodiversidade reconhecidamente estruturado, nota-se que programas de neurodiversidade podem, de fato, ter sua origem: (i) em iniciativas mais amplas de diversidade e inclusão, em geral, direcionadas a pessoas com deficiência; e (ii) em programas globais de neurodiversidade, implementados e incentivados pelas matrizes internacionais:

> Já desde muitos anos existe uma área global de diversidade e inclusão, com várias frentes. Então, a questão de pessoas – em inglês, se chamava "com descapacidades" - já tinha inclusão de forma geral, com cadeirantes, mudos, cegos, enfim. E, através de, na verdade, de pesquisa de dados de mercado, se identificou que a população autista, muitas vezes até formada e com muitas potencialidades, estava em subempregos, desempregada ou empregadas em empregos de um nível inferior à sua capacidade.

Somente seguir diretrizes globais adotadas por um grupo empresarial não seria a única justificativa apontada para a existência da prática de neurodiversidade em organizações. Outro aspecto relevante é o nível de maturidade dos programas de compliance e de inclusão e diversidade, como aponta a experiência compartilhada pelo Participante RH 6:

> [...] aqui existe uma estrutura muito bem consolidada de recepção de denúncias, de assédio e discriminação, de investigação dessas denúncias e de punição. Então, é uma verdade que as pessoas [...], elas pensam duas vezes antes de discriminar alguém por conta da sua condição, porque elas sabem que existe aqui uma política de tratativa de tolerância zero.

A respeito da maturidade de programas de compliance e de inclusão e diversidade, ressalta-se que o diagnóstico poderá ser feito a partir de diferentes critérios e definição de níveis indicando o grau atingido pela organização, como proposto por consultorias especializadas, como a Deloitte (2024), ou a aplicação de novas metodologias, como sugerido por Barbosa Junior e Nunes (2017). A definição de índices e níveis de maturidade especificamente para programas de neurodiversidade poderá ser objeto de estudos futuros.

Aliada à maturidade do programa de compliance está a maturidade das próprias práticas de gestão de pessoas, que devem refletir um olhar para a diversidade e inclusão em uma organização, como refletem a Participante RH 5 e o Participante RH 6:

> Eu acho que até, no que tange a parte mais específica de neurodiversidade, principalmente quando a gente fala do grupo de pessoas, os autistas. Isso cresceu muito pelo nosso dia a dia que a gente tem contato junto aos funcionários e familiares. Então, a nossa equipe faz muito suporte em relação a toda a tratativa de tratamento de profissionais de saúde, então de cuidados de saúde. [...] E até num olhar um pouco mais amplo, foi uma necessidade que a gente viu de um tema que a gente precisa, de um programa que a gente precisa ter um formato mais específico justamente na jornada do colaborador. Então, hoje temos, sim, esse horário no comitê, na diversidade, mas também dentro da jornada do colaborador. Então, desde lá da captação, do início da sua jornada na empresa até o final. Então, faz parte também desse projeto que a gente está construindo (Participante RH 5).

> [...] a gente treina de maneira contínua as pessoas para incluir e valorizar a diversidade, para trazer a necessidade das pessoas como prioridade para as nossas decisões. E aí a gente vem construindo soluções de maneira contínua para acolher e construir, gerar oportunidades para que no final dos dias as pessoas sejam ainda mais incluídas (Participante RH 6).

A este respeito, pesquisa conduzida pela startup To.gather em 2024 (FERREIRA, 2024) indica que, no Brasil, a maior parte das organizações ainda não possui áreas específicas para as temáticas de diversidade e inclusão, de modo que se estima que cerca de 61% das organizações acabam conduzindo assuntos de diversidade e inclusão por meio da área de RH. Pesquisas futuras poderão mapear com mais detalhes como as áreas de RH e de diversidade e inclusão poderão estar relacionadas e atuar em organizações, quando se tratar da implementação de programas de neurodiversidade propriamente ditos.

Tema 2. Ações para a valorização da neurodiversidade

Algumas organizações ainda não conseguiram implementar programas de neurodiversidade estruturados. Acabam, entretanto, adotando algumas ações que fomentam, ainda que de forma não estruturada, a neurodiversidade internamente. Sugere-se que essas práticas poderão ser consideradas como verdadeiras sementes para programas estruturados de neurodiversidade futuros, além de representarem, por si só, práticas para a percepção de um ambiente mais diverso pela área de RH, como se denota do relato da Participante RH 3:

> [...] sempre tentando ampliar a diversidade aqui dentro, trazer o máximo de pessoas possíveis de todos os jeitos, formas, situações, condições [...] A gente sente isso no clima da empresa [...]

Já o Participante RH 6 explica que, ainda que não houvesse um programa de neurodiversidade formalizado na sua organização à época, já havia a prática de contratação de pessoas com TEA, sem necessária relação com a obrigação prevista na Lei de Cotas[15]:

> [...] nós não tínhamos um programa de inclusão de pessoas com autismo dedicado a pessoas com autismo, mas desde sempre nós contratamos pessoas com autismo. [...] Em vários momentos, até sem enquadrar na condição de pessoa com deficiência, sem usufruir do que a lei de inclusão prevê nesse sentido do enquadramento, e unicamente por entender que a gente aqui tem capacidade de treinar as pessoas, contribuir para o desenvolvimento delas, permitir que elas construam uma carreira e abrir as portas, de fato, para quem busca essa oportunidade como uma característica de negócio.

No contexto de ações que valorizam a neurodiversidade, mas que ainda não compõem um programa devidamente estruturado, aspectos que parecem influenciar na condução dessas medidas seriam: (i) o interesse pessoal dos profissionais que atuam na área de RH e gestão de pessoas; e (ii) o conhecimento dos referidos profissionais a respeito do TEA e da própria neurodiversidade, como se afere pela fala da Participante RH 2:

> Eu sou formada em psicologia, então, tenho uma facilidade maior para lidar com as pessoas. [...] em um momento da minha vida, eu quis começar a me cercar de mais conteúdo de pessoas completamente diferentes de mim. Então, eu comecei a buscar conteúdos de outras pessoas pretas, pessoas de outros países, pessoas autistas, pessoas com TDAH, enfim, todo espectro aí que a gente tem da neurodiversidade [...] porque essa questão de trazer a diversidade para dentro de casa é muito importante para mim.

Dentre os exemplos práticos realizados em organizações para a divulgação da neurodiversidade, podem ser citadas: (i) ações específicas adotadas no mês de abril, considerando-se a celebração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo no dia 2 de abril; (ii) ações específicas adotadas no mês de setembro, considerando-se a celebração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro; (ii) compartilhamento de experiências por empregados da organização com relação ao mercado de trabalho; (iii) grupos de afinidade; e (iv) rodas de conversa com temas envolvendo famílias de pessoas com deficiência ou TEA; entre outros, como compartilha a Participante RH 1:

> Eu tenho mês de abril, que é o mês da consciência do autismo mundial. Então, assim, sempre no mês de abril, a gente tem atividades. A gente traz um palestrante, a gente faz, tem atividades globais desse grupo global. Em setembro, tem a semana de PCD. A gente sempre traz também algum tema. E,

[15] Lei nº 8.213/91 - Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I - até 200 empregados: 2%; II - de 201 a 500: 3%; III - de 501 a 1.000: 4%; e IV - de 1.001 em diante: 5%.

> ao longo do ano, a gente tenta usar muito dos nossos funcionários, trazendo experiência. Então, a gente já fez esse ano muito focado: Como foi essa experiência no mercado de trabalho? Como é a experiência? Quais são as dificuldades? A gente já fez um bate-papo, eles falando para os gerentes "olha como é que eu posso contratar da melhor forma?" Fez um bate-papo focando na família, porque hoje a nossa comunidade [...] não é só de funcionários autistas, mas funcionários neurotípicos, que tem filhos autistas, sobrinhos autistas, têm um membro da família autista e que quer saber mais e que quer participar. Então, digamos que já tem um ecossistema. Então, a gente vai fazendo isso ao longo do ano, vai fazendo campanhas.

Tema 3. Cumprimento de obrigações legais relacionadas a pessoas com deficiência

Em algumas situações, os programas de neurodiversidade dedicados à contratação de pessoas com TEA acabam sendo estruturados com a finalidade de contratar o número de pessoas com deficiência exigido pela Lei de Cotas, principalmente como forma de se evitar as penalidades previstas[16]. É o que indica o relato do Participante RH 6:

> [...] o comitê chegou para profissionalizar toda essa jornada, mas num contexto que já existia muita representatividade. Dentre essas pessoas com deficiência, pessoas com deficiência intelectual e autismo ou pessoas só com autismo enquadradas na lei de cotas de pessoa com deficiência. Em linhas gerais, essas são as motivações.

Destaca-se que esse achado reforça o apontado por alguns estudos nacionais empíricos, como os propostos por Garbin et al. (2022) e Basto e Cepellos (2023), que mencionam a existência da referida lei.

Segundo a pesquisa conduzida pelo Instituto Ethos em 2024 (LOUREIRO, 2024), as seguintes organizações se destacam com relação à inclusão de pessoas com deficiência e quanto ao cumprimento da Lei de Cotas: (i) Sodexo, com cerca de dois mil empregados contratados com diferentes tipos de deficiência, que tem adotado a tradução de conteúdos para a linguagem de sinais; (ii) P&G, que afirma conduzir rodas de conversa para escuta ativa, treinamentos para equipes e palestras de sensibilização; e (ii) Arcos Dorados, que contrata aproximadamente 1.800 empregados com diversos tipos de deficiência, sendo cerca de 70% com deficiência intelectual.

Há dados que indicam que a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (2024), iniciada em 2008, tem contribuído para o cumprimento da Lei de Cotas pelas organizações e,

[16] Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 11 de janeiro de 2024 – Art. 8º [...] III - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 3.215,07 (três mil duzentos e quinze reais e sete centavos) a R$ 321.505,87 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos) (BRASIL, 2024).

consequentemente, representou um aumento, desde 2008 até 2023, de 64% nas contratações de pessoas com deficiência (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2024). Em 2023, teriam sido contratadas 142.618 pessoas com deficiência, sendo que 30.189 teriam sido realizadas como resultado da fiscalização direta do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por ter também essa finalidade de cumprimento da Lei de Cotas, as vagas destinadas para pessoas com deficiência, ou as denominadas "vagas afirmativas", dependem de um maior rigor pela organização na hora da contratação do potencial candidato com deficiência. Na percepção do Participante RH 6, não ter acesso a laudos que cumpram os requisitos legais é uma barreira para a contratação de pessoas com TEA:

> Não passam por um acompanhamento contínuo que permita entender qual é a condição, qual é o quadro, para enquadrar. E aí a gente não consegue enquadrar e se é uma vaga afirmativa, por exemplo, a pessoa não vai ser contratada para aquela posição. E aí ela vai entrar para o processo de seleção e vai competir com muito mais gente. Então, esse é um desafio gigante, gigante. Porque muitas pessoas em algum momento tiveram um diagnóstico que foi laudado, mas que não dá detalhes. E aí, no caso do autismo, o enquadramento depende de uma avaliação biopsicossocial. [...] E aí as vagas que eu tenho são vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Então, se a única vaga que eu tenho, a gente acaba não contratando a pessoa enquanto a gente não consegue um laudo que permita enquadrar ela e colocá-la naquela posição.

Esse tema tem relação com as potenciais barreiras identificadas no processo de obtenção do laudo com o diagnóstico de TEA, discutido no Tema 1 do Grupo 1, e com a decisão de um profissional com TEA em participar em processos de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência, analisado no Tema 8 do Grupo 1.

A discussão a respeito da relevância da avaliação biopsicossocial para fins de acessibilidade do profissional com TEA foi realizada no Tema 5 do Grupo 2, enquanto uma das barreiras macro identificadas por organizações para os programas de neurodiversidade.

Tema 4. Contratação de serviços prestados por consultorias e entidades sem fins lucrativos

Para estruturar seus programas de neurodiversidade, há evidências de que organizações contratam serviços prestados por consultorias, especializadas em gestão de pessoas, em diversidade e inclusão ou neurodiversidade; e por instituições e entidades sem fins lucrativos, que podem ou não ter metodologias próprias para o apoio na contratação de pessoas com TEA, como o emprego apoiado, abordado no Tema 1 do Grupo 3.

A partir dos relatos do Participante RH 6, é possível notar que o próprio comitê de diversidade e inclusão de sua organização foi inicialmente estruturado a partir de serviços prestados por uma consultoria especializada, criando as bases para iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e para a neurodiversidade:

> [...] surgiu o Comitê de Diversidade e Inclusão [...] e esse comitê surgiu de um estudo feito por uma consultoria terceira para mapear, que tinha por objetivo mapear quais eram os desafios para a sustentabilidade do nosso negócio. Dentre esses desafios mapeados, um deles era [...] criar soluções para incluir verdadeiramente todas as pessoas, independente das suas características. Nascendo esse Comitê de Diversidade e Inclusão, nasce um trabalho mais intencional para a inclusão de pessoas com deficiência.

Neste Comitê de Diversidade e Inclusão, são tratadas questões relacionadas à diversidade e inclusão de forma macro, o que inclui pessoas com deficiência. Além disso, para endereçar o aumento nas demandas associadas a profissionais com TEA em suas equipes no Brasil, o Participante RH 6 explica que a organização onde trabalha criou um grupo específico de trabalho para estudar as questões associadas à neurodiversidade:

> A gente tem um comitê de diversidade e inclusão olhando para todas as iniciativas de diversidade na América Latina, um grupo dedicado a olhar questões que envolvem pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, a partir dessa vivência, [...] criou-se um *squad* adicional para olhar e discutir questões ligadas a neurodiversidades, que é onde a gente tem maior representatividade e casos que foram gerando essa necessidade de olhar por esse lugar mais específico.

Também a Participante RH 2 relata a contratação de outra consultoria de gestão de pessoas e RH para as práticas de diversidade e inclusão, por meio da qual acabou contratando a única profissional com TEA de sua organização, ainda que não tenham desenvolvido um programa estruturado e especificamente voltado para a neurodiversidade:

> [...] as medidas de diversidade que a gente tem feito é através da Gupy. A gente tem ali módulos de diversidade deles, então, assim, de vez em quando, eu faço filtro ali, "Ok, quais são as pessoas mais diversas que eu posso ter aqui na minha *shortlist*", para apresentar para o gestor também. É, então, ainda não foi estruturado. A gente ainda vai pensar em formas de como fazer isso. [...] A gente não tem nenhuma vaga afirmativa ainda.

Adicionalmente, para a contratação reiterada de pessoas com deficiência, o Participante RH 6 descreve a utilização da metodologia do emprego apoiado, por meio da prestação de serviços de entidades sem fins lucrativos:

> A gente aqui em São Paulo, por exemplo, trabalha com a metodologia do emprego apoiado e até mesmo no diagnóstico de deficiência e também da condição do transtorno do espectro autista. [...] Então, sim, a gente segue com

> esse trabalho especializado, seja de consultoria, de treinamento ou de acompanhamento. Eles entram em diferentes momentos aqui do negócio.

A experiência da Participante RH 1 explica a decisão de sua organização de contratar os serviços oferecidos pela Specialisterne, uma das referências no mercado em se tratando de contratação de pessoas com TEA, e que também foi discutida no Tema 1 do Grupo 3:

> A gente não tinha expertise, não tinha contatos, não tinha nada. Então a Specialisterne foi crucial. Ainda hoje é nosso parceiro, mas a gente já faz um outro tipo de trabalho com eles. [...] eu precisava deles para captar profissionais, estudantes, enfim, existem tanto profissionais, que são funcionários, quanto estagiários autistas. Então, [...] eles nos ajudavam nesse pipeline de candidatos. [...] a Specialisterne me ajuda quando os funcionários já estão aqui na empresa e a gente faz um trabalho de *coaching*, que a gente chama, que eles identificam o perfil, algum tipo de necessidade, as potencialidades. Preparam o time que vai receber. Então, nessa parte mais de conscientização e mapeamento do perfil específico do candidato que não tem vindo mais por eles [...]. Então, mas, sem dúvida, a Specialisterne segue nosso parceiro, agora num outro nível, de intervenção, digamos assim, que a gente era desde o início, hoje não mais. Então é isso.

Há evidências, portanto, de que a contratação de consultorias especializadas e/ou de entidades e instituições sem fins lucrativos poderá ser um fator relevante para a implementação de programas de neurodiversidade em organizações. Pelo que se compreende do trecho da fala do Participante RH 6, a ausência de atendimento em determinados locais onde existem operações de sua organização pode ser considerada como algo que limita o número de contratação de pessoas com TEA:

> [...] a gente ainda sofre com algumas regiões justamente por não ter parceria local que possa atender com um atendimento especializado, acompanhar e, enfim, dar suporte ali no dia a dia. [...] em uma ou outra cidade, a gente tem uma instituição, mas de maneira até mais informal. É uma instituição que já assiste a pessoa com autismo, que aí conecta com a gente e continua fazendo esse acompanhamento, mas é muito mais ligado àquela pessoa e não ao negócio e nas outras regiões a gente fica descoberto desse atendimento especializado para o acompanhamento da pessoa. [...] Então, sim, a gente segue com esse trabalho especializado, seja de consultoria, de treinamento ou de acompanhamento. Eles entram em diferentes momentos aqui do negócio.

Como futuras pesquisas, sugere-se o mapeamento mais preciso de consultorias, entidades e instituições sem fins lucrativos que prestem atendimento para as organizações que desejam implementar programas de neurodiversidade ou contratar pessoas com TEA, como forma de reduzir barreiras para a empregabilidade de profissionais com TEA.

Os achados descritos nos Temas 1 a 4 do Grupo 2 foram organizados no Quadro 24:

Quadro 24. Visão geral dos Temas 1 a 4 do Grupo 2.

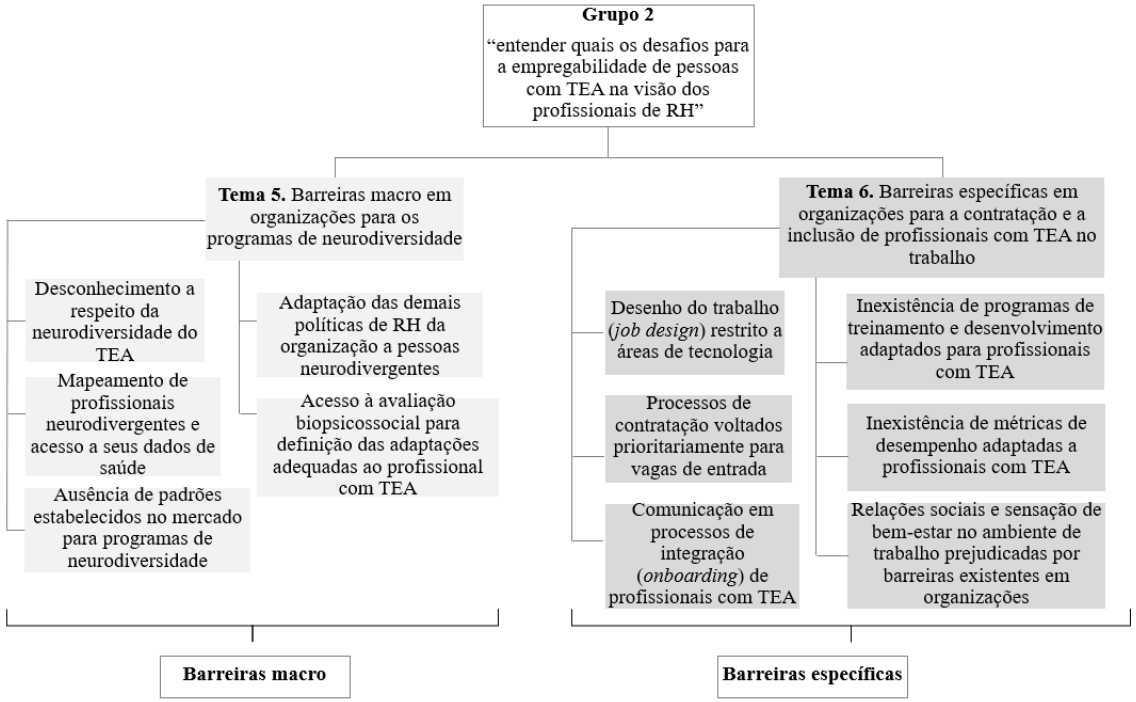
Temas 1 a 4 do Grupo 2	**Descrição dos aspectos identificados nos Temas 1 a 4 do Grupo 2 para compreender como são estruturados os programas de neurodiversidade em organizações**
A neurodiversidade na visão da Alta Administração	Percepção de que o posicionamento da Alta Administração a respeito de programas de neurodiversidade é fator crucial para a percepção da neurodiversidade nas práticas de RH e de gestão de pessoas. Ausência de clareza quanto ao posicionamento da Alta Administração sobre programas de neurodiversidade pode impactar a percepção de profissionais de RH e de gestão de pessoas acerca da longevidade de programas de neurodiversidade na organização. Evidências de que programas de neurodiversidade poderão ter sua origem em iniciativas mais amplas de diversidade e inclusão ou iniciativas direcionadas a pessoas com deficiência em geral em organizações. Evidências de que programas de neurodiversidade poderão ter sua origem em programas globais de neurodiversidade, implementados e incentivados por matrizes internacionais de organizações. Evidências de que o nível de maturidade de programas de compliance e de inclusão e diversidade poderão impactar os programas específicos de neurodiversidade. Evidências de que a maturidade das práticas de gestão de pessoas poderá impactar as práticas de diversidade e inclusão em organizações.
Ações para a valorização da neurodiversidade	Percepção de que ações individuais que fomentam a neurodiversidade poderão fomentar a criação de programas de neurodiversidade estruturados em organizações. Percepção de que as ações individuais que fomentam a neurodiversidade poderão contribuir para a criação de um ambiente organizacional diverso. Evidências de que o interesse pessoal de profissionais de RH e de gestão de pessoas poderá fomentar ações em prol da neurodiversidade, em organizações que ainda não tenham programa de neurodiversidade estruturado. Evidências de que as ações individuais adotadas por organizações que ainda não possuem programas de neurodiversidade estruturado compreenderiam palestras, rodas de conversa e ações específicas em datas relevantes para o movimento de valorização de pessoas com TEA ou pessoas com deficiência.
Cumprimento de obrigações legais relacionadas a pessoas com deficiência	Evidências de que organizações estão cientes de que devem cumprir a Lei de Cotas, caso estejam enquadradas nos limites legais. Evidências de que a contratação de pessoas com TEA para vagas destinadas a pessoas com deficiência poderá ser impactada pelas barreiras na obtenção do laudo.
Contratação de serviços prestados por consultorias e entidades sem fins lucrativos	Evidências de que organizações contratam serviços prestados por consultorias específicas em diversidade e inclusão ou instituições e entidades sem fins lucrativos que capacitam e preparam profissionais com TEA para o mercado. Evidências de que grupos específicos de trabalhos para fomentar a neurodiversidade poderão ter seu início associado a programas mais amplos de diversidade e inclusão em organizações. Evidências de que a contratação de pessoas com TEA em organizações ainda sem programas estruturados de neurodiversidade poderá contar com serviços prestados por consultorias de diversidade e inclusão. Evidências da utilização da metodologia do emprego apoiado para a contratação de pessoas com TEA em organizações. Evidências de que as organizações poderão contratar serviços da Specialisterne por não terem conhecimento inicial para estruturar programas de neurodiversidade. Evidências de que as organizações poderão continuar a contratar a Specialisterne para a manutenção de seus programas de neurodiversidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

Outro objetivo específico definido para a pesquisa e que está relacionado com os participantes do Grupo 2 é “entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais de RH”.

Foram definidos os seguintes temas, que estão alinhados com o referido objetivo específico: (i) Tema 5 – Barreiras macro em organizações para os programas de neurodiversidade; e (ii) Tema 6 – Barreiras específicas em organizações para a contratação e a inclusão de profissionais com TEA no trabalho. A Figura 10 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 10. Visão geral da análise temática para os Temas 5 e 6 do Grupo 2.



Fonte: Elaborado pela autora.

Não se pretende esgotar na presente análise o mapeamento de todas as barreiras (sejam elas macro ou específicas) relacionadas à empregabilidade de pessoas com TEA na visão de profissionais de RH, sugerindo-se, portanto, que tais temáticas sejam exploradas futuramente em outras pesquisas.

Tema 5. Barreiras macro em organizações para os programas de neurodiversidade

Considerando o enfoque desta pesquisa, os participantes do Grupo 2 selecionados e os objetivos geral e específicos definidos em conexão com o Grupo 2, foram considerados os seguintes subtemas para o Tema 5: (i) Desconhecimento a respeito da neurodiversidade do TEA; (ii) Mapeamento de profissionais neurodivergentes e acesso a seus dados de saúde; (iii)

Ausência de padrões estabelecidos no mercado para programas de neurodiversidade; (iv) Adaptação das demais políticas de RH da organização a pessoas neurodivergentes; e (v) Acesso à avaliação biopsicossocial para definição das adaptações adequadas ao profissional com TEA.

Desconhecimento a respeito da neurodiversidade do TEA

Conforme indicado por Khan et al. (2022) na literatura internacional, a falta de conhecimento pelos profissionais de RH e de gestão de pessoas a respeito da neurodiversidade e do TEA é considerada uma barreira relevante para a empregabilidade de pessoas com TEA e pode ser notada por meio do relato da Participante RH 1:

> Eu acho que assim eu, eu não, eu assim... não acho que seja falta de interesse, olhando muito para a gente. Quando a gente começou lá [...] atrás, sim, eu acho que é mais o medo do desconhecido. [...] "mas como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ter uma autista no meu time? Como é que eu tenho que falar? O que é que tem, o que é que eu tenho que fazer? [...] O não conhecimento, e é isso em qualquer área, te gera uma ansiedade, te gera...e traz erros porque tu não conhece.

Como forma de superar esse obstáculo, Albright, Kuloka e Scarpa (2020) sugerem o aprimoramento da compreensão a respeito do TEA, por meio de treinamentos nos locais de trabalho para essa finalidade. E é essa a indicação feita pela Participante RH 2 e Participante RH 3:

> É, eu acho que o principal seria treinamento, mas é para todo mundo da empresa, principalmente recrutadoras. [...] eu acho que treinamentos e conscientização em todos os processos, então, todas as gestões na empresa (Participante RH 2).

> É exatamente isso: o conhecimento, ele é libertador e as pessoas precisam se munir (Participante RH 3).

Possivelmente, o desconhecimento a respeito do TEA seja um dos motivos pelos quais as organizações entendam que necessitam da contratação de consultorias especializadas e/ou de entidades e instituições sem fins lucrativos que prestem serviços às organizações a respeito de neurodiversidade como uma das formas de implementar programas de neurodiversidade, como discutido no Tema 4 do Grupo 2.

Mapeamento de profissionais neurodivergentes e acesso a seus dados de saúde

Uma barreira relevante apontada pelo Participante RH 6 diz respeito à dificuldade de se obter um mapeamento preciso a respeito dos profissionais com TEA em uma organização, levando a potenciais atrasos na estruturação de medidas e obtenção dos avais necessários para a implementação de programas efetivos:

> E aí o desafio vira, às vezes, a falta de informação, ou de dados, que faz com que a gente demore mais para estruturar as ideias e poder bancar ou fazer as aprovações que precisa. Então, existe sim um interesse verdadeiro e genuíno de desenvolver projetos, mas ainda assim essa é uma companhia que depende de programas pautados na necessidade que sejam estruturados como qualquer negócio de fato exige.

Tais fatos podem estar associados a questões legais, como a legislação de proteção de dados pessoais[17], que prevê que dados relacionados à saúde são considerados dados pessoais sensíveis[18] e, portanto, sujeitos a regramentos específicos quanto ao seu tratamento por organizações. Não seriam, portanto, de livre acesso, como destaca a Participante Org. 4:

> [...] mas o mapeamento em si das neurodiversidades e algumas não só do autismo em si, mas TDAH e algumas subdiagnosticadas [...]. Então, a gente criou algumas ferramentas para tentar fazer um levantamento e essa abertura, essa acessibilidade da população para a gente conseguir até ter numericamente pessoas que se dizem ou que ainda não se diagnosticaram ou que se entendem [...]. Então, a gente teve essa certa dificuldade, fizemos algumas estratégias, principalmente jurídicas, no sentido de atingimento, de abordagem, para conseguir chegar, de fato, nos funcionários e perguntar tem alguma coisa com a área de saúde, essa acessibilidade "tem alguma coisa, tem algum quadro, alguma situação que te dificultou, que te dificulta no dia a dia do trabalho em si?" A gente teve um pouco nesse embate de conseguir chegar a ponto nessa pesquisa [...]

Adicionalmente, não pode ser desconsiderado neste cenário o receio indicado por muitos profissionais com TEA a respeito da revelação de sua neurodivergência no ambiente de trabalho, em virtude de preconceito de empregadores (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023), como discutido no Tema 1 do Grupo 1 deste trabalho.

---

[17] Como a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)

[18] Art. 5º, inciso II da Lei Geral de Proteção de Dados - II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (BRASIL, 2018).

Ausência de padrões estabelecidos no mercado para programas de neurodiversidade

Como sugerido por Dreaver et al. (2019) no contexto internacional, percebe-se que, também no Brasil, ainda há uma compreensão limitada de como apoiar na prática e da melhor forma os profissionais com TEA no ambiente de trabalho, sendo necessárias mais pesquisas e discussões a respeito do tema.

Um achado relevante no presente estudo e compartilhado pela Participante RH 5 é a constatação de que ainda não haveria um padrão estabelecido no mercado brasileiro de como deveriam ser estabelecidos os programas de neurodiversidade:

> Até uma dificuldade que a gente sentiu... a gente fez bastante benchmarking com muitas empresas até para entender o que as outras empresas estavam oferecendo. Só que o que a gente viu é que isso a gente já faz, porque o nosso público e o nosso sistema, como é muito pulverizado, todos os problemas de saúde que a gente precisa implantar sempre é diferente. Então, não existe uma receita, porque a gente não está numa fábrica, a gente não tem um local que fica fácil para a gente disseminar esses programas. Então, sempre é diferente, mas mesmo fazendo benchmark com os parceiros, foi uma dificuldade que a gente teve de... "O que a gente precisa? O que é imprescindível? O que é algo a mais que a gente pode fazer?" Então, não teve uma definição do que é praticado hoje no mercado.

Essa percepção trazida pela Participante RH 5 parece estar em linha com o apontado em estudos internacionais, como o proposto por Khan et al. (2022), ao indicar que as ideias relacionadas à neurodiversidade envolvem diferentes contextos, como o médico e o psicológico, havendo ainda limitada pesquisa empírica em estudos organizacionais e de gestão. Além disso, considerando novamente a existência de características específicas em cada pessoa com TEA ("*no two autistic adults are the same*") (CARRERO; KRZEMINSKA; HÄRTEL, 2019), haveria, portanto, necessidades de adaptação também específicas, dependendo das características do negócio da organização, do número de empregados envolvidos na operação, das atividades que seriam exercidas pelas pessoas com TEA, entre outros aspectos.

Barreiras como desconhecimento a respeito do TEA pelos profissionais de RH e gestão de pessoas, dificuldades associadas ao mapeamento de pessoas neurodivergentes em organizações e a necessidade de apoio constante de consultorias especializadas e/ou entidades e instituições sem fins lucrativos especializadas na capacitação e inclusão de profissionais com TEA no mercado de trabalho parecem influenciar na ausência de um desenho padrão para programas de neurodiversidade no país.

Adaptação das demais políticas de RH da organização a pessoas neurodivergentes

Outro achado relevante na presente análise é obtido por meio do relato do Participante RH 6, relacionado à adaptação de outras políticas de gestão de pessoas, como as de remuneração e benefícios, para abordar situações específicas de profissionais neurodivergentes, como afastamentos necessários por questões de saúde ou tratamento. Por questões de confidencialidade e sigilo, foram subtraídos alguns trechos da transcrição a seguir:

> [...] a gente conseguiu aprovar uma alteração na nossa política de pagamento de bônus, por exemplo, que prevê que pessoas enquadradas na cota de PCD que têm afastamentos relacionados à sua condição, ou seja, se eu tenho uma pessoa autista afastada do trabalho por alguma doença que desenvolveu, pela necessidade de um tratamento ligado à sua condição, esse período de afastamento é considerado período trabalhado para fins de pagamento de bônus.

Isso é viabilizado por meio da atuação conjunta dos profissionais de gestão de pessoas e medicina e segurança do trabalho com o time de benefícios da organização, compreendendo que as pessoas com TEA poderão ter necessidades específicas associadas a atendimento médico e de outros profissionais da saúde, como explica a Participante RH 5:

> Eu acho que até, no que tange a parte mais específica de neurodiversidade, principalmente quando a gente fala do grupo de pessoas autistas. Isso cresceu muito pelo nosso dia a dia que a gente tem contato junto aos funcionários e familiares. Então, a nossa equipe faz muito suporte em relação a toda a tratativa de tratamento de profissionais de saúde, de cuidados de saúde. A gente tem esse relacionamento muito próximo com o time de benefícios. Como temos bastante diversidade, quando a gente fala de tratamento de saúde em relação ao espectro autista, seja psicólogo que é referência no tema, seja o neurologista, seja o pediatra, seja o fono. Tem uma multidisciplinaridade que a gente precisa olhar quando a gente fala de tratamento de saúde, que muitas vezes dificulta tanto o acesso quanto até a realização desse tratamento.

Esses apontamentos feitos pela Participante RH 5 parecem ter relação com aspectos da jornada de trabalho diária para pessoas com TEA, que poderão ter necessidade de flexibilização para atendimento médico de outros profissionais de saúde, como discutido no Tema 4 do Grupo 1 desta pesquisa.

Ainda a respeito dos benefícios que são concedidos a empregados, a Participante RH 4 destacou a experiência que teve em sua organização com o mapeamento do uso do plano de saúde corporativo, buscando identificar como o empregador poderia sugerir melhorias para o atendimento clínico geralmente procurado por pessoas com TEA, como empregados ou como responsáveis legais por dependentes com TEA:

> Muitas dificuldades, muitas vezes, de direcionamento, entendimento e liberação, muitas vezes, de plano de saúde para a rede ou, muitas vezes, nesse entendimento do profissional de início principalmente, de diagnóstico para apoio e para sustentação posterior de tratamento. Acho que esse é um ponto muito falado. Onde ir, como fazer. Então, isso foi mapeado de início em todos os casos, pois realmente era muito confuso. Inicialmente tem aquele uso do plano que a gente não consegue identificar e aí, de fato, quando é diagnosticado, a gente tem um direcionamento melhor, vamos dizer assim, do tratamento e acompanhamento com os profissionais adequados.

Em razão das necessidades mapeadas internamente com relação aos profissionais com TEA, a Participante RH 5 explica que a organização onde atua implementou uma plataforma para acesso a serviços de saúde por parte das pessoas com TEA, indicando outra prática que compõe as adaptações feitas para dar o apoio necessário a profissionais com TEA:

> E, recentemente, a gente fez a implantação de uma plataforma de telemedicina, até telepsicologia online, telenutrição. Isso facilitou o acesso ao tratamento para essas pessoas.

Além disso, constata-se, pela fala do Participante RH 6, que outras práticas de RH foram adaptadas por sua organização para promover a adaptação do profissional com TEA desde o início do processo de recrutamento e seleção, com o objetivo de mitigar a rotatividade dos profissionais com TEA e impactos negativos à sua sensação de bem-estar no trabalho. Algumas pequenas alterações foram implementadas no relato do Participante RH 6 apenas com a finalidade de atender à confidencialidade e sigilo de suas operações, como indicado no TCLE:

> Primeiro, em relação à adaptação, é sempre uma surpresa, até para mitigar um pouco o risco de alguém não se adaptar. Na entrevista, a gente leva a pessoa para o seu local de trabalho [...] faz uma visita, porque pode oferecer muito estímulo sensorial. Então, algumas pessoas a gente acredita que vão se adaptar e, na prática, não conseguem se adaptar, acabam entrando em crises e aí, em alguns casos, até optam pela saída. [...] A gente tem tentado mitigar isso sempre com a visita antes, durante o processo de entrevista, leva o pessoal para conhecer [...]. Em alguns casos, a gente até constrói as escalas de trabalho para que as pessoas autistas trabalhem em horários de menor movimento, porque vão ter menos estímulos sensoriais. Então, o fator adaptação é sempre um ponto de preocupação e um ponto sensível.

Em razão de algumas pessoas com TEA necessitarem de maior previsibilidade quanto a mudanças, o Participante RH 6 identificou a necessidade de implementar na sua organização práticas de RH voltadas especificamente para cenários de transferência de profissionais com TEA entre equipes, preparando tanto a gestão para recepcionar a pessoa com TEA que ingressará no time quanto o próprio profissional a respeito da mudança de seu gestor.

Novamente, algumas modificações foram realizadas no relato com a intenção de preservar a confidencialidade e sigilo das operações da organização onde trabalha o Participante RH 6:

> [...] a gerência tende a ser o ponto de segurança ou a pessoa de referência da pessoa com autismo. E se adaptar às transferências também é um ponto sensível, tanto é que hoje o checklist de transferência prevê que antes de realizar uma transferência você entenda quem são as pessoas com deficiência que trabalham lá, quem são as pessoas que podem estar na condição de neurodivergente também, e antecipar essas mudanças com a pessoa com deficiência intelectual ou autista, porque eles acabam sofrendo muito com a mudança. Então tem que ter um processo para apresentar quem vai chegar, antecipar essa notícia de quando vai acontecer essa movimentação, porque, historicamente, as pessoas não reagem muito bem às movimentações.

Para além das pessoas com TEA empregadas pela organização, a Profissional RH 4 explica que sua organização também passou a identificar e adaptar práticas de RH para profissionais neurotípicos que são responsáveis por pessoas com TEA em suas vidas pessoais:

> A gente tinha famílias atípicas que a gente conversou, entendendo ali dois cenários: a nossa população atípica, neurodiversa, e os responsáveis, muitas vezes os pais, os cuidadores, no sentido de ver também as necessidades que eles entendiam que têm, no sentido do cuidado, principalmente. [...] Quando a gente fala de cuidadores, a gente tem também essa sinalização de rede, de suporte, de cuidado. E aí a gente tem outras pesquisas internas com relação às saídas de, muitas vezes, cuidadores com relação a cuidados de neurodiversos e que, por incompatibilidade do trabalho em si, precisaram se ausentar ou até se desligar da empresa para cuidar desse dependente. Então, houve algumas situações mais pontuais, vamos dizer assim, de liberação do horário de trabalho, flexibilização do horário de trabalho.

Ao compreender a situação de empregados que poderão ser responsáveis por pessoas com TEA em suas respectivas famílias, a organização onde trabalha a Participante RH 4 parece ter uma preocupação que foi endereçada pela Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022 (BRASIL, 2022), que, no Artigo 8º, prevê medidas para flexibilização de jornada de trabalho a empregados e empregadas que "tenham filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, com vistas a promover a conciliação entre o trabalho e a parentalidade". Dentre as medidas, a legislação estabelece: (i) possibilidade de compensação de jornada por meio de banco de horas; (ii) antecipação de férias individuais; e (iii) horários de entrada e saída flexíveis.

A partir desses achados, recomenda-se que novos estudos aprofundem não apenas a necessidade de flexibilização da jornada de trabalho para profissionais com TEA propriamente ditos, mas também os responsáveis legais por pessoas com TEA, pois poderão necessitar de apoios específicos para manter suas atividades laborais e a própria empregabilidade.

Acesso à avaliação biopsicossocial para definição das adaptações adequadas ao profissional com TEA

Nos termos do art. 2º, §1º da LBI, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe composta por diferentes profissionais e será interdisciplinar, devendo indicar:

> I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
>
> II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
>
> III - a limitação no desempenho de atividades; e
>
> IV - a restrição de participação.

Um achado obtido por meio do relato do Participante RH 6 é o fato de que poucos profissionais com TEA teriam acesso a tais avaliações, dificultando a compreensão da organização a respeito dos ajustes que seriam necessários para redução de barreiras e garantia de acessibilidade:

> [...] mas, para além disso, eu também cito que, para fins de enquadramento, ter acesso a pessoas que tem avaliação, que passam por avaliação biopsicossocial, que tem um laudo que defina de fato, que esclareça quais são as habilidades que necessitam adaptação ou que não foram desenvolvidas, é super desafiador. Assim, via de regra, as pessoas, no máximo, têm um laudo com CID.

As discussões realizadas nos subtemas do Tema 5 do Grupo 2 foram organizadas no Quadro 25:

Quadro 25. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 2.

Subtemas do Tema 5 do Grupo 2	**Descrição das barreiras macro identificadas nos subtemas do Tema 5 do Grupo 2**
Desconhecimento a respeito da neurodiversidade do TEA (continua) (continuação)	Evidências de que há falta de conhecimento por profissionais de RH e de gestão de pessoas a respeito da neurodiversidade e do TEA. Evidências de que organizações têm utilizado treinamentos no local de trabalho para mitigar a falta de conhecimento por profissionais de RH e de gestão de pessoas a respeito da neurodiversidade.
Mapeamento de profissionais neurodivergentes e acesso a seus dados de saúde	Dificuldade para a realização de mapeamento de profissionais com TEA em organizações, podendo levar a potenciais atrasos na estruturação de medidas e obtenção de aprovações internas. Existência de leis específicas para a proteção de dados pessoais de profissionais com TEA.
Ausência de padrões estabelecidos no mercado para programas de neurodiversidade (continua)	Constatação de que não há padrão estabelecido no mercado brasileiro para programas de neurodiversidade estruturados para referência de organizações que desejam implementar tais programas.

(continuação)	
Adaptação das demais políticas de RH da organização a pessoas neurodivergentes	Percepção acerca da necessidade de adaptação de outras políticas de gestão de pessoas, como as de remuneração e benefícios, contratação, planos de saúde, entre outras, para pessoas com TEA.
Acesso à avaliação biopsicossocial para definição das adaptações adequadas ao profissional com TEA	Percepção de que os profissionais com TEA não teriam acesso a avaliação biopsicossocial. Evidências de que a ausência de uma avaliação biopsicossocial poderia impactar na compreensão pelos profissionais de RH e de gestão de pessoas dos apoios necessários para cada profissional com TEA.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 6 – Barreiras específicas em organizações para a contratação e inclusão de profissionais com TEA no trabalho

Para a identificação das barreiras específicas nas organizações para a contratação e a inclusão de profissionais com TEA no trabalho propostas neste Tema 6 do Grupo 2, assim como indicado no Tema 4 do Grupo 1 e no Tema 5 do Grupo 3, serão analisadas as evidências obtidas por meio dos relatos dos participantes do Grupo 2 e as seis áreas principais de RH sugeridas por Doyle e McDougall (2022), discutidas no item 2.3.3. do presente estudo.

Com base nas referidas seis áreas de RH e a partir da aplicação dos conceitos de acessibilidade e de desenho universal previstos na LBI, foram propostos os seguintes subtemas para este Tema 6 do Grupo 2: (i) Desenho do trabalho (*job design*) restrito a áreas de tecnologia; (ii) Processos de contratação voltados prioritariamente para vagas de entrada; (iii) Comunicação em processos de integração (*onboarding*) de profissionais com TEA; (iv) Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA; (v) Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA; e (vi) Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações.

Salienta-se que a temática tratada neste Tema 6 do Grupo 2 refere-se a um objetivo específico que também foi associado aos participantes do Grupo 1 e Grupo 3. Será discutida, posteriormente, a visão integrada dos participantes dos três grupos (Grupos 1, 2 e 3) a respeito das barreiras específicas em organizações para a contratação e inclusão de profissionais com TEA no trabalho, que levem à identificação dos desafios para a empregabilidade das pessoas com TEA.

Desenho do trabalho (job design) restrito a áreas de tecnologia

Um dos aspectos identificados quanto ao desenho do trabalho (*job design*) que parece restringir a atuação de profissionais com TEA é a percepção de que as características comumente associadas ao TEA favoreceriam o desenvolvimento de trabalhos na área de tecnologia. É o que se denota do relato da Participante RH 1:

> [...] descobrimos que eles também têm características - a gente sabe - que são únicas. Eu sou a mais a defensora disso, de que não existe uma receita de bolo, mas que características do ambiente de TI, teste de software, teste de qualidade, verificações de padrões, enfim, tinha uma aderência, um "fit" com, digamos, o perfil. Se a gente puder generalizar autista. [...] É assim: tem escritórios, onde tem áreas comerciais, enfim; e tem laboratórios onde tem uma estrutura. Tens que ter área de desenvolvimento de suporte, de inovação. Tem... também pode ter uma parte de vendas, mas é basicamente como o nome diz, né? A área de desenvolvimento e inovação. Atendimento ao cliente nessa questão do software mesmo.

Essa opinião parece corroborar o apontamento feito por Skibell (2017) de que cada vez o trabalho com tecnologia tem sido visto como uma área ideal para alguns adultos com TEA, com possibilidade de desenvolvimento de carreira na referida área.

Apesar de haver evidências de que profissionais com TEA poderiam atuar em diferentes áreas e que há certos mitos associados ao seu temperamento, como a introversão, a percepção da Participante RH 2 é de que as pessoas com TEA também estariam mais bem ajustadas ao desenho de trabalho tipicamente encontrado em áreas de TI:

> É, então, acho que, no dia a dia, TI, no geral, sendo uma área um pouco mais introvertida, eu acho que, no geral, eles se deram muito bem.

Uma das barreiras que poderá ser criada quanto a essa interpretação restritiva a respeito da área de atuação das pessoas com TEA e suas respectivas habilidades pessoais é a redução de oportunidades de trabalho para esse grupo de profissionais. Neste contexto, tais pessoas poderão se tornar verdadeiros reféns de determinadas carreiras e organizações, sem conseguirem se desenvolver em suas verdadeiras áreas de interesse e aptidão.

Essa avaliação está em linha com o apontado por Johnson et al. (2020), que indicam que os modelos atuais de contratação ofereceriam oportunidades limitadas de engajamento e crescimento para profissionais neurodivergentes nas organizações.

Processos de contratação voltados para vagas de entrada

Outra barreira que poderia ser apontada em organizações para a contratação de profissionais com TEA é a percepção de que haveria mais opções em vagas de entrada (como o estágio) do que em outros cargos mais avançados e estruturados em organizações. É o que se afere do relato da Participante RH 2:

> Então, é... por ser uma vaga de estágio, a nossa entrevista é estruturada de uma forma um pouco diferente. Então, a gente não busca pessoas que já tenham uma experiência prévia. Justamente, é um estágio, é uma porta de entrada.

Essa mesma avaliação foi realizada por participantes do Grupo 3, nas discussões feitas no Tema 3, que sugerem que as instituições ou entidades sem fins lucrativos que trabalham com a colocação e treinamento de pessoas com deficiência e profissionais com TEA acabam sendo procuradas por organizações para preenchimento das referidas "vagas de entrada" com profissionais com TEA e outras pessoas com deficiência.

Diante deste cenário, o Participante RH 6 explica que, na sua organização, uma posição operacional seria a porta de entrada para profissionais com TEA em razão: (i) das características próprias do modelo de negócio no local onde trabalha; (ii) do fato de que, muitas vezes, as pessoas com TEA estariam buscando o primeiro emprego; e (iii) de outras posições serem preenchidas por meio de recrutamento interno, em linha com um plano de carreira estruturado para profissionais com TEA. Há também a percepção de que pessoas neurodivergentes teriam um tempo diferente para desenvolver certas habilidades exigidas para o trabalho. Alguns pequenos ajustes foram realizados no relato para preservar a confidencialidade e sigilo das operações da organização onde o Participante RH 6 atua:

> A grande porta de entrada do nosso negócio é a posição de base de atendente. Por isso que, majoritariamente, as pessoas estão numa condição de primeiro emprego. As outras posições são preenchidas com o recrutamento interno, justamente porque existe um plano de carreira estruturado. Quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, historicamente, elas levam um tempo maior para se desenvolver, postularem as posições e, consequentemente, crescer. Mas elas ocupam já todos os níveis da nossa organização.

Evidências que apontam neste sentido podem sugerir que ainda não há, na maioria das organizações, um planejamento para a carreira de profissionais com TEA, que podem se sentir forçados a reiniciar constantemente sua vida profissional em novas organizações, mas na mesma posição anterior que já ocupavam. Sugere-se como próximas pesquisas entender como

são estruturados planos de carreira adaptados para as necessidades de pessoas com TEA em organizações.

Comunicação em processos de integração (onboarding) de profissionais com TEA

Dentre as características que são geralmente associadas ao TEA, destacam-se formas diferentes de se comunicar, em comparação aos demais profissionais neurotípicos. Para a Participante RH 2, esse aspecto pode ser indicado como uma potencial barreira na organização, caso o profissional com TEA não receba os devidos apoios:

> Então, a gente repara algumas questões um pouco mais... Vamos dizer simples assim, né? Então, aquela dificuldade, às vezes, um pouco de entender as ironias que a gente fazia, as questões de expressões muito "ao pé da letra" e, às vezes, um pouquinho de noção social, não é. A gente percebia "acho que não era o momento de você ter falado isso. Você poderia ter falado de alguma outra forma".

Essa mesma percepção é reforçada por meio do relato do Participante RH 6, que, ao identificar eventuais apoios necessários para a comunicação de pessoas neurodivergentes, explica que a organização onde trabalha considera tais aspectos tanto nas avaliações quanto nos treinamentos internos para fins de desenvolvimento de carreira:

> Quando a gente fala da condição de neurodivergência, de novo, o tempo de desenvolvimento acaba sendo um pouco maior, principalmente pelas habilidades de comunicação comprometidas. Porque para se candidatarem a uma avaliação de uma nova posição, essa pessoa passa por uma avaliação técnica e uma avaliação comportamental, que inclui uma entrevista. Então, eles têm, às vezes, mais dificuldade de expressar as suas ideias, até de fazer gestão de pessoas. A ascensão depende muito dessa habilidade desenvolvida. Então, acaba exigindo um pouco mais. Mas todos os nossos mecanismos de treinamento e desenvolvimento contribuem muito para esse crescimento. Então, acho que isso que tem contribuído para que a gente consiga fazer com que as pessoas, de fato, se desenvolvam e cresçam.

Esses achados parecem estar em linha com o apontado por Szulc (2021), que explica que a superação de potenciais problemas atrelados à interação social é um dos pontos associados por profissionais de organizações na contratação de pessoas com TEA. Leopoldino e Costa Coelho (2017) apresentam tais características como limitações na comunicação de pessoas com TEA, em uma terminologia mais próxima ao modelo médico da deficiência.

Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA

De acordo com a Participante RH 2, que trabalha em uma organização que informa não possuir programa de neurodiversidade estruturado implementado ainda, não há também programas de treinamento e de desenvolvimento especificamente desenhados para pessoas com TEA:

> Então, hoje ainda não existe aquela questão do RH ter métricas, de apresentar resultados, de poder, levar essa informação e falar assim "olha que legal. A gente tem uma pessoa autista que vai ser promovida. Olha o quão incrível é isso. Vamos tentar abraçar, vamos tentar trazer", então, ainda não tem...

O Participante RH 6, entretanto, explica que, na organização onde atua, foi estruturado um programa de treinamento especificamente voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais, focado em como lidar com o estresse, comunicação não violenta e inteligência emocional. O objetivo é permitir o desenvolvimento individual de profissionais com TEA, em linha com o proposto com plano de carreira na organização. Alguns trechos do relato foram adaptados de modo a preservar a confidencialidade e sigilo das operações da referida organização:

> [...] foi desenvolvido um programa com o objetivo de desenvolver oito competências socioemocionais: tolerância ao estresse, comunicação não violenta e inteligência emocional. E ele termina essa formação com a construção do projeto de vida, quando a pessoa é desafiada a definir seu propósito e traçar as ações de desenvolvimento individual que vão levar ela até onde ela quer chegar, com foco 100% de desenvolvimento de habilidades socioemocionais e não habilidades técnicas. Esse projeto foi construído pensando numa linguagem acessível, numa linguagem menos robusta, que permita que a pessoa não alfabetizada ou com baixa escolaridade consiga também produzir e se desenvolver a partir de onde ela chegou e onde ela quer chegar.

Esse achado parece estar em linha com as experiências descritas pela Participante Org 2., no Tema 2 do Grupo 3, enquanto um dos serviços oferecidos para profissionais com TEA como forma de apoio para o ingresso no mercado de trabalho.

Para a Participante RH 5, outro aspecto relevante do treinamento que foi desenvolvido na organização onde trabalha é a capacitação de líderes e gestores que trabalham com pessoas neurodivergentes a respeito de sua própria saúde emocional, como um modo mais amplo de, em um primeiro momento, conseguir lidar com as pressões e responsabilidades do trabalho em si para, em um segundo momento, ser capaz de se relacionar com times neurodivergentes:

> O foco que a gente está trabalhando muito forte esse ano é a parte de capacitação de saúde emocional, que eu acho que liga bastante com essas questões de como lidar, inclusive voltado para a equipe gerencial. Então, a gente esse ano focou para fazer o treinamento dessas lideranças para entendimento dele. Então, cuidando de si, cuidando de quem cuida e fazendo esse paralelo de como tratar todas essas questões junto aos seus liderados.

Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA

De acordo com os relatos dos participantes do Grupo 2, não foram constatadas métricas de desempenho adaptadas especificamente a profissionais com TEA, apesar de a Participante RH 1 trabalhar em uma organização que alega possuir um programa de neurodiversidade implementado:

> Acaba não tendo nenhum tipo de diferença, nem de remuneração, nem de avaliação, nem de nada, de benefícios, nada. O que que a gente faz de diferente é identificar se ele necessita de alguma acomodação.

Um achado que parece contrariar a percepção da Participante Org. 2 quanto à saída precoce de profissionais com TEA de seus respectivos empregos, antes mesmo de conseguirem participar de avaliações de desempenho, é a experiência descrita pelo Participante RH 6 da realidade que observa na organização onde trabalha. Na visão do Participante RH 6, as pessoas com TEA tendem a ficar mais tempo do que os demais profissionais neurotípicos, por terem um tempo de aprendizado diferente e terem a sensação de que estão sendo desafiados constantemente. Alguns trechos do relato foram adaptados para preservar a confidencialidade e sigilo das operações da organização onde o Participante RH 6 atua:

> Mas justamente como o tempo de aprendizagem das pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência é um pouco maior, eles acabam ficando mais tempo porque eles se sentem desafiados em crescimento constante por mais tempo. A pessoa sem deficiência, ela com três meses, seis meses, um ano, acha que ela já está pronta para ir ganhar o mundo. E a pessoa com deficiência, às vezes, entende que ela precisa de mais tempo para ir construindo essa ascensão. Então a rotatividade é menor.

As diferenças entre as percepções da Participante Org. 2 e do Participante RH 6 podem ter relação com os seguintes fatores: (i) características próprias do modelo de negócio de diferentes organizações; (ii) perfil dos profissionais neurotípicos que atuam em diferentes organizações; e (iii) perfil e nível de suporte dos profissionais com TEA que atuam em diferentes organizações.

Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações

Os relatos dos participantes do Grupo 2 indicam algumas percepções quanto a reações de profissionais com TEA diante de situações sociais, como almoços de equipe, confraternizações e festas corporativas:

> Ou tinha o almoço do time e que não tem uma agenda. As pessoas falam coisas aleatórias. Isso gera muita ansiedade. Aí o colega foi e ficou 3 dias sem trabalhar, porque aquilo gerou um burnout de interação social. Então, essas coisas acontecem (Participante RH 1)

> Eu acho que a maior experiência que eu tive com ela, nesse sentido, foi de festas. Então, quando a gente tem festa, eu pergunto para ela "você tem problemas com barulho?" Ela "sim". Então, "olha, vai com cuidado, se você não quiser ficar muito tempo, não tem problema". Então, a gente já teve 2 festas lá na empresa que eu tive o cuidado de passar isso para ela. Mas as outras questões de querer ficar mais tempo em casa, não tanto (Participante RH 2)

Tais falas parecem corroborar o estudo feito por Melo, Garrocho e Guerra (2021), que sugerem haver dúvidas em organizações quanto à capacidade de profissionais com TEA de: (i) comportarem-se de determinadas maneiras, que seriam esperadas no mundo corporativo; e (ii) serem capazes de se relacionar em grupos.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 6 do Grupo 2 foram organizados no Quadro 26:

Quadro 26. Visão geral dos subtemas do Tema 6 do Grupo 2.

Subtemas do Tema 6 do Grupo 2	**Descrição das barreiras específicas identificadas nos subtemas do Tema 6 do Grupo 2**
Desenho do trabalho (*job design*) restrito a áreas de tecnologia	Percepção de que as características comumente associadas ao TEA favoreceriam o desenvolvimento de trabalhos na área de tecnologia. Restrição de ofertas de trabalho para profissionais com TEA.
Processos de contratação voltados prioritariamente para vagas de entrada	Percepção de que haveria mais opções em vagas de entrada (como o estágio) do que em outros cargos. Limitação de oportunidades de emprego para pessoas com TEA. Ausência de plano de carreira para profissionais com TEA.
Comunicação em processos de integração (*onboarding*) de profissionais com TEA	Percepção de que as diferentes formas de comunicação utilizadas por alguns profissionais com TEA poderia impactar na sua integração com os demais colegas neurotípicos.
Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA	Inexistência de programas de treinamento adaptados para profissionais com TEA em organizações nas quais ainda não há programas de neurodiversidade estruturados. Existência de treinamentos e desenvolvimento em organizações com programas de neurodiversidade com foco em habilidades socioemocionais e não técnicas. Existências de treinamentos para líderes e gestores focado em saúde emocional e não neurodiversidade propriamente dita.

(continua)

(continuação) Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Evidências de que não haveria métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA em organização que conta com programa de neurodiversidade estruturado. Percepção de que pessoas neurodivergentes apresentam, de forma geral, um tempo maior para desenvolvimento, podendo impactar seu crescimento na organização.
Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Percepção de que as diferentes formas de reação a estímulos sociais de alguns profissionais com TEA poderia impactar no seu bem-estar na organização

Fonte: Elaborado pela autora.

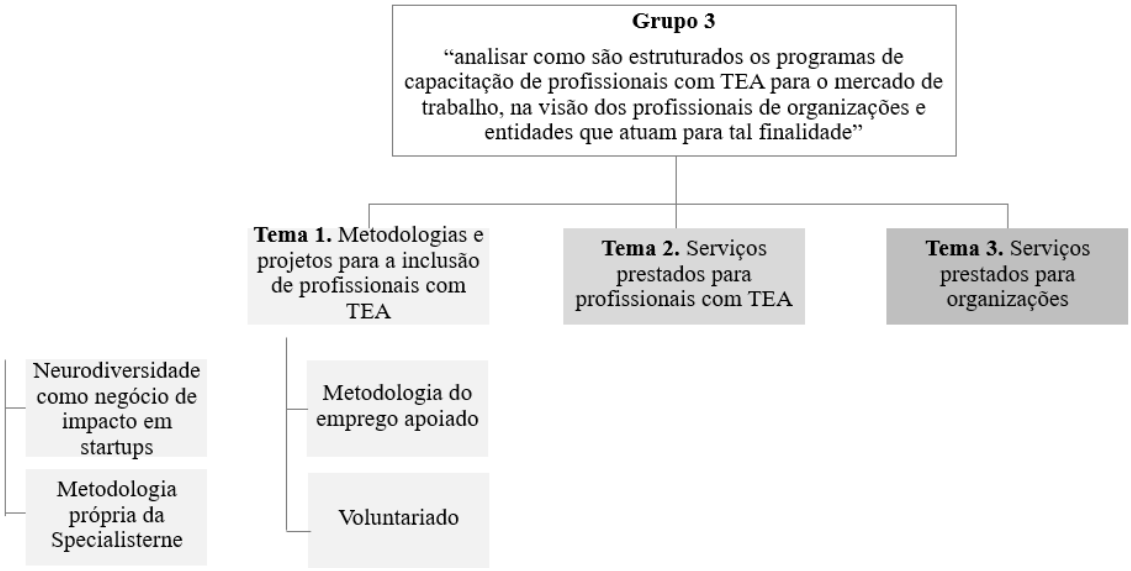
4.1.3 Relatos do Grupo 3

Um dos objetivos específicos definidos para a pesquisa e que está relacionado com os participantes do Grupo 3 é "analisar como são estruturados os programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho, na visão dos profissionais de organizações e entidades que atuam para tal finalidade".

Os seguintes temas foram estabelecidos e alinhados com o referido objetivo específico: (i) Tema 1 - Metodologias e projetos para a inclusão de profissionais com TEA; (ii) Tema 2 – Serviços prestados para profissionais com TEA; e (iii) Tema 3 - Serviços prestados para organizações.

A Figura 11 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 11. Visão geral da análise temática para os Temas 1 a 3 do Grupo 3.



Fonte: Elaborado pela autora.

Não se pretende, no entanto, esgotar na presente análise todas as metodologias e projetos desenvolvidos internacional ou nacionalmente para a inclusão de profissionais com TEA ou descrever todos os serviços prestados para profissionais com TEA e organizações, recomendando-se que tais temáticas sejam exploradas futuramente em outras pesquisas.

Tema 1. Metodologias e projetos para a inclusão de profissionais com TEA

Com base nos relatos de cada participante do Grupo 3, a respeito dos programas de capacitação e/ou inclusão de profissionais com TEA no mercado de trabalho conduzidos por suas respectivas organizações e entidades sem fins lucrativos, foram definidos 4 subtemas para o presente tema: (i) Neurodiversidade como negócio de impacto em startups; (ii) Metodologia própria da Specialisterne; (iii) Metodologia do emprego apoiado; e (iv) Voluntariado.

De uma forma geral, nota-se que o trabalho desenvolvido como negócio de impacto e o voluntariado utilizam-se de metodologias e práticas menos estruturadas e menos organizadas para a capacitação e apoio a profissionais com TEA, oscilando de acordo com as dinâmicas típicas da atuação de startups e de voluntários. Especificamente quanto ao voluntariado, outro fator que parece impactar o desenvolvimento de projetos é a obtenção de verbas e estrutura adequadas para a implementação de projetos envolvendo profissionais com TEA.

Em contraposição, tanto a metodologia do Emprego Apoiado quanto a desenvolvida pela Specialisterne já possuem etapas mais bem definidas, sendo aplicadas de forma padronizada em outros países há mais anos. Aparentam também conseguir alinhar com maior facilidade os serviços prestados aos profissionais com TEA à sua atuação junto às organizações, para otimizar os processos de inclusão de profissionais com TEA.

Neurodiversidade como negócio de impacto[19] em startups

De acordo com estudo realizado pela FADERS, em 2024, um total de 34,4% de adultos com TEA estariam empregados no Rio Grande do Sul, sendo que somente 10,85% foram contratados em razão da Lei de Cotas (CORREIA, 2024). Diante deste cenário, que poderia ser

[19] Negócios de impacto podem ser definidos como "empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável", conforme previsto no Art. 3º, inciso III, do Decreto nº 11.646, de 16 de agosto de 2023, que institui a Estratégia Nacional de Economia de Impacto e o Comitê de Economia de Impacto (BRASIL, 2023).

considerado similar em outros estados brasileiros, viabilizar oportunidades de emprego para profissionais neurodivergentes, que atendam às suas demandas específicas e necessidades de apoio, pode ser caracterizado como um negócio de impacto, de acordo com o relatado pela Participante Org. 1:

> Eu vi que a taxa de desemprego para essas populações e a taxa de *turnover* acaba sendo muito alta. Mergulhei para entender esses motivos e vi que boa parte deles vem do desconhecimento do que é a neurodivergência, quais são suas características ou como gerar acomodações no ambiente de trabalho em um ambiente colaborativo, tanto na rede pública quanto na privada.
> [...] Por que não ligar isso a, de fato, uma plataforma que gere impacto social, tanto diretamente para a pessoa neurodivergente quanto para a organização, que quer saber melhor como acolher, enfim, todos esses talentos que a gente tem aí pelo Brasil e pelo mundo?
> [...] o grande diferencial também, porque as soluções são construídas [...] por demandas, mesmo ali, da própria comunidade.

Além de ser estruturado como um negócio de impacto, outro aspecto do projeto que merece destaque é o seu desenvolvimento por meio do uso de plataformas digitais e/ou tecnologia, em um ambiente de constante mudança e com recursos escassos, como é comumente relatado em startups (VASCONCELOS; et al, 2019). Esses fatores acabam por impactar a estrutura que é planejada para os programas para a capacitação de profissionais com TEA e para letramento e treinamento de organizações a respeito da neurodiversidade. Conforme relato da Participante Org. 1, são esperados ajustes no desenho proposto para os programas, que podem ser baseados nas opiniões dos usuários (profissionais com TEA e outras neurodivergências) e que devem ser implementados no menor tempo possível para a apuração do seu êxito:

> A gente entende que a startup é enxuta, time enxuto, o tempo é bem estratégico, então, a gente também gosta muito de reunir mesmo a comunidade para as pessoas trazerem não só a sua perspectiva, mas a experiência também no assunto.

Para complementar a análise, foram realizadas buscas na internet para mapear outras startups que atuam por meio de plataformas digitais e que focam na empregabilidade de pessoas com TEA ou profissionais neurodivergentes. Destaca-se que os participantes do Grupo 3 não necessariamente possuem relação com essas startups, que são citadas no presente estudo para fins de discussão no contexto da análise proposta.

Assim, por meio da análise documental, constatou-se que há no mercado algumas plataformas focadas em disponibilizar oportunidades de emprego especificamente para indivíduos neurodivergentes, ao adaptar processos, comunicação e/ou vagas para esse grupo de

profissionais. Uma dessas startups é a Mentra, citada no estudo de Ara et al. (2024). De acordo com informações obtidas no site da Mentra (MENTRA, 2024), sua fundadora, Jhillika Kumar, declara que a ideia para a criação de sua startup surgiu da convivência com sua irmã com TEA e da busca pelos direitos das pessoas com deficiência e por um mundo mais inclusivo. A plataforma da Mentra permite a utilização tanto por profissionais neurodivergentes, que buscam vagas que considerem suas neurodivergências, quanto empregadores, que poderão acessar, avaliar e contratar profissionais neurodivergentes.

A *Impact Investing Australia* (2024), por sua vez, apresenta a Xceptional como um negócio de impacto social que, inicialmente, tinha como objetivo a prestação de serviços de tecnologia. Ao contratar profissionais com TEA para a prestação de serviços, a Xceptional desenvolveu um ambiente de trabalho onde essas pessoas pudessem se sentir acolhidas, aplicando suas habilidades e conhecimentos. Seu fundador, Mike Tozer, criou a Xceptional inspirado em sua irmã com TEA, assim como Jhillika Kumar da Mentra. Com o tempo, a Xceptional passou a também oferecer serviços de recrutamento e seleção exclusivamente para pessoas com TEA (WISETECH GLOBAL, 2022).

No Brasil, foram identificadas por meio de buscas na internet, a aTip, a Stardust Zone e a Adapte. Em suas mídias sociais, a aTip, fundada por Caio Bogos, diagnosticado com TEA em 2022 (MARCHESINI, 2023), apresenta-se como uma "startup de impacto social que busca quebrar as barreiras da empregabilidade de pessoas autistas" (ATIP, 2023), ao funcionar como um polo que conecta profissionais neurodivergentes e organizações com oportunidades de trabalho para esses profissionais. Com foco na área de tecnologia, a aTip também organiza a Autismo Tech, um evento de inovação e impacto social que busca "aumentar o protagonismo e desenvolvimento da comunidade autista" (MICROSOFT, 2022).

A Stardust Zone, criada em 2022 por Sarah Fernn, diagnosticada com TDAH, também atua com foco na empregabilidade de pessoas neurodivergentes, principalmente nas áreas de tecnologia e ciência, oferecendo tanto a capacitação para esses profissionais quanto o treinamento para as organizações, a partir de um mapeamento do seu nível de maturidade a respeito da temática da inclusão e diversidade (BRITO, 2023).

A Adapte, criada em 2019, é outra startup de impacto social, que indica como missão em seu site "incluir pessoas autistas e neurodivergentes na educação formal e no mercado de trabalho" (ADAPTE, 2024). Para tanto, oferece treinamentos e programas de capacitação para pessoas com TEA e cursos e treinamentos voltados para as organizações, escolas, profissionais de saúde, educação e familiares de pessoas com TEA. Dentre as iniciativas, destaca-se o

CooTEA – Programa de Cooperação para Treinamento e Emprego de Autistas, que é gratuito e tem como finalidade impulsionar "a incorporação de pessoas autistas no mercado de trabalho, treinando e supervisionando autistas e empresas, a fim de promover a inclusão e a diversidade" (ADAPTE, 2024). Desenvolvido por meio de parcerias, o que inclui a Poli-USP, o programa exige alguns requisitos dos participantes, como ter o laudo médico indicando que é pessoa com TEA, ter entre 18 e 24 anos de idade, interesse na área de programação e desenvolvimento, entre outras condições.

As discussões a respeito dos serviços prestados a profissionais com TEA e às organizações foram feitas nos Temas 2 e 3 do Grupo 3, respectivamente.

Diante do apresentado, há indícios de que a atuação de startups envolvendo a temática da neurodiversidade e os serviços de capacitação de profissionais neurodivergentes são estruturados a partir de uma visão de negócio de impacto social. Tais negócios são promovidos por meio do uso da tecnologia e de plataformas digitais e, em geral, nascem a partir de interesses pessoais dos respectivos fundadores das startups, que podem ser eles próprios pessoas neurodivergentes ou ter membros de suas respectivas famílias que também são neurodivergentes.

De modo geral, não foram identificados critérios específicos para o cadastro de pessoas neurodivergentes nas plataformas analisadas. Contudo, algumas exigências poderão ser feitas ao longo do processo de recrutamento e seleção conduzido por organizações parceiras da startup (por exemplo, quando da participação do profissional neurodivergente em processos seletivos que trabalhem vagas exclusivas para pessoas com deficiência); ou a depender das características do projeto desenvolvido e dos parceiros envolvidos, como é o caso do programa de treinamento CooTea.

Em razão das características de negócios de impacto e de startups em geral, não foi possível concluir pela existência de um único modelo estruturado e utilizado por essas plataformas para fins de promoção de capacitação de profissionais com TEA ou mesmo para viabilizar a conexão entre profissionais com TEA e as organizações parceiras.

Entretanto, nota-se a existência de alguns aspectos em comum nas plataformas analisadas, tais como: (i) a atuação junto às organizações que pretendem contratar profissionais neurodivergentes para ampliação do conhecimento a respeito do TEA e de inclusão e diversidade; (ii) a capacitação de profissionais neurodivergentes, mediante a promoção de diferentes cursos e treinamentos, que podem, inclusive, ser oferecidos de forma gratuita; (iii) a oferta de oportunidades de emprego nas organizações parceiras para os profissionais

neurodivergentes cadastrados nas plataformas, que podem ser vagas exclusivamente para pessoas com deficiência ou não; e (iv) a realização de eventos especificamente voltados para a participação de profissionais neurodivergentes.

Metodologia própria da Specialisterne

A Specialisterne é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por Thorkil Sonne na Dinamarca, em 2004, ao perceber os desafios enfrentados por pessoas com TEA para a participação em trabalhos significativos, inicialmente na área de tecnologia da informação (TI) (SPECIALISTERNE, 2024). A criação da Specialisterne tem relação direta com o filho do fundador, que é uma pessoa com TEA, conforme relatado pela Participante Org. 2:

> A Specialisterne tem origem lá na Dinamarca. Hoje a gente está em 26 países. [...] lá na Dinamarca, o Thorkil Sonne, nosso fundador, ele era um profissional da área de TI e já num alto cargo. E aí o filho dele tem o diagnóstico de autismo e ele se inspirou ali, numa situação com o filho e aí ele decidiu fundar a Specialisterne. Imagino que, como ele tinha os contatos, já era da área e também ele viu as habilidades do filho e das pessoas autistas que ele conhecia, ele percebeu também que estavam bem alinhadas com área de tecnologia. Foi assim que teve a nossa origem, então, já desde lá da Dinamarca, em 2004, que começou como uma empresa que proporcionava oportunidades nessa área. Então, por isso que a gente tem essa ênfase hoje em dia.

Quanto à missão da Specialisterne, destaca-se a ação de "proporcionar treinamento e emprego para as pessoas com autismo", para que esses profissionais consigam ter melhores condições para acessar o mercado de trabalho (SPECIALISTERNE, 2024). O contexto da criação da Specialisterne e sua missão mostram aparente relação com os negócios de impacto envolvendo neurodiversidade que são desenvolvidos pelas startups, mediante o uso de plataformas digitais e uso de tecnologia.

Apesar da similaridade, a Specialisterne desenvolveu uma metodologia própria, bem estruturada, por meio da qual oferece formação gratuita para as pessoas com TEA, que será descrita no Tema 2 do Grupo 3. Os profissionais que são aprovados passam a compor o banco de talentos da Specialisterne, podendo ser: (i) alocados nos parceiros como parte de um time terceirizado da própria Specialisterne (modelo de terceirização); ou (ii) contratados diretamente pela organização (modelo de contratação direta), geralmente em vagas destinadas a pessoas com deficiência, para cumprimento de obrigações legais, de acordo com o relatado pela Participante Org. 2:

> [...] no caso da contratação direta, todas as pessoas vão entrar com esse cargo dentro ali das pessoas com deficiência. Mas a gente teve, acho que desde a nossa origem, a gente sempre teve muito mais oportunidades de outsourcing, então, nesse formato de terceirização. Mas tem sido um movimento. [...] Então, esse movimento da gente perceber que tem mais pessoas, mais empresas, aliás, buscando já uma contratação direta [...]

Caso o contrato com o parceiro seja encerrado ou na hipótese de não alinhamento entre o profissional com TEA e o gestor da organização, mesmo após a implementação de plano de ação desenhado pela Specialisterne para solucionar quaisquer divergências, o profissional com TEA retorna para o banco de talentos e poderá prestar serviços temporariamente para a própria Specialisterne, considerando suas habilidades técnicas, ou ser preparado para alocação em outro parceiro.

Além do treinamento, a Specialisterne também oferece "acompanhamento e suporte especializado" para os profissionais que são selecionados após a conclusão dos cursos de formação (SPECIALISTERNE, 2024), de acordo com o explicado pela Participante Org. 2:

> A gente tem 3 etapas, dentro dessa metodologia. Primeiro um processo de entrada. Então, os candidatos passam aqui com a gente por um processo de 4 etapas para que a gente possa conhecer cada um deles, conhecer o perfil deles. Depois, aqueles que são aprovados, [...] eles passam por um treinamento com a gente. [...] A gente tem hoje em dia esses 2 formatos. E aí, quando eles concluem a formação com a gente, aqueles que a gente entende que têm o perfil das oportunidades que a gente costuma ter aqui nos nossos clientes ficam no nosso banco de talentos. E aí a gente consegue, em parceria com os clientes, identificar oportunidades e depois identificar qual o candidato que está no nosso banco de talentos, que tem o perfil dessas oportunidades. [...]

Para a participação nos referidos cursos de formação, não é exigida a apresentação de laudo comprovando o diagnóstico de TEA nem formação específica ou experiência prévia, nem mesmo na área de tecnologia ou informática. Apesar de não exigir o laudo ou formações específicas, para participar do processo de formação oferecido pela Specialisterne, a pessoa com TEA deverá: (i) ser maior de idade; (ii) ter interesse em tecnologia ou informática, em razão da maior parte das oportunidades de emprego em organizações parcerias da Specialisterne atuarem nesse segmento; (iii) ter a intenção de obter um emprego, no município de São Paulo, Estado de São Paulo; e (iv) ter autonomia para deslocamento até o local de trabalho, realizar refeições e outras tarefas pessoais. O relato da Participante Org. 2 corrobora tais critérios:

> Não, não é um critério de exclusão não ter o laudo. [...] Olha, pode surgir, a gente não tem, a gente não fecha em tecnologia, até porque, na verdade, nem é do nosso interesse. [...] A gente não exige nenhum tipo de formação específica, nem de experiência. A gente costuma dizer que, assim, os nossos requisitos para participar aqui do nosso processo vão ser: (i) ser maior de

> idade; (ii) ter um interesse, uma motivação por tecnologia, informática, porque as nossas... tanto o nosso treinamento quanto as nossas oportunidades, vão ter esse foco; (iii) ter motivação para trabalhar também, então, querer trabalhar; (iv) no momento, ter a disponibilidade para trabalhar em São Paulo; e (v) ter ali uma certa autonomia, que a gente diz, que vai ser essa autonomia para se deslocar até o trabalho e voltar, fazer a sua própria refeição ali do almoço sozinho, né? Então, esse tipo de autonomia

Destaca-se, contudo, que, para o modelo de contratação direta, no qual o profissional com TEA é geralmente demandado para preenchimento de uma vaga destinada a pessoas com deficiência, o laudo acaba sendo solicitado em algum momento do processo, para assegurar o atendimento a critérios legais:

> Mas, no momento em que elas são aprovadas, que elas vão iniciar o treinamento com a gente, aí sim, a gente costuma pedir. Entender qual o documento que a pessoa tem. De novo, não vai ser uma exigência para ela passar no nosso treinamento. Mesmo que ela não tenha, ela pode passar, mas a gente já faz um controle um pouco maior para identificar quem já tem, quem ainda está em avaliação, quem ainda não tem. [...] nesses casos, a gente precisa fazer e, por isso, a gente faz esse controle depois para saber quem tem o laudo ou não, porque isso vai também influenciar em quem a gente vai conseguir indicar para uma oportunidade que já seja direta (Participante Org. 2).

Atualmente, a Specialisterne não conta com parcerias específicas com outras entidades sem fins lucrativos que atuam com pessoas com deficiência ou pessoas com TEA nem órgãos públicos da área da saúde com médicos que poderiam emitir o laudo após a realização do diagnóstico. Os profissionais com TEA já procuram os serviços prestados pela Specialisterne de forma espontânea, como explicado pela Participante Org. 2:

> Hoje em dia, a gente recebe principalmente as pessoas, então, eles chegam até nós através de indicações ou de um profissional da área da saúde ou família, ou eles acham a gente numa busca ali na internet. Então, a gente hoje tem um volume bem grande de pessoas que nos procuram. Então, a gente não tem ali, por exemplo, uma parceria com uma instituição e aí a gente vai recrutar dessa instituição, né? Porque eles já nos procuram.

Além desses serviços, a Specialisterne atua junto às organizações parceiras, oferecendo alguns serviços, como palestras de sensibilização, prestação de serviços terceirizados nas áreas de tecnologia e administrativa e colocação direta de profissionais com TEA em vagas que, em geral, são destinadas a pessoas com deficiência. Essa atuação será descrita no Tema 3 do Grupo 3.

Adicionalmente, por meio da análise documental, foi também identificada a Mind Shift, que, conforme explicado no site da própria organização (MIND SHIFT, 2024), surgiu a partir da atuação da Specialisterne em Minnesota, nos Estados Unidos, em 2012, tornando-se a

Specialisterne Midwest, em 2013, com sede em Wilmington, no estado de Delaware. Inicialmente, em 2025, a Specialisterne Midwest acaba se transformando em uma instituição sem fins lucrativos, separada da Specialisterne USA, e, em 2016, passa a ser a Mind Shift. Por conta do seu processo de constituição, a Mind Shift manteve a mesma missão e a visão da Specialisterne, além de sua conexão com a rede estabelecida pela Specialisterne, expandindo suas operações para outras localidades nos Estados Unidos da América. A proposta da Mind Shift é: (i) atuar como parceira de diferentes negócios para identificar as necessidades e tarefas que poderiam ser desempenhadas por profissionais com TEA; e (ii) recrutar, avaliar e empregar profissionais com TEA, conforme as oportunidades de emprego oferecidas pelos parceiros.

A Mind Shift apresenta uma metodologia própria (MIND SHIFT, 2024), similar à da Specialisterne, dividida em seis passos: (i) Passo 1 – a Mind Shift trabalha junto aos parceiros para identificar tarefas e posições que dependem de detalhe, foco e precisão; (ii) Passo 2 – a Mind Shift constrói os processos de recrutamento, seleção e treinamento para encontrar e preparar profissionais com TEA para esses trabalhos; (iii) Passo 3 – a Mind Shift recruta profissionais com TEA que seriam adequados para as necessidades do parceiro, mapeadas no Passo 1; (iv) Passo 4 – dentro de 4 a 8 semanas, a Mind Shift faz, junto com o time do parceiro, a seleção e treinamento de candidatos específicos para ocupar as vagas de emprego, sem cobrar qualquer remuneração do parceiro por este trabalho; (v) Passo 5 – após a conclusão do Passo 4, os profissionais com TEA da Mind Shift passam a realizar as tarefas e ocupar as posições de emprego no parceiro; e (vi) Passo 6 – a Mind Shift continua a trabalhar junto com os gestores e supervisores do profissional com TEA alocado e a acompanhar o desempenho do profissional com TEA alocado.

A partir dos pontos indicados, percebe-se que a metodologia da Specialisterne (e, em termos similares, a da Mind Shift) foi estruturada há alguns anos e vem sendo testada globalmente com aparentes resultados positivos, tanto para as organizações (que mencionam os trabalhos da Specialisterne como referência em entrevistas para a mídia), quanto para os profissionais com TEA que buscam recolocação no mercado de trabalho, como apontado por Conceição, Escalante e Silva (2021), principalmente nas áreas de tecnologia e administrativas (como relatado por um dos participantes com TEA do Grupo 1, que indicou ter participado dos treinamentos oferecidos e estar atualmente contratado em um dos parceiros da Specialisterne).

Um diferencial da metodologia Specialisterne é algo que se assemelha a um modelo de negócios, que vai além do atendimento gratuito a profissionais com TEA. Nesse desenho, há a alocação de profissionais com TEA aprovados nos treinamentos oferecidos em um banco

de talentos interno, possibilitando o atendimento de demandas de seus clientes. Paralelamente a esses trabalhos, há a atuação da Specialisterne ao longo do processo, acompanhando o profissional com TEA treinado em seus parceiros, mediante a contratação remunerada pela organização contratante de um dos modelos de atuação (terceirização ou contratação direta).

Metodologia do Emprego Apoiado[20]

Dentre as quatro metodologias e práticas identificadas por meio da análise dos relatos dos participantes do Grupo 3, o Emprego Apoiado é o modelo mais estruturado e aplicado há mais tempo, em diferentes países, como os Estados Unidos da América, para fins de inclusão de pessoas com deficiência, como explicado pelo Participante Org. 3:

> Emprego apoiado, que não é nada que a gente, que nós criamos aqui [...], é uma metodologia que surge na década de 70, mais precisamente em 78, na região de Illinois, nas universidades de Wisconsin, nos Estados Unidos, e depois vai se difundindo pelo mundo. Fortemente, principalmente na União Europeia, e aqui na América chega para nós, muito por meio do professor, já falecido, Romeu Sasaki, que era uma referência [...]. Foram criadas oficinas protegidas, inclusive é daí que o emprego apoiado surge, é uma crítica a partir das oficinas protegidas, que seriam serviços direcionados a pessoas com deficiência que acontecem dentro da instituição e não em ambientes fora da instituição, na própria sociedade.

A metodologia do Emprego Apoiado é uma proposta desenvolvida de acordo com as três etapas explicadas por Betti (2017)[21] e o Participante Org. 3 confirma algumas dessas etapas durante a entrevista:

> Então foi evoluindo essa temática da inclusão social até chegar num tema específico de inclusão profissional, que era mais voltado para a questão da qualificação dentro da instituição.
> [...] Normalmente a gente faz um trabalho de casamento, tem uma coisa que a gente está adaptando agora na nomenclatura, que a gente faz, de um lado uma descoberta de perfil.

[20] O Emprego Apoiado é definido por Betti (2017) como "uma metodologia que visa à inclusão no mercado competitivo de trabalho" de pessoas que estejam "em situação de incapacidade mais significativa", devendo ser respeitados seus interesses e escolhas, suas capacidades e as necessidades de apoio. Para Costa e Sinhoretto (2017), o Emprego Apoiado é uma metodologia que "consiste em preparar pessoas com deficiência interessadas num posto de trabalho mediante a assistência pessoal de profissionais especializados".

[21] As três etapas propostas por Betti (2017) são: Etapa 1 - Descoberta do perfil vocacional do profissional com deficiência; Etapa 2 – Desenvolvimento do emprego na organização; e Etapa 3 – Acompanhamento do profissional com deficiência pós-colocação.

> [...] Então, normalmente, a gente faz um acompanhamento pós-colocação, que é o nome que a gente utiliza, que pode ter até 12 meses de acompanhamento junto à empresa e a pessoa com deficiência ou dentro do transtorno de espectro autista acompanhada. Então, a gente faz visitas que podem ser ou presenciais, como eu disse, ou um Meet, um Teams, como estamos fazendo aqui agora, junto com o gestor e um junto com a pessoa, para tentar desenvolver os apoios e contemplar as necessidades que estão requeridas naquele espaço, durante o processo. A gente sempre diz que o melhor seja o levantamento de perfil e a descoberta, o *match*, um casamento, a gente só aprende a trabalhar trabalhando e não é diferente para as pessoas com deficiência.
>
> [...] E nessas visitas normalmente a gente preenche um instrumental de avaliação para a gente poder mensurar as competências que estão sendo melhoradas ou não, tanto da pessoa quanto do ambiente.

A entidade sem fins lucrativos que utiliza a metodologia do Emprego Apoiado conta com parcerias com órgãos públicos de saúde e secretarias municipais para o desenvolvimento das suas atividades de colocação de profissionais com TEA no mercado de trabalho, o que é corroborado pelo Participante Org. 3:

> [...] nós temos parcerias e recebemos pessoas com TEA encaminhadas por meio de UBS, da saúde e outros aparelhos. [...] e temos uma parceria oficial com a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de São Paulo. Então, os CRAS, os CREAS, os Centros POPs também são parceiros que nos encaminham pessoas e que nós fazemos grupos de trabalho dentro dessas localidades.

Adicionalmente, segundo relatado pelo Participante Org. 3, não há critérios específicos para a elegibilidade de pessoas ao Emprego Apoiado, em linha com o proposto por Betti (2017), para que não haja restrição ao acesso ao trabalho. Corrobora-se que a intenção é a eliminação de eventuais barreiras que possam afetar a inclusão de uma pessoa com deficiência no trabalho (BETTI, 2017).

Voluntariado[22]

A AFAPA, uma entidade sem fins lucrativos, foi constituída no ano de 2019, a partir da iniciativa de familiares e amigos de pessoas com TEA e "vem sendo administrada voluntariamente por todos os envolvidos na causa" (AFAPA, 2024). As pessoas envolvidas na

[22] De acordo com o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que trata a respeito do serviço voluntário, considera-se serviço voluntário "a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa" (BRASIL, 1998).

AFAPA atuam por meio do trabalho voluntário e diversas parcerias formalizadas com terceiros, como explicado pela Participante Org. 4:

> [...] nós iniciamos alguns atendimentos terapêuticos, mas com profissionais voluntários. [...] esse planejamento da instituição, nós tivemos muitos parceiros pensando. Muitos parceiros, muitos profissionais que se dispuseram a pensar sobre o que seria de importante dentro da área do autismo, o que precisaria. Então, tivemos muitos parceiros profissionais que se colocaram à disposição e alguns deles atenderam de forma presencial nesse espaço que nós tínhamos. [...] Com parcerias, a gente tem espaços públicos, às vezes gratuitos, na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, alguns espaços cedidos, a gente convida profissionais da área para dar palestra.

As atividades descritas pela Participante Org. 4 estão em linhas com o proposto por Rego, Zózimo e Correia (2017), que explicam que o voluntariado se trata de atividades que são desenvolvidas por organizações que não têm como objetivo principal auferir lucros, mas sim "a inclusão social, a representação de interesses, a educação cidadã, entre outros objetivos". O voluntário, por sua vez, segundo as autoras, seria aquele "indivíduo que, de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora".

A AFAPA presta outros serviços às pessoas com TEA, que serão descritos no Tema 2 do Grupo 3. Entre os diversos projetos desenvolvidos pela AFAPA envolvendo pessoas com TEA, há o projeto "Preparação para o Trabalho", que tem como objetivo "ampliar as possibilidades de ação dos jovens e adultos, com TEA, no mercado de trabalho" (AFAPA, 2024).

Conforme relatado pela Participante Org. 4, o projeto "Preparação para o Trabalho" ainda não foi desenvolvido, mas tem como etapas previstas: (i) o acolhimento de profissionais com TEA, a partir de suas especificidades, condições e necessidades; (ii) cursos de formação e capacitação; (iii) parcerias com organizações, por meio de profissionais de serviços sociais; e (iv) desenvolvimento de programas de Jovem Aprendiz para pessoas com deficiência:

> De qualquer forma, se entende que, independente do nome, do diagnóstico, a gente acolhe, pretende e busca acolher o sujeito a partir das suas especificidades, da sua condição, das suas necessidades, e poder levar isso para as empresas. [...] Nós temos o encaminhamento para o mercado de trabalho como planejamento, encaminhamento para o mercado de trabalho e cursos de formação, de capacitação. [...] Então, o que se pretende junto com o serviço social, estreitar laços com algumas empresas para que se possa, então, inseri-los nesse programa. [...] Então, aí nós temos o Jovem Aprendiz, que também tem vagas voltadas também no Jovem Aprendiz para a Deficiência e buscar inseri-los nestes cursos que eles fazem antes de encaminhar para as empresas.

A AFAPA não estabelece critérios para a inclusão em seus projetos, auxiliando pessoas com TEA independentemente do diagnóstico formal ou do nível de suporte de TEA, de acordo com o DSM-V-TR.

Como o próprio nome da AFAPA já diz, a associação foi constituída em virtude de interesses particulares de familiares e amigos de pessoas com TEA, que dedicam parte de seu tempo para a consecução dos objetivos da instituição. Como visto, a relação pessoal com o TEA é também observada nas startups de impacto social analisadas e na criação da Specialisterne, indicando um potencial fator motivacional para a idealização destes tipos de trabalho.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 1 do Grupo 3 foram organizados no Quadro 27:

Quadro 27. Visão geral dos subtemas do Tema 1 do Grupo 3.

Subtemas do Tema 1 do Grupo 3	**Descrição dos aspectos identificados nos subtemas do Grupo 3 para compreender como são estruturados os programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho**
Neurodiversidade como negócio de impacto em startups	Constatação de altos índices de desemprego ou subemprego de profissionais com TEA. Constatação de barreiras para que profissionais com TEA se mantenham em seus empregos. Constatação de oportunidades de negócio para atendimento de demandas específicas e necessidades de apoio para profissionais com TEA. Uso da tecnologia e de plataformas digitais para a prestação de serviços a profissionais com TEA e organizações. Constatação da necessidade de ajustes e revisões nos serviços prestados a profissionais com TEA e organizações pela natureza da própria *startup*. Percepção de que os fundadores de negócios de impacto voltados para a neurodiversidade teriam relação pessoal com a neurodiversidade. Ausência de critérios específicos para o cadastro de profissionais com TEA. Possibilidade de exigências de atendimento de critérios mínimos por profissionais com TEA para participação em outras etapas dos serviços e projetos. Ausência de um modelo único de negócio de impacto para a neurodiversidade.
Metodologia própria da Specialisterne	Criação da Specialisterne vinculada à relação pessoal de seu fundador com o TEA e focada na área de tecnologia. Desenvolvimento de metodologia própria e estruturada. Oferecimento de treinamento gratuito para pessoas com TEA. Indicação de profissionais com TEA aprovados no treinamento para compor o banco de talentos da Specialisterne e futura indicação para prestação de serviços (modelo de terceirização) ou para contratação direta por parceiros (modelo de contratação direta). Indicação de profissionais com TEA para contratação em vagas destinadas a pessoas com deficiência (no modelo de contratação direta) para cumprimento de obrigações legais da organização. Serviços de alocação e treinamento do profissional com TEA indicado para atuação em parceiros (em ambos os modelos). Indicação de critérios mínimos para a participação em treinamentos oferecidos. Ausência de parcerias específicas com outras entidades sem fins lucrativos que atuam com pessoas com deficiência ou com órgãos públicos da área da saúde com médicos para emissão de laudos. Oferta de serviços para organizações que desejam aprimorar conhecimentos sobre a neurodiversidade ou contratar pessoas com TEA.
Metodologia do emprego apoiado	Modelo estruturado e aplicado há mais tempo no Brasil e em outros países, como os Estados Unidos da América. Desenvolvida em etapas, que envolvem a identificação das características da vaga de emprego ofertada pela organização, a compreensão do perfil do candidato com TEA e o acompanhamento da inclusão do profissional com TEA. Realização de parcerias específicas com órgãos públicos da área da saúde e secretarias municipais para o desenvolvimento das

(continua)

(continuação)	atividades de colocação de profissionais com TEA. Ausência de critérios para a participação do profissional com TEA nos serviços prestados.
Voluntariado	Administração voluntária dos serviços prestados. Realização de parcerias com terceiros para a realização dos serviços prestados. Elaboração de projetos para implementação pela associação voltados à preparação de pessoas com TEA para o trabalho. Ausência de critérios para a participação do profissional com TEA nos serviços prestados.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 2. Serviços prestados para profissionais com TEA

Na visão da Participante Org. 1, os serviços oferecidos pela startup para profissionais com TEA não seriam "treinamentos" propriamente ditos, pois as pessoas neurodivergentes necessitariam, na verdade, de apoios para viabilizar a acessibilidade na organização:

> A gente enxerga dentro de uma ótica de pertencimento. [...] A gente não treina a pessoa autista, a gente dá suporte e esse suporte geralmente vem pela adaptação da organização e a gente até fala com a organização para instruir a organização que, geralmente, essa adaptação não vai beneficiar só a pessoa autista. Ela vai beneficiar, na verdade, o andamento do time como um todo, a liderança como um todo.

Essas declarações estariam em linha com o modelo social da deficiência, segundo o qual as barreiras são encontradas no ambiente, não sendo consideradas uma limitação da pessoa com deficiência, que precisaria de apoios para acessibilidade - e não serem "treinadas". Para a Participante Org. 1, o apoio que é oferecido geraria a sensação de pertencimento dos profissionais com TEA e é realizado, muitas vezes, por meio de mentorias, oferecimento de formação técnica e outras adaptações para que o profissional com TEA consiga atuar no mercado de trabalho:

> [...] a gente tem uma corrente de oferecer suporte para pessoa autista, ou seja, o programa de mentoria, programa de formação técnica mesmo, caso ela esteja procurando mudar de área ou ingressar numa nova profissão. Mas, quando a gente fala de adaptação no mercado de trabalho, a gente trabalha mais com adaptação, digamos assim, da organização, pelo bem da organização, que gera um bem da pessoa autista.

Quanto à sensação de pertencimento, a expressão também surge durante a entrevista com a Participante Org. 2, quando descreve conversas que teve em grupos de profissionais com TEA, que afirmam se sentir à vontade pela primeira vez na vida ao conhecer a Specialisterne e pelo fato de estarem participando de processos que envolvem somente pessoas com TEA:

> Olha, acho que a frase que eu escuto em todo o grupo que eu participo é eles dizendo o quanto que a Specialisterne, muitas vezes, foi o primeiro lugar em que eles se sentiram à vontade. Não exatamente pela Specialisterne, mas pelos

> candidatos, porque todos eles são autistas. Então, eles têm esse sentimento de pertencimento, de criar ali a comunidade. [...]E aí isso mostra que, em todos os outros lugares que eles conviveram, foi diferente.

Esses achados parecem corroborar o estudo internacional empírico conduzido por Crompton et al. (2020), que conduziram entrevistas semiestruturadas com 12 pessoas com TEA e identificaram benefícios para indivíduos com TEA ao criar e manter relações sociais com outras pessoas com TEA. O estudo citado, no entanto, explorou aspectos da vida social e momentos de lazer de pessoas com TEA na perspectiva das próprias pessoas com TEA, de modo que os diferenciais para a presente pesquisa consistem na análise de relações de trabalho e na visão de uma profissional que atua com capacitação de profissionais com TEA.

A partir dos temas identificados por Crompton et al. (2020), os autores sugerem que os participantes do estudo, que são pessoas com TEA, identificaram que: (i) geralmente se sentem mais bem compreendidos por outras pessoas com TEA do que por neurotípicos; (ii) teriam sensação de que são minoria quando convivem com neurotípicos, geralmente sentindo pressão para se comunicarem de acordo com estilos e preferências de pessoas neurotípicas, impactando na forma como os participantes com TEA se sentem enquanto pessoas com TEA; e (iii) teriam uma percepção de pertencimento quando se relacionam com outras pessoas da família ou amigos que também são pessoas com TEA.

Por trás dessas proposições, é possível interpretar que, fora de contextos devidamente adaptados para as pessoas com TEA, esses profissionais não têm se sentido realmente incluídos, sofrendo as consequências das barreiras existentes no ambiente. Os profissionais com TEA acabam tendo a impressão de que não pertencem de fato às suas organizações, que não são compreendidos e que não podem desfrutar de condições similares às oferecidas para os demais profissionais neurotípicos. Os desafios à empregabilidade das pessoas com TEA foram descritos em temas específicos nessa pesquisa.

Dentre os serviços prestados, a Specialisterne oferece treinamento gratuito para profissionais com TEA, o que dura, em média, de 2 a 4 meses, com foco nas áreas de tecnologia e tarefas administrativas, viabilizando uma formação técnica, e apoio socioprofissional, para que os profissionais com TEA possam conseguir oportunidades de emprego em organizações (SPECIALISTERNE, 2024). O atendimento é feito tanto em grupo quanto individual, de acordo com as necessidades de cada pessoa com TEA. A formação técnica é dividida em módulos, com matérias específicas, como explica a Participante Org. 2:

> É totalmente gratuito, desde o momento que a pessoa entra no processo, então, ela não tem ali nenhum custo com a gente. [...] A gente tem a nossa formação

> dividida em módulos técnicos. Nesses módulos, a ênfase é na área de tecnologia e administrativa. Então, eles passam ali por pacote Office, metodologia de gestão de projetos, teste de software, conteúdos mais voltados para a área de tecnologia. E, em paralelo, a gente tem o trabalho que é o socioprofissional, que é a parte do suporte, do apoio para as questões mais comportamentais, relacionadas a competências. E aí, nessa parte, a gente vai ter tanto um trabalho que é um grupo, mais geral, como também o individual, individualizado. A pessoa participa, ao longo das semanas de atividades, de aulas que a gente chama de sociais ou sociolaborais e também ela participa de um encontro ali com a especialista do time, que aí já vai ser individual, para trabalhar questões mais focadas. Cada um vai ter o seu próprio, essas próprias competências, essas próprias necessidades de desenvolvimento. Aí a gente já consegue fazer esse trabalho de forma mais focada.

Na metodologia da Specialisterne, contudo, não estão previstos serviços de avaliação da pessoa para a confirmação do diagnóstico de TEA ou de outras neurodivergências:

> A gente vai explorar ali a importância explicar para ele por que que é importante ter esse diagnóstico formal, mas a gente não tem aqui uma área que vai fazer esse processo de avaliação (Participante Org. 2).

Dentre todos os profissionais com TEA do Grupo 1 entrevistados (n=19), apenas um deles confirma ter participado e sido aprovado nos treinamentos oferecidos pela Specialisterne para capacitação, tendo sido contratado por uma das organizações parceiras da Specialisterne para uma vaga administrativa. Esse profissional concluiu graduação e passou a trabalhar em uma área diferente daquela de sua formação.

De acordo com o relatado pelo Participante Org. 3, além dos serviços para inclusão profissional, também é oferecido programa de reabilitação para a pessoa com TEA que não se sente preparada para se integrar no mercado de trabalho. Nesse contexto, alguns suportes são desenvolvidos junto à pessoa com TEA e à sua família, por meio de atendimento terapêutico, caso seja necessário, além da prática de atividades artísticas, esportivas, entre outras. Há também acesso a serviços de diagnóstico de TEA por médicos e psicodiagnósticos, feitos por outros profissionais da saúde.

Conforme informado pelo Participante Org. 3, uma das preocupações da organização sem fins lucrativos onde trabalha, que utiliza a metodologia do emprego apoiado, é não apenas prestar serviços de alocação do profissional em uma determinada vaga, mas também identificar o perfil do profissional com TEA:

> Às vezes, a gente não consegue o ideal, mas só de se aproximar do desejo, a gente já consegue, por vezes, auxiliar que uma pessoa com TEA encontre satisfação, encontre aquilo que para ela é caro, aquilo que para ela é importante. [...] Então, acho que esse é um exercício de, junto com a pessoa,

> criar alternativas criativas para que ela consiga estar bem, estar satisfeita dentro da possibilidade.

A AFAPA, por sua vez, informa em seu site a programação de diferentes projetos, que, de acordo com o explicado pela Participante Org. 4, deverão ser implementados no médio e longo prazo. Referidos projetos não envolvem somente atividades relacionadas à capacitação de profissionais com TEA, mas também práticas esportivas, oficinas terapêuticas de sabores e diferentes áreas de atendimento voltadas para pessoas com TEA, como serviços de assistência social, terapia ocupacional, entre outros (AFAPA, 2024).

A respeito do perfil dos profissionais com TEA que procuram os serviços prestados por entidades e instituições sem fins lucrativos para capacitação e alocação em vagas de emprego, a Participante Org. 1 revela que são profissionais (portanto, adultos), com diferentes neurodivergências que atualmente acessam a plataforma e realizam seu cadastro para usufruir dos serviços disponíveis.

A Participante Org. 2, por sua vez, informa que a maioria dos usuários dos serviços prestados pela Specialisterne: (i) recebeu diagnóstico na fase adulta; (ii) é do gênero masculino; (iii) tem entre 20 e 35 anos; (iv) está cursando a graduação ou uma pós-graduação; e (v) é considerada pessoa com TEA com nível 1 de suporte.

O Participante Org. 3 constata um perfil de pessoa com TEA um pouco diferente ao descrito pela Org. 1 e Participante Org. 2, o que provavelmente pode ser associado ao fato de a entidade sem fins lucrativos onde o referido participante trabalha oferecer outros serviços para pessoas com TEA e com deficiência intelectual de forma gratuita: (i) apesar de a maioria ser composta por pessoa com TEA com nível 1 de suporte, há também pessoas com nível 2 e até mesmo com nível 3, na área de reabilitação sensorial; (ii) a maioria é do gênero masculino; (iii) atendimento de pessoas com TEA em todas as idades, com muitos na faixa dos 14 a 17 anos; (iv) dentre aquelas pessoas com nível 1 de suporte, a maioria ainda não concluiu o ensino superior, apesar de haver profissionais que estão cursando o ensino superior ou técnico.

Para a Participante Org. 4, o atendimento feito pela associação é direcionado a jovens e adultos, independentemente do nível de suporte, com predominância de jovens com TEA com nível de suporte 2 ou 3:

> A gente percebe ali que são jovens de suporte 2 e 3. [...] Nós temos um grupo de adultos de funcionamento, de funcionamento nível 1, que são muitos profissionais, inclusive, que já estão no mercado de trabalho e que descobriram tem um diagnóstico tardio.

Nota-se que, de um lado, os profissionais com TEA que buscam os serviços disponíveis em plataformas para conexão de profissionais neurodivergentes com oportunidades de empregos em organizações e aqueles prestados pela Specialisterne aparentam ter um foco específico em questões de empregabilidade e inclusão profissional. Por outro lado, os usuários dos serviços prestados por entidade sem fins lucrativos que utilizam a metodologia do emprego apoiado e aqueles que buscam a AFAPA e outras associações privadas para suporte a pessoas com TEA podem ter também interesse em outros serviços de cunho assistencial que vão além das questões laborais propriamente ditas.

Há indícios, portanto, de que o perfil da entidade ou instituição sem fins lucrativos e o tipo de serviços disponíveis ao público com TEA podem ter relação com o perfil das pessoas com TEA e neurodivergentes que procuram e contratam tais serviços.

Tema 3. Serviços prestados para organizações

Como visto no Tema 1 do Grupo 3, as plataformas de negócio de impacto oferecerem alguns serviços voltados para as organizações, tais como treinamento, tanto na modalidade *online* quanto presencial; elaboração de materiais para comunicação interna com os times das próprias organizações; e conscientização a respeito da neurodiversidade e TEA, de acordo com o relato da Participante Org. 1:

> [...] Tanto que um dos nossos serviços que mais tem aderência, o letramento. A gente tem tanto letramento quanto preparo ali de políticas internas, de ações dentro das organizações. Mas a gente vê que ainda é uma fase muito maior de letramento mesmo, tanto do que é quanto reconhecer quais são as características positivas. Então, ainda há muito estigma, um certo receio de não saber gerenciar.

Os serviços prestados pela Specialisterne, por sua vez, a organizações envolvem palestras de sensibilização a respeito da neurodiversidade, TEA e diversidade e inclusão; terceirização e acompanhamento de profissionais com TEA que foram treinados pela Specialisterne para atuação em áreas de tecnologia e administrativas, que são serviços oferecidos de forma conjunta, conforme metodologia descrita no Tema 1 do Grupo 3; e colocação de profissionais com TEA em vagas pré-definidas pelas organizações, geralmente, voltadas para pessoas com deficiência para fins de atendimento da legislação, o que tem crescido na Specialisterne, como explica a Participante Org. 2:

> A busca cresceu muito, mas a gente tem sim. Então, o treinamento para as empresas e consultoria também. Tem empresas que nos contratam para, por exemplo, não querem inicialmente contratar uma pessoa, mas querem começar a sensibilizando a empresa ou os times. [...] Então, eles contratam a gente para a gente falar sobre o autismo, para a gente apoiar ali alguma situação específica e, às vezes, é uma porta de entrada mesmo para, depois, futuramente, eles se interessarem e a gente conseguir ir para essa parte da inclusão. [...] É um serviço que ele está vinculado. Então, a indicação está vinculada ao acompanhamento, ao suporte. [...] A equipe que está recebendo essa pessoa recebe um treinamento, que gira em torno ali de 1 hora e meia, e depois, quando a pessoa entra normalmente, mas isso vai depender do contrato do cliente, mas normalmente é 1 ano, que a pessoa trabalha como terceira, recebendo esse suporte, podendo ser estendido esse contrato também.

De acordo com o site da Specialisterne, a entidade possui como clientes dos seus serviços empresas de grande porte e, em especial, instituições financeiras, tais como Bradesco, BTG Pactual, C6 Bank, Itaú, BV Banco, ABN Amro Bank, entre outros (SPECIALISTERNE, 2024). É o que confirma a Participante Org. 2 em seu relato:

> São empresas normalmente de grande, grande porte. A gente tem muitos clientes que são bancos. Então, da área financeira, acho que a maioria, se a gente for pensar em setor, a maioria dos nossos clientes são dessa área financeira. Temos algumas empresas de tecnologia também.

As instituições ou entidades sem fins lucrativos que trabalham com a colocação e treinamento de pessoas com deficiência e profissionais com TEA acabam sendo procuradas por organizações para preenchimento das denominadas “vagas de entrada” ou “vagas operacionais” com profissionais com TEA e pessoas com deficiência, ou seja, há a busca desses serviços para posições que correspondem ao início de carreira em organizações, como confirmado pelo Participante Org. 3 e pela Participante Org. 2:

> É, até tomando como base essa questão do emprego apoiado, que é a nossa prerrogativa, a gente acaba levando em consideração as potencialidades das pessoas. Então, se ele já está estudando uma área, a gente vai tentar buscar a vaga mais próxima possível daquela área. Mas, principalmente, os que são mais jovens, são empregos de entrada. A gente sempre diz que isso não muda para ninguém, são pessoas sem experiência profissional. Então, dificilmente a gente consegue, mesmo aqueles que estão cursando ensino superior, colocar já numa vaga efetiva de uma escala maior, que não seja vagas de entrada, porque eles estão iniciando esse processo e esse entendimento do que é o mundo do trabalho. Então, a maioria das vezes são vagas de entrada e mais recorrentemente vagas operacionais. A gente ainda não tem tantas vagas técnicas específicas disponibilizadas a esse público (Participante Org. 3).
>
> Sim, normalmente, a gente trabalha com cargos de entrada. Até porque também muitas pessoas que passam aqui com a gente vêm de outras áreas. Então, já tem a formação, por exemplo, já tivemos pessoas com formação em direito ou pessoas que ainda não saíram no ensino médio, então, ainda não tem ali a experiência. Às vezes, tem o interesse, tem uma habilidade, mas não tem

> uma experiência que muitas vezes é exigido também nas vagas nos clientes. Então, normalmente, são cargos "Junior", que a gente trabalha, de entrada.

Esses achados parecem corroborar os estudos feitos por Leopoldino e Costa Coelho (2017), que identificaram relatos de oferta de vagas com baixa qualidade para profissionais com TEA. Tanto é que, para posições de liderança, a percepção da Participante Org. 2 é a de que a maioria dos profissionais com TEA que ocupam essas posições seriam de pessoas que receberam o seu diagnóstico tardiamente, o que significa que já estavam na fase adulta e que ocupavam o cargo antes de saberem que estavam no TEA. Na visão da Participante Org. 2, o desconhecimento da organização afetaria a forma como esses profissionais com TEA são tratados no trabalho:

> [...] as lideranças que eu conheço que são autistas acabaram tendo diagnóstico tardio e aí, com o diagnóstico tardio, virou um divisor de águas no sentido de parte dessas pessoas, que a gente teve a interação, que são lideranças e que são autistas, quando se declararam efetivamente autistas, elas sentiram que o tratamento das outras pessoas para com elas mudou de alguma forma, também de novo acaba bebendo dessa fonte do desconhecimento.

Outro componente associado aos serviços prestados a organizações por essas entidades e instituições é a combinação entre as características da pessoa com TEA e a posição oferecida, buscando a melhor combinação possível, aumentando-se, portanto, as chances de êxito na contratação do profissional com TEA e a sua permanência na vaga. Quando o cargo ainda é inexistente, as instituições também podem atuar junto a organizações para auxiliar no seu desenho e atribuição de atividades e responsabilidades, em linha com o apresentado pelo Participante Org. 3:

> Normalmente a gente faz um trabalho de casamento, [...] de um lado, uma descoberta de perfil. A gente tem um trabalho de, quando recebe as pessoas, fazer com elas atividades para que elas possam ir se descobrindo ou até se redescobrindo, fortalecendo alguma habilidade que elas tenham ou que desejam ter. E para que a gente possa conhecer mais ou menos quem é essa pessoa em diferentes âmbitos. E, do outro lado, a gente faz um levantamento do perfil, da vaga, para entender quais são essas vagas que estão sendo ofertadas para tentar fazer um *match*, um casamento da pessoa de um lado com a vaga do outro. E, quando não há essa vaga, a gente faz um trabalho junto com os RHs, os setores de diversidade e inclusão, um trabalho de levantamento, então, de possibilidades de trabalho que aquelas pessoas que nós estamos levantando o perfil poderiam exercer.

Os achados descritos nos Temas 2 e 3 do Grupo 3 foram organizados no Quadro 28:

Quadro 28. Visão geral dos Temas 2 e 3 do Grupo 3.

Temas 2 e 3 do Grupo 3	**Descrição dos aspectos identificados nos Temas 2 e 3 do Grupo 3 para compreender como são estruturados os programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho**
Serviços prestados para profissionais com TEA	Percepção de que profissionais com TEA necessitam de apoios para viabilizar a acessibilidade na organização e não treinamentos propriamente ditos para que modifiquem sua forma de ser e agir. Oferecimento de apoios a pessoas com TEA poderiam gerar a sensação de pertencimento dos profissionais com TEA. Percepção de que profissionais com TEA se sentiriam mais acolhidos e compreendidos ao conviver com outros profissionais com TEA. Constatação de que profissionais com TEA não têm se sentindo acolhidos e pertencentes a ambientes não adaptados às suas necessidades. Oferecimento de treinamento gratuito para aprimorar formação técnica de pessoas com TEA. Oferecimento de programa de reabilitação para a pessoa com TEA que nãos e sente preparada para se integrar no mercado de trabalho. Desenvolvimento de apoios para a pessoa com TEA e sua família, se necessário. Identificação de diferentes perfis de profissionais com TEA, a depender da entidade ou instituição sem fins lucrativos procurada.
Serviços prestados para organizações	Oferecimento de serviços para organizações por plataformas de negócio de impacto, como treinamentos, elaboração de materiais para comunicação interna e ações para conscientização a respeito da neurodiversidade e do TEA. Oferecimento pela Specialisterne de palestras de sensibilização a respeito da neurodiversidade, TEA e diversidade e inclusão, terceirização e acompanhamento de profissionais com TEA com treinamento pela própria Specialisterne e colocação de profissionais com TEA em vagas pré-definidas pelas organizações que, em geral, são destinadas à contratação de pessoas com deficiência para atendimento da Lei de Cotas. Constatação de que seriam trabalhadas mais vagas de entrada ou operacionais pela Specialisterne junto a parceiros. Percepção de que o desconhecimento a respeito do TEA e da neurodiversidade por organizações afetaria a forma como os profissionais com TEA são tratados. Atuação junto a organizações para desenho da vaga destinada a pessoas com TEA.

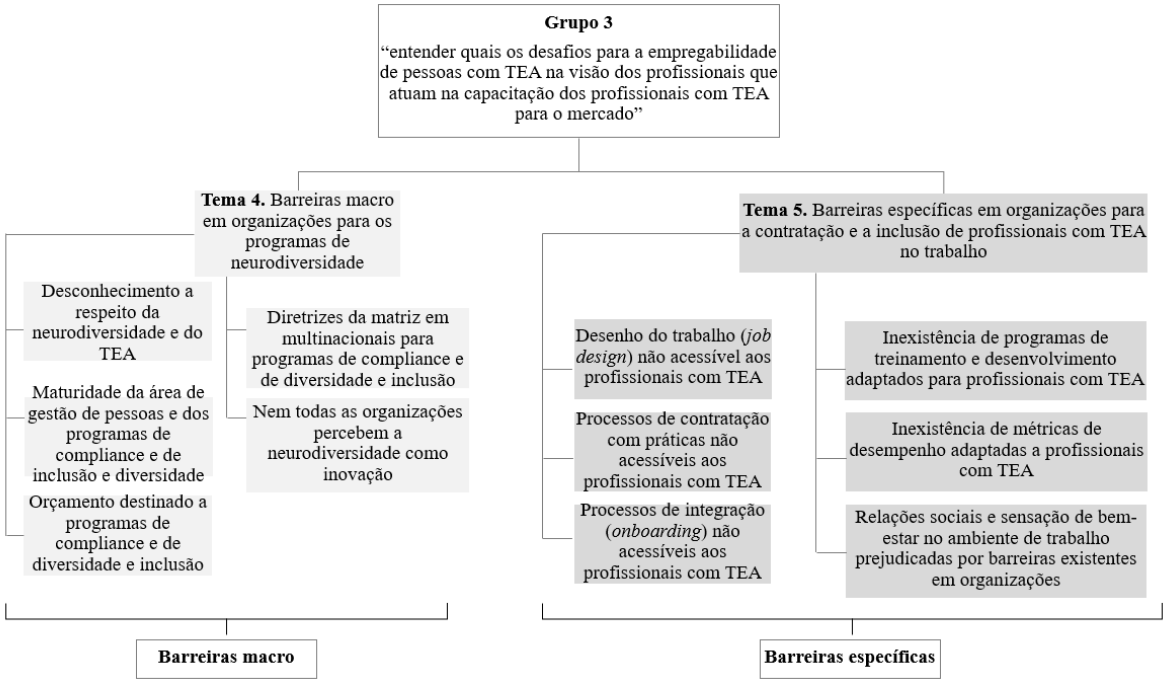
Fonte: Elaborado pela autora.

Outro objetivo específico definido para a pesquisa e que está relacionado com os participantes do Grupo 3 é "entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado".

Os códigos analisados revelaram os seguintes temas, que estão alinhados com o referido objetivo específico: (i) Tema 4 – Barreiras macro em organizações para os programas de neurodiversidade; e (ii) Tema 5 – Barreiras específicas em organizações para a contratação e a inclusão de profissionais com TEA no trabalho.

A Figura 12 indica uma síntese dos resultados obtidos para o objetivo específico em questão:

Figura 12. Visão geral da análise temática para os Temas 4 e 5 do Grupo 3.



Fonte: Elaborado pela autora.

Merecem destaque os relatos dos participantes do Grupo 3 quanto às potenciais barreiras macro ou específicas identificadas em organizações, por se tratar de profissionais que trabalham, na maior parte dos casos, em entidades e/ou instituições sem fins lucrativos que prestam serviços tanto a profissionais com TEA, que buscam capacitação e oportunidades de emprego, quanto a organizações, que desejam conhecer mais sobre neurodiversidade, adaptar seus processos internos e contratar pessoas neurodivergentes. Essa atuação com dois grupos distintos pode ser traduzida em uma visão complementar e relevante para a compreensão dos desafios à empregabilidade de profissionais com TEA.

Ressalta-se também que, nas pesquisas realizadas para a construção do Quadro 6, no item 2.3.3. deste trabalho, com foco no mapeamento de desafios à empregabilidade de profissionais com TEA, não foram encontrados, nas bases pesquisadas, estudos internacionais ou nacionais que analisam a temática especificamente a partir dos relatos dos profissionais de entidades e instituições sem fins lucrativos para capacitação de pessoas com TEA. Portanto, sugere-se que os Temas 4 e 5 poderão indicar novos achados para a literatura e assuntos para pesquisas futuras.

Não se pretende esgotar na presente análise o mapeamento de todas as barreiras (sejam elas macro ou específicas) relacionadas à empregabilidade de pessoas com TEA na visão de profissionais que atuam em instituições e entidades sem fins lucrativos que capacitam

profissionais com TEA, sugerindo-se, portanto, que tais temáticas sejam exploradas futuramente em outras pesquisas.

Tema 4. Barreiras macro em organizações para os programas de neurodiversidade

Considerando o enfoque desta pesquisa, os participantes do Grupo 3 selecionados e os objetivos geral e específicos definidos em conexão com o Grupo 3, foram considerados os seguintes subtemas para o Tema 4: (i) Desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA; (ii) Maturidade da área de gestão de pessoas e dos programas de compliance e de inclusão e diversidade; (iii) Orçamento destinado a programas de compliance e de diversidade e inclusão; (iv) Diretrizes da matriz em multinacionais para programas de compliance e de diversidade e inclusão; e (v) Nem todas as organizações percebem a neurodiversidade como inovação.

Desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA

Considerando a complexidade da temática abordada nesta pesquisa, a percepção é de que ainda há desconhecimento das organizações e da Alta Administração a respeito da neurodiversidade e do próprio TEA, como sugerido pela Participante Org. 1:

> [...] o momento do mercado atual, segundo a ótica que eu tenho percebido das empresas que eu tenho conversado, ainda é de desconhecimento e de procurar. [...] Então, quanto mais você fala com o *board* mais alto, *C-level*, *board* de diretores, alguns... alguns não, eu te diria que 80% já ouviu falar sobre o assunto "autismo", mas não... não sabe o que é. As características... muitos imaginam que isso é algo reservado ao infanto juvenil, ao público infanto juvenil. Tem dificuldade de observar isso em adultos.

A ausência de conhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA em organizações pode também estar associada à sensação de pertencimento relatada no Tema 2, que ocorre somente quando as pessoas com TEA ou neurodivergentes convivem com outras pessoas também com TEA ou neurodivergentes em processos conduzidos por entidades como a Specialisterne. Afinal, se uma organização ainda não conhece a respeito do TEA e da neurodiversidade, faz sentido pensar que menores seriam as chances de promover a inclusão desses profissionais no ambiente de trabalho, como indica o Participante Org. 3:

> É muito importante que o ambiente que vai receber ela desde o começo tem ali o mínimo de informação para que possa adquirir ferramentas mesmo para apoiar a pessoa. Eu acho que a gente tem, às vezes, culturalmente, uma ideia

> de que a inclusão é quase que uma questão intuitiva, que está dentro de cada pessoa ser inclusiva. E isso, pelo menos na prática que eu vivencio, não é isso que eu vejo. Eu acho que é algo a ser aprendido como a maioria das coisas que a gente faz como humano, inclusive. Então, ter esse processo também, essa trilha de aprendizagem, ela é fundamental e é uma etapa que é importante não ser pulada. Ser compreendido.

Provavelmente por tal motivo, uma das buscas dos serviços prestados a organizações descritos no Tema 3 do Grupo 3 tem a finalidade de sensibilizar inicialmente os times e profissionais neurotípicos internos e melhorar a compreensão a respeito do TEA, como indicado por Albright, Kuloka e Scarpa (2020). Tais práticas podem servir, muitas vezes, como uma verdadeira porta de entrada para a contratação dos demais serviços prestados por entidades e instituições sem fins lucrativos para promover a contratação de pessoas com TEA, como se percebe do relato da Participante Org. 2:

> [...] acho que, muitas vezes, um passo importante inicial é o contato com o treinamento para as pessoas e sensibilização. Então, até quando a gente fecha parcerias com os clientes é muito comum que as empresas nos procurem primeiro para fazer esse treinamento para ser essa porta de entrada, porque, às vezes, pode ser que a empresa tenha ali pouca maturidade, pouco conhecimento e aí [...] a organização procura ter essa porta de entrada através dos treinamentos, da conscientização. Então, acho que isso é fundamental, porque até se você coloca, por exemplo, um programa numa empresa que ainda não está madura e que ainda não está pronta, que nunca falou de repente sobre o assunto, com certeza, vai ter conflito. Então, minimamente ali um preparo antes mesmo da empresa toda, mesmo que não seja só da equipe é super importante.

Maturidade da área de gestão de pessoas e dos programas de compliance e de inclusão e diversidade

A neurodiversidade e a contratação de pessoas com TEA podem ser interpretadas por organizações, geralmente de maior porte, como um requisito para ser atendido no contexto de programas de compliance e cumprimento da Lei de Cotas[23]. No entanto, contratar um número maior de empregados não parece ser a única justificativa para que organizações de grande porte acabem por contratar, proporcionalmente, mais profissionais com TEA, tendo em vista que as

[23] Lei nº 8.213/91 - Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I - até 200 empregados: 2%; II - de 201 a 500: 3%; III - de 501 a 1.000: 4%; e IV - de 1.001 em diante: 5%.

vagas destinadas a pessoas por deficiência não necessariamente serão preenchidas apenas por profissionais com TEA, mas também com pessoas com outras deficiências.

Assim, além do tamanho da força de trabalho, um dos motivos que poderia ser apontado é o fato de que muitas dessas organizações teriam uma área de gestão de pessoas ou de recursos humanos mais estruturada ~~e~~, tendo já cumprido as exigências mínimas legais, como a prevista pela Lei de Cotas. Com isso, estariam aptas não apenas a compreender melhor o TEA, mas a investir em outras frentes, como a contratação e o desenvolvimento de pessoas com deficiência e profissionais com TEA, como aponta o Participante Org. 3:

> São empresas que têm o seu quadro de funcionários já preenchidos, de acordo com o que a lei pede. Aí ela consegue avançar em outras questões que envolvem, acho que, um pouco mais de maturidade, como, por exemplo, o desenvolvimento das pessoas com deficiência dentro das empresas, para outros postos de trabalho, além de cargos de entrada. [...] Então, a gente ainda tem, vamos dizer assim, um longo caminho para cumprir a legislação, mas, no entanto, a gente já tem empresas muito preocupadas com isso há bastante tempo.

Uma área de gestão de pessoas ou de recursos humanos mais madura estaria refletida na existência de programas de compliance e de diversidade e inclusão ou, ainda, com o pilar específico para a inclusão de pessoas com deficiência, mais estruturadas. Tais programas estariam aptos a fomentar iniciativas internas, como grupos de afinidade, palestras, treinamentos e estimulariam a participação de outros profissionais das organizações que, mesmo sendo neurotípicos, possuem familiares que são pessoas com deficiência ou pessoas com TEA. Ainda que sejam programas de natureza ampla e, consequentemente, sem o foco em profissionais com TEA, acabam servindo, muitas vezes, como uma base para a discussão da neurodiversidade e a estruturação de projetos especificamente voltados para o TEA em um segundo momento, como explicado pela Participante Org. 2:

> [...] pelo menos de diversidade e inclusão todos têm. A gente vê alguns que tem um pilar mais específico já para neurodiversidade ou, pelo menos, ali para pessoas com deficiência. [...] é mais comum que a gente tenha ali o pilar de pessoas com deficiência e pessoas autistas neste pilar do que a gente ter um especificamente para neurodiversidade. Algumas têm, mas acho que a maioria entraria nessa parte de pilar de pessoas com deficiência.
>
> A gente vê sim, principalmente, grupo de afinidade. Então, tem, às vezes, dependendo da empresa, vai ter de pessoas com deficiência e eles incluem as pessoas autistas. E tem muitos também que já tem o grupo focado na neurodiversidade ou no próprio autismo. Eu vejo ações assim também em algumas empresas para familiares, então, não só, por exemplo, se eles têm um grupo sobre autismo, não só pessoas autistas participam, mas, às vezes, pais, mães participam também, podem participar.

Outro reflexo dos programas de compliance e de diversidade e inclusão é a adoção de práticas mais inclusivas pela organização (MACCALI et al. 2015), o que poderia levar à redução de algumas das barreiras previstas na LBI, como as barreiras nas comunicações e na informação e as atitudinais, favorecendo mudanças no ambiente de trabalho a favor da acessibilidade para profissionais com TEA, de acordo com o explicado pelo Participante Org. 3:

> Empresas que, de fato, adotam práticas mais inclusivas, a gente percebe, no caso principalmente de transtorno do espectro autista, que a comunicação com a pessoa é flexibilizada e melhora e, consequentemente, a colaboração entre todos melhora. E isso vai valendo para outras questões também, como, por exemplo, a escuta. A escuta também da demanda, o compartilhar, o ato de tentar ajudar um colega de trabalho que está com uma demanda maior do que a sua naquele momento. Tudo isso acaba sendo permeado por uma prática inclusiva que é feita com uma pessoa e que acaba se espalhando entre toda a equipe. Então, de fato, ser mais inclusivo é uma decisão, mas essa decisão, por vezes, pode ser também um enfrentamento à lógica tradicional do trabalho que a gente cada vez está mais imerso. Então, é uma forma de enxergar esse ponto de vista.

O relato da Participante Org. 2 também indica a mesma percepção:

> Mas acho que a gente tem um grau de maturidade bem bacana quando existe por trás – e, às vezes, até dentro da própria estratégia da empresa, um olhar para as pessoas autistas, neurodivergência, esse olhar para a diversidade, porque acaba... se você tem pessoas ali por trás trabalhando, você fala mais sobre o assunto na empresa, as pessoas sabem mais, vão aceitando mais, né? E a própria... faz parte ali da própria cultura.

Em contrapartida, em organizações nas quais o grau de maturidade dos programas de compliance e de diversidade e inclusão ainda está em desenvolvimento, pode se tornar mais comum haver questionamentos dos demais profissionais neurotípicos a respeito da adaptação de práticas para fins de acessibilidade de pessoas com TEA ao trabalho, como se nota dos relatos dos Participantes Org. 2 e Org. 3:

> Então, por exemplo, as pessoas que têm uma dificuldade de aceitar dentro da equipe que uma pessoa vai ter uma diferença e outras não. Então, vou dar um exemplo "Ah, por que a pessoa pode fazer mais home office do que as outras, sendo que a política da empresa é tal". Então, acho que falta essa maturidade mesmo de aceitar, entender que pessoas vão ter características diferentes e necessidades diferentes (Participante Org. 2).
>
> [...] E aí eu acho que um desafio, uma barreira é essa, a gente pode falar que é comunicacional, mas por vezes é atitudinal, porque é a mudança de uma atitude. Às vezes, as pessoas que lá estão na empresa fazem aquele processo há muitos anos, estão acostumados a fazer daquela forma e, de repente, por conta da inclusão de uma pessoa, aquilo terá que ser repensado ou até adaptado a essa pessoa. Então, essa é uma barreira bastante frequente [...] (Participante Org. 3)

Esse achado corrobora a percepção de colegas de trabalho neurotípicos de que haveria um tratamento especial às pessoas com TEA no ambiente organizacional, em pesquisa conduzida por Spoor, Bury e Hedley (2021) em organização que implementou programa de empregado voltado para profissionais com TEA.

Orçamento destinado a programas de compliance e de diversidade e inclusão

Nem toda organização, seja de grande ou médio porte ou uma startup, consegue, entretanto, desenvolver programas de compliance e de diversidade e inclusão, ou mesmo programas especificamente voltados para pessoas com deficiência e para profissionais com TEA, ainda que apresentem uma área de gestão de pessoas ou de recursos humanos minimamente estruturada. É necessário ter condições financeiras para alocar em seu orçamento verbas e recursos para a implementação de ações internas e externas, revisão de práticas organizacionais, contratação de pessoas qualificadas e/ou de consultorias externas especializadas, entre outros, como aponta a Participante Org. 1:

> Vejo interesse de startups e empresas de médio porte. Até mais, eu te diria em termos de frequência, até maior do que a empresa de grande porte. O que acontece... [...] Essas empresas, organizações menores ou startups, tinham a vontade, mas não tinham budget, porque, como era um assunto, ainda é - se você for olhar para o mercado, um assunto, eu vou chamar aqui de "recente", abre aspas, apesar de ter mais de 20 anos aí de pesquisa sobre, mas por ser, no Brasil, um assunto recente, isso encareceu muito os serviços de consultoria, de palestra, enfim, e isso tornou menos acessível para essas empresas para contratar qualquer tipo de solução.

Diretrizes da matriz em multinacionais para programas de compliance e de diversidade e inclusão

Diante do cenário apresentado, o que parece influenciar tanto nas condições financeiras quanto nas medidas adotadas por uma organização para o desenvolvimento de programas de compliance e de diversidade e inclusão, ou pilares específicos para pessoas com deficiência ou para a neurodiversidade, é a sua atuação global, caracterizando-se como organizações multinacionais, conforme explica a Participante Org. 2:

> Eu arrisco dizer que a maioria são multinacionais [...]. Então, isso é bem comum também que, às vezes, a gente consegue ter essa troca global. Então, acho que o perfil das empresas é mais esse: empresas grandes, multinacionais [...].

Nem todas as organizações percebem a neurodiversidade como inovação

Há indícios de que algumas startups e organizações associam profissionais neurodivergentes ao fomento de inovação em seus negócios (KRZEMINSKA et al., 2019), principalmente por meio da diversidade (LOUREIRO, 2024). Essa percepção a respeito do TEA e da neurodiversidade é corroborada pelo relato da Participante Org. 1:

> Geralmente, o grande porte, se for liderado por uma pessoa que não é neurodivergente, vem por quesitos de compliance. Já da pequena empresa e startup e média empresa vem por um interesse genuíno de como alimentar a inovação, de como trazer um time mais diverso, de entender quais outros tipos de... vou chamar aqui de "pool" de pessoas e candidatos ela pode acessar [...] nas PMEs, você vê muito a intenção. Então... e isso é assim: a cada 10 organizações que eu falo que se enquadram como PME, 10 são intenção e não são, de fato, compliance, porque a legislação ali não chega a tocá-las. Então, não é... Você percebe que não é um quesito de cota ou de compliance, é de entender mesmo, querer diversidade para fomentar inovação.

Entretanto, pelo relato da Participante Org. 1, há a percepção de que algumas organizações ainda consideram contratar pessoas com TEA para fins de cumprimento da Lei de Cotas, por serem consideradas pessoas com deficiência, como discutido no Tema 3 do Grupo 2.

Os achados descritos nos subtemas do Tema 4 do Grupo 3 foram organizados no Quadro 29:

Quadro 29. Visão geral dos subtemas do Tema 4 do Grupo 3.

Subtemas do Tema 4 do Grupo 3	**Descrição das barreiras macro identificadas nos subtemas do Tema 4 do Grupo 3**
Desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA	Percepção de que há desconhecimento das organizações e da Alta Administração a respeito da neurodiversidade e do TEA. Percepção de que a ausência de conhecimento sobre a neurodiversidade e o TEA impactam na promoção de inclusão de pessoas com TEA no trabalho. Contratação de serviços de entidades e instituições sem fins lucrativos para sensibilizar equipes a respeito do TEA e da neurodiversidade poderia ser o início da contratação de mais pessoas com TEA em organizações.
Maturidade da área de gestão de pessoas e dos programas de compliance e de inclusão e diversidade	Percepção de que organizações com áreas de gestão de pessoas ou recursos humanos mais estruturadas poderiam investir na contratação e desenvolvimento de pessoas com deficiência e profissionais com TEA. Maturidade da área de RH e de gestão de pessoas poderia refletir a existência de programas de compliance e de diversidade e inclusão ou pilares específicos para a inclusão de pessoas com deficiência mais estruturadas. Existência de programas de compliance e de diversidade e inclusão poderia levar à adoção de práticas mais inclusivas para as pessoas com TEA. Percepção de que menores índices de maturidade de programas de compliance e de diversidade e inclusão poderiam fomentar mais

(continua)

(continuação)	questionamentos de profissionais neurotípicos a respeito da adaptação de práticas para acessibilidade de pessoas com TEA.
Orçamento destinado a programas de compliance e de diversidade e inclusão	Necessidade de orçamento específico para a implementação de ações internas ou externas voltadas à neurodiversidade.
Diretrizes da matriz em multinacionais para programas de compliance e de diversidade e inclusão	Influência das diretrizes da matriz internacional para o desenvolvimento de programas de compliance e de diversidade e inclusão ou pilares específicos para pessoas com deficiência e para a neurodiversidade em organizações nacionais.
Nem todas as organizações percebem a neurodiversidade como inovação	Percepção da inovação trazida por profissionais neurodivergentes restrita a algumas organizações e áreas e de que outras ainda contratam pessoas com TEA exclusivamente para fins de cumprimento da Lei de Cotas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tema 5 – Barreiras específicas em organizações para a contratação e inclusão de profissionais com TEA no trabalho

Para a identificação das barreiras específicas nas organizações para a contratação e a inclusão de profissionais com TEA no trabalho propostas neste Tema 5 do Grupo 3, assim como indicado no Tema 4 do Grupo 1 e no Tema 6 do Grupo 2, serão analisadas as evidências obtidas por meio dos relatos dos Participantes do Grupo 3 com base nas seis áreas principais de RH sugeridas por Doyle e McDougall (2022), discutidas no item 2.3.3. do presente estudo.

Com base nas referidas seis áreas de RH e a partir da aplicação dos conceitos de acessibilidade e de desenho universal previstos na LBI, foram propostos os seguintes subtemas para este Tema 5 do Grupo 3: (i) Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA; (ii) Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA; (iii) Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA; (iv) Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA; (v) Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA; e (vi) Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações.

De um modo geral, como indicado na literatura (SPECIALISTERNE, 2024), as barreiras identificadas nos subtemas a seguir decorrem da aplicação de práticas tradicionais de contratação por organizações, sem que sejam feitos ajustes necessários para fins de acessibilidade de profissionais neurodivergentes. Não foram encontrados na pesquisa inicial para elaboração do Quadro 6, no entanto, detalhes das referidas práticas – o que se pretende construir com a presente análise.

Ainda, como visto, a temática tratada neste Tema 5 do Grupo 3 refere-se a um objetivo específico que também foi associado aos participantes do Grupo 1 e 2. Será discutida, posteriormente, a visão integrada dos participantes dos três grupos (Grupos 1, 2 e 3) a respeito das barreiras específicas em organizações para a contratação e inclusão de profissionais com TEA no trabalho, que levem à identificação dos desafios para a empregabilidade das pessoas com TEA.

Desenho do trabalho (job design) não acessível aos profissionais com TEA

A falta de compreensão e apoio nas configurações de vagas de emprego para pessoas com TEA é indicada de forma geral por Baldwin, Costley e Warren (2014). Conceição, Escalante e Silva (2021), por sua vez, explicam, sob a ótica dos próprios profissionais com TEA, que muitos desses profissionais sentem grandes dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. O relato da Participante Org. 4 parece corroborar essa informação, mas a partir da visão de uma profissional que atua com capacitação e atendimento de pessoas com TEA em uma associação sem fins lucrativos:

> Tem uns, talvez, que não se conseguem se inserir no mercado de trabalho porque não encontram algo que lhe atenda às suas necessidades. Não conseguem.

Quanto aos possíveis motivos para que essa situação ocorra, a Participante Org. 2 sugere que a redação imprecisa de habilidades exigidas para uma vaga de emprego poderia impactar o processo de candidatura de uma pessoa com TEA, que tende a ter uma compreensão mais concreta e precisa do quanto é solicitado na descrição de uma oportunidade de trabalho:

> Por exemplo, quando a gente vai se candidatar a uma vaga e a gente olha a descrição daquela vaga, muitas vezes o que está descrito ali, às vezes, muitas vezes, são habilidades meio abstratas que a gente tem, que muitas vezes não dizem muita coisa. E muitas das vezes também é difícil a gente avaliar. Então, assim, não tem uma nota para a gente dizer "ah, o quão proativo a pessoa é". Então, assim, eu posso pensar "poxa, eu sou proativa", mas de repente a minha gestão pensa "ah, ela não é tão proativa, porque eu convivo com alguém muito mais proativa". Então, às vezes, existe essa barreira no momento de ler ali para se candidatar, a pessoa mesmo olhar aquilo, até pelo pensamento mais lógico e mais concreto e falar "nossa, está pedindo uma pessoa proativa, mas acho que eu não sou muito proativo" "Ah, não sei se eu sou, então, não vou me candidatar" Então, não é uma coisa tão objetiva assim. [...]

Esse aspecto parece corroborar a descrição feita por Melo, Garrocho e Guerra (2021) a respeito das sensações de confusão e ansiedade sentidas por pessoas com TEA no processo

de identificação de vagas de emprego, por não terem conhecimento se possuem ou não as qualificações necessárias para o cargo. Apresentado a partir da visão de uma profissional que trabalha em entidade sem fins lucrativos para a capacitação e colocação de profissionais com TEA no mercado, trata-se de achado na presente pesquisa que reforça a necessidade de aprimoramento do desenho de vagas disponíveis, apresentando da forma mais precisa possível as habilidades requeridas dos candidatos que aplicarão para as vagas. Tal fato poderia também representar um dos motivos pelos quais as pessoas com TEA acabam não se candidatando a determinadas posições, tendo a impressão de que não há vagas que atendam às suas necessidades, como indicado no relato da Participante Org. 1 transcrito no início deste subtema, como explica a Participante Org. 2:

> Aí, às vezes, a pessoa acaba não se candidatando ou, às vezes, se candidata, mas não inclui às vezes alguma informação. [...] Então, muitas vezes, a gente se aplica, às vezes, quem está procurando emprego se aplica a vaga que nem... você nem tem todos os requisitos, mas se se aplica, porque, às vezes, na entrevista, existe o encaixe. Mas, para a pessoa que tem já esse pensamento mais lógico, nem sempre ela vai. "Poxa, eu tenho isso aqui que não... Não está... Sei lá, precisa morar em São Paulo, eu moro em Osasco, eu não vou, não vou me incluir".

Outra característica das vagas de emprego desenhadas no Brasil e que não foi detectada nos estudos feitos para a elaboração do Quadro 6 do item 2.3.3. é a jornada padrão de trabalho de oito horas diárias, que também parece ser um motivo que afastaria os profissionais com TEA do mercado de trabalho brasileiro, tendo em vista que cada pessoa com TEA é diferente e poderá necessitar de apoios específicos, conforme explicado pela Participante Org. 2:

> Então, um exemplo muito clássico que a gente tem é a questão da carga horária. Então, independente, às vezes, do nível de suporte da pessoa, tem as pessoas que não conseguem ainda trabalhar nas 40 horas. Vão ter ali algumas questões das vezes até sensoriais mesmo e a pessoa vai ter uma dificuldade importante em ficar as 40 horas. [...] Então, às vezes, as pessoas acabam não participando do processo porque "Ah, bom, não adianta participar, né? Porque eu, nesse momento, não consigo" ou até uma família. Às vezes, a pessoa tem um nível 3, por exemplo, de suporte, normalmente, a família está muito próxima do processo. E aí, no próprio processo, a família percebe "ah não. Acho que nesse momento ele não tem essa autonomia".

Há similaridade com o relato trazido pelo Participante TEA 17, quando das discussões do Tema 4 do Grupo 1.

Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA

Caso o profissional com TEA consiga, de alguma forma, superar as barreiras que poderão estar associadas ao desenho do trabalho refletido no anúncio da oportunidade de emprego e decida aplicar para uma determinada posição, a tendência é que também enfrente barreiras no processo de seleção de candidatos, ao decidir se revelar ou não como uma pessoa com TEA, como discutido no Tema 1 do Grupo 1.

Na percepção da Participante Org. 2, profissionais com TEA acabam, no geral, tentando participar de diferentes processos conduzidos por inúmeras organizações ou agências de recrutamento e seleção, sem receber, no entanto, qualquer retorno a respeito dos resultados:

> Acho que primeiro é a clássica em relação à entrevista e dinâmica. Então a maioria traz ali pelo menos alguma experiência ruim de entrevista e de processo de entrada. Muitas pessoas fazem, assim, várias e não recebem ali nenhum retorno, porque a entrevista vai envolver a questão de se vender, de dar ênfase em uma habilidade e competência que, muitas vezes, a pessoa autista acaba sendo mais direta, mais objetiva. [...]

A ausência de retornos foi também comentada pelos participantes do Grupo 1, nas discussões do Tema 1 e do Tema 4.

Além disso, como apresentado no Tema 1 do Grupo 1, a decisão pela revelação do diagnóstico de TEA por um profissional com TEA logo no início do processo seletivo, como sugerido por Khan et al. (2022), não significa necessariamente êxito em sua participação. Na verdade, a percepção de muitos profissionais com TEA é de que haveria uma exclusão sumária do referido profissional de processos seletivos, tanto para vagas regulares quanto aquelas especificamente endereçadas para pessoas com deficiência, não sendo sequer chamados para participar de entrevistas. Segundo as pesquisas de Leopoldino e Costa Coelho (2017), Conceição, Escalante e Silva (2021), Araújo e Dourado (2022) e Basto e Cepellos (2023), tais situações poderiam estar baseadas no preconceito de empregadores com relação a profissionais com TEA. De todo modo, essa percepção foi trazida inicialmente pelos relatos dos participantes do Grupo 1 e é corroborada pela Participante Org. 2, com base em sua experiência:

> Sim, já comentaram de dizer, assim, bem diretamente, até, inclusive, de tirar essa informação de currículo e de LinkedIn por conta de sentirem que isso atrapalha e que não são chamados, ou que eles falam numa entrevista que são autistas e não são chamados depois. Então, sim, já ouvi alguns relatos desses.

Outro fator que poderia influenciar na ausência de êxito ou retorno de resultados de processos seletivos aos profissionais com TEA é a existência de evidências científicas de que a

relação entre sucesso acadêmico e sucesso na carreira seriam, na realidade, modestas, como explicado por Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013).

Como consequência, apesar de muitos profissionais com TEA terem formação em ensino superior, pós-graduações e certificações, como é o caso de vários participantes do Grupo 1 desta pesquisa, não necessariamente tais níveis de instrução formal representariam maiores possibilidades de sucesso na contratação para vagas em suas áreas desejadas de atuação. Esses achados estão em linha com o estudo internacional de Hurlbutt e Chalmers (2014) e a pesquisa nacional de Garbin et al. (2014) quanto à dificuldade que profissionais com TEA possuem de obter colocação compatível com a formação profissional.

Para que não fiquem fora do mercado de trabalho, esses profissionais acabariam aceitando outras posições, até mesmo "vagas de entrada", ou de baixa qualidade, nos dizeres de Leopoldino e Costa Coelho (2017), que não refletem exatamente suas pretensões e aspirações, tendo que, muitas vezes, recomeçar suas carreiras. Essas sugestões são confirmadas pelo relato da Participante Org. 2:

> [...] às vezes, a pessoa tem ali várias formações, já fez vários cursos, já fez intercâmbio. E aí, no momento de conseguir uma oportunidade, às vezes, faz uma atividade que não tem nada a ver com a sua área de formação, com essa área de motivação. E eu vejo - e aí é uma percepção minha mesmo - que talvez isso aconteça muito pela dificuldade de entrar em outras vagas. E aí a pessoa acaba... precisa trabalhar, acaba se candidatando para outras vagas que não tem tanto a ver com, às vezes, o perfil, com a sua formação, e acabam entrando e aí vão trabalhar em uma área, numa atividade bem diferente do que ela gostaria inicialmente. Então, acho que muito pela dificuldade de entrar nas outras, a pessoa acaba por querer e precisar trabalhar também, se candidatando a outras vagas diferentes para fazer outras coisas. Às vezes, acaba sendo aprovado e aí vai trabalhar com outras... outro tipo de tarefa.

Processos de integração (onboarding) não acessíveis aos profissionais com TEA

De um lado, tomando como parâmetro os processos regulares de contratação e integração de profissionais neurotípicos, como explicam Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013), a característica de empregados ou de candidatos a vagas de emprego que parece ser considerada mais importante para fins de empregabilidade seriam as habilidades interpessoais ou as competências sociais do indivíduo.

Por outro lado, como descrito por Szulc et al. (2021), em muitas ocasiões, uma das principais barreiras enfrentadas pelos profissionais neurodivergentes no processo de integração (*onboarding*) padrão em organizações relaciona-se precisamente com a superação de potenciais problemas atrelados à interação social. Essa percepção é compartilhada pela Participante Org. 1 em sua fala:

> Outro ponto que eu diria que eu ouço muito é a parte de interação social, então, isso, obviamente, não é exclusivo da pessoa autista. Até porque, de novo, cada pessoa autista é de uma forma diferente, vai ter influências diferentes e está ali no espectro, mas tem, sim, muito esse ponto relatado como uma, abre aspas, falta de interação ou menor interação, seja com a equipe ou coisas nesse sentido.

Haveria, portanto, um aparente conflito entre o que os empregadores desejariam de suas novas contratações (estabelecido com base no padrão neurotípico de comportamento humano) e o que tem sido apontado pela literatura (principalmente com base no modelo médico da deficiência) como sendo geralmente esperado das interações sociais com pessoas com TEA. Tais visões opostas acabam gerando uma grande barreira para a integração de profissionais com TEA em organizações após a contratação.

Além disso, como explicado por Melo, Garrocho e Guerra (2021), em geral, pessoas com TEA tendem a ter uma compreensão muito literal da linguagem, o que poderia impactar tanto a interação social com os demais empregados da organização quanto a sua comunicação. O entendimento a respeito das características da comunicação comumente encontrada em pessoas com TEA é explicada pela Participante Org. 2 e pelo Participante Org. 3:

> Sim, é muito na questão da comunicação clara e objetiva, porque a compreensão deles é muito mais fácil também quando é concreta, direta. Então, quando as coisas ficam muito soltas, muito abertas, ou, às vezes, é esperado ali que a pessoa faça sua própria gestão, muito flexível... No final, às vezes, acaba sendo uma dificuldade para a pessoa autista. Então, acho que tem essa questão da comunicação de “ah, a pessoa não foi clara” ou “eu falei algo e a pessoa interpretou de uma outra forma”. [...] a falta de informação, às vezes, faz também com que as pessoas não compreendam, às vezes, uma forma de se comunicar diferente. Então tem essa... Eu acho que esse desafio (Participante Org. 2).
>
> Então, o que a gente mais percebe no início das questões é a dificuldade, por vezes, de comunicação e eu acho que isso tem a ver com a questão diagnóstica, pelo que a gente empiricamente tem vivenciado, a dificuldade do autista é com a comunicação. E não adianta, por vezes, não ser num processo, uma via de mão dupla. A gente sim trabalha para que a pessoa dentro do TEA consiga se comunicar de acordo com o que a empresa espera, mas também as pessoas que lá estão tem de fazer esse movimento de também flexibilizar processos que existem para eles se comunicarem com os funcionários de forma que aquela pessoa com TEA consiga também acessar (Participante Org. 3).

Retomando o exposto por Szulc et al. (2021) em seus estudos, as evidências encontradas nos relatos dos Participantes do Grupo 3 parecem reforçar a noção de que as barreiras na comunicação e na interação social enfrentadas por profissionais com TEA são, em grande escala, influenciadas pela aplicação de práticas organizacionais previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias para assegurar a acessibilidade. Partindo-se do modelo social da deficiência, é o ambiente em que a pessoa com deficiência se encontra que deve ser modificado para viabilizar a sua participação e fruição de seus direitos – e não o contrário. Essa noção pode ser percebida no relato apresentado pela Participante Org. 1:

> [...] quando se fala "comunicação", a gente vê que é uma desestruturação dos processos da empresa. Então, muitas vezes, o cerne não está na pessoa autista, por exemplo, que, abre aspas, não sabe se comunicar ou coisas nesse sentido. O processo geralmente para aquela pessoa conseguir se comunicar ou passar alguma informação para frente está desestruturado. Isso gera uma sobrecarga para a pessoa autista e também acaba respingando na equipe, nas lideranças, enfim.

Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA

Pela experiência dos participantes do Grupo 3, é possível inferir que não são regularmente identificados programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA em organizações. Possivelmente, a ausência de conhecimento a respeito do TEA e da neurodiversidade combinada com um nível de maturidade ainda baixo na maioria dos programas de compliance e de diversidade e inclusão voltados para pessoas com TEA, identificados como barreiras macro em organizações no Brasil para fins do Tema 4 desse estudo, podem ter alguma relação com a dificuldade em saber como apoiar da melhor forma profissionais com TEA, como apontado por Dreaver et al. (2019).

Para fins da análise neste subtema, são também retomados os relatos dos Participantes do Grupo 3: (i) no Tema 3, acerca da predominância de "vagas de entrada" destinadas a pessoas com TEA; e (ii) neste Tema 5, quanto ao desligamento precoce de profissionais com TEA de suas posições em organizações, muitas vezes fazendo com que sequer participem de processos de avaliação de desempenho, o que incluiria uma eventual progressão de cargo. A partir dessas evidências e diante da ausência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados, sugere-se que um dos principais reflexos que poderiam ser percebidos a médio e certamente a longo prazo nas carreiras de profissionais com TEA é a barreira criada pela própria organização,

dificultando o seu avanço para posições de gestão e liderança, como corroborado pela experiência da Participante Org. 1:

> Teve um só, mas é uma situação que [...] é o reconhecimento das características técnicas daquela pessoa autista. A empresa quis levá-la para cargo de liderança, fazer uma promoção. E aí aquelas lideranças que estavam naquele momento ali tiveram dificuldade de imaginar, digamos assim, de entender como preparar uma pessoa autista para um cargo de liderança por conta de habilidades sócio-emocionais, vamos chamar assim.

Oportunidades limitadas de engajamento e crescimento para profissionais neurodivergentes foram também apontadas nos estudos conduzidos por Johnson et al. (2020), mostrando similaridade com a realidade em organizações brasileiras.

A visão que se pretende trazer com essa análise, feita com base no modelo social da deficiência, é de que os treinamentos para fins de desenvolvimento de pessoas com TEA não sejam feitos com a intenção de corrigir algo ou mesmo moldar o profissional com TEA de acordo com características de grupos neurotípicos. A ideia é viabilizar caminhos na organização para que posições de gestão e liderança sejam acessíveis a todos, por meio da aceitação de suas particularidades, do reconhecimento de suas potencialidades e do oferecimento dos apoios necessários para sua plenitude na organização. Essa abordagem é compartilhada pela Participante Org. 2, ao emitir a seguinte opinião:

> Eu vejo muito mais uma necessidade do próprio ambiente, das organizações, de se adaptar do que, às vezes, da própria pessoa, porque, muitas vezes, a pessoa já estudou, já foi atrás e onde ela vai ter a dificuldade vai ser, às vezes, para entrar... a pessoa vai ter dificuldade no processo de entrada, mas, em termos de formação, ela já tem [...] Então, eu acho que a necessidade é muito mais na mudança das empresas do que da pessoa [...].

Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA

Como discutido, há evidências empíricas que revelam uma tendência de os empregadores apresentarem maior interesse nas habilidades sociais (*social skills*) dos empregados do que em sua habilidade cognitiva, segundo Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013). Essa prática é associada ao padrão neurotípico de comportamento e, em geral, reflete-se, direta ou indiretamente, em critérios aplicados na maior parte das avaliações de desempenho de organizações. Nesse contexto, os modelos tradicionais de avaliação deveriam ser repensados

por organizações que desejam mitigar barreiras para a evolução profissional de pessoas com TEA, como tem sido visto em alguns casos de empregadores que começam a ter mais experiência com pessoas neurodivergentes em seus times, conforme relato da Participante Org. 2:

> [...] o que a gente vê: algumas empresas que estão trabalhando já com o público neurodivergente estão buscando adaptar as suas práticas ali de gestão de performance, levando em consideração as diferenças das pessoas autistas, os neurodivergentes. Então, com certeza, quando a gente pensa numa avaliação muito tradicional ali, que às vezes quer avaliar até o quanto que você ajuda o colega ou se coloca numa reunião. E aí isso pode ser um ponto ali para você importante, então, com certeza é necessário.

Não se ignora, contudo, que a revisão de processos já estabelecidos e arraigados em organizações pode ser algo que demandará tempo, investimento e esforços conjuntos, acabando por envolver, como explicado no Tema 3, a contratação de serviços prestados por entidades e instituições sem fins lucrativos para o apoio necessário. Neste cenário, o Participante Org. 3 explica a importância da compreensão de que: (i) as pessoas neurodivergentes provavelmente responderão de forma distinta de outros profissionais neurotípicos; e (ii) os profissionais neurotípicos poderão ter a sua própria curva de aprendizado para lidar com as neurodivergências identificadas em outros profissionais de sua equipe:

> Sim, acho que é importante enfatizar que é necessário, nesse processo, muitas vezes, ter um pouco de paciência para a criação de um vínculo, [...] desconstruir um pouco essa cultura quase que objetal de que as pessoas têm que responder num tempo padronizado. O suporte que a gente mais precisa é o humano, principalmente do outro lado que apoia. Existe, por vezes, um tempo de cada um para conseguir se sentir vinculado a esse consultor de emprego apoiado, tanto da pessoa com deficiência para com o consultor, quanto do líder ou pessoa que foi indicada pela empresa para acompanhar como consultor, para que venham surgindo as dificuldades e as barreiras no caminho.

De todo modo, trata-se de uma iniciativa urgente que necessita ser adotada para o acolhimento de profissionais com TEA no trabalho e a redução de barreiras que possam atrapalhar o seu sucesso na organização. Isso porque, considerando as características geralmente atribuídas a pessoas com TEA no que diz respeito a formas de comunicação diferenciadas e aspectos de interação social próprios, a ênfase em habilidades meramente sociais em detrimento das demais habilidades de profissionais neurodivergentes, como as cognitivas e de personalidade, poderia ser indicada como um dos fatores que afeta o desempenho do profissional com TEA em organizações que ainda não ajustaram seus parâmetros. Um dos reflexos é a dificuldade de manter empregos compatíveis com o respectivo

nível de habilidades técnicas, como apontado na literatura internacional por Hurlbutt e Chalmers (2004).

Consequentemente, em muitas das vezes, a pessoa com TEA sequer acaba conseguindo chegar às etapas de avaliação de sua performance, em virtude de desligamentos ou demissões precoces, como explica a Participante Org. 2:

> Olha, eu acho que isso é até um pouco triste, porque muitas pessoas acabam, às vezes, nem ficando tanto tempo numa empresa para chegar nessa parte. Então, assim, eu não lembro de ninguém ter comentado comigo sobre isso. [...] pessoalmente, acho que nunca ouvi nenhum relato assim de uma outra pessoa muito direta e falando sobre essa parte de gestão, de performance, enfim, de avaliação, aliás, de performance.

Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações

Como explicado neste Tema 5, aspectos da comunicação e da interação de pessoas com TEA no trabalho acabam por influenciar em sua vida social dentro da organização, especialmente quanto ao relacionamento com outros profissionais neurotípicos (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Relatos trazidos pela Participante Org. 2 parecem corroborar essa percepção:

> Sim, acho que a maioria está relacionada a essa parte da comunicação deles. Então, de falaram "ah o gestor ou o lugar em que eu estava não me entendia e aí eu falava, eu era muito honesto, eu era muito direto e as pessoas não gostavam que eu falava a verdade" ou "achavam que eu era rude". Então, acho que principalmente relacionadas a questão de ser rude e também de falar a verdade. Então, isso, por incrível que pareça, às vezes é malvisto em uma equipe. "Ah, a pessoa traz muitas verdades. Fala as coisas no momento que não deveria falar". Então, também existe. Eu já ouvi alguns relatos nesse sentido.

Para além de relações sociais inerentes às organizações, as condições do ambiente físico de trabalho podem configurar em barreiras para que os profissionais com TEA consigam desempenhar as suas atividades e experimentarem sensação de bem-estar, como explica Szulc (2022). É certo que cada profissional com TEA terá as suas particularidades e preferências, não devendo a organização generalizar soluções que seriam aplicáveis a todas as pessoas com TEA ou neurodivergentes. Tal posição já seria por si só contrária à noção de acessibilidade trazida pela LBI e utilizada como norte para análise no presente estudo.

De todo modo, questões associadas a barulhos, ausência de flexibilidade em horários e impossibilidade de adaptação de materiais constam das experiências dos Participantes Org. 2 e 3 quanto à atuação de profissionais com TEA:

> [...] E, na questão também da adaptação de um ambiente físico. Então, por exemplo, ter ali um espaço que seja muito barulhento. Às vezes, tem pessoas que vão trabalhar em oportunidades, por exemplo, tem muito contato, às vezes, com o cliente também. Então, isso acaba exigindo e já exige de todo mundo um contato social muito alto. E que... acho que, para qualquer ser humano, dá aquele cansaço depois. [...] Mas para eles, isso é maior ainda. Então, acho que os principais desafios seriam, assim, na comunicação, com os pares, na aceitação e compreensão também do time em relação àquela pessoa e adaptações, assim, ambientais (Participante Org. 2).
>
> [...] e outras barreiras também, por vezes, de flexibilização de horário, de adequação de materiais e treinamentos que são padronizados para todos os profissionais e que talvez para aquela pessoa em específico precisará ser repensado. Então, as barreiras são, eu diria, que são únicas e individualizadas. Acho que é importante dizer isso. A gente pode fazer a melhor cartilha do mundo, mas pela experiência que eu tenho, e trabalhando com isso, cada ambiente tem uma cultura própria. Portanto, terão barreiras específicas. Uma cartilha geral até pode ajudar e ajuda, mas é importante olhar ambiente-ambiente, pessoa-pessoa e não perder isso de perspectiva (Participante Org. 3).

Os achados descritos nos subtemas do Tema 5 do Grupo 3 foram organizados no Quadro 30:

Quadro 30. Visão geral dos subtemas do Tema 5 do Grupo 3.

Subtemas do Tema 5 do Grupo 3	**Descrição das barreiras específicas identificadas nos subtemas do Tema 5 do Grupo 3**
Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA	Barreiras para ingressar no mercado de trabalho. Redação imprecisa de habilidades exigidas pela organização para uma vaga de emprego. Redução no número de candidaturas de profissionais com TEA a determinadas posições pela ausência de vagas que atendam às necessidades de pessoas com TEA. Falta de flexibilidade para o profissional com TEA na duração da jornada de trabalho padrão.
Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA	Ausência de retorno para profissionais com TEA que participam de processos de recrutamento e seleção. Percepção de que profissionais com TEA não têm sido contratados por organizações após se revelarem como pessoas com TEA. Constatação de que profissionais com TEA acabam aceitando vagas não compatíveis com a sua formação por não terem outras opções de emprego.
Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA	Percepção de empregadores de que profissionais com TEA teriam problemas associados à comunicação e à interação social, limitando oportunidades de contratação. Evidências de que as barreiras na comunicação e interação social de pessoas com TEA encontram-se nas organizações e não no profissional com TEA.
Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA (continua)	Constatação de que não são regularmente implementados programas de treinamento e de desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA. Treinamentos devem focar em habilidades técnicas e necessárias para executar as tarefas exigidas e não em corrigir ou moldar o profissional com TEA a características neurotípicas.

(continuação) Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Necessidade de repensar modelos tradicionais de avaliação destinados a profissionais neurotípicos. Necessidade de se considerar que profissionais neurodivergentes e neurotípicos poderão ter curva de aprendizado distintas, podendo responder de forma distinta. Percepção de que profissionais com TEA são desligados antes que cheguem às etapas de avaliação de desempenho.
Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Barreiras associadas à falta de compreensão de aspectos distintos de comunicação e interação social que algumas pessoas com TEA poderão ter. Barreiras associadas à configuração do ambiente físico do trabalho, dependendo das características de cada pessoa com TEA.

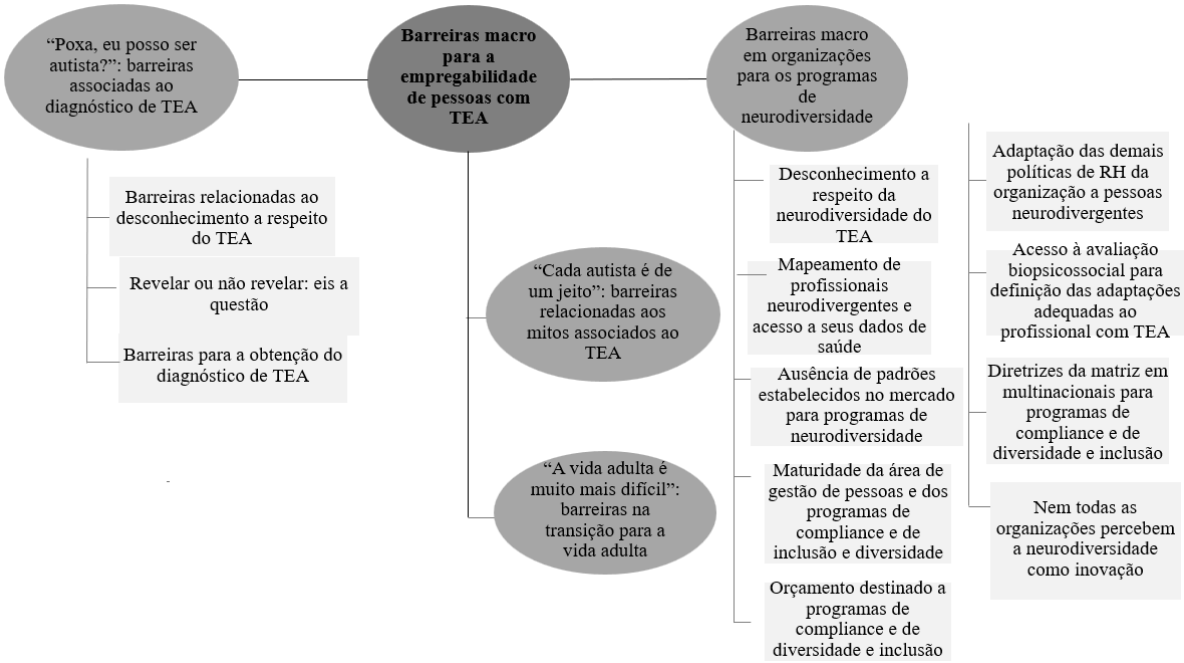
Fonte: Elaborado pela autora.

4.2. VISÃO INTEGRADA DOS RELATOS DOS GRUPOS 1, 2 E 3

A partir dos temas propostos para os Grupos 1, 2 e 3, sugere-se uma visão integrada dos desafios à empregabilidade enfrentados por profissionais com TEA.

Começando com as barreiras macro definidas mediante os relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3, propõe-se a Figura 13 com a visão integrada das referidas barreiras para apoiar as discussões:

Figura 13. Visão integrada das barreiras macro identificadas por meio dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3.



Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o modelo social da deficiência, reforça-se que não se sugere que o TEA ou o fato de um indivíduo ser diagnosticado como pessoa com TEA sejam barreiras em si. Foram apontados como barreiras macro, portanto, os desafios obtidos por meio das entrevistas com pessoas com TEA a partir da sua interação com o ambiente onde vivem e com as pessoas com as quais convivem.

O desconhecimento a respeito do TEA, principalmente em situações de diagnóstico tardio, pode requerer apoios e suportes específicos para as pessoas com TEA, especialmente na transição para a vida adulta, ao ter que conciliar diferentes aspectos da vida pessoal e profissional, com os quais não estavam familiarizados. Além disso, é comum pessoas com TEA terem que lidar com alguns mitos associados ao TEA, fruto de generalizações, estereótipos e do senso comum a respeito do TEA.

No que diz respeito às organizações, tanto para profissionais do Grupo 2 quanto do Grupo 3 o desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA parece constituir barreira macro relevante para a empregabilidade de pessoas com TEA. Não ter parâmetros definidos no mercado para programas de neurodiversidade também pode constituir um obstáculo para os avanços nessa temática, de acordo com a percepção de participantes do Grupo 2. Sugere-se que a decisão de organizações pela contratação de serviços prestados por consultorias e entidades sem fins lucrativos especializadas, como identificado no Tema 4 do Grupo 2 e no Tema 3 do Grupo 3, pode ter relação com essas barreiras indicadas e poderá auxiliar na revisão e adaptação de políticas internas de RH e de gestão de pessoas com foco nas necessidades de apoio de profissionais com TEA.

Entretanto, os custos associados aos serviços prestados pelas referidas consultorias poderão ser uma barreira para as organizações que não possuem um orçamento definido para programas de neurodiversidade, conforme relatos dos participantes do Grupo 3. Ter o orçamento e o interesse em investir em programas de neurodiversidade poderá ter relação tanto com a maturidade da área de RH e gestão de pessoas de uma organização quanto a existência de diretrizes de matrizes no exterior, em multinacionais, para atuação nesse sentido, de acordo com a visão dos participantes do Grupo 3.

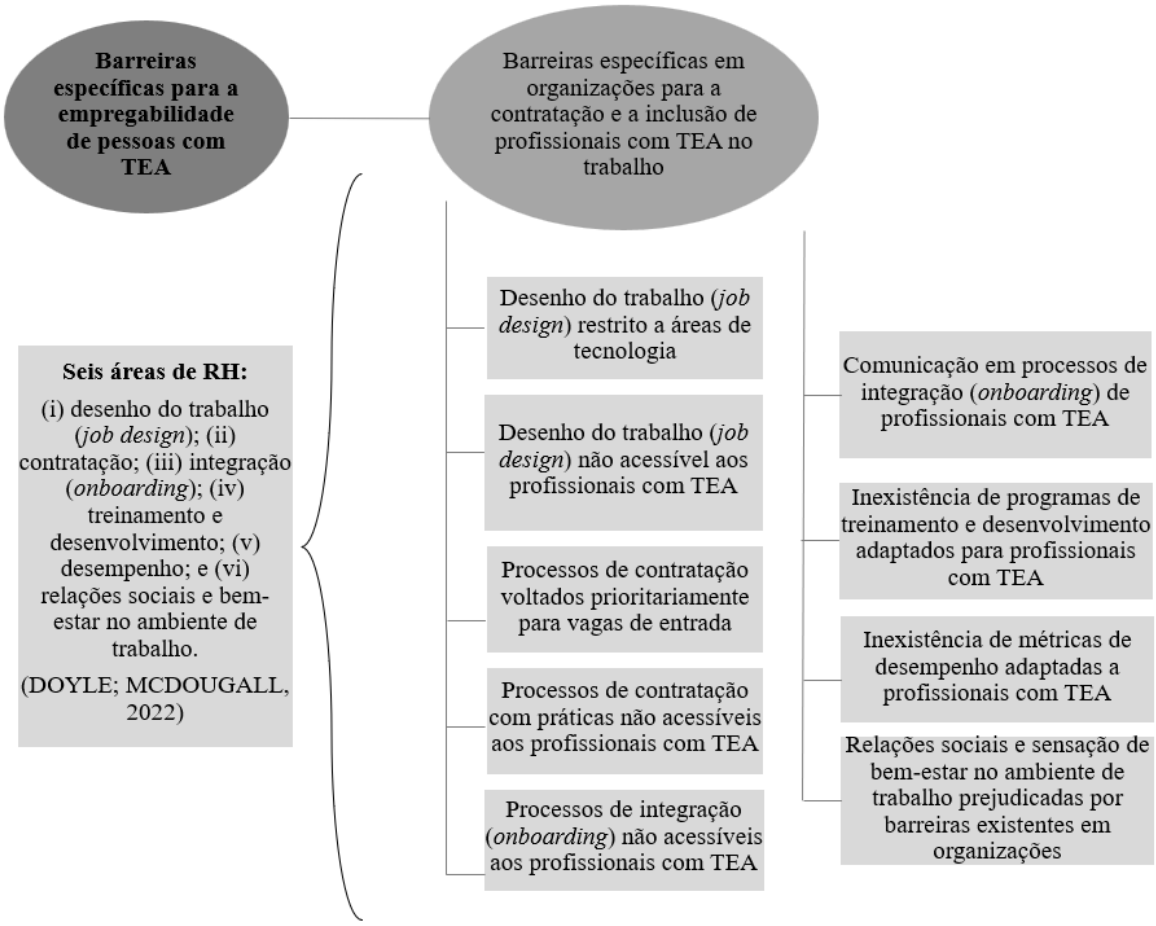
Ainda não há um consenso quanto ao fomento à inovação por meio da contratação de profissionais neurodivergentes em organizações, em linha com a experiência compartilhada por participantes do Grupo 3.

As barreiras para acesso a dados pessoais e à avaliação biopsicossocial de pessoas com TEA por organizações também poderão impactar na avaliação acerca da necessidade da

implementação de programas de neurodiversidade estruturados, destinação de orçamento para projetos dessa natureza e a definição dos apoios específicos para cada indivíduo com TEA, como informado por participantes do Grupo 2.

Para as barreiras específicas definidas mediante os relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3, propõe-se a Figura 14 com a visão integrada das referidas barreiras para apoiar as discussões:

Figura 14. Visão integrada das barreiras específicas identificadas por meio dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3.



Fonte: Elaborado pela autora.

Ainda, considerando a proposta de uma visão integrada dos Grupos 1, 2 e 3 quanto às barreiras específicas para a empregabilidade de profissionais com TEA, foram elaborados quadros específicos a respeito de cada uma das seis áreas de RH propostas por Doyle e McDougall (2022), discutidas no item 2.3.3. do presente estudo. Cada quadro foi dividido da seguinte forma: (i) identificação do Grupo 1, 2 e 3; (ii) indicação da literatura utilizada no referencial teórico como base para as discussões; (iii) as barreiras específicas definidas a partir

dos subtemas dos temas de cada grupo; e (iv) a descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática, conforme Quadros 31 a 36.

Por meio dos referidos quadros, pretende-se demonstrar os novos achados e contribuições para a literatura e facilitar a discussão entre as diferentes percepções dos Grupos 1, 2 e 3, contribuindo para uma visão integrada de cada ponto levantado.

Quadro 31. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao desenho do trabalho (job design).

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1	Obtenção de uma colocação compatível com a formação do profissional (HURLBUTT; CHALMERS, 2004; GARBIN et al., 2022). Dificuldade na manutenção de empregos compatíveis com o respectivo nível de habilidades técnicas (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Confusão e ansiedade no processo de identificar uma vaga de emprego, por desconhecerem se possuem as qualificações necessárias para o cargo (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021).	Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA	Ausência de conhecimento prévio pelo profissional com TEA sobre as características do ambiente de trabalho e a rotina de trabalho. Falta de flexibilidade para o profissional com TEA na duração da jornada de trabalho padrão. Ausência de oferta de vagas de emprego compatíveis com a formação de profissionais com TEA. Poucas ofertas de vaga em *home office* ou regime híbrido para profissionais com TEA. Falta de definição de horários fixos e previsibilidade para profissionais com TEA em algumas áreas, como consultorias.
Grupo 2	Ausência de compreensão e apoio nas configurações dos empregos encontrados (BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014). Oferta de vagas com baixa qualidade (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017). Falta de preparo vocacional dos profissionais com TEA (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; BASTO; CEPELLOS, 2023).	Desenho do trabalho (*job design*) restrito a áreas de tecnologia	Ausência de conhecimento prévio pelo profissional com TEA sobre as características do ambiente de trabalho e a rotina de trabalho. Percepção de que as características comumente associadas ao TEA favoreceriam o desenvolvimento de trabalhos na área de tecnologia. Restrição de ofertas de trabalho para profissionais com TEA.
Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Desenho do trabalho (*job design*) não acessível aos profissionais com TEA	Barreiras para ingressar no mercado de trabalho. Redação imprecisa de habilidades exigidas pela organização para uma vaga de emprego. Redução no número de candidaturas de profissionais com TEA a determinadas posições pela ausência de vagas que atendam às necessidades de pessoas com TEA. Falta de flexibilidade para o profissional com TEA na duração da jornada de trabalho padrão.

Fonte: Elaborado pela autora.

Com base na descrição das barreiras específicas verificadas quanto ao desenho do trabalho (*job design*), verifica-se que a percepção dos profissionais do Grupo 1 quanto aos benefícios associados ao conhecimento prévio da rotina do trabalho e do ambiente onde as atividades serão desenvolvidas foi compartilhada por profissionais do Grupo 2, quando notaram redução na rotatividade de pessoas com TEA contratadas após inserir no processo de contratação de sua organização uma etapa para a familiarização do profissional com TEA com o ambiente de trabalho e as principais rotinas que seriam desenvolvidas pelo recém-contratado. Sugere-se, portanto, que o aprimoramento dessas práticas poderá refletir de forma positiva na redução dessas barreiras.

Adicionalmente, no que diz respeito à rotina do trabalho, barreiras associadas à ausência de flexibilidade da jornada de trabalho de pessoas com TEA foram compartilhadas tanto pelos profissionais do Grupo 1 quanto pelos profissionais do Grupo 3.

De um lado, profissionais do Grupo 1 têm a percepção de que há ausência de oferta de vagas de emprego compatíveis com a sua formação, a qual, como visto nos participantes do Grupo 1, poderá ter relação com as mais diversas áreas da ciência. De outro: (i) profissionais do Grupo 2 acabam tendo a percepção de que (i.a) profissionais com TEA seriam mais adequados para atividades na área de tecnologia, o que é apontado nesse estudo como um dos mitos associados ao TEA, e (i.b) haveria restrição de oportunidades de emprego para profissionais com TEA; e (ii) os profissionais do Grupo 3 acabam tendo a visão de que (ii.a) há restrições para o ingresso de pessoas com TEA no mercado de trabalho; (ii.b) a redação imprecisa de habilidades exigidas para uma vaga de emprego poderia afastar alguns profissionais com TEA de oportunidades de trabalho; e (ii.c) haveria a percepção de pessoas com TEA que as vagas não atenderiam às suas necessidades. Essa análise integrada das três visões poderia contribuir para o aprimoramento dos processos de desenho de vagas para acomodar a realidade descrita pelos participantes desta pesquisa, eliminando as barreiras identificadas.

Quadro 32. Visão integrada das barreiras específicas associadas à contratação.

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1 (continua)	Revelação da própria neurodiversidade durante o processo de candidatura (KHAN et al., 2022). Sensação	Processos de contratação com práticas não acessíveis aos	Ausência de retorno ao candidato com TEA ao aplicar para vagas de emprego em geral. Ausência de retorno ao candidato com TEA ao aplicar para

(continuação)	de falta de apoio e acomodações quando da candidatura a uma vaga de emprego (KHAN et al., 2022). Obtenção do emprego (GARBIN et al., 2022). Percepção de grandes dificuldades para ingressar no mercado de trabalho (CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021).	profissionais com TEA	vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência. Ausência de retorno ao candidato com TEA após informar em entrevistas a respeito dos apoios necessários. Utilização de dinâmicas de grupo como etapa eliminatória para profissionais com TEA em processos de contratação. Ausência de adaptação de processos seletivos para profissionais com TEA para a modalidade *online*. Ausência de adaptações específicas para profissionais com TEA de acordo com suas características e necessidades.
Grupo 2	Falta de conhecimento pelos profissionais de RH a respeito da neurodiversidade, estereotipagem e atitudes negativas com relação às pessoas neurodivergentes (KHAN et al., 2022). Preconceito de empregadores (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO; DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023). Processos de contratação com definição de talentos de forma mais restritiva e excessivamente baseados no desempenho do candidato em entrevistas (SZULC, 2021).	Processos de contratação voltados prioritariamente para vagas de entrada	Percepção de que haveria mais opções em vagas de entrada (como o estágio) do que em outros cargos. Limitação de oportunidades de emprego para pessoas com TEA. Ausência de plano de carreira para profissionais com TEA.
Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Processos de contratação com práticas não acessíveis aos profissionais com TEA	Ausência de retorno para profissionais com TEA que participam de processos de recrutamento e seleção. Percepção de que profissionais com TEA não têm sido contratados por organizações após se revelarem como pessoas com TEA. Constatação de que profissionais com TEA acabam aceitando vagas não compatíveis com a sua formação por não terem outras opções de emprego.

Fonte: Elaborado pela autora.

Quanto às barreiras específicas verificadas na fase da contratação, percebe-se que as percepções dos profissionais do Grupo 1 e do Grupo 3 são similares e indicam barreiras aparentes na forma como processos de contratação de pessoas com TEA têm sido conduzidos por recrutadores. Para os participantes dos Grupos 1 e 3, a revelação do diagnóstico de TEA antes ou durante as entrevistas por uma pessoa com TEA poderia impactar diretamente no desejo dos empregadores de seguir com a sua contratação.

A indicação por profissionais do Grupo 2 de que fariam a contratação de pessoas com TEA para vagas de entrada e/ou operacionais foi corroborada por meio de relatos de participantes dos Grupos 1 e 3 analisados em outros temas e subtemas desta pesquisa.

Quadro 33. Visão integrada das barreiras específicas associadas à integração (onboarding).

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1	Permanência no emprego (GARBIN et al., 2022). Restrições relacionadas ao próprio autismo, como limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017).	Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA	Ausência de disponibilização de meios de comunicação por escrito para profissionais com TEA, como aplicativos e softwares. Ausência de interação dos profissionais da organização neurotípicos com profissionais com TEA. Ausência de ambientes e momentos para socialização na organização acessíveis para profissionais com TEA.
Grupo 2	Superação de potenciais problemas atrelados à interação social (SZULC, 2021). Aplicação de práticas de RH previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias (SZULC, 2021). Dúvidas a respeito da integração dos profissionais com TEA no ambiente de trabalho como um todo, em razão de programa de emprego voltado especificamente para profissionais TEA (SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021).	Comunicação em processos de integração (*onboarding*) de profissionais com TEA	Percepção de que as diferentes formas de comunicação utilizadas por alguns profissionais com TEA poderia impactar na sua integração com os demais colegas neurotípicos.
Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Processos de integração (*onboarding*) não acessíveis aos profissionais com TEA	Percepção de empregadores de que profissionais com TEA teriam problemas associados à comunicação e à interação social, limitando oportunidades de contratação. Evidências de que as barreiras na comunicação e interação social de pessoas com TEA encontram-se nas organizações e não no profissional com TEA.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como barreiras específicas para a integração (*onboarding*) de profissionais com TEA, ao verificar os achados do presente estudo, é possível entender que, de um lado, os participantes do Grupo 2 parecem partir do pressuposto de que a integração com colegas neurotípicos é afetada de forma negativa em razão de diferentes formas de comunicação utilizadas por alguns

profissionais com TEA, ou seja, seriam dificuldades dos próprios profissionais com TEA em interagir com outros profissionais. De outro lado, no entanto, as falas dos participantes do Grupo 1 e do Grupo 3 permitem compreender que seriam barreiras encontradas nas próprias organizações que afetam essa integração, quando não fornecem os apoios necessários para que as pessoas com TEA consigam se comunicar e, consequentemente, interagir. Espera-se que, com essa visão integrada, seja possível contribuir para a mitigação das referidas barreiras.

Quadro 34. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao treinamento e desenvolvimento.

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1	Frustação de adultos com TEA com relação à abordagem proposta em alguns programas de reabilitação vocacional em linha com o modelo médico da deficiência (ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020).	Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA	Falta de treinamento para as funções que serão desempenhadas pelo profissional com TEA. Baixa adesão e participação de profissionais da organização em programas e iniciativas voltadas à neurodiversidade e pessoas com deficiência. Ausência de programas especificamente voltados para pessoas com TEA. Ausência de individualização de treinamentos para os diferentes tipos de deficiência.
Grupo 2	Existência de poucos programas de formação profissional voltados para profissionais com TEA (VERAS; CASTRO, 2021). Compreensão limitada de como apoiar da melhor forma profissionais com TEA no ambiente de trabalho (DREAVER et al., 2019). Necessidade de aprimoramento a respeito da compreensão a respeito do TEA, por meio de treinamentos nos locais de trabalho para essa finalidade (ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020).	Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA	Inexistência de programas de treinamento adaptados para profissionais com TEA em organizações nas quais ainda não há programas de neurodiversidade estruturados. Existência de treinamentos e desenvolvimento em organizações com programas de neurodiversidade com foco em habilidades socioemocionais e não técnicas. Existências de treinamentos para líderes e gestores focado em saúde emocional e não neurodiversidade propriamente dita.
Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Inexistência de programas de treinamento e desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA	Constatação de que não são regularmente implementados programas de treinamento e de desenvolvimento adaptados para profissionais com TEA. Treinamentos devem focar em habilidades técnicas e necessárias para executar as tarefas exigidas e não em corrigir ou moldar o profissional com TEA a características neurotípicas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os participantes do Grupo 1 e do Grupo 3 parecem concordar que não há programas de treinamento e desenvolvimento regularmente implementados e oferecidos a profissionais com TEA.

Quando existentes, tais treinamentos deveriam ser focados em habilidades técnicas e profissionais para evolução do profissional com TEA na organização – e não deveriam ser direcionados a "ensinar" pessoas com TEA a atuar como pessoas neurotípicas. Além disso, o formato do treinamento deve ser adaptado de acordo com as necessidades da pessoa com TEA – e não implementado de forma genérica para todas as pessoas com diferentes deficiências.

Apesar das iniciativas descritas pelos participantes dos Grupos 2 e 3 a respeito da neurodiversidade em organizações, a percepção dos participantes do Grupo 1 é que tais iniciativas nem sempre contam com a adesão dos demais profissionais neurotípicos da organização; ou que teriam temáticas especificamente voltadas para a neurodiversidade. Espera-se que, a partir da visão integrada dos programas de treinamento, as barreiras apontadas possam ser endereçadas.

Quadro 35. Visão integrada das barreiras específicas associadas ao desempenho.

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1	Permanência no emprego (GARBIN et al., 2022). Restrições relacionadas ao próprio autismo, como limitações na comunicação (LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017).	Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Ênfase em habilidades sociais (social skills) para fins de avaliação do profissional com TEA. Ausência de parâmetros para avaliação de habilidades técnicas de profissionais com TEA. Ausência de critérios objetivos e plano de carreira para profissionais com TEA.
Grupo 2	Expectativa de supervisores e colegas de trabalho, em geral, de que adultos trabalhem de forma independente no emprego (LINDSAY et al., 2019). Aplicação de práticas de RH previstas para pessoas neurotípicas aos neurodivergentes, sem as adaptações e revisões necessárias (SZULC, 2021). Oportunidades limitadas de engajamento e crescimento para profissionais neurodivergentes nas organizações (JOHNSON et al., 2020).	Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Evidências de que não haveria métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA em organização que conta com programa de neurodiversidade estruturado. Percepção de que pessoas neurodivergentes apresentam, de forma geral, um tempo maior para desenvolvimento, podendo impactar seu crescimento na organização.

(continua)

(continuação) Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Inexistência de métricas de desempenho adaptadas a profissionais com TEA	Necessidade de repensar modelos tradicionais de avaliação destinados a profissionais neurotípicos. Necessidade de se considerar que profissionais neurodivergentes e neurotípicos poderão ter curva de aprendizado distintas, podendo responder de forma distinta. Percepção de que profissionais com TEA são desligados antes que cheguem às etapas de avaliação de desempenho.

Fonte: Elaborado pela autora.

Parece haver um consenso no que diz respeito às barreiras específicas identificadas quanto às métricas de desempenho de profissionais com TEA. De forma geral, a visão integrada dos relatos dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3 sugere que, de fato, não haveria a definição de parâmetros adaptados para profissionais com TEA.

Essa evidência aponta para a necessidade indicada pelos participantes do Grupo 3 de se repensar os modelos tradicionais de avaliação de pessoas com TEA, o que poderia ser feito com base nas sugestões dos participantes do Grupo 1, com base em critérios objetivos, previsibilidade e definição de plano de carreira para profissionais com TEA.

Quadro 36. Visão integrada das barreiras específicas associadas às relações sociais e bem-estar.

Grupo analisado	**Referencial teórico para os desafios à empregabilidade de pessoas com TEA**	**Barreiras específicas identificadas na análise temática**	**Descrição das barreiras específicas identificadas na análise temática**
Grupo 1	Frustração com aspectos sociais do trabalho e mais dificuldades em interações sociais (HURLBUTT; CHALMERS, 2004). Dificuldades associadas ao ambiente físico do trabalho, inclusive quanto ao trabalho remoto (SZULC, 2022). Estresse na mudança de rotina (SZULC, 2022).	Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Situações no trabalho que levam a episódios de *meltdown* de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam ao burnout no TEA (*autistic burnout*) de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam a episódios de inércia (*inertia*) de profissionais com TEA. Situações no trabalho que levam a episódios de *shutdown* de profissionais com TEA. Sensação de falta de compreensão de gestores e demais colegas neurotípicos em situações de *meltdown*, *burnout* no TEA (*autistic burnout*), inércia (*inertia*) e *shutdown* de profissionais com TEA. Impressão de profissionais neurotípicos e gestores de que apoios necessários para superação de barreiras na organização são forma de tratamento especial a profissionais com TEA. Sensação de pressão social dos demais colegas neurotípicos para participação em festas e confraternizações corporativas.

(continua)

(continuação)			Manifestações negativas de colegas neurotípicos e gestores em razão de diferentes formas de ser, de se manifestar e de se comunicar que alguns profissionais com TEA podem apresentar. Percepção de que programas de neurodiversidade só existiriam em organizações de grande porte, restringindo opções de emprego e carreira para profissionais com TEA. Percepção de profissionais com TEA de que precisam reiniciar carreiras constantemente por falta de acessibilidade em organizações.
Grupo 2	Existência de dúvidas quanto à capacidade dos profissionais com TEA de: (i) comportar-se de determinadas maneiras (que seriam esperadas no mundo corporativo); (ii) apresentar sensibilidade e demonstrar emoções faciais; (iii) serem capazes de se relacionar em grupos; e (iv) compreender conceitos abstratos (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021). Percepção dos colegas neurotípicos de que haveria um tratamento especial às pessoas com TEA no ambiente de trabalho, em organização com programa de emprego voltado para pessoas com TEA (SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021).	Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Percepção de que as diferentes formas de reação a estímulos sociais de alguns profissionais com TEA poderia impactar no seu bem-estar na organização
Grupo 3	Aplicação de práticas tradicionais de contratação (SPECIALISTERNE, 2024).	Relações sociais e sensação de bem-estar no ambiente de trabalho prejudicadas por barreiras existentes em organizações	Barreiras associadas à falta de compreensão de aspectos distintos de comunicação e interação social que algumas pessoas com TEA poderão ter. Barreiras associadas à configuração do ambiente físico do trabalho, dependendo das características de cada pessoa com TEA.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os achados relacionados às barreiras associadas às relações sociais e bem-estar na organização parecem ser os mais distintos entre si, quando comparadas as visões dos participantes dos Grupos 1, 2 e 3. Possivelmente, tal constatação decorre do fato de que: (i) são as próprias pessoas com TEA que acabam por ter os sentimentos associados à ausência de bem-estar, de modo que os relatos foram mais intensos e recorrentes entre os participantes do Grupo 1; e (ii) esses sentimentos poderão ser um reflexo da soma das consequências negativas

percebidas pela pessoa com TEA a respeito de todas as demais barreiras para a sua empregabilidade.

Diante disso, notam-se relatos reiterados de *burnout* no TEA (*autistic burnout*), *meltdown*, inércia (*inertia*) e *shutdown* por diferentes participantes do Grupo 1 quando questionados a respeito do seu bem-estar e de suas relações sociais em organizações.

Ademais, as entrevistas com os participantes do Grupo 1 também revelam a pressão que os profissionais com TEA acabam sentindo de outros colegas para participar de eventos corporativos não adaptados e de comentários negativos que recebem por apresentarem formas de comunicação e de agir distintas do padrão neurotípico.

Os participantes dos Grupos 2 e 3 acabam por reconhecer a existência de barreiras relacionadas aos aspectos distintos de comunicação e interação social que pessoas com TEA poderão ter, em comparação a outros profissionais neurotípicos. Contudo, sugere-se que se aprofundem nos impactos negativos para as vidas pessoal e profissional de pessoas com TEA e na sua saúde mental para que possam endereçar tais barreiras mais assertivamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão de pesquisa proposta para o presente estudo foi “Quais são os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais (Grupo 1), dos profissionais de RH e gestão de pessoas (Grupo 2) e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho (Grupo 3)?”. Para tanto, foi definido como objetivo geral entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos profissionais do Grupo 1, dos profissionais do Grupo 2 e dos profissionais do Grupo 3. Esse objetivo geral foi atendido por meio dos resultados obtidos com esta pesquisa.

Adicionalmente, os objetivos específicos propostos foram os seguintes: (i) para o Grupo 1: (i.a) entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais do Grupo 1; e (i.b) identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais do Grupo 1 a respeito de sua empregabilidade; (ii) para o Grupo 2: (ii.a) analisar como são estruturados os programas de neurodiversidade voltados para profissionais com TEA em organizações, na visão dos profissionais do Grupo 2; e (ii.b) entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais do Grupo 2; e (iii) para o Grupo 3: (iii.a) analisar como são estruturados os programas de capacitação de profissionais

com TEA para o mercado de trabalho, na visão dos profissionais do Grupo 3; e (iii.b) entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais do Grupo 3.

Por meio da análise temática realizada, todos os objetivos específicos estabelecidos foram respondidos, com a definição de subtemas e temas distribuídos entre os Grupos 1, 2 e 3. A estrutura proposta para a presente pesquisa, portanto, contribuiu para a definição de estratégias para a criação de apoios e projetos de acessibilidade para a força de trabalho neurodivergente, em linha com o disposto na LBI.

Segundo a visão integrada dos desafios à empregabilidade enfrentados por profissionais com TEA proposta para a presente pesquisa e desenhada de acordo com os conceitos propostos pelo modelo social da deficiência e na LBI, constatou-se que há barreiras macro e barreiras específicas que puderam ser identificadas mediante a análise dos relatos dos profissionais do Grupo 1; dos profissionais do Grupo 2; e dos profissionais do Grupo 3.

As barreiras macro mapeadas a partir das entrevistas realizadas com os profissionais do Grupo 1 estão associadas ao diagnóstico do TEA, em razão do desconhecimento dos próprios indivíduos ao se descobrirem como pessoas com TEA e quando da relação com o ambiente onde vivem e atuam (que, em regra, não está adaptado) e com as pessoas neurotípicas com as quais convivem (que, em sua maioria, desconhecem a respeito do TEA). Neste contexto, revelar ou não revelar ser uma pessoa neurodivergente pode ter consequências para esses profissionais no mercado de trabalho, que, em geral, são vistas como negativas para a sua carreira. Sugere-se o aprofundamento do tema em pesquisas futuras. A transição para a vida adulta também pode representar desafios, considerando que as pessoas com TEA passarão a conviver cada vez mais com pessoas fora do seu núcleo familiar e a receber cobranças relacionadas ao desempenho no trabalho, entre outras. Outra barreira macro encontrada por meio da análise temática e que poderá ser explorada futuramente em novos estudos tem relação com a avaliação de profissionais do Grupo 1 de que os altos custos para a obtenção do laudo de TEA trariam consequências negativas para o seu ingresso no mercado de trabalho.

Para os profissionais do Grupo 2, as barreiras macro têm relação com as características das áreas de RH e de gestão de pessoas de organizações nos processos de desenvolvimento de programas de neurodiversidade. Em um primeiro momento, o desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA pelos profissionais das referidas áreas e a falta de padrões estabelecidos no mercado para os programas de neurodiversidade parecem impactar a decisão pela criação e a implementação de tais programas em organizações. Pesquisas futuras que

tenham como objetivo a definição de tais padrões poderão contribuir para a criação de programas de neurodiversidade em um maior número de organizações. Em um segundo momento, a partir da decisão de que programas de neurodiversidade serão implementados, foram relatadas barreiras para o mapeamento de profissionais neurodivergentes que trabalham na organização e, consequentemente, acesso a dados de saúde e à avaliação biopsicossocial, como prevista na LBI, para constatação de apoios necessários e para a adaptação de outras políticas de recursos humanos e gestão de pessoas a pessoas neurodivergentes.

Os profissionais do Grupo 3, por sua vez, também acreditam que o desconhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA em organizações seja uma barreira macro para a empregabilidade de profissionais com TEA. Ainda, para o grupo, a maturidade da área de gestão de pessoas e dos programas de compliance e de inclusão e diversidade e o orçamento destinado para tais programas poderiam afetar o processo de implementação de programas dessa natureza. Ao se constatar que, muitas vezes, os programas de neurodiversidade são implementados a partir de diretrizes de matrizes em multinacionais, presume-se que organizações de médio e pequeno porte poderiam ter mais barreiras para conseguir desenvolver programas de neurodiversidade ou mesmo de diversidade e inclusão. Trata-se de um aspecto que poderá ser discutido em pesquisas futuras. Paralelamente, ainda não há uma percepção unânime do mercado de trabalho de que a neurodiversidade poderia estar relacionada à inovação, criando mais uma barreira macro para a contratação de profissionais com TEA.

No que diz respeito às barreiras específicas para a contratação de pessoas com TEA, segundo as áreas de RH propostas por Doyle e McDougall (2022), apesar de terem sido identificados alguns estudos prévios nacionais e internacionais nas buscas prévias conduzidas para fins desta pesquisa, os Quadros 31 a 36 não deixam dúvidas quanto aos novos achados identificados a partir da análise temática conduzida a partir das entrevistas com participantes dos Grupos 1, 2 e 3.

Dentre eles, destacam-se, para o Grupo 1 (i.a) a percepção de profissionais com TEA a respeito da necessidade de se conhecer mais a respeito do ambiente e da rotina de trabalho previamente à contratação; (i.b) os impactos associados à ausência de flexibilidade da jornada padrão de trabalho em organizações para que a pessoa com TEA consiga conciliar suas consultas médicas e estudos, o que poderia impedir uma pessoa com TEA de concorrer a determinadas vagas; (i.c) a definição de critérios objetivos e de previsibilidade nas avaliações de desempenho, com a flexibilização de métricas associadas a aspectos de socialização e habilidades sociais; (i.d) a percepção de profissionais com TEA de que, ao se revelarem como

pessoas com TEA em redes sociais e processos seletivos, teriam deixado de ser considerados para oportunidades de emprego por recrutadores; e (i.e) situações de burnout no TEA (*autistic burnout*), *meltdown*, inércia (*inertia*) *e shutdown* no trabalho, que poderão contribuir para as recentes pesquisas envolvendo essas temáticas.

Por meio dos relatos do Grupo 2, constata-se que (i.a) há mais vagas de estágio, de entrada ou operacionais disponíveis para profissionais com TEA; e (i.b) não há plano de carreira desenhado para profissionais com TEA.

Quanto ao Grupo 3, as contribuições envolveriam (i.a) a redação imprecisa de habilidades exigidas pela organização para uma vaga de emprego; (i.b) a necessidade de se considerar que profissionais neurodivergentes e neurotípicos poderão ter curva de aprendizado distintas, podendo responder de forma distinta; e (i.c) a percepção de que profissionais com TEA são desligados antes mesmo que cheguem às etapas de avaliação de desempenho.

Todos os achados indicados como barreiras específicas dos Grupos 1, 2 e 3 poderão ser aprofundados em estudos que venham a ser desenvolvidos oportunamente.

Com base no levantamento de literatura realizado previamente a esta pesquisa, não foram encontrados estudos nacionais ou internacionais que: (i) abordam os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA de forma integrada; (ii) apontam as barreiras macro e específicas sugeridas a partir do modelo social da deficiência e das disposições da LBI na área de estudos organizacionais e organizadas como proposto no presente trabalho; (iii) tratam das iniciativas tomadas por profissionais com TEA para tentar mitigar a ausência de apoios para acessibilidade; (iv) apresentam como são estruturados programas de neurodiversidade por organizações; e (v) descrevem como atuam as entidades e instituições sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoa com TEA e organizações a respeito da neurodiversidade.

Trata-se, portanto, de novidade nos estudos a respeito de profissionais com TEA em organizações, vez que foi apurada uma tendência das demais pesquisas de: (i) focar em um ou outro grupo de participantes de forma individualizada; (ii) não discutir a estruturação de programas de neurodiversidade; (iii) não endereçar a atuação de entidades e instituições sem fins lucrativos que trabalham com capacitação e apoio profissional de pessoas com TEA; e (iv) não apresentar com clareza os resultados obtidos de acordo com a ótica da análise proposta.

A este respeito, em razão da multidisciplinaridade da temática, que pode envolver terminologias da área da saúde e questões legais, também foi constatado que trabalhos anteriores na área de estudos organizacionais nacionais tendem a confundir: (i) alguns conceitos e aspectos relacionados ao TEA, como o histórico para a definição atual do espectro, os critérios

para diagnósticos, quais manuais nosológicos estão em vigor no Brasil, como são utilizados e quais os reflexos para a pessoa com TEA; (ii) definições legais relacionadas ao TEA e a pessoas com deficiência no país; e (iii) aspectos relacionados aos diferentes modelos da deficiência, em especial, o médico e o social. A falta de clareza acaba por reforçar, ainda que de forma não intencional, certos estereótipos associados às pessoas com TEA e acabam por não contribuir de forma efetiva para as discussões acerca da empregabilidade de profissionais com TEA.

Diante deste cenário, por meio desta pesquisa, foi realizado um trabalho inicial de: (i) esclarecimento dos principais momentos históricos para a definição do TEA; (ii) esclarecimento a respeito da utilização dos manuais DSM-V-TR e CID 10 e a identificação de critérios para definição de níveis de suporte de pessoas com TEA; (iii) mapeamento de disposições legais mais relevantes para a compreensão da temática; (iv) apresentação dos principais modelos de deficiência e como o modelo social da deficiência está relacionado à neurodiversidade; (v) indicação dos conceitos atualmente utilizados para a neurodiversidade; (vi) definição do conceito de empregabilidade; e (vii) discussão a respeito da neurodiversidade em organizações e indicação dos desafios mais comumente enfrentados por pessoas com TEA constantes da literatura.

Como contribuições para os profissionais com TEA, em primeiro lugar, foram ouvidos os relatos de 19 participantes com TEA, de diferentes locais do Brasil, gêneros e idades. Por meio de entrevistas, puderam se expressar e conseguiram compartilhar suas experiências de forma inédita em estudos organizacionais nacionais. Em segundo lugar, considerando que boa parte dos participantes do Grupo 1 recebeu o diagnóstico tardio de TEA e nos últimos anos, foi possível contribuir para o seu conhecimento a respeito do TEA a partir da construção de um panorama com as barreiras macro e específicas enfrentadas no mercado de trabalho. Em terceiro lugar, de forma inovadora, os resultados foram analisados a partir do modelo social da deficiência, deixando claro que os desafios enfrentados no mercado de trabalho pelos profissionais com TEA não são resultado de suas características ou do seu modo de agir e ser no mundo, mas que existem em função de barreiras identificadas em organizações e com relação às pessoas com as quais convivem regularmente.

Para as organizações, a primeira contribuição diz respeito ao aprimoramento do conhecimento a respeito da neurodiversidade e do TEA, diante do desconhecimento apurado nos relatos dos participantes do Grupo 2. Como segunda contribuição, foi apresentado como os profissionais com TEA de fato se sentem e percebem suas experiências no mercado de trabalho, para além dos estereótipos comumente associados ao TEA. E, a título de terceira contribuição,

foram apresentados subtemas e temas que explicam como são estruturados os programas de neurodiversidade no país, fornecendo dados relevantes para a futura construção de um modelo padrão no mercado para tais programas.

No que diz respeito às entidades e instituições sem fins lucrativos, a primeira contribuição foi identificar que há diferentes metodologias e práticas que poderão ser utilizadas para apoiar tanto organizações quanto profissionais com TEA para ingresso no mercado de trabalho. Para a segunda contribuição, destaca-se a identificação da relevância dos serviços prestados tanto para organizações quanto profissionais com TEA, em virtude do desconhecimento a respeito do TEA e da neurodiversidade no ambiente de trabalho e da ausência de parâmetros para a constituição de programas de neurodiversidade. A terceira contribuição é constatar, por meio da visão integrada dos relatos, que as entidades e instituições sem fins lucrativos poderão atuar como mediadoras e interlocutoras entre profissionais com TEA e profissionais de RH e gestão de organizações, auxiliando na mitigação de barreiras enfrentadas por pessoas com TEA, ao prestar serviços tanto às organizações quanto aos profissionais com TEA.

É indiscutível a relevância social desta pesquisa, quando se consideram as percepções dos profissionais com TEA de que não conseguem fazer parte do mercado de trabalho e que teriam que enfrentar diversas barreiras para assegurar sua empregabilidade, apesar de suas habilidades técnicas e competências. Esse cenário impacta negativamente na sensação de bem-estar e na saúde mental de pessoas com TEA, que descrevem sofrer diferentes reações às pressões no trabalho e às frustrações nas tentativas de obtenção e manutenção de empregos compatíveis às suas aspirações. Diante da importância do trabalho para a formação da identidade pessoal de um ser humano, torna-se fundamental tratar da temática proposta no presente estudo para que sejam discutidas as bases para oportunidades de carreira e desenvolvimento para profissionais com TEA com dignidade, indo além da mera "sobrevivência".

Os achados desta pesquisa estão limitados: (i) aos profissionais com TEA entrevistados, em razão da natureza qualitativa da pesquisa; e (ii) aos profissionais com TEA com nível 1 de suporte, de modo que outras barreiras poderão ser apontadas a partir de estudos similares que envolvam profissionais com TEA que apresentem nível de suporte 2 ou até mesmo nível de suporte 3.

Para o Grupo 2, os resultados deste estudo tiveram como limite o retorno de um baixo número de organizações que confirmaram interesse na participação, apesar dos esforços

reiterados para obtenção de mais participantes deste grupo. Considera-se que o desconhecimento a respeito da neurodiversidade e a novidade da temática podem ter influenciado na avaliação das organizações do convite para as entrevistas. Futuras pesquisas poderão ter foco apenas em organizações, com a intenção de aprofundar os desafios que enfrentam para criar e manter programas de neurodiversidade.

Quanto ao Grupo 3, da mesma forma como o Grupo 2, em que pese ter sido grande esforço para o mapeamento de diversas entidades e instituições sem fins lucrativos em todo o país, houve baixa adesão de participantes deste grupo na pesquisa. Tal fato pode decorrer da sensibilidade de informações envolvendo pessoas com deficiência e pessoas com TEA. De todo modo, em virtude da ausência de estudos organizacionais com foco nas referidas instituições, novas pesquisas poderão esclarecer outros aspectos importantes de sua atuação junto a profissionais com TEA.

REFERÊNCIAS

ADAPTE. Adapte, 2024. Adapte. Disponível em: https://www.adapte.com.vc/. Acesso em: 25 maio de 2024.

AFAPA. AFAPA, 2024. Quem somos. Disponível em: https://afapa.com.br/quem-somos. Acesso em: 05 maio 2024.

AGÊNCIA IBGE. IBGE, 2023. *Mais de 70% das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas inovaram em 2021*. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35875-mais-de-70-das-empresas-industriais-com-100-ou-mais-pessoas-ocupadas-inovaram-em-2021. Acesso em: 15 jun. 2024.

ALBRIGHT, Jordan; KULOKA, Sydney; SCARPA, Angela. A qualitative analysis of employer perspectives on the hiring and employment of adults with autism spectrum disorder. *Journal of Vocational Rehabilitation*, v. 53, p. 167–182, 2020.

ALVARES, Gail A; et al. The misnomer of 'high functioning autism': Intelligence is an imprecise predictor of functional abilities at diagnosis. *Autism*, 2020, DOI: 10.1177/1362361319852831.

ALVAREZ-LÓPEZ, Eva M et al. Autismo: mitos y realidades científicas. *Rev Med UV*, p. 36-41, 2014.

ANDERSON, Anastasia H.; STEPHENSON, Jennifer; CARTER, Mark. A qualitative study of the transition to employment of former university students on the autism spectrum from Australia and New Zealand. *International Journal of Developmental Disabilities*, v. 0, n. 0, p. 1-10, 2022.

ANTSHEL, Kevin M.; RUSSO, Natalie. Autism Spectrum Disorders and ADHD: overlapping phenomenology, diagnostic issues, and treatment considerations. *Current Psychiatry Reports*, p. 21-34, 2019.

ARA, Zinat et al. *Collaborative Job Seeking for People with Autism: Challenges and Design Opportunities*. *arXiv:2403.01715*, Cornell University, 2024. https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.01715.

ARAÚJO, Adriana Silvino; DOURADO, Jakson Luis Galdino. Transtorno do espectro autista (TEA) e a empregabilidade: entre a formação e a inclusão. *Perspectivas em Diálogo*, Naviraí, v. 09, n. 20, p. 291-306, 2022.

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. *Referência rápida aos critérios diagnósticos do DSM-5-TR*. Porto Alegre: Artmed, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR (ABMES). ABMES, 2024. *Graduação aumenta em 75% as chances de empregabilidade após conclusão do curso*. Disponível em: http://www.abmes.org.br/noticias/detalhe/5006/graduacao-aumenta-em-75-as-chances-de-empregabilidade-apos-conclusao-do-curso. Acesso em: 08 jun. 2024.

ATIP. ATIP, 2023. *Oportunidades para pessoas autistas*. Disponível em: https://www.instagram.com/atip.io/p/CyDsRg7LHcI/. Acesso em: 25 maio 2024.

AYDOS, Valéria. A (des)construção social do diagnóstico de autismo no contexto das políticas de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. *Anuário Antropológico*, v. 44, n.1, p. 93-116, 2019.

BALDWIN, Susanna; COSTLEY, Debra; WARREN, Anthony. Employment Activities and Experiences of Adults with High-Functioning Autism and Asperger's Disorder. *J Autism Dev Disord*, 2014, DOI 10.1007/s10803-014-2112-z.

BARBOSA JUNIOR, Oswaldo Ferreira; NUNES, Simone Costa. Proposta de índice de maturidade em gestão inclusiva: nova metodologia deve facilitar a comunicação com as empresas e a definição de estratégias e investimentos. *In*: VI SINGEP. *Anais do VI SINGEP.* São Paulo, 2017. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/resultado/558.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.

BASTO, Ana Teresa Oliveira da Silva; CEPELLOS, Vanessa Martines. Autismo nas organizações: percepções e ações para inclusão do ponto de vista de gestores. *Cad. EBAPE.BR*, v. 21, n. 1, p. 1-15, 2023.

BERKELL, Dianne E. Career Development for Youth with Autism. *Journal of Career Development*, v. 13, n. 4, p. 14-20, 1987.

BETTI, Alexandre Prado. Perspectivas do emprego apoiado: mudanças na forma de se pensar e conceber o acesso ao trabalho de pessoas com deficiência intelectual são necessárias e urgentes. *In:* Formação em ação. Departamento de Educação Especial AEE – Escola Inclusiva, 2017. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/1semestre2017/fa2017_escolas_especializadas_anexo3.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. [Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943]. *Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho*. Brasília, DF: Presidência da República, [1943]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. [Constituição da República Federativa do Brasil de 1988]. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. [Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990]. *Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais*. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em 18 jun. 2024.

BRASIL. [Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991]. *Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências*. Brasília, DF: Presidência da República, [1991].

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 16 maio 2023.

BRASIL. [Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998]. *Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências*. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 07 maio 2024.

BRASIL. *F80-F89 Transtornos do desenvolvimento psicológico*. Datasus: 2008. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f80_f89.htm. Acesso em: 17 jun. 2023.

BRASIL. [Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012]. *Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990*. Brasília, DF: Presidência da República, [2012]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 16 maio 2023.

BRASIL. [Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015]. *Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)*. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018]. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 03 jun. 2024.

BRASIL. [Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018]. *Reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta*. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm. Acesso em: 18 jun. 2024.

BRASIL. [Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019]. *Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos*. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13861.htm#:~:text=L13861&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%207.853,espectro%20autista%20nos%20censos%20demogr%C3%A1ficos. Acesso em: 23 fev. 2023.

BRASIL. [Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022]. *Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011*. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 18 jun. 2024.

BRASIL. [Decreto nº 11.487, de 10 de abril de 2023]. *Institui o Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania*. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Decreto/D11487.htm. Acesso em: 5 jun. 2023.

BRASIL. [Decreto nº 11.646, de 16 de agosto de 2023]. *Institui a Estratégia Nacional de Economia de Impacto e o Comitê de Economia de Impacto*. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11646.htm#art14. Acesso em: 25 maio 2024.

BRASIL. [Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 11 de janeiro de 2024]. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mps/mf-n-2-de-11-de-janeiro-de-2024-537035232. Acesso em: 03 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Definição - Transtorno do Espectro Autista (TEA) na criança.* Disponível em: https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/. Acesso em: 03 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Ministério da Saúde coordena tradução do novo Código Internacional de Doenças para a língua portuguesa*. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/julho/ministerio-da-saude-coordena-traducao-do-novo-codigo-internacional-de-doencas-para-a-lingua-portuguesa. Acesso em: 15 maio 2023.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil*. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Estudos e Pesquisas: Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 47. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Divulgação dos resultados*. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/etapas/divulgacao-dos-resultados.html. Acesso em: 20 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Avaliação biopsicossocial da deficiência*. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd/apresentacoes-em-eventos/audiencias-publicas-2019/apresentacao-liliane-cristina-bernardes-mdh. Acesso em: 17 jun. 2023.

BRASIL. Conheça o eSocial, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/esocial/pt-br/centrais-de-conteudo. Acesso em: 15 jun. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. *Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência inicia atuação durante seminário em Brasília*. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/grupo-de-trabalho-sobre-a-

avaliacao-biopsicossocial-unificada-da-deficiencia-inicia-atuacao-durante-seminario-em-brasilia. Acesso em: 5 jun. 2023.

BRASIL. Senado. *Já está no Senado projeto que apoia pessoas com deficiência no mercado de trabalho*. Brasília (DF): Planalto, 2023. Disponível em https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/04/03/ja-esta-no-senado-projeto-que-apoia-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em 01 jun. 2023.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.

BRÎNZEA, Victoria-Mihaela. Encouraging neurodiversity in the evolving workforce – the next frontier to a diverse workplace. *Scientific Bulletin – Economic Sciences*, v.18, 2019.

BRITO, Carina. Empreendedora cria startup para promover contratação de pessoas neurodivergentes. *Pequenas Empresas e Grandes Negócios*, 2023. Disponível em: https://revistapegn.globo.com/mulheres-empreendedoras/noticia/2023/08/empreendedora-cria-startup-para-promover-contratacao-de-pessoas-neurodivergentes.ghtml. Acesso em: 25 maio 2024.

BUIJSMAN, Riley; BEGEER, Sander; SCHEEREN, Anke M. 'Autistic person' or 'person with autism'? Person-first language preference in Dutch adults with autism and parents. *Autism*, n. 27, v. 3, p. 788-795, 2023.

BURGER-VELTMEIJER, Agnes E.J; MINNAERT, Alexander E.M.G; VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH, Els J. The co-occurrence of intellectual giftedness and Autism Spectrum Disorders. *Educational Research Review*, n. 6, p. 67–88, 2011.

BURY, Simon M; JELLETT, Rachel; SPOOR, Jennifer R; HEDLEY, Darren. "It defines who I am" or "It's something I have": what language do [Autistic] Australian adults [on the autism spectrum] prefer? *J Autism Dev Disord*. v. 53, n. 2, p. 677-687, 2023.

CARRERO, Justin; KRZEMINSKA, Anna E. J.; HÄRTEL, Charmine. The DXC technology work experience program: disability-inclusive recruitment and selection in action. *Journal of Management & Organization*, v. 25, p. 535–542, 2019.

CASAGRANDE, Ingrid; GALANTE, Maria Eduardo Lobosque; SILVA, Nilson Rogério da. Percepção de um indivíduo com diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – sobre ingresso e permanência no trabalho. *Cuadernos de Educación y Desarollo*, v. 16, n.2, p. 01-25, 2024.

CHAPMAN, Robert. Neurodiversity, disability, wellbeing. *In*: ROSQVIST, Hanna Bertilsdotter, STENNING, Anna, CHOWN Nick. *Neurodiversity studies*: a new critical paradigm. Londres: Routlege, 2020, p. 57-72.

CHAPMAN, Robert. Neurodiversity and the Social Ecology of Mental Functions. *Perspectives on Psychological Science*, v.16, n. 6, p. 1–13, 2021.

CHAPMAN, Roberta; BOTHA, Monique. Neurodivergence-informed therapy. *Dev Med Child Neurol*, n. 65, p. 310–317, 2023.

CHUN, Jina et al. The interplay of supports and barriers during the transition to adulthood for youth on the autism spectrum. *Disability and Rehabilitation*, DOI: 10.1080/09638288.2022.2112097.

CONCEIÇÃO, Leon Ramires da; ESCALANTE, Núbia Regina de Freitas; SILVA, Francielle Molon da. Autistas no mercado de trabalho: análise sobre as ações e práticas inclusivas. *Gest. Contemp.*, v.11, n.2, p. 203-221, 2021.

CORDELL, Alexandria T. Creating a vocational training site for individuals with autism spectrum disorder. *Intervention in School and Clinic*, n. 0, v. 0, p. 1-7, 2023.

CORREIA, Aline Monteiro et al. Características da população com Transtorno do Espectro Autista no Estado do Rio Grande do Sul. Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades (FADERS), 2024. Disponível em: https://estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202404/02060150-caracteristicas-da-populacao-com-autismo-3-edicao.pdf. Acesso em: 17 jun. 2024.

COSTA, Sônia da; SINHORETTO, Pasqualina Jacomaci. Apresentação. *In*: GARCÍA, Jesus Carlos Delgado; INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL (ITS BRASIL) (Org.). *Trabalho com apoio para pessoas com deficiência: uma proposta de política pública. Metodologia do Emprego Apoiado*. São Paulo: ITS BRASIL, 2017.

CRESWELL, John W., CRESWELL, J. David. *Projeto de pesquisa*: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

CROMPTON, Catherine J. et al. "I never realised everybody felt as happy as I do when I am around autistic people": a thematic analysis of autist adults' relationships with autistic and neurotypical friends and family. *Autism*, v. 24, n. 6, p. 1438-1448, 2020.

DI NUBILA, Heloisa Brunow Ventura; BUCHALLA, Cassia Maria. O papel das Classificações da OMS - CID e CIF nas definições de deficiência e incapacidade. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 11, n. 2, p. 324–335, 2008.

DELOITTE. Deloitte, 2024. *Maturidade em diversidade e inclusão*. Disponível em: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/human-capital/articles/maturidade-diversidade-inclusao.html. Acesso em: 18 jun. 2024.

DOYLE, Nancy. Making the invisible visible. *Occupational Health & Wellbeing*, v. 71, n. 2, p. 10-13, 2019.

DOYLE, Nancy; MCDOWALL, Almuth. Diamond in the rough? An "empty review" of research into "neurodiversity" and a road map for developing the inclusion agenda. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 2022, DOI 10.1108/EDI-06-2020-0172.

DREAVER, Jessica; THOMPSON, Craig; GIRDLER, Sonya; ADOLFSSON, Margareta; BLACK, Melissa H.; FALKMER, Marita. Success Factors Enabling Employment for Adults

on the Autism Spectrum from Employers' Perspective. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2019, https://doi.org/10.1007/s10803-019-03923-3.

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (ENSP). *Capacitismo: o que é, como combater e por que é tão importante falar sobre o tema* (2024). Disponível em https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/54855#:~:text=Considerada%20uma%20das%20mais%20recorrentes,exerc%C3%ADcio%20da%20cidadania%20dessas%20pessoas. Acesso em 31 ago 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Centers for Disease Control and Prevention. *Autism Prevalence Higher, According to Data from 11 ADDM Communities*. Estados Unidos da América: 2023. Disponível em https://www.cdc.gov/media/releases/2023/p0323-autism.html. Acesso em 31 maio 2023.

FALQUETO, Junia Maria Zandonade; HOFFMAN, Valmir Emil; FARIAS, Josivania Silva. Saturação teórica em pesquisas qualitativas: relato de uma experiência de aplicação em estudo na área de Administração. *Revista de Ciências da Administração*, v. 20, n. 52, p. 40-53, 2018.

FARIA, Clenilton Martins. Orientação profissional no contexto escolar. Disponível em: https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/8031/5726. Acesso em: 08 jun. 2024.

FARRELL-BANKS, David. Can archaeology become a positive working environment for adults with autism spectrum disorders? *Journal of Community Archaeology & Heritage*, 2018, DOI: 10.1080/20518196.2018.1477038.

FEINSTEIN, Adam. The two great pioneers. *In*: FEINSTEIN, Adam. *A History of Autism*: Conversations with the Pioneers. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011, p. 9-36.

FEINSTEIN, Adam. Definition, diagnosis, and assessment. The history of the tool. *In*: FEINSTEIN, Adam. *A History of Autism*: Conversations with the Pioneers. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011, p. 165-202.

FERNANDES, Conceição Santos; TOMAZELLIB, Jeane; GIRIANELLIC, Vania. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas. *Psicologia USP*, v. 31, p. 1-10, 2020.

FERREIRA, Shagaly. Três em cada quatro empresas no Brasil não têm área dedicada à diversidade e inclusão, diz pesquisa. *O Estado de São Paulo*, 2024. Disponível em: https://www.estadao.com.br/economia/governanca/empresas-brasil-diversidade-inclusao-pesquisa/?utm_source=linkedin:newsfeed&utm_medium=social-organic&utm_campaign=redes-sociais:062024:e&utm_content=:::&utm_term=. Acesso em: 18 jun. 2024.

FLOWER, Rebecca L.; DICKENS, Louise M.; HEDLEY, Darren Hedley. Barriers to employment: raters' perceptions of male autistic and non-autistic candidates during a simulated job interview and the impact of diagnostic disclosure. *Autism in adulthood*, v. 3, n. 4, p. 300-309, 2021.

FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno; KLAZURA, Marcos Antonio. Pessoa com deficiência entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial: concepções em disputa. *Emancipação*, v. 21, p. 1-18, 2021.

FRANÇA, Tiago Henrique. Modelo social da deficiência: uma ferramenta sociológica para a emancipação social. *Lutas Sociais*, v.17 n.31, p.59-73, 2013.

FRIGAUX, Antonie et al. Differential diagnosis on the autism spectrum: Theorizing an "Ordinary Autism". *L'Évolution Psychiatrique*, v. 86, n. 1, 2021.

GARBIN, Cléa Adas Saliba; CARNEIRO, Carolina Santos de Almeida; ARTÊNIO, Tânia Adas Saliba; GARBIN, José Isper. Autismo e os entraves no mercado de trabalho em um município de grande porte. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. 1-9, 2022.

GARCIA, Jesus Carlos Delgado; SALA, José Blanes. Uma proposta de anteprojeto de lei de política nacional de trabalho com apoio. *In*: GARCÍA, Jesus Carlos Delgado; INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL (ITS BRASIL) (Org.). *Trabalho com apoio para pessoas com deficiência: uma proposta de política pública. Metodologia do Emprego Apoiado*. São Paulo: ITS BRASIL, 2017.

GODOI, Christiane Kleinübing; MATTOS, Pedro Lincoln C. L. de. Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e evento dialógico. *In*: GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; SILVA, Anielson Barbosa da. *Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais*: paradigmas, estratégias e método. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 301-323.

GOTO, Matheus. Neurodiversidade ganha espaço dentro de grandes empresas. *Época Negócios*, 2022. Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2022/08/neurodiversidade-ganha-espaco-dentro-de-grandes-empresas.html. Acesso em 15 jun. 2024.

GREEN, Renée M.; TRAVERS, Alyssa M.; HOWE, Yamini; MCDOUGLE, Christopher J. Women and autism spectrum disorder: diagnosis and implications for treatment of adolescents and adults. *Current Psychiatry Reports*, n. 21, v. 22, p. 1-8, 2019.

HOGAN, Robert; CHAMORRO-PREMUZIC, Tomas; KAISER, Robert B. Employability and career success: bridging the gap between theory and reality. *Industrial and Organizational Psychology*, v. 6, p. 3–16, 2013.

HONSBERGER, Toby J.; BRADY, Michael P.; HONSBERGER, Christine F.; KEARNEY, Kelly B. Peer-mediated literacy-based behavioral interventions: a job coaching strategy for secondary students with ASD. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, p. 1–12, 2018.

HUGHES, Jonathan A. Does the heterogeneity of autism undermine the neurodiversity paradigm? *Bioethics*, v. 35, p. 47–60, 2021.

HULL, Laura et al. "Putting on my best normal": social camouflaging in adults with Autism Spectrum conditions. *J Autism Dev Disord*, v. 47, p. 2519–2534, 2017.

HURLBUTT, Karen; CHALMERS, Lynne. Employment and adults with Asperger syndrome. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, v. 19, n. 4, p. 215–222, 2004.

IBGE. IBGE, 2010. *As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2010*. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/fasfil.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.

IBGE. IBGE, 2014. *Nota mercadológica nº 14: emprego e remunerações*. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Sistema_de_Contas_Nacionais/Notas_Metodologicas_2010/14_emprego_e_remuneracoes.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.

IBGE. IBGE, 2022. *Desemprego e informalidade são maiores entre as pessoas com deficiência*. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34977-desemprego-e-informalidade-sao-maiores-entre-as-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 08 jun. 2024.

IBGE. IBGE, 2024. *Comissão Nacional de Classificação. Administração Pública*. Disponível em: https://concla.ibge.gov.br/documentacao/cronologia/344-concla/estrutura/2122-administracao-publica.html#:~:text=A%20categoria%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20compreende%20tamb%C3%A9m%3A,ver%20c%C3%B3digo%20203%2D8). Acesso em: 15 jun. 2024.

IBGE. IBGE, 2024. *O que é desemprego*. Disponível em https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20desemprego,basta%20n%C3%A3o%20possuir%20um%20emprego. Acesso em 15 jun. 2024.

IMPACT INVESTING AUSTRALIA. Impact Investing Australia, 2024. *Xceptional*. Disponível em: https://impactinvestingaustralia.com/portfolio/xceptional/. Acesso em 25 maio 2024.

JOHNSON, Karen R.; ENNIS-COLE, Demetria; BONHAMGREGORY, Matthew. Workplace Success strategies for employees with autism spectrum disorder: a new frontier for human resource development. *Human Resource Development Review*, v. 19, n. 2, p. 122–151, 2020.

JURGENS, Alan. *Neurodiversity in a neurotypical world*: an enactive framework for investigating autism and social institutions. *In*: ROSQVIST, Hanna Bertilsdotter, STENNING, Anna, CHOWN Nick. *Neurodiversity studies*: a new critical paradigm. Londres: Routlege, 2020, p. 73-88.

KAPLAN, B. et al. Comorbidity, co-occurrence, continuum: what's in a name? *Journal compilation. Child: care, health and development*, v. 32, n. 6, p. 723–731, 2006.

KEATING, Connor Tom; HICKMAN, Lydia; LEUNG, Joan; MONK, Ruth; MONTGOMERY, Alicia; HEATH, Hannah; SOWDEN, Sophie. Autism-related language preferences of English-speaking individuals across the globe: A mixed methods investigation. *Autism Res*., v. 16, n. 2, p. 406-428, 2023.

KHAN, Maria Hameed; GRABARSKI, Mirit, K.; ALI, Muhammad; BUCKMASTER, Stephen. Insights into Creating and Managing an Inclusive Neurodiverse Workplace for Positive Outcomes: A Multistaged Theoretical Framework. *Group & Organization Management*, v. 0, n. (0), p. 1–48, 2022.

KIDWELL, Kate E; Clancy, Rebecca L.; Fisher, Gwenith G. The devil you know versus the devil you don't: disclosure versus masking in the workplace. *Industrial and Organizational Psychology*, v. 16, p. 55-60, 2023.

KRZEMINSKA, Anna et al. The advantages and challenges of neurodiversity employment in organizations. *Journal of Management & Organization*, v. 25, p. 453–463, 2019.

KRZEMINSKA, Anna; HAWSE, Sally. *Mainstreaming Neurodiversity for an Inclusive and Sustainable Future Workforce*: Autism-Spectrum Employees. In: WOOD, Leigh; TAN, Lay Peng; BREYER, Yvonne A.; HAWSE, Sally. *Industry and higher education*. Sydney: Springer, 2020, p. 229-261.

KVALE, Steinar. Dominance Through Interviews and Dialogues. *Qualitative Inquiry*, v. 12, n.3, p. 480-500, 2006.

LAI, Meng-Chuan et al. Quantifying and exploring camouflaging in men and women with autism. *Autism*, v. 21, n. 6, p. 690-702, 2017.

LEOPOLDINO, Claudio Bezerra; COSTA COELHO, Pedro Felipe da. O processo de inclusão de autistas no mercado de trabalho. *E&G Economia e Gestão*, Belo Horizonte, v. 17, n. 48, p. 141-156, 2017.

LEOPOLDINO, Cláudio Bezerra; SILVA FILHO, José Carlos Lázaro da; NISSEL, Katrin Maria. Inclusão produtiva de pessoas com Autismo: o caso da Auticon. *RIGS revista interdisciplinar de gestão social*, v.9, n.3, p. 15-33, 2020.

LEWIS, Laura Foran; STEVENS, Kailey. The lived experience of meltdowns for autistic adults. *Autism*, v. 27, n. 6, p. 1817-1825, 2023.

LINDSAY, Sally; OSTEN, Victoria; REZAI, Mana; BUI, Sunny Bui. Disclosure and workplace accommodations for people with autism: a systematic review. *Disability and Rehabilitation*, 2019, DOI: 10.1080/09638288.2019.1635658.

LORD, Catherine; ELSABBAGH, Mayada; BAIRD, Gillian; VEENSTRA-VANDERWEELE, Jeremy. Autism spectrum disorder. *Lancet*, 2018, 10.1016/S0140-6736(18)31129-2.

LOUREIRO, Michele. Conheça as empresas líderes em diversidade no Brasil, segundo a pesquisa Ethos/Época de Inclusão. *Época Negócios*, 2024. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/empresas/noticia/2024/06/pesquisa-ethosepoca-de-inclusao-o-poder-da-diversidade-para-promover-inovacao.ghtml. Acesso em: 18 jun. 2024.

MACCALI, Nicole et al. A prática de recursos humanos para a gestão da diversidade: a inclusão de deficientes intelectuais em uma federação pública do Brasil. *Rev. Adm. Mackenzie*, n. 16, v. 2, 2015.

MARCHESINI, Adriele. Ele se descobriu autista após criar startup para neurodivergentes. *Terra*, 2022. Disponível em https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/ele-se-descobriu-autista-apos-criar-startup-para-neurodivergentes,4bdf74f16f9aa6341322991774e5deedeu3zpo67.html. Acesso em 25 maio 2024.

MARTINS, Nathália Alonso; BORGES, Grasiely Faccin. O corpo com deficiência: uma reflexão sobre os modelos de saúde. *Revista Saúde e Pesquisa*, v. 5, n. 2, p. 378-385, 2012.

MAS, Natalie Andrade. *Transtorno do espectro autista* – história da construção de um diagnóstico. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

MCMAHON, Camilla M.; LINTHICUM, Meghan; STOLL, Brianna. Developmental disability vs. neurodiverse identity: how cognitive lens affects the general public's perceptions of autism, *Disability & Society*, 2021, DOI: 10.1080/09687599.2021.1881882.

MCMAHON, Camilla M.; HENRY, Stacey; LINTHICUM, Meghan. Employability in autism spectrum disorder (ASD): job candidate's diagnostic disclosure and ASD characteristics and employer's ASD knowledge and social desirability. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, v. 27, n. 1., p. 142–157, 2021.

MELICIO, Rose Kelly Irene Santos da Conceição; VENDRAMETTO, Oduvaldo; COSTA NETO, Pedro Luiz Oliveira. Autista no mercado de trabalho: uma comparação e mensuração da capacidade de produção de pessoas autistas versus neurotípica. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 6, p. 1-11, 2021.

MELO, Eduardo Cardoso; GARROCHO, Charles Tim Batista; GUERRA, Francismara Fernandes. Inclusão pelo trabalho: participação de um indivíduo com Síndrome de Asperger em atividades de uma instituição de ensino. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 2, e44110212821, p. 1-8, 2021.

MENTRA. Mentra, 2024. *About us*. Disponível em: https://www.mentra.com/about-us. Acesso em: 25 maio 2024.

MERRIAM, Sharam B. Types of qualitative research. *In*: MERRIAM, Sharam B. *Qualitative research*. A guide to design and implementation. Revised and expanded from Qualitative Research and Case Study Application in Education. San Francisco: Jossey-Bass, 2009, p. 21-38.

MEYERS, Christopher A.; BAGNALL, Richard G. A case study of an adult learner with ASD and ADHD in an undergraduate online learning environment. *Australasian Journal of Educational Technology*, n. 31, v. 2, p. 208-219, 2015.

MICROSOFT. Microsoft, 2022. *Microsoft Brasil é uma das apoiadoras do Autismo Tech 2022*. Disponível em: https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-brasil-e-uma-das-apoiadoras-do-autismo-tech-2022/. Acesso em: 25 maio 2024.

MINARELLI, José Augusto. *Empregabilidade: como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho*. São Paulo: Editora Gente, 2010.

MIND SHIFT. Mind Shift, 2024. *About*. Disponível em: https://mindshift.works/about/. Acesso em: 25 maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Saúde, 2024. *Saiba o que é capacitismo e a importância de combatê-lo*. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro/saiba-o-que-e-capacitismo-e-a-importancia-de-combate-lo. Acesso em 09 junho 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Ministério do Trabalho e Emprego, 2024. *Caracterização das deficiências: orientações para fins de cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91*. Disponível em: https://sinicesp.org.br/inclusao/publica%C3%A7%C3%B5es/orientacoes%20_pcd_2018.pdf. Acesso em: 15 jun. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Ministério do Trabalho e Emprego, 2024. *Levantamento do eSocial aponta 545,9 mil trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho no Brasil*. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Marco/levantamento-do-esocial-aponta-545-9-mil-trabalhadores-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-no-brasil. Acesso em: 15 jun. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Ministério Público do Estado do Mato Grosso, 2023. *Por que o Brasil pode ter 6 milhões de autistas?* Disponível em: https://mpmt.mp.br/portalcao/news/1013/123113/por-que-o-brasil-pode-ter-6-milhoes-de-autistas. Acesso em: 18 jun. 2024.

MONTEIRO, Patricia; REZENDE, Ana Paula; D´ÁVILA, Juliana; FARIA, Viviane. Desafios da inclusão do indivíduo com transtorno de espectro autista (TEA) na educação profissional. *Cadernos Cajuína*, v. 7, n. 1, p. 1-25, 2022.

MONTEIRO, Renata Alves de Paula. A importância do trabalho na transição para a vida adulta. *Desidades*, n. 4, v. 2., p. 20-29, 2014.

MORIÑA, Anabel; BIAGIOTTI, Gilda. Inclusion at university, transition to employment and employability of graduates with disabilities: A systematic review. *International Journal of Educational Development*, v. 93, p. 1-8, 2022.

MURFITT, Kevin; CROSBIE, Jenny; ZAMMIT, J; WILLIAMS, G. Employer engagement in disability employment: a missing link for small to medium organizations-a review of the literature. *Journal of vocational rehabilitation*, v. 48, p. 417-431, 2018.

NALIN, Luísa Macedo et al. Impactos do diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, e382111638175, 2022.

NE'EMAN, Ari; PELLICANO, Elizabeth. Neurodiversity as Politics. *Human Development*, v. 66, p. 149–157, 2022.

NORTH, Gemma. Reconceptualising ‘reasonable adjustments’ for the successful employment of autistic women. *Disability & Society*, 2021, DOI: 10.1080/09687599.2021.1971065.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ONU, 2024. *No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, evento na ONU celebra as contribuições das pessoas com autismo para a sociedade*. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/264920-no-dia-mundial-da-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-sobre-o-autismo-evento-na-onu-celebra-contribui%C3%A7%C3%B5es-das. Acesso em: 09 jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ONU, 2021. *2021 Inclusion in the Workplace: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World*. Disponível em: https://www.un.org/en/observances/autism-day/2021. Acesso em: 30 nov. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. OMS, 2022. *Autism*. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders. Acesso em: 30 nov. 2022.

ORRÚ, Sílvia Ester. *O autismo em meninas e mulheres*: diferença e interseccionalidade. Petrópolis: Vozes, 2024.

ORTEGA, Francisco. Deficiência, autismo e neurodiversidade. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 14, n. 1, p. 67 -77, 2009.

OTT, Dana L.; RUSSO, Emily; MOELLER, Miriam. Neurodiversity, Equity, and Inclusion in MNCs. *AIB Insights*, v. 22, n. 3, 2022.

OZONOFF, Sally; DAWSON, Geraldine; MCPARTLAND, James C. *Autismo de alto desempenho*. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

PARR, Alissa D; HUNTER, Samuel T. Enhancing work outcomes of employees with autism spectrum disorder through leadership: Leadership for employees with autism spectrum disorder. *Austim*, 2014, DOI: 10.1177/1362361313483020.

PATTON, Eric. To disclose or not disclose a workplace disability to coworkers: attributions and invisible health conditions in the workplace. *Equality, Diversity and Inclusion*, v. 41, n. 8, p. 1154-1180, 2022.

PEHLIVANIDIS, Artemios et al. Lifetime co-occurring psychiatric disorders in newly diagnosed adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) or/ and autism spectrum disorder (ASD). *BMC Psychiatry*, v. 20, n. 423, p. 1-12, 2020.

PESONEN, Henri V.; TUONONEN, Tarja; FABRI, Marc; LAHDELMAA, Minja. Autistic graduates: graduate capital and employability. *Journal of Education and Work*, v. 35, n. 4, p. 374–389, 2022.

PHUNG, Jasmine et al. What I wish you know: insights on burnout, inertia, meltdown, and shutdown from autistic youth. *Frontiers in Psychology*, v. 12, 2021.

PRICE, Devon. *Autismo sem máscara: uma jornada de autodescoberta e aceitação*. Tradução Cássia Zanon. São Paulo: nVersos Editora, 2024.

PRIZANT, Barry M. *Humano à sua maneira*. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Edipro, 2023.

PUC CARREIRAS. PUC Carreiras, 2023. *O que é e como funciona uma startup?* Disponível em: https://carreiras.pucminas.br/o-que-e-e-como-funciona-uma-startup/. Acesso em: 15 jun. 2024.

RAYMAKER, Dora M. et al. "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in adulthood*, v. 2, n. 2, 2020.

RADULSKI, Elizabeth M. Conceptualising Autistic Masking, Camouflaging, and Neurotypical Privilege: Towards a Minority Group Model of Neurodiversity. *Human Development*, n. 66, p. 113–127, 2022.

REGO, Raquel; ZÓZIMO, Joana; CORREIA, Maria João. Voluntariado em Portugal: do trabalho invisível à validação de competências. *Sociologia, Problemas e Práticas*, n. 83, 2017, p. 75-97. DOI:10.7458/SPP2017836498.

RIO GRANDE DO SUL. *CID-11 já está em vigor*. Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS): 2023. Disponível em: https://cremers.org.br/cid-11-já-esta-em-vigor/. Acesso em: 16 maio 2023.

ROCHA, Vitória Pataro et al. Diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista e seus impactos sociais e clínicos. *Brazilian Journal of Health Review*. Curitiba, v. 6, n. 2, p. 6962-6970, 2023.

RODRIGUES, Caroline Kurowski. Percepção do autista e sua inclusão nas organizações: "Nada sobre nós, sem nós". 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24102023-154930/. Acesso em: 17 jun. 2024.

ROMUALDEZ, Anna Melissa; WALKER, Zachary; REMINGTON, Anna. Autistic adults' experiences of diagnostic disclosure in the workplace: decision-making and factors associated with outcomes. *Autism & Developmental Language Impairments*, v. 6, p. 1-12, 2021.

RONZANI, Letícia Domingos; LIN, Jaime; NETTO, Brunna Bittencourt; DA COSTA, Maiara de Aguiar; DE REZENDE, Victória Linden; GONÇALVES, Cinara Ludvig. Comorbidades psiquiátricas no transtorno de espectro autista: um artigo de revisão. *Bol Curso Med UFSC*, v. 7, n. 3, p. 47-54, 2021.

ROSQVIST, Hanna Bertilsdotter; STENNING, Anna; CHOWN Nick. *Introduction*. *In:* ROSQVIST, Hanna Bertilsdotter; STENNING, Anna; CHOWN Nick. *Neurodiversity studies*: a new critical paradigm. Londres: Routlege, 2020, p. 1-11.

SADZINSKI JUNIOR, Anastácio; WAYSZCEYK, Sheila; WUO, Andrea Soares. Neurodiversidade: levantamento das produções nacionais. *Revista Eletrônica Humanitaris*, v. 2, n. 02, p. 156-166, 2020.

SARAIVA, Maria Laura. IBM anuncia a criação do Grupo de Afinidade da Neurodiversidade. *Forbes*, 2021. Disponível em: https://forbes.com.br/carreira/2021/04/ibm-anuncia-programa-para-dobrar-numero-de-colaboradores-autistas/. Acesso em: 15 jun. 2024.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Atualizações semânticas na inclusão de pessoas: Deficiência mental ou intelectual? Doença ou transtorno mental? *Revista Nacional de Reabilitação*, ano IX, n. 43, p.9-10, 2005.

SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). Lei nº 17.645, de 07 de março de 2023. [Institui a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência e dá outras providências]. Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2023/lei-17645-07.03.2023.html. Acesso em 01 jun. 2023.

SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). Lei nº 17.669, de 06 de abril de 2023. [Dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o Transtorno do Espectro Autista – TEA]. Disponível em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2023/lei-17669-06.04.2023.html. Acesso em 17 jun. 2023.

SCOTT, Melissa; MILBOURN, Ben; FALKMER, Marita; BLACK, Melissa; BÖLTE, Sven; HALLADAY, Alycia; LERNER, Matthew; TAYLOR, Julie Lounds; GIRDLER, Sonya. Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review. *Autism*, 2018, DOI: 10.1177/1362361318787789.

SIMÕES, Paula. Empresas criam programas para contratar profissionais neurodiversos. Você RH, 2023. Disponível em: https://vocerh.abril.com.br/diversidade/empresas-criam-programas-para-contratar-profissionais-neurodiversos. Acesso em: 15 jun. 2024.

SKIBELL, Arianna. More people with autism are getting training for technology jobs. *Tech Directions*, v. 79, n. 5, 2017.

SOARES, André Gonçalves Vasconcelos Soares et al. Revisão de escopo: as implicações do diagnóstico tardio do TEA em mulheres. *Rev Neurocienc*, v. 31, p. 1-37, 2023.

SPECIALISTERNE. Specialisterne, 2024. *O que é a Specialisterne*. Disponível em: https://specialisternebrasil.com/o-que-e-a-specialisterne/. Acesso em: 05 maio 2024.

SPOOR, Jennifer R; BURY, Simon M; HEDLEY, Darren. Non-autistic employees' perspectives on the implementation of an autism employment programme. *Autism*, v. 25, n. 8, p. 2177–2188, 2021.

SZULC, Joanna Maria. AMO model for neuro-inclusive remote workplace. *Personnel Review*, v. 51, n. 8, p. 1867-1882, 2022.

SZULC, Joanna Maria; DAVIES, Julie; TOMCZAK, Michaeł T.; MCGREGOR, Frances-Louise. AMO perspectives on the well-being of neurodivergent human capital. *Employee Relations: The International Journal*, v. 43, n. 4, p. 858-872, 2021.

TABOAS, Amanda; DOEPKE, Karla; ZIMMERMAN, Corinne. Preferences for identity-first versus person-first language in a US sample of autism stakeholders. *Autism*. v. 27, n. 2, p. 565-570, 2023.

TAMANAHA, Ana Carina; PERISSINOTO, Jacy; CHIARI, Brasilia Maria. Uma breve revisão histórica sobre a construção dos conceitos do Autismo Infantil e da síndrome de Asperger, *Rev Soc Bras Fonoaudiol*. n.13, v. 3, p. 296-299, 2008.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TCU, 2024. *Governança Pública. Gestão de riscos: glossário*. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/gestao-de-riscos/glossario.htm. Acesso em: 30 maio 2024.

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM. University of Birmingham, 2024. Co-occurrence. Disponível em: https://www.birmingham.ac.uk/schools/education/departments/disability-inclusion-special-needs/resources/understanding-neurodivergence/co-occurence. Acesso em: 17 jun. 2024.

VASCONCELOS, Isabella Francisca Freitas Gouveia de et al. Inovação tecnológica radical e mudança organizacional: a institucionalização de organizações resilientes e formas de trabalho mais substantivas. *Cad. EBAPE.BR*, v. 17, n. 4, 2019.

VERAS, Paulo Roberto Miranda; CASTRO, Raimundo Márcio Mota de. Acesso de pessoas com autismo no mercado de trabalho. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.10, p. 95945-95965, 2021.

VAN DER PUTTEN et al. (2024). Is camouflaging unique for autism? A comparison of camouflaging between adults with autism and ADHD. *Autism Research*, p. 1–12, 2024.

VILARINHO-REZENDE, Daniela; FLEITH, Denise de Souza; ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano. Desafios no diagnóstico de dupla excepcionalidade: um estudo de caso. *Revista de Psicología*, v. 34, n. 1, p. 61-84, 2016.

VINCENT, Jonathan. Employability for UK University Students and Graduates on the Autism Spectrum: Mobilities and Materialities. *Scandinavian Journal of Disability Research*, n. 22, v. 1, p. 12–24, 2020.

WALKOWIAK, Emmanuelle. Neurodiversity of the workforce and digital transformation: The case of inclusion of autistic workers at the workplace. *Technological Forecasting and Social Change*, n.168, p. 1-11, 2021.

WEBER, Clara; KRIEGAR, Beate; HÄNE, Eunji; YARKER, Joanna; MCDOWALL, Almuth. Physical workplace adjustments to support neurodivergent workers: A systematic review, *Applied Psychology*, 2022, DOI: 10.1111/apps.12431.

WISETECH GLOBAL. Wistech Global, 2022. *Promovendo mudanças para a comunidade neurodiversa*. Disponível em: https://www.wisetechglobal.com/pt-br/news/driving-change-for-the-neurodiverse-community/. Acesso em: 25 maio 2024.

APÊNDICE I

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PROFISSIONAIS COM TEA

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa "**Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**", desenvolvida pela Mestranda Débora Cunha Romanov (assistente de pesquisa), sob orientação da pesquisadora responsável Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro, e aprovada pelo CEP/UPM sob o CAAE nº 73802023.2.0000.0084.

Esta pesquisa pretende entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais com TEA, dos profissionais de RH e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho.

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de que o número de pessoas diagnosticadas com TEA, inclusive já na idade adulta, tem aumentado nos últimos anos. A temática da neurodiversidade no ambiente de trabalho, no entanto, ainda é desconhecida por muitas organizações. No que diz respeito a trabalhos acadêmicos prévios, verificamos que há predominância de estudos teóricos a respeito da empregabilidade de profissionais com TEA e a ausência de uma visão estruturada e integrada a respeito tema, que é o que pretendemos com a pesquisa.

Caso decida participar e desde que você tenha mais que 18 (dezoito) anos, você deverá realizar uma entrevista com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov, que terá cerca de 14 (quatorze) questões e poderá ser gravada em áudio e/ou em vídeo, mediante sua expressa autorização (conforme campos no item "Autorizações Específicas" abaixo). A expectativa é que a conversa dure entre 20 (vinte) e 30 (trinta) minutos e que trate a respeito de questões relacionadas ao objetivo anteriormente mencionado.

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Durante sua participação na entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é equivalente àqueles encontrados na vida cotidiana. No entanto, você poderá sentir cansaço ao participar da entrevista ou constrangimento ao se confrontar com alguma questão sensível e/ou que exponha alguma fragilidade sua ou da organização onde você trabalhou ou trabalha. Também poderão ocorrer oscilações de comportamento e emoções durante a entrevista e há a possibilidade de você sentir algum desconforto ou incômodo com alguma lembrança relacionada a fatos comentados durante sua entrevista.

Em razão disso, para as questões e/ou temas a respeito dos quais você se sinta de alguma forma constrangido, exposto ou não tenha conhecimento a respeito, você poderá não responder ou solicitar a interrupção da entrevista a qualquer momento e sem qualquer prejuízo. Ainda, caso haja algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência imediata e *a posteriori* gratuita que será prestada entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov.

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov nos contatos informados abaixo. No caso de danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, você terá direito à indenização nos termos da legislação.

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela assisstente de pesquisa Débora Cunha Romanov em local seguro e por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

Essa pesquisa poderá ser realizada presencialmente em local definido por você, ou, se preferir e se sentir mais confortável, de forma *online*, por meio de plataformas como o Teams ou Google Meet, ou por meio de videochamada do WhatsApp. Caso seja realizada de forma presencial, se você tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa (como transporte), os custos serão assumidos pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov e reembolsados a você.

Caso haja qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um “Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: cep@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.

Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Disponibilização do TCLE

Este documento foi emitido eletronicamente e disponibilizado a você por e-mail e/ou por WhatsApp, conforme sua preferência, pela assistente de Débora Cunha Romanov, já com as assinaturas e rubricas da pesquisadora responsável e da assistente de pesquisa.

Devolutivas

Nos termos da legislação vigente, você também terá o direito de receber a sua via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito desta pesquisa, que poderá ser fornecida a você por e-mail ou por WhatsApp, a menos que você opte por outro tipo de encaminhamento ou que você expresse não querer receber qualquer devolutiva. Caso deseje receber a devolutiva e que tal devolutiva seja feita somente por e-mail ou por WhatsApp, solicitamos, por favor, que informe expressamente abaixo o seu desejo e insira o seu endereço de e-mail e o seu número de WhatsApp no espaço indicado:

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE

☐ Desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por e-mail. Para tal finalidade, informo o meu e-mail a seguir: _____

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por WhatsApp. Para tal finalidade, informo o meu número de WhatsApp a seguir: _____

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada de outra forma, que não seja o e-mail ou o WhatsApp. Para tal finalidade, informo a seguir a forma que gostaria de receber: _____☐ **Não** desejo receber a minha via do presente TCLE

☐ **Não** desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada”

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)", e autorizo a divulgação dasinformações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

São Paulo, xxxxxx

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Nome do Participante da pesquisa_____

Assinatura do Participante da pesquisa_____

E-mail do Participante da pesquisa _____

WhatsApp do Participante da pesquisa _____

Autorizações Específicas: Pedimos, por favor, que assinale nos campos abaixo se você autoriza ou **não** autoriza a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista para fins da nossa pesquisa:

☐ Autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e a transcrição da entrevista

☐ **Não** autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista

Declaração da pesquisadora responsável e da assistente de pesquisa

A pesquisadora responsável e a assistente de pesquisa do estudo Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), declaram que assumem a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, que deverá ter mais do que 18 (dezoito) anos, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaramos ainda estarmos cientes que na inobservância do compromisso ora assumido estaremos infringindo as normas federais de ética, que regulamentam as pesquisas envolvendo o ser humano.

São Paulo, (data).

Nome da pesquisadora responsável: Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro
Assinatura da pesquisadora responsável:
Nome da assistente de pesquisa: Débora Cunha Romanov
Assinatura da assistente de pesquisa:
Telefone: +55 11 98886-8228
e-mails: darcy.hanashiro@mackenzie.br e debora.romanov@mackenzista.com.br
Endereço Institucional: Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo, São Paulo - SP, Brasil

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

APÊNDICE II

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
ORGANIZAÇÕES (PROFISSIONAIS DE RH)

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa "**Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**", desenvolvida pela Mestranda Débora Cunha Romanov (assistente de pesquisa), sob orientação da pesquisadora responsável Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro, e aprovada pelo CEP/UPM sob o CAAE nº 73802023.2.0000.0084.

Esta pesquisa pretende entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais com TEA, dos profissionais de RH e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho.

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de que o número de pessoas diagnosticadas com TEA, inclusive já na idade adulta, tem aumentado nos últimos anos. A temática da neurodiversidade no ambiente de trabalho, no entanto, ainda é desconhecida por muitas organizações. No que diz respeito a trabalhos acadêmicos prévios, verificamos que há predominância de estudos teóricos a respeito da empregabilidade de profissionais com TEA e a ausência de uma visão estruturada e integrada a respeito tema, que é o que pretendemos com a pesquisa.

Caso decida participar e desde que você tenha mais que 18 (dezoito) anos, você deverá realizar de uma entrevista com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov, que terá cerca de 10 (dez) questões e poderá ser gravada em áudio e/ou em vídeo, mediante sua expressa autorização (conforme campos no item "Autorizações Específicas" abaixo). A expectativa é que a conversa dure entre 20 (vinte) e 30 (trinta) minutos e que trate a respeito de questões relacionadas ao objetivo anteriormente mencionado.

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Durante sua participação na entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é equivalente àqueles encontrados na vida cotidiana, e poderá envolver cansaço ao participar da entrevista, constrangimento ao se confrontar com alguma questão sensível e/ou que exponha alguma fragilidade sua ou da organização onde você trabalhou ou trabalha.

Em razão disso, para as questões e/ou temas a respeito dos quais você se sinta de alguma forma constrangido, exposto ou não tenha conhecimento a respeito, você poderá não responder ou solicitar a interrupção da entrevista a qualquer momento e sem qualquer prejuízo. Ainda, caso haja algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência imediata e *a posteriori* gratuita que será prestada entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov.

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov nos contatos informados abaixo. No caso de danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, você terá direito à indenização nos termos da legislação.

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov em local seguro e por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

Essa pesquisa poderá ser realizada presencialmente em local definido por você, ou, se preferir e se sentir mais confortável, de forma *online*, por meio de plataformas como o Teams ou Google Meet, ou por meio de videochamada do WhatsApp. Caso seja realizada de forma presencial, se você tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa (como transporte), os custos serão assumidas pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov e reembolsados a você.

Caso haja qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um "Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: cep@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.

Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Disponibilização do TCLE

Este documento foi emitido eletronicamente e disponibilizado a você por e-mail pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov.

Devolutivas

Nos termos da legislação vigente, você também terá o direito de receber a sua via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito desta pesquisa, que poderá ser fornecida a você por e-mail ou por WhatsApp, a menos que você opte por outro tipo de encaminhamento ou que você expresse não querer receber qualquer devolutiva. Caso deseje receber a devolutiva e que tal devolutiva seja feita somente por e-mail ou por WhatsApp, solicitamos, por favor, que informe expressamente abaixo o seu desejo e insira o seu endereço de e-mail e o seu número de WhatsApp no espaço indicado:

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE

☐ Desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por e-mail. Para tal finalidade, informo o meu e-mail a seguir: _____

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por WhatsApp. Para tal finalidade, informo o meu número de WhatsApp a seguir: _____

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada de outra forma, que não seja o e-mail ou o WhatsApp. Para tal finalidade, informo a seguir a forma que gostaria de receber: _____

☐ **Não** desejo receber a minha via do presente TCLE

☐ **Não** desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada”

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)", e autorizo a divulgação dasinformações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

São Paulo, xxxxxx

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Nome do Participante da pesquisa

_____

Assinatura do Participante da pesquisa_____

E-mail do Participante da pesquisa _____

WhatsApp do Participante da pesquisa _____

Autorizações Específicas: Pedimos, por favor, que assinale nos campos abaixo se você autoriza ou **não** autoriza a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista para fins da nossa pesquisa:

☐ Autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e a transcrição da entrevista

☐ **Não** autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista

Declaração da pesquisadora responsável e do assistente de pesquisa

A pesquisadora responsável e a assistente de pesquisa do estudo Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), declaram que assumem a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, que deverá ter mais do que 18 (dezoito) anos, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaramos ainda estarmos cientes que na inobservância do compromisso ora assumido estaremos infringindo as normas federais de ética, que regulamentam as pesquisas envolvendo o ser humano.

São Paulo, (data).

Nome da pesquisadora responsável: Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro
Assinatura da pesquisadora responsável:
Nome da assistente de pesquisa: Débora Cunha Romanov
Assinatura da assistente de pesquisa:
Telefone: +55 11 98886-8228
e-mails: darcy.hanashiro@mackenzie.br e debora.romanov@mackenzista.com.br
Endereço Institucional: Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo, São Paulo - SP, Brasil

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

APÊNDICE III

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
ORGANIZAÇÕES (PROFISSIONAIS DE ORGANIZAÇÕES QUE CAPACITAM PROFISSIONAIS COM TEA)

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa "**Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**", desenvolvida pela Mestranda Débora Cunha Romanov (assistente de pesquisa), sob orientação da pesquisadora responsável Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro, e aprovada pelo CEP/UPM sob o CAAE nº 73802023.2.0000.0084.

Esta pesquisa pretende entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais com TEA, dos profissionais de RH e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho.

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de que o número de pessoas diagnosticadas com TEA, inclusive já na idade adulta, tem aumentado nos últimos anos. A temática da neurodiversidade no ambiente de trabalho, no entanto, ainda é desconhecida por muitas organizações. No que diz respeito a trabalhos acadêmicos prévios, verificamos que há predominância de estudos teóricos a respeito da empregabilidade de profissionais com TEA e a ausência de uma visão estruturada e integrada a respeito tema, que é o que pretendemos com a pesquisa.

Caso decida participar e desde que você tenha mais que 18 (dezoito) anos, você deverá realizar de uma entrevista com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov, que terá cerca de 10 (dez) questões e poderá ser gravada em áudio e/ou em vídeo, mediante sua expressa autorização (conforme campos no item "Autorizações Específicas" abaixo). A expectativa é que a conversa dure entre 20 (vinte) e 30 (trinta) minutos e que trate a respeito de questões relacionadas ao objetivo anteriormente mencionado.

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Durante sua participação na entrevista, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é equivalente àqueles encontrados na vida cotidiana, e poderá envolver cansaço ao participar da entrevista, constrangimento ao se confrontar com alguma questão sensível e/ou que exponha alguma fragilidade sua ou da organização onde você trabalhou ou trabalha.

Em razão disso, para as questões e/ou temas a respeito dos quais você se sinta de alguma forma constrangido, exposto ou não tenha conhecimento a respeito, você poderá não responder ou solicitar a interrupção da entrevista a qualquer momento e sem qualquer prejuízo. Ainda, caso haja algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência imediata e *a posteriori* gratuita que será prestada entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov.

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com a assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov nos contatos informados abaixo. No caso de danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, você terá direito à indenização nos termos da legislação.

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov em local seguro e por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

Essa pesquisa poderá ser realizada presencialmente em local definido por você, ou, se preferir e se sentir mais confortável, de forma *online*, por meio de plataformas como o Teams ou Google Meet, ou por meio de videochamada do WhatsApp. Caso seja realizada de forma presencial, se você tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa (como transporte), os custos serão assumidas pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov e reembolsados a você.

Caso haja qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um "Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: cep@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Disponibilização do TCLE

Este documento foi emitido eletronicamente e disponibilizado a você por e-mail pela assistente de pesquisa Débora Cunha Romanov.

Devolutivas

Nos termos da legislação vigente, você também terá o direito de receber a sua via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito desta pesquisa, que poderá ser fornecida a você por e-mail ou por WhatsApp, a menos que você opte por outro tipo de encaminhamento ou que você expresse não querer receber qualquer devolutiva. Caso deseje receber a devolutiva e que tal devolutiva seja feita somente por e-mail ou por WhatsApp, solicitamos, por favor, que informe expressamente abaixo o seu desejo e insira o seu endereço de e-mail e o seu número de WhatsApp no espaço indicado:

☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE
☐ Desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada
☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por e-mail. Para tal finalidade, informo o meu e-mail a seguir:_____
☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada somente por WhatsApp. Para tal finalidade, informo o meu número de WhatsApp a seguir: _____
☐ Desejo receber a minha via do presente TCLE e uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada de outra forma, que não seja o e-mail ou o WhatsApp. Para tal finalidade, informo a seguir a forma que gostaria de receber: _____
☐ **Não** desejo receber a minha via do presente TCLE
☐ **Não** desejo receber uma devolutiva a respeito da pesquisa realizada”

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)", e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

São Paulo, xxxxxx

Nome do Participante da pesquisa
_____

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

Assinatura do Participante da pesquisa_____

E-mail do Participante da pesquisa _____

WhatsApp do Participante da pesquisa _____

Autorizações Específicas: Pedimos, por favor, que assinale nos campos abaixo se você autoriza ou **não** autoriza a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista para fins da nossa pesquisa:

☐ Autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e a transcrição da entrevista

☐ **Não** autorizo a gravação (imagem e/ou voz) e transcrição da entrevista

Declaração da pesquisadora responsável e do assistente de pesquisa

A pesquisadora responsável e a assistente de pesquisa do estudo Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho: Desafios para a Empregabilidade de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), declaram que assumem a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, que deverá ter mais do que 18 (dezoito) anos, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaramos ainda estarmos cientes que na inobservância do compromisso ora assumido estaremos infringindo as normas federais de ética, que regulamentam as pesquisas envolvendo o ser humano.

São Paulo, (data).

Nome da pesquisadora responsável: Profª Drª Darcy Mitiko Mori Hanashiro
Assinatura da pesquisadora responsável:
Nome da assistente de pesquisa: Débora Cunha Romanov
Assinatura da assistente de pesquisa:
Telefone: +55 11 98886-8228
e-mails: darcy.hanashiro@mackenzie.br e debora.romanov@mackenzista.com.br
Endereço Institucional: Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo, São Paulo - SP, Brasil

_____	_____	_____
Pesquisadora responsável	Assistente de pesquisa	Participante de pesquisa

APÊNDICE IV

Roteiro para profissionais com TEA	
Objetivos específicos relacionados	**Perguntas**
Identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade.	1. Qual curso você escolheu fazer na faculdade? E o que te levou a escolher esse curso? 2. Como foi a sua experiência na faculdade? Do que você mais gostou? E do que você menos gostou? 3. Você trabalhou nos anos em que cursou a faculdade? Como foi a sua experiência? 4. Você fez cursos específicos relacionados à área em que fez a faculdade ou não? O que te levou a fazer esses cursos? 5. Você estagiou durante seus anos de estudo na faculdade? Como foi essa experiência?
Entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais com TEA (desenho do trabalho; contratação; treinamento).	6. De forma geral, como tem sido a sua experiência de emprego até o momento? 7. Como você se sente sendo uma pessoa com TEA? Como você acha que a revelação do diagnóstico impactou o seu trabalho ou as suas escolhas de carreira profissional? 8. Com relação às pessoas que trabalham com você, como é a sua equipe atualmente? Quantas pessoas estão no time? Como é trabalhar com essas pessoas? 9. Com relação ao espaço físico (ambiente) do seu trabalho, há algo que você sente que te incomoda? Poderia contar mais sobre essa experiência? 10. O que você tem feito para aprimorar seus conhecimentos naquilo que você faz? O que você aconselharia para profissionais com TEA em busca de emprego?

APÊNDICE V

Roteiro para profissionais de RH e gestão de pessoas	
Objetivos específicos relacionados	**Perguntas**
Analisar como são estruturados os programas de neurodiversidade voltados para profissionais com TEA nas organizações brasileiras, na visão dos profissionais de RH.	1. O que levou a sua organização a contratar pessoas com TEA? Como vocês fizeram? 2. Quantos profissionais com TEA já foram contratados? Quantos ainda permanecem? Qual foi a causa de saída desses profissionais da sua organização? 3. Após a contratação e a integração, a área de RH faz o acompanhamento do profissional com TEA na organização, como em avaliações de desempenho e treinamentos? Como funciona esse acompanhamento, por favor? Poderia citar algumas experiências? 4. Vocês já fizeram ações de conscientização a respeito do TEA internamente na organização? Poderia explicar como foi, por favor?
Entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais de RH (Desenho do trabalho; contratação; integração; desempenho; treinamento e desenvolvimento; relações sociais e bem-estar).	5. Qual é o seu conhecimento a respeito do TEA? 6. Poderia relatar, por favor, sua experiência com profissionais com TEA no trabalho? Como a organização enxerga as pessoas com TEA? Quais as percepções com relação a estes profissionais? 7. Quais são os principais desafios que você nota? (desenho do trabalho, contratação, integração, desempenho, treinamentos e desenvolvimento e relações sociais e bem-estar). 8. Com base na sua experiência, o que você acha que poderia ser aprimorado na organização para reduzir os desafios à empregabilidade dos profissionais com TEA?

APÊNDICE VI

Roteiro para profissionais que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado	
Objetivos específicos relacionados	**Perguntas**
Analisar como são estruturados os programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho, na visão dos profissionais de organizações que atuam para tal finalidade.	1. Poderia contar quando e como foi criado o programa de capacitação de pessoas com TEA da sua organização? 2. Essas pessoas com TEA procuram diretamente o programa de capacitação ou são encaminhadas internamente de outros núcleos de atendimento da organização? 3. E qual é o perfil dos profissionais com TEA que fazem parte do programa de capacitação da sua organização? (mulheres/homens; média de idade; segundo grau cursando ou concluído ou não; nível de suporte I, II ou III). 4. Após a capacitação e o treinamento, a organização faz o acompanhamento do profissional com TEA em seu trabalho? Como funciona esse acompanhamento, por favor? Poderia citar algumas experiências? 5. Vocês também realizam ações junto às organizações que contratam pessoas com TEA? Poderia dar exemplos dessa atuação, por favor. 6. Em geral, você nota que as organizações que tratam pessoas com TEA realizam as contratações para atendimento da Lei de Cotas ou em razão de programas de neurodiversidade que implementaram?
Entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado (Desenho do trabalho; contratação; integração; desempenho; treinamento e desenvolvimento; relações sociais e bem-estar).	7. Poderia relatar, por favor, quais são os principais desafios identificados pela organização com relação aos profissionais com TEA para a empregabilidade? (desenho do trabalho, contratação, integração, desempenho, treinamentos e desenvolvimento e relações sociais e bem-estar) 8. Poderia dar exemplos de situações que os profissionais com TEA que vocês capacitam ou as organizações que contratam profissionais com TEA tenham relatado como desafios à empregabilidade de profissionais com TEA? 9. Qual é a visão que a organização tem do TEA e dos profissionais com TEA que são capacitados? 10. Com base na experiência da sua organização, o que você acha que poderia ser aprimorado nas organizações em geral e no mercado de trabalho para reduzir os desafios à empregabilidade dos profissionais com TEA?

APÊNDICE VII

Termo de Anuência - Specialisterne

DocuSign Envelope ID: D3CDA105-098C-4F91-B94A-67738C3538D6

SPECIALISTERNE
Passion for details

Termo de Anuência

Eu, Rute Rodrigues, na qualidade de responsável pela **SPECIALISTERNE BRASIL**, autorizo a realização da pesquisa intitulada **NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO: DESAFIOS PARA A EMPREGABILIDADE DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)** a ser conduzida sob a responsabilidade da Mestranda (assistente de pesquisa) **DÉBORA CUNHA ROMANOV**; e declaro que esta organização apresenta as condições necessárias à realização da referida pesquisa. Este termo é válido, em razão do parecer favorável do Comitê de Ética avaliador do estudo (CAAE nº 73802023.2.0000.0084).

São Paulo, 03 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Rute Rodrigues

RUTE RODRIGUES – Diretora de Operações
SPECIALISTERNE BRASIL

APÊNDICE VIII

Termo de Anuência - AFAPA



Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Alegre

AFAPA

Termo de Anuência

Eu **Nara Pinheiro**, na qualidade de responsável pela **AFAPA – Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Alegre**, autorizo a realização da pesquisa intitulada **NEURODIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO: DESAFIOS PARA A EMPREGABILIDADE DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)** a ser conduzida sob a responsabilidade da **pesquisadora DÉBORA CUNHA ROMANOV**. e declaro que esta instituição apresenta as condições necessárias à realização da referida pesquisa. Este termo é válido apenas no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética avaliador do estudo.

São Paulo, 23 de agosto de 2023

[Assinatura do responsável pela instituição]

NARA PINHEIRO - PRESIDENTE

[carimbo da Instituição]

APÊNDICE IX

SATURAÇÃO – GRUPO 1

1. **Objetivo específico:** entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais com TEA

Grupo 1 - Entrevistas*																		
Participantes	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**P16**	**P17**	**P18**	**P19**
Temas																			
Tema 1	*		X				X	X	X		X			X	X	X			X
Tema 2	*					X									X		X	X	
Tema 3	*	X						X				X	X	X		X		X	
Tema 4	*	X		X	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X		

***Legenda:** * - tema novo / X – tema repetido

2. **Objetivo específico:** identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade

Grupo 1 - Entrevistas*																			
Participantes	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**P16**	**P17**	**P18**	**P19**
Temas																			
Tema 5		*							X						X		X	X	
Tema 6	*	X			X			X					X						
Tema 7	*									X	X								
Tema 8	*	X			X				X	X	X						X		
Tema 9										*						X			
Tema 10		*														X		X	X
Tema 11			*		X	X	X	X			X		X			X	X	X	

***Legenda:** * - tema novo / X – tema repetido

APÊNDICE X

MATRIZ DE AMARRAÇÃO

Problema de pesquisa: Quais são os desafios para a empregabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais, dos profissionais de RH e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho?							
Objetivo geral: entender os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA, a partir de uma visão integrada dos próprios profissionais, dos profissionais de RH e dos profissionais de organizações que atuam na capacitação dos profissionais com TEA para o mercado de trabalho.							
Objetivos específicos	**Referencial teórico**	**Técnica de coleta de dados**				**Itens do roteiro**	**Técnica de análise de dados***
		Entrevista	Observação*	Documentos*	Outros*		
1. analisar como são estruturados os programas de neurodiversidade voltados para profissionais com TEA nas organizações brasileiras, na visão dos profissionais de RH.	Spoor, Bury e Hedley (2021); Doyle e McDougall (2022); Szulc et al. (2021); Walkowiak (2021).	X		X		Apêndice V Itens 1 a 4	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)
2. analisar como são estruturados os programas de capacitação de profissionais com TEA para o mercado de trabalho, na visão dos profissionais de organizações que atuam para tal finalidade.	Albright, Kuloka e Scarpa (2020); Veras e Castro (2021).	X		X		Apêndice VI Itens 1 a 6	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)
3. entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais com TEA. (continua)	**Desenho do trabalho (job design)** (HURLBUTT; CHALMERS, 2004; GARBIN et al., 2022; HURLBUTT; CHALMERS, 2004; MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021); **Contratação** (KHAN et al., 2022; GARBIN et al., 2022; CONCEIÇÃO;	X				Apêndice IV Itens 6 a 10	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)

(continuação)	ESCALANTE; SILVA, 2021); **Integração** (GARBIN et al., 2022; LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017); **Treinamento e desenvolvimento** (ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020); **Desempenho (**GARBIN et al., 2022; LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017); **Relações sociais e bem-estar** (HURLBUTT; CHALMERS, 2004; SZULC, 2022).						
4. identificar quais são as iniciativas tomadas pelos próprios profissionais com TEA a respeito de sua empregabilidade.	Hogan, Chamorro-Premuzic e Kaiser (2013); McMahon, Henry e Linthicum (2021).	X				Apêndice IV Itens 1 a 5	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)
5. entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais de RH. (continua) (continuação)	**Desenho do trabalho *(job design)*** (BALDWIN; COSTLEY; WARREN, 2014; LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; BASTO; CEPELLOS, 2023); **Contratação** (KHAN et al., 2022; LEOPOLDINO; COSTA COELHO, 2017; CONCEIÇÃO; ESCALANTE; SILVA, 2021; ARAÚJO;	X				Apêndice V Itens 5 a 8	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)

	DOURADO, 2022; BASTO; CEPELLOS, 2023); SZULC, 2021); **Integração** (SZULC, 2021; SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021); **Treinamento e desenvolvimento** (VERAS; CASTRO, 2021; (DREAVER et al., 2019; ALBRIGHT; KULOKA; SCARPA, 2020); **Desempenho** (LINDSAY et al., 2019; SZULC, 2021; JOHNSON et al., 2020); **Relações sociais e bem-estar** (MELO; GARROCHO; GUERRA, 2021; SPOOR; BURY; HEDLEY, 2021).						
6. entender quais os desafios para a empregabilidade de pessoas com TEA na visão dos profissionais que atuam na (continua) (continuação) capacitação dos profissionais com TEA para o mercado.	Desenho do trabalho (*job design*); Contratação; Integração; Treinamento e desenvolvimento; Desempenho; Relações sociais e bem-estar (SPECIALISTERNE, 2024)	X				Apêndice VI Itens 7 a 10	Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)

Fonte: HANASHIRO, Darcy Mitiko Mori (2009), adaptado de Mazzon (1981), *In*: Telles, R. A efetividade da "matriz de amarração" de Mazzon nas pesquisas em Administração. *Revista de Administração*. v. 36, p. 64-72, 2001.